ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 14 · OR

Manual de

OTORRINOLARINGOLOGÍA

ORL

Módulo 2 · Cirugía y Especialidades · 20 clases

Índice general

01 Patología del Oído Externo y Medio 3

14.1. Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos 5
14.2. Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa 10
14.3. Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos 14
14.4. Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis 19

02 Audiología & Trastornos del Equilibrio 23

14.5. Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber) 25
14.6. Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia 28
14.7. Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière 32
14.8. Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt 37

03 Rinología & Senos Paranasales 42

14.9. Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales 44
14.10. Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias 47
14.11. Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos 51
14.12. Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal 56

04 Faringe, Laringe & Vía Aérea Superior 61

14.13. Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina 63
14.14. Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo 68
14.15. Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas 73
14.16. Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke 77
14.17. Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia 81

05 Cuerpos Extraños, Glándulas Salivales & Oncología Cervical 87

14.18. Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea 89
14.19. Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo 93
14.20. Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical 97

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 102

MANUAL EUNACOM DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

BLOQUE 01 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO

4	15	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

14.1	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	5
14.2	Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa	10
14.3	Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos	14
14.4	Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis	19

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
6.03.1.020, 2.01.1.026, 2.01.1.102	Otitis Media Aguda	Específico	Completo	Completo
6.03.1.021, 6.03.1.022, 6.03.4.005	Otitis Media con Efusión	Específico	Inicial	Específico
6.03.1.019, 1.02.1.014, 6.03.3.006, 6.03.5.010, 6.03.2.014, 6.03.5.005	Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos	Específico	Completo	Completo
6.03.2.001, 6.03.1.022, 6.03.5.001	Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis	Específico	Inicial	Específico

BLOQUE 01 · PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
15 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- El abombamiento de la membrana timpánica es el signo otoscópico cardinal más específico para el diagnóstico de OMA supurada.
- El tratamiento antimicrobiano de primera línea es la Amoxicilina oral a 80-90 mg/kg/día dividida cada 12 horas.
- Si no existe mejoría clínica tras 48 a 72 horas de amoxicilina, la conducta mandataria es cambiar a Amoxicilina + Ácido Clavulánico (80-90 mg/kg/día).
- La presencia de otorrea espontánea calma transitoriamente la otalgia debido a la descompresión mecánica del tímpano.
- La OMA Recurrente se define por ≥ 3 episodios en 6 meses o ≥ 4 en 1 año; requiere evaluación por ORL para inserción de tubos de ventilación.
- En niños menores de 6 meses, toda sospecha de OMA debe tratarse obligatoriamente con antibióticos sin período de observación.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Otitis Media Aguda	EUNACOM Diciembre 2024 · #128 · EUNACOM Julio 2024 · #13 · EUNACOM Julio 2013 · #175
Otitis Media con Efusión	EUNACOM Diciembre 2025 · #148 · EUNACOM Julio 2025 · #153 · EUNACOM Julio 2025 · #35 · EUNACOM Julio 2018 · #173
Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos	EUNACOM Diciembre 2025 · #160 · EUNACOM Julio 2024 · #157 · EUNACOM Diciembre 2024 · #93 · EUNACOM Enero 2023 · #113
Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis	EUNACOM Diciembre 2025 · #148 · EUNACOM Julio 2025 · #153 · EUNACOM Julio 2025 · #35 · EUNACOM Julio 2018 · #173

14.1. Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.03.1.020 2.01.1.026 2.01.1.102

¿POR QUÉ?

La Otitis Media Aguda (OMA) es la infección bacteriana más frecuente de la infancia y una de las causas líderes de prescripción de antimicrobianos en atención primaria y servicios de urgencia. En el examen EUNACOM se evalúa de forma reiterada la capacidad de discriminar entre una OMA inflamatoria supurada (que exige antibioticoterapia precoz en dosis plenas) y una otitis con efusión serosa (que no debe recibir antibióticos), así como la correcta conducta terapéutica ante la falla de primera línea a las 48-72 horas.

1. FISIOPATOLOGÍA, DISFUNCIÓN TUBÁRICA Y MICROBIOLOGÍA

6.03.1.020 2.01.1.026

La **otitis media aguda (OMA)** es un proceso inflamatorio e infeccioso de la mucosa del oído medio y celdas mastoideas de curso agudo (< 3 semanas). La génesis de la enfermedad radica casi invariablemente en una **disfunción de la trompa de Eustaquio**, habitualmente desencadenada por una infección respiratoria alta de etiología viral (rinovirus, VRS, influenza, adenovirus). La obstrucción tubárica genera una presión negativa intratimpánica persistente, con transudación serosa posterior y colonización bacteriana retrógrada desde la nasofaringe. **(ver Imagen 14.1A y B)**

Los tres patógenos bacterianos dominantes en pediatría y adultos son: *Streptococcus pneumoniae* (neumococo, 35-40%), *Haemophilus influenzae* no tipificable (30-35%, de los cuales un 30-40% produce betalactamasas), y *Moraxella catarrhalis* (10-15%, >90% productora de betalactamasas). Tras la introducción de la vacuna neumocócica conjugada (PCV10/PCV13 en el PNI de Chile), la proporción relativa de *H. influenzae* ha aumentado de manera significativa.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y HALLAZGOS OTOSCÓPICOS CARDINALES

6.03.1.020 2.01.1.026

El diagnóstico de certeza de la OMA es eminentemente **clínico y otoscópico**, requiriendo el cumplimiento estricto de tres criterios indispensables: (1) *Inicio agudo y reciente de signos y síntomas* (otalgia severa, tirones de oreja o llanto inconsolable en lactantes, fiebre); (2) *Signos evidentes de efusión en oído medio* (abombamiento timpánico moderado a severo, nivel hidroaéreo visible o perforación timpánica con otorrea aguda no traumática); y (3) *Signos de inflamación timpánica activa* (eritema intenso de la membrana timpánica, opacidad y marcada disminución o ausencia de movilidad en la otoscopía neumática).

El **abombamiento de la membrana timpánica** es el signo otoscópico individual más sensible, específico y reproducible de OMA supurada. El eritema aislado sin abombamiento ni hipomovilidad suele responder a llanto o hiperemia por fiebre viral y no justifica el inicio de antibióticos (véase Tabla 14.1).

TABLA 14.1.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL OTOSCÓPICO Y MANEJO CLÍNICO EN PATOLOGÍA DE OÍDO MEDIO 6.03.1.020, 2.01.1.026, 2.01.1.102

ENTIDAD CLÍNICA	SIGNOS OTOSCÓPICOS CARDINALES	SINTOMATOLOGÍA PREDOMINANTE	CONDUCTA TERAPÉUTICA OFICIAL
Otitis Media Aguda (OMA)	Abombamiento timpánico marcado, eritema intenso, opacidad y otorrea aguda si hay perforación	Otalgia lancinante aguda, fiebre, hipoacusia conductiva transitoria	Amoxicilina 80-90 mg/kg/día oral x 7-10 días + analgesia con Paracetamol / Ibuprofeno
Otitis Media con Efusión (OME)	Membrana timpánica retraída, color ámbar/amarillento, nivel hidroaéreo o burbujas visibles	Hipoacusia de conducción indolora, sin fiebre ni eritema agudo	Observación clínica estricta x 3 meses · Prohibidos antibióticos y antihistamínicos
Miringitis Bulosa	Bulás hemorrágicas o serosas en la superficie externa del tímpano	Otalgia súbita e hiperaguda desgarradora, sangrado escaso	Analgesia potente + Macrólido oral (asociado a Mycoplasma pneumoniae y virus)
Otitis Externa Difusa	Edema y eritema circunferencial del CAE con detritos; tímpano indemne	Signo del trago (+), dolor extremo a la tracción del pabellón, prurito	Aseo cuidadoso del CAE + gotas óticas de Ciprofloxacino/Corticoides tópicos

14.1. Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TERAPIA FARMACOLÓGICA: DOSIS PLENAS DE AMOXICILINA Y ESCALONAMIENTO

El antibiótico de **primera línea indiscutido** en Chile y guías internacionales (AAP/MINSAL) es la **Amoxicilina oral en dosis altas: 80 a 90 mg/kg/día dividida cada 12 horas** (dosis máxima 2 a 3 g/día) durante 7 a 10 días (10 días en menores de 2 años u OMA severa; 5-7 días en mayores de 2 años con cuadros leves). La dosis alta es mandatoria para superar las cepas de *Streptococcus pneumoniae* con susceptibilidad disminuida a penicilinas por mutación de las PBP (proteínas fijadoras de penicilina). 6.03.1.020 2.01.1.026

Si el paciente presenta **falla terapéutica a las 48-72 horas** (persistencia o empeoramiento de fiebre y otalgia), o si ha recibido amoxicilina en los últimos 30 días, o presenta conjuntivitis purulenta concurrente (síndrome otitis-conjuntivitis habitualmente por *H. influenzae*), se debe escalar de inmediato a **Amoxicilina + Ácido Clavulánico (relación 14:1) a 80-90 mg/kg/día de amoxicilina** oral.

En pacientes con alergia confirmada a penicilina no anafiláctica (alergia tipo IV / exantema tardío), se utiliza una cefalosporina oral de 2ª o 3ª generación (Cefuroxima axetil 30 mg/kg/día o Cefdinir). En anafilaxia o hipersensibilidad inmediata mediada por IgE, la alternativa de rescate son los macrólidos (Azitromicina 10 mg/kg el día 1, seguido de 5 mg/kg/día del día 2 al 5) o Claritromicina (15 mg/kg/día), reconociendo tasas de resistencia neumocócica del 25-30%.



A. TÍMPANO NORMAL DERECHO **B.** OMA: TÍMPANO ABOMBADO

Imagen 14.1

FIGURA 14.1 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESCALONADO DE LA OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)

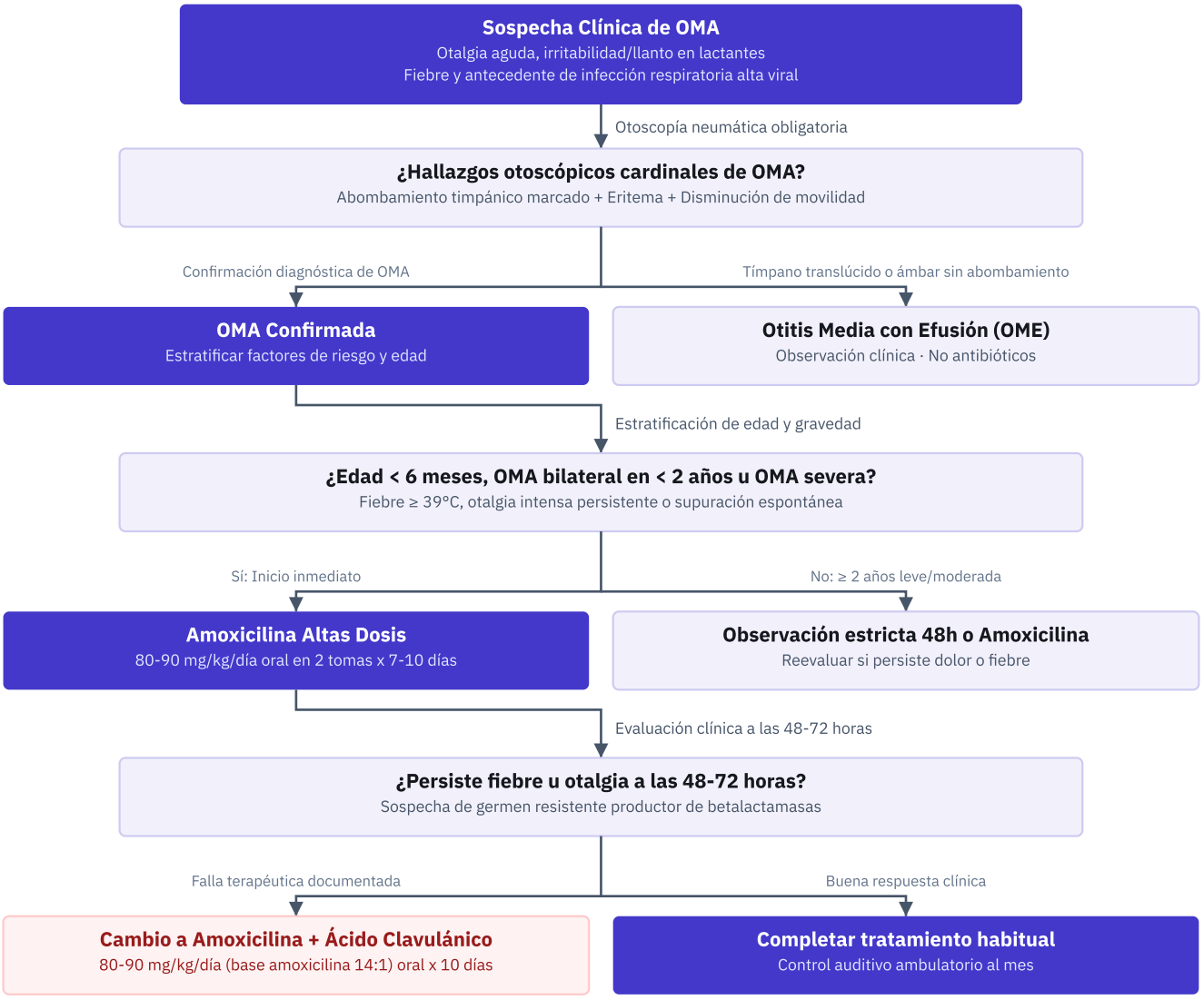


TABLA 14.1.B · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y CRITERIOS DE ALARMA EN OMA PEDIÁTRICA Y DEL ADULTO CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	CRITERIOS CLÍNICOS DEFINITORIOS	FACTORES DE ALTO RIESGO MICROBIOLÓGICO	ESQUEMA TERAPÉUTICO RECOMENDADO
OMA Leve a Moderada	Fiebre < 39°C, otalgia leve o autolimitada, niño > 2 años sin toxicidad sistémica	Sin uso de antibióticos en últimos 30 días, sin asistencia a sala cuna	Amoxicilina oral 80-90 mg/kg/día en 2 tomas x 7 días
OMA Severa	Fiebre ≥ 39°C axilar, otalgia severa continua > 48 horas, o niño < 2 años con compromiso bilateral	Lactante menor de 6 meses, antecedente de OMA en el último mes	Amoxicilina 90 mg/kg/día oral x 10 días (o Amoxicilina-Clavulánico directo)
OMA con Complicación Inminente	Eritema retroauricular, edema fluctuante, caída del pabellón auricular, parálisis facial o vértigo	Patógenos resistentes, inmunodeficiencia, colesteatoma subyacente	Hospitalización inmediata, TAC de peñasco con contraste, Ceftriaxona EV + Miringotomía

14.1. Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. OMA RECURRENTE Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN A OTORRINOLARINGOLOGÍA

Se define **OMA Recurrente (OMAr)** como la presencia de: (a) **≥ 3 episodios documentados de OMA en 6 meses**, o (b) **≥ 4 episodios en 12 meses** (con al menos 1 episodio en los últimos 6 meses), siempre que exista resolución clínica y otoscópica completa entre los eventos. 6.03.1.020 2.01.1.026 2.01.1.102

Estos pacientes requieren derivación a ORL para estudio de factores predisponentes (hipertrofia adenoidea, fisura palatina, reflujo faringolaríngeo) e instalación de **tubos de ventilación timpánica (colleras)** asociados o no a **adenoidectomía**, lo que restaura la aireación del oído medio y reduce drásticamente las recurrencias bacterianas.

TABLA 14.1.C · PROTOCOLO ANTIMICROBIANO ESCALONADO EN OTITIS MEDIA AGUDA (GUÍA EUNACOM 2026) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESCENARIO TERAPÉUTICO	FÁRMACO DE ELECCIÓN Y VÍA	DOSIS Y POSOLOGÍA PEDIÁTRICA	DURACIÓN Y OBJETIVO CLÍNICO
Primera Línea Estándar	Amoxicilina oral	80-90 mg/kg/día dividida cada 12 horas (máx 3 g/día)	7 a 10 días · Erradicación de S. pneumoniae resistente
Falla Clínica a 48-72h	Amoxicilina + Ácido Clavulánico oral	80-90 mg/kg/día de amoxicilina (relación 14:1) cada 12h	10 días · Cobertura de H. influenzae y M. catarrhalis
Alergia Leve a Penicilina (no IgE)	Cefuroxima axetil oral	30 mg/kg/día dividida en 2 tomas (con alimentos)	10 días · Alternativa con baja reactividad cruzada
Alergia Grave / Anafiláctica (IgE)	Azitromicina o Claritromicina oral	Azitromicina: 10 mg/kg día 1, luego 5 mg/kg/día días 2-5	5 días · Rescate estricto en anafilaxia confirmada
Vómitos incoercibles / Mala absorción	Ceftriaxona intramuscular o EV	50 mg/kg/día IM o EV dosis única diaria x 1-3 dosis	Rescate parenteral ambulatorio o pre-hospitalario

14.1. Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (OTITIS MEDIA AGUDA (OMA))

- El abombamiento de la membrana timpánica es el signo otoscópico cardinal más específico para el diagnóstico de OMA supurada.
- Si no existe mejoría clínica tras 48 a 72 horas de amoxicilina, la conducta mandataria es cambiar a Amoxicilina + Ácido Clavulánico (80-90 mg/kg/día).
- La OMA Recurrente se define por ≥ 3 episodios en 6 meses o ≥ 4 en 1 año; requiere evaluación por ORL para inserción de tubos de ventilación.
- Los antihistamínicos y corticoides orales carecen de utilidad en OMA no complicada y están formalmente desaconsejados.
- El tratamiento antimicrobiano de primera línea es la Amoxicilina oral a 80-90 mg/kg/día dividida cada 12 horas.
- La presencia de otorrea espontánea calma transitoriamente la otalgia debido a la descompresión mecánica del tímpano.
- En niños menores de 6 meses, toda sospecha de OMA debe tratarse obligatoriamente con antibióticos sin período de observación.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

14.1

Un niño de 18 meses, previamente sano y con vacunas al día, es llevado al servicio de urgencia por su madre debido a fiebre de hasta 39.2°C axilar de 24 horas de evolución, llanto desconsolado e irritabilidad marcada durante la noche, llevándose las manos repetidamente hacia la oreja derecha. Como antecedente, presentó un resfriado común hace 5 días en la sala cuna. Al examen físico se observa febril, reactivo, sin signos meníngeos. La otoscopía del oído izquierdo es normal; en el oído derecho se evidencia una membrana timpánica francamente abombada, eritematosa, opaca y con nula movilidad al estímulo neumático, sin otorrea.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico y otoscópico es patognomónico de una Otitis Media Aguda (OMA) derecha de curso severo (fiebre > 39°C y dolor intenso en lactante < 2 años). El abombamiento timpánico asociado a eritema e hipomovilidad confirma la presencia de efusión purulenta hipertensiva en el oído medio. La conducta oficial de elección inmediata es el inicio de Amoxicilina oral en dosis altas de 80 a 90 mg/kg/día dividida en 2 tomas por 10 días, asociada a analgesia reglada con Paracetamol o Ibuprofeno. No está indicado el uso de descongestionantes ni antihistamínicos. Se debe instruir a los padres a consultar de inmediato si presenta signos de alarma (edema retroauricular, somnolencia) o si persiste la fiebre tras 48-72 horas de antibiótico para escalar a amoxicilina-clavulánico.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.020

1. Un lactante de 14 meses es diagnosticado de otitis media aguda derecha y se le prescribe amoxicilina en dosis de 85 mg/kg/día. A las 72 horas de tratamiento, la madre vuelve a consultar porque el niño persiste febril (38.8°C), muy irritable y con dolor en el oído. La otoscopía de control muestra persistencia del abombamiento y eritema timpánico. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada en este momento?

A) Aumentar la dosis de amoxicilina a 120 mg/kg/día y controlar en 48 horas.
B) Cambiar el tratamiento antimicrobiano a amoxicilina con ácido clavulánico oral.
C) Suspender la amoxicilina e iniciar gotas óticas de ciprofloxacino con hidrocortisona.
D) Derivar de urgencia para miringotomía y timpanocentesis inmediata.
E) Mantener la amoxicilina por 48 horas adicionales ya que el efecto bactericida puede tardar hasta 5 días.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.026

2. Un niño de 4 años presenta cuadro de 2 días de rinorrea serosa y fiebre leve. Su madre nota que no responde adecuadamente cuando se le habla despacio. Al examen físico, el niño no tiene dolor ótico. La otoscopía revela tímpanos íntegros, de aspecto translúcido pero discretamente opacos y de color amarillento-ámbar, con presencia de nivel hidroaéreo y burbujas detrás de la membrana, sin eritema ni abombamiento. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta de elección?

A) Otitis media aguda; iniciar amoxicilina a 90 mg/kg/día por 10 días.
B) Otitis media con efusión; conducta expectante y control en 3 meses.
C) Otitis media crónica colesteatomatosa; solicitar TAC de peñasco urgente.
D) Otitis externa difusa; indicar gotas óticas de neomicina y polimixina B.
E) Disfunción tubárica aguda; iniciar corticoides orales y antihistamínicos por 14 días.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.020

3. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el agente etiológico aislado con mayor frecuencia en la otitis media aguda bacteriana no complicada en Chile?

A) Pseudomonas aeruginosa
B) Streptococcus pneumoniae
C) Staphylococcus aureus
D) Klebsiella pneumoniae
E) Streptococcus pyogenes

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.102

4. Un lactante de 11 meses presenta su tercer episodio de otitis media aguda supurada en los últimos 4 meses, respondiendo satisfactoriamente a la amoxicilina en cada oportunidad. La madre pregunta cuál es la definición médica de su condición y el paso a seguir. ¿Cuál es la respuesta correcta?

A) Corresponde a una otitis media crónica supurada y debe iniciar profilaxis antibiótica diaria con cotrimoxazol.
B) Cumple criterios de otitis media recurrente y debe ser derivado al especialista otorrinolaringólogo para evaluación de tubos de ventilación.
C) No cumple criterios de recurrencia porque se requieren al menos 5 episodios en 6 meses.
D) Se trata de una falla inmunológica primaria y requiere inmunoglobulinas endovenosas mensuales.
E) Debe recibir amoxicilina en dosis profiláctica continua durante toda la temporada de invierno.

Más preguntas online de Otitis Media Aguda →

14.2. Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.03.1.021 6.03.1.022 6.03.4.005

¿POR QUÉ?

La patología crónica del oído medio abarca desde la otitis media con efusión serosa (OME) hasta las variantes destructivas de la otitis media crónica (OMC). En EUNACOM es imprescindible saber que la OME se observa por 3 meses antes de plantear colleras; que la OMC simple tiene perforación central no marginal con otorrea mucosa indolora; y que la presencia de escamas de queratina o perforación atical/marginal define al colesteatoma, una patología osteolítica que exige TAC y resolución quirúrgica obligatoria por riesgo de fístula laberíntica y abscesos endocraneales.

1. OTITIS MEDIA CON EFUSIÓN (OME): FISIOPATOLOGÍA Y CONDUCTA DE 3 MESES

La **Otitis Media con Efusión (OME)**, también llamada otitis serosa o secretora, es la presencia de exudado no purulento en la cavidad del oído medio con membrana timpánica intacta, en ausencia de signos o síntomas de infección aguda. Su etiología primordial es la disfunción ventilatoria de la trompa de Eustaquio (secundaria a hipertrofia adenoidea en niños, o rinitis alérgica). Es la **causa más frecuente de hipoacusia de conducción en niños de edad preescolar y escolar**. **(ver Imagen 14.2A)** 6.03.1.021

El 80-90% de los derrames serosos resuelven espontáneamente en un plazo de 3 meses. Por ende, la **conducta clínica inicial es la observación expectante por 12 semanas** con audiometría e impedanciometría de seguimiento (que muestra una curva B plana). Los antibióticos orales, antihistamínicos, descongestionantes y corticoides están formalmente desaconsejados. Si la OME persiste más de 3 meses con hipoacusia conductiva bilateral documentada (umbral > 25-30 dB), está indicada la miringotomía con colocación de **tubos de ventilación timpánica (colleras)**.

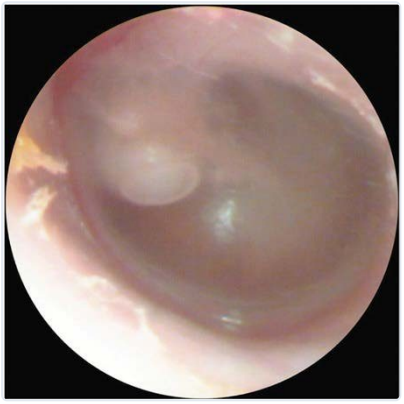
2. OTITIS MEDIA CRÓNICA SIMPLE (OMC SUPURADA BENIGNA)

La **OMC simple o benigna** se define como una inflamación crónica del mucoperiostio del oído medio caracterizada por una **perforación timpánica permanente que respeta el annulus fibrosus (perforación central en la pars tensa)** y otorrea indolora intermitente o persistente por más de 6 a 12 semanas. **(ver Imagen 14.2C)** 6.03.1.022

Los microorganismos predominantes son *Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus*. En las fases activas supurativas, el tratamiento consiste en aseo auditivo bajo otomicroscopía y **gotas óticas de Ciprofloxacino al 0.3%** (¡evitar aminoglucósidos tópicos por ototoxicidad cocleovestibular ante tímpano abierto!). En fase seca, el tratamiento definitivo es quirúrgico mediante **timpanoplastia electiva** para cerrar la membrana y restituir la audición. **(ver Imagen 14.2B)**

3. OTITIS MEDIA CRÓNICA COLESTEATOMATOSA: ALARMA OSTEOLÍTICA Y QUIRÚRGICA

El **colesteatoma** es una lesión no neoplásica pero localmente destructiva y osteolítica, formada por acumulación de **epitelio escamoso estratificado queratinizante** dentro de la hendidura del oído medio y mastoides. Se manifiesta típicamente con **perforación marginal (que compromete el reborde óseo o annulus) o atical (en la pars flácida)**, acompañada de escamas blanquecinas nacaradas y otorrea crónica fétida purulenta, refractaria a antibióticos. 6.03.1.022

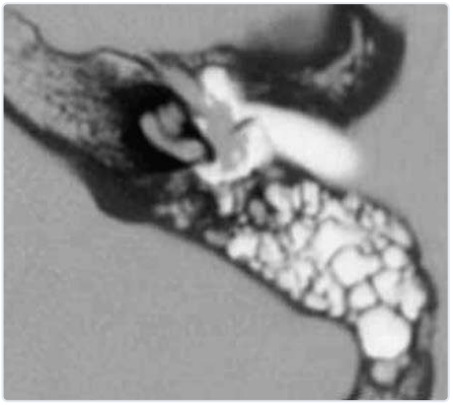


Colesteatoma: masa blanco nacarada en la otoscopía

Debido a la producción de enzimas colagenasas y citoquinas líticas, el colesteatoma destruye la cadena oscicular (conduciendo a hipoacusia severa), el canal de Falopio (causando *parálisis facial periférica*), el canal semicircular lateral (generando *fístula laberíntica y vértigo*) y el tegmen tympani (produciendo *meningitis o absceso cerebral temporal/cerebeloso*). Su confirmación imagenológica requiere **TAC de peñascos de alta resolución sin contraste** y su tratamiento es **quirúrgico ineludible (timpanomastoidectomía radical o conservadora)**. 6.03.1.022 6.03.4.005

4. TAC DE OÍDOS SIN CONTRASTE: QUÉ PIDE Y QUÉ INFORMA EL MÉDICO GENERAL

La **TAC de oídos (peñascos) sin medio de contraste** es el examen de elección para estudiar el hueso temporal y se solicita ante una **otitis media crónica con sospecha de colesteatoma** o ante cualquier complicación (mastoiditis, parálisis facial, vértigo, signos meníngeos). El médico general *emplea el informe*; no lo interpreta cortes a corte. Un informe de colesteatoma describe típicamente una **masa de partes blandas en el ático (epitímpano) o antro mastoídeo con erosión del scutum** (borde óseo lateral del ático), erosión de la cadena osicular (sobre todo la **apófisis larga del yunque** y la supraestructura del estribo) y ensanchamiento del aditus ad antrum, con mastoides poco neumatizada u ocupada por tejido inflamatorio. 6.03.4.005



Colesteatoma congénito: TAC axial de oído izquierdo con masa de partes blandas en el oído medio

Los hallazgos que cambian la conducta son los de **complicación**: **erosión del tegmen tympani o mastoideo** (riesgo de meningitis, absceso temporal), **fístula del canal semicircular lateral** (vértigo inducido por presión), **dehiscencia del canal del nervio facial** y erosión de la pared sigmoidea (trombosis del seno sigmoides). Cualquiera de ellos obliga a derivación urgente a ORL. Un TAC normal **no descarta un colesteatoma pequeño**: manda la otoscopía/microscopía, y la resonancia con secuencias de difusión se reserva para el colesteatoma residual o la sospecha de complicación intracraneal (donde se prefiere RM o TAC con contraste).



A. EFUSIÓN: NIVEL DE LÍQUIDO



B. COLLERA EN EL TÍMPANO



C. PERFORACIÓN CENTRAL

Imagen 14.2

FIGURA 14.2 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y MANEJO DE LA PATOLOGÍA CRÓNICA DEL OÍDO MEDIO



TABLA 14.2 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: OME VS OMC SIMPLE VS OMC COLESTEATOMATOSA `6.03.1.021, 6.03.1.022, 6.03.4.005`

CARACTERÍSTICA CLÍNICA	OTITIS MEDIA CON EFUSIÓN (OME)	OMC SIMPLE (SUPURADA)	OMC COLESTEATOMATOSA
Estado Timpánico	Tímpano íntegro, retraído, color ámbar, burbujas visibles	Perforación central en pars tensa (respeta el annulus)	Perforación marginal en pars flácida o bolsillo de retracción atical
Otorrea	Ausente (líquido retenido detrás del tímpano)	Otorrea mucosa o purulenta no fétida, indolora	Otorrea fétida persistente con escamas nacaradas de queratina
Comportamiento Óseo	No osteolítico · Reversible espontáneamente	Rara vez osteolítico · Cadena típicamente conservada	Altamente osteolítico: erosión de huesecillos, laberinto y tegmen
Conducta Oficial	Observación 3 meses; colleras si persiste hipoacusia	Aseo + Ciprofloxacino tópico; timpanoplastia en fase seca	TAC de peñasco sin contraste + Mastoidectomía quirúrgica obligatoria

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 14.2

Un hombre de 42 años consulta por hipoacusia progresiva izquierda y supuración ótica intermitente de larga data. Refiere que en el último mes la supuración se ha vuelto constante y con olor sumamente fétido, asociándose hace 4 días a sensación de inestabilidad y mareo al limpiarse el oído. A la otoscopía se aprecia en el oído izquierdo una perforación marginal en la región posterosuperior y pars flácida del tímpano, a través de la cual asoman detritos blanquecinos escamosos fétidos y tejido de granulación. Al comprimir el trago, el paciente experimenta una crisis vertiginosa con nistagmo horizontal hacia la derecha.

Conducta oficial. El cuadro clínico corresponde a una Otitis Media Crónica Colesteatomatosa izquierda complicada. La localización atical/marginal de la perforación junto a la visualización de escamas nacaradas de queratina y fetidez extrema son diagnósticas de colesteatoma. El signo de la fístula positivo (vértigo y nistagmo inducidos por compresión neumática del CAE) demuestra erosión osteolítica del canal semicircular lateral por la masa epidérmica. La conducta prioritaria es solicitar un TAC de peñasco de alta resolución sin contraste para evaluar la extensión ósea y derivar de urgencia al especialista otorrinolaringólogo para exploración y mastoidectomía quirúrgica para erradicar el colesteatoma y prevenir meningitis o fístulas extensas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La OME es la causa más común de hipoacusia conductiva en preescolares y se maneja con conducta expectante durante 3 meses.
- En OME no deben indicarse antibióticos, antihistamínicos ni corticoides de rutina.
- La OMC simple se caracteriza por perforación timpánica central que respeta el annulus, con otorrea no fétida.
- El colesteatoma presenta perforación marginal en la pars flácida con escamas nacaradas blanquecinas y otorrea intensamente fétida.
- El colesteatoma es una lesión osteolítica destructiva con riesgo de parálisis facial, fístula laberíntica y abscesos intracraneales.
- El examen de elección para estudiar la anatomía y extensión del colesteatoma es el TAC de peñasco sin contraste.
- El tratamiento del colesteatoma es siempre quirúrgico (timpanomastoidectomía); los antibióticos tópicos solo controlan la sobreinfección.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.021

1. Un escolar de 6 años es evaluado en el policlínico por sospecha de déficit atencional, ya que en el colegio la profesora nota que no obedece las órdenes y pide con frecuencia que le repitan las frases. No ha tenido otalgia ni fiebre. A la otoscopía se aprecian membranas timpánicas íntegras, ligeramente retraídas, de color amarillento y con visualización de nivel hidroaéreo y burbujas bilaterales. La timpanometría arroja curvas tipo B bilaterales con hipoacusia de conducción de 25 dB. El cuadro se ha documentado por 4 meses consecutivos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Corticoides sistémicos orales en pulsos por 10 días.
B) Amoxicilina con ácido clavulánico por 21 días consecutivos.
C) Inserción bilateral de tubos de ventilación timpánica (colleras).
D) Realización inmediata de mastoidectomía bilateral abierta.
E) Tratamiento prolongado con antihistamínicos orales y descongestionantes nasales.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.022

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen otoscópico orienta con mayor especificidad a una otitis media crónica colesteatomatosa por sobre una otitis media crónica simple?

A) Perforación central puntiforme en el cuadrante anteroinferior de la pars tensa.
B) Presencia de escamas blanquecinas nacaradas en una perforación marginal en la pars flácida.
C) Membrana timpánica abombada y eritematosa con pulsación visible.
D) Otorrea mucosa transparente no fétida a través de una perforación amplia que respeta el annulus.
E) Membrana timpánica íntegra con burbujas de aire retro timpánicas.

Más preguntas online de Otitis Media con Efusión →

14.3. Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.03.1.019 | 1.02.1.014 | 6.03.3.006 | 6.03.5.010 | 6.03.2.014 | 6.03.5.005

¿POR QUÉ?

La otitis externa representa una de las consultas más frecuentes en atención de urgencia estival. El médico general debe dominar dos escenarios radicalmente distintos: (1) La Otitis Externa Difusa benigna (oído de nadador), que cura rápidamente con gotas antibióticas tópicas y analgesia sin requerir antibióticos orales; y (2) La Otitis Externa Maligna o Necrotizante, una osteomielitis de la base del cráneo por Pseudomonas aeruginosa en pacientes ancianos con diabetes mellitus, patología potencialmente letal que causa parálisis facial y requiere hospitalización inmediata y antibioticoterapia endovenosa prolongada.

1. OTITIS EXTERNA DIFUSA AGUDA: ETIOLOGÍA Y SIGNO DEL TRAGO (+)

La **otitis externa difusa aguda (oído de nadador)** es la dermo-epidermitis aguda infecciosa que compromete la piel del conducto auditivo externo (CAE). Su factor predisponente clásico es la humedad excesiva (baños en piscinas, playas), el rascado o traumatismos locales con hisopos (cotonitos), lo que barre la capa protectora lipídica del cerumen y altera el pH ácido cutáneo, favoreciendo la proliferación bacteriana. **(ver Imagen 14.3A y B)** 6.03.1.019 6.03.3.006

El agente microbiológico causal en > 70-80% de los casos es *Pseudomonas aeruginosa*, seguido de *Staphylococcus aureus* (15-20%). La clínica se distingue por **otalgia severa desproporcionada, prurito inicial y exquisito dolor a la tracción del pabellón auricular o a la presión del trago (Signo del Trago positivo)**. A la otoscopía se observa eritema y edema difuso del CAE que ocluye la luz, con presencia de detritos blanquecinos o verdosos y membrana timpánica íntegra (o difícil de visualizar por el edema). 6.03.1.019

2. MANEJO DE LA OTITIS EXTERNA DIFUSA: PRIMACÍA DE LA VÍA TÓPICA

El tratamiento de la otitis externa difusa no complicada se basa en tres pilares: (1) **Aseo meticuloso del CAE** retirando detritos mediante aspiración o hisopado suave bajo visualización directa; (2) **Gotas óticas antibióticas de Ciprofloxacino (0.3%) asociado o no a Dexametasona o Hidrocortisona**, administrando 3 a 4 gotas cada 8 a 12 horas por 7 a 10 días; y (3) **Analgesia reglada por vía oral con AINEs** (Ibuprofeno, Ketoprofeno) o Paracetamol. 6.03.1.019

Los antibióticos orales NO están indicados en la otitis externa difusa simple porque las gotas tópicas alcanzan concentraciones locales mil veces superiores a la concentración inhibitoria mínima tisular. Los antibióticos orales solo se agregan si la infección se extiende más allá del CAE hacia el pabellón auricular (celulitis periauricular) o si el paciente está inmunocomprometido. Debe prohibirse estrictamente el ingreso de agua al oído durante todo el tratamiento. 6.03.1.019 6.03.3.006

TABLA 14.3.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: OTITIS EXTERNA DIFUSA VS OTITIS EXTERNA MALIGNA 6.03.1.019, 1.02.1.014, 6.03.3.006, 6.03.5.010, 6.03.2.014, 6.03.5.005

CRITERIO COMPARATIVO	OTITIS EXTERNA DIFUSA AGUDA	OTITIS EXTERNA MALIGNA (NECROTIZANTE)
Población de Riesgo	Cualquier edad, nadadores, usuarios de hisopos/cotonitos	Adultos mayores (> 65 años) diabéticos o inmunodeprimidos
Etiología Principal	Pseudomonas aeruginosa (70%) y S. aureus (20%)	Pseudomonas aeruginosa (> 95% de los casos)
Severidad del Dolor	Otalgia aguda moderada a severa, signo del trago (+)	Dolor terebrante intolerable, nocturno, que despierta al paciente
Hallazgo Otoscópico	Edema y eritema difuso del CAE con detritos descamativos	Tejido de granulación en el piso del CAE (unión osteocartilaginosa)
Compromiso Nervioso	Ausente · Función de pares craneales rigurosamente intacta	Frecuente parálisis del VII par craneal (facial); luego IX, X, XI, XII
Manejo Terapéutico	Ambulatorio: Gotas tópicas de Ciprofloxacino + analgesia oral	Hospitalario urgente: Ciprofloxacino o Ceftazidima EV x 6-8 semanas

14.3. Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos — Enfrentamiento Diagnóstico

3. OTITIS EXTERNA MALIGNA (NECROTIZANTE): FISIOPATOLOGÍA Y OSTEOMIELITIS

La **otitis externa maligna (OEM) o necrotizante** no es una neoplasia sino una **infección invasiva necrotizante y osteomielitis progresiva del hueso temporal y base del cráneo**, causada casi exclusivamente por ***Pseudomonas aeruginosa*** (raramente por hongos como *Aspergillus* en VIH severo). Ocurre típicamente en **ancianos con diabetes mellitus mal controlada** o en pacientes con inmunosupresión celular severa. 6.03.1.019 1.02.1.014

La infección se inicia en el CAE y progresa a través de las fisuras de Santorini y la unión osteocartilaginosa hacia la fosa infratemporal, el agujero estilomastoideo y el foramen yugular. La sintomatología se caracteriza por **otalgia intensa, profunda y terebrante, de predominio nocturno, que no cede con analgésicos habituales**, acompañada de otorrea fétida persistente.



A. CONDUCTO EDEMATOSO **B.** OTOMICOSIS: MASA BLANQUECINA **C.** OTOHEMATOMA DEL PABELLÓN

Imagen 14.3

FIGURA 14.3 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA OTITIS EXTERNA DIFUSA Y MALIGNA NECROTIZANTE

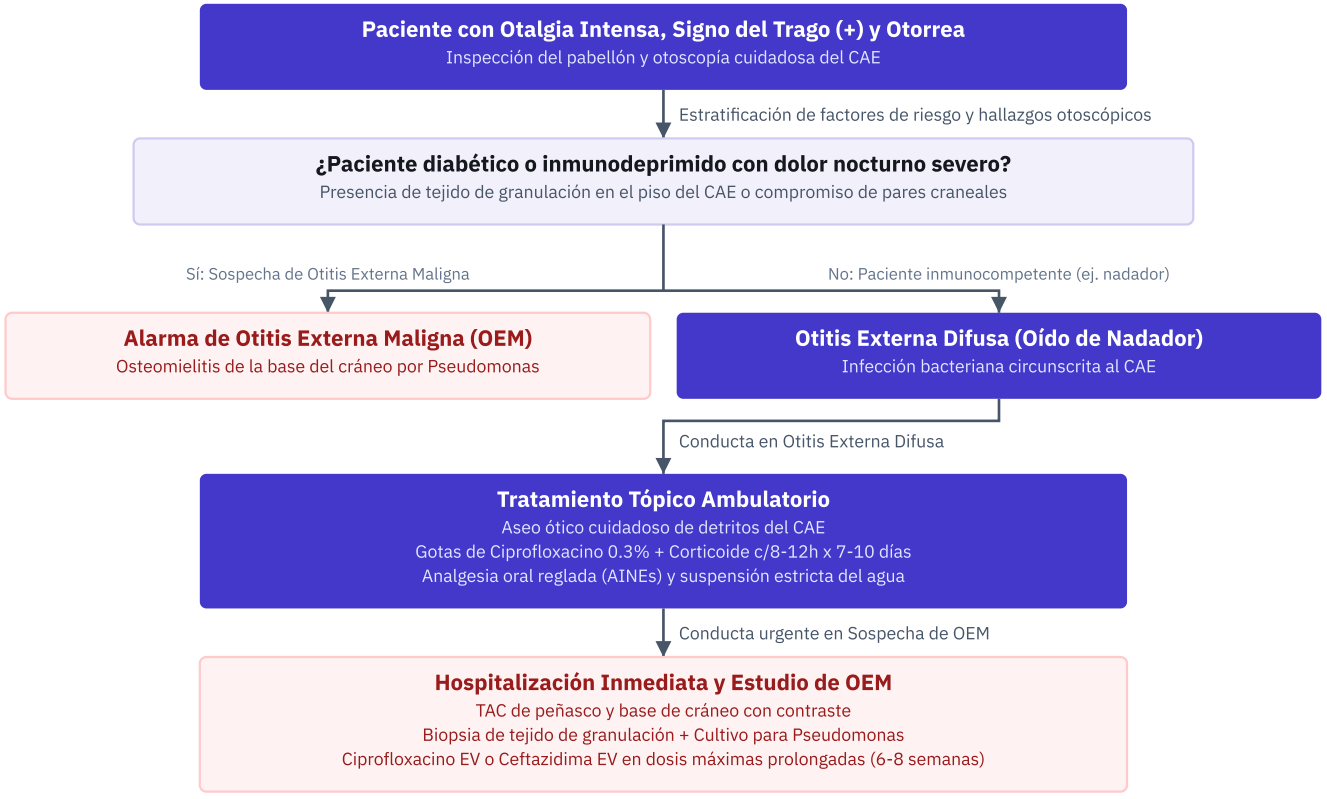


TABLA 14.3.B · CRITERIOS DE GRAVEDAD Y PROGRESIÓN EN OTITIS EXTERNA MALIGNA CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESTADIO CLÍNICO	COMPROMISO ANATÓMICO	RIESGO DE MORTALIDAD	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
Estadio I (Local)	Limitado a los tejidos blandos y cartílago del CAE	Baja (< 5%) con terapia oportuna	Ciprofloxacino EV o dosis altas orales bajo estricto control
Estadio II (Óseo)	Osteomielitis del hueso temporal con parálisis facial (VII par)	Moderada (15-20%)	Ceftazidima o Ciprofloxacino EV en dosis máximas + control de glicemia
Estadio III (Base Cráneo)	Extensión a pares bajos (IX, X, XI, XII), clivus y fosa posterior	Alta (30-50%). Riesgo de trombosis de seno sigmoide	Biterapia EV (Meropenem + Ciprofloxacino) + Debridamiento quirúrgico selectivo

14.3. Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos — Manejo Terapéutico y Urgencias

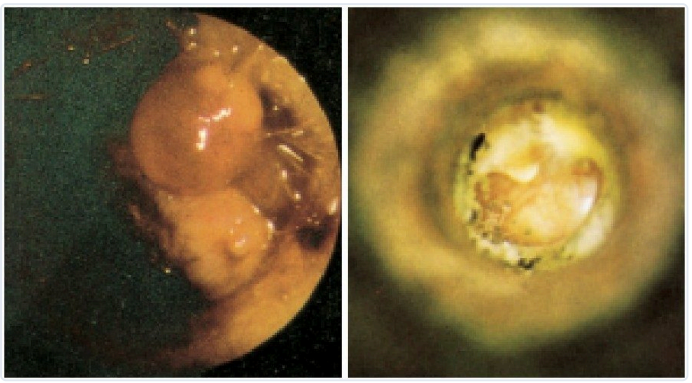
4. HALLAZGOS CARDINALES DE OEM, NEUROIMAGEN Y ESQUEMA ANTIMICROBIANO

El hallazgo otoscópico patognomónico es la presencia de **tejido de granulación inflamatorio en el piso del conducto auditivo externo, en la unión osteocartilaginosa**. La complicación más temida es la extensión a pares craneales: el **nervio facial (VII par) es el primer y más frecuentemente comprometido** (parálisis facial periférica ipsilateral de mal pronóstico), seguido por los pares bajos (IX, X, XI en el foramen yugular y XII en el canal hipogloso). 6.03.1.019 1.02.1.014

El estudio confirmatorio requiere **TAC de peñasco y base de cráneo con contraste** (que demuestra erosión ósea y osteólisis del hueso timpánico y clivus) asociado a cintigrafía ósea con Tc-99 o Ga-67 para monitorizar actividad y resolución. El manejo exige **hospitalización inmediata, control estricto de la glicemia y antibioticoterapia endovenosa prolongada en dosis altas: Ciprofloxacino EV (400 mg c/8-12h) o Ceftazidima EV (2 g c/8h) o Meropenem EV durante un mínimo de 6 a 8 semanas**.

5. PREVENCIÓN DE LA OTITIS EXTERNA Y LAVADO DE OÍDOS

La **prevención de la otitis externa** se basa en mantener el conducto auditivo externo seco, limpio e íntegro: **secar el CAE tras el baño** (inclinar la cabeza, secador a distancia con aire tibio), usar **tapones y gorro de natación** en nadadores, **no introducir hisopos, ganchos ni objetos** (destruyen la barrera lipídica del cerumen) y no limpiar en exceso el cerumen, que es protector. En nadadores con episodios recurrentes sirven las gotas acidificantes (ácido acético o alcohol boricado) después de cada baño. Se tratan además las dermatopatías de base (eccema, dermatitis seborreica), se revisa el uso de audífonos y, en el **diabético**, el control glicémico y la consulta precoz ante otalgia, por el riesgo de otitis externa maligna. 6.03.3.006



Otitis externa maligna: granulación en el conducto auditivo

El **lavado de oídos** es un procedimiento que el médico general debe **realizar**. Su indicación principal es el **tapón de cerumen** (hipoacusia de conducción, plenitud ótica) tras **ablandar el cerumen 3 a 5 días** con gotas cerumenolíticas (agua oxigenada diluida, carbonato de sodio o aceite). Técnica: agua **tibia a temperatura corporal (37 °C)**, porque el agua fría o caliente provoca vértigo calórico; jeringa de 50 mL o irrigador con punta blanda; traccionar el pabellón hacia **arriba y atrás** (adulto) o abajo y atrás (niño) y dirigir el chorro contra la **pared posterosuperior** del CAE, nunca directo al tímpano; secar después. 6.03.5.010

Contraindicaciones: perforación timpánica conocida o sospechada, antecedente de cirugía de oído o tubos de ventilación, otitis externa o media aguda, cuerpo extraño orgánico (semillas, legumbres; se hinchan con el agua), oído único funcional y dolor intenso. Las complicaciones son perforación timpánica, otitis externa, vértigo y acúfeno. Ante cualquier contraindicación se extrae el cerumen bajo visión directa (curetaje o aspiración) o se deriva.

6. INFECCIONES EN LA PERSONA CON DIABETES: DEL OÍDO AL PIE

Más allá de la otitis externa maligna, la diabetes expone a otras infecciones graves que el médico general debe reconocer. El **pie diabético infectado** (neuropatía + isquemia + hiperglicemia) se clasifica en leve (celulitis <2 cm), moderada (>2 cm o tejidos profundos) y grave (respuesta inflamatoria sistémica); la **osteomielitis** se sospecha con úlcera que *toca hueso* (probe-to-bone), úlcera extensa o crónica y se estudia con radiografía y VHS/PCR. Manejo inicial: **control glicémico, aseo y desbridamiento, descarga del pie**, cultivo de tejido profundo y antibiótico según gravedad (leve: amoxicilina-ácido clavulánico o cefalosporina oral; moderada a grave: hospitalizar con esquema endovenoso de amplio espectro). Se **deriva** para evaluación vascular, cirugía y podología; la prevención de la amputación es parte de la garantía GES de diabetes. 1.02.1.014

En el área ORL el equivalente de alarma es la **mucormicosis rinoorbitocerebral**, propia de la cetoacidosis y el mal control glicémico: dolor facial, escara negra en cornete o paladar, edema periorbitario y oftalmoplejía. Es una urgencia vital (desbridamiento quirúrgico + anfotericina B). Otras infecciones frecuentes en el diabético son la candidiasis orofaríngea y genital, la infección urinaria y la otitis externa maligna; todas se resuelven mejor con control metabólico estricto.



Mucormicosis en una mujer con diabetes: proptosis, edema facial unilateral y parálisis facial

7. OTOHEMATOMA Y SU DRENAJE

El **otohematoma** es la colección de sangre entre el pericondrio y el cartílago del pabellón auricular, secundaria a un **traumatismo contuso o cizallante** (luchadores, rugby, boxeo, golpes). Clínica: tumefacción violácea, fluctuante y dolorosa que **borra los relieves normales** del pabellón (hélix, antehélix, fosa triangular). Se debe sospechar en todo golpe de oreja con aumento de volumen; el diagnóstico es clínico. Si no se drena, el hematoma priva de irrigación al cartílago, que se necrosa y se reabsorbe o se fibrosa, dejando la deformidad en **«oreja en coliflor»**; además puede sobreinfectarse (pericondritis por *Pseudomonas*). **(ver Imagen 14.3C)** 6.03.2.014



Otohematoma del pabellón auricular

El **drenaje del otohematoma** es un procedimiento de nivel **derivar**, idealmente en las primeras 24 a 48 horas y siempre antes de 7 días: evacuación por aspiración con aguja (colecciones pequeñas y recientes) o por incisión, seguida de **vendaje compresivo** (rollos de algodón o dental, suturas colchonero transfixiantes) para evitar la reacumulación, y **antibiótico con cobertura antipseudomonas** (ciprofloxacino). Se reevalúa a las 24 a 48 horas por recidiva. El médico general sospecha, 6.03.5.005

protege el pabellón, indica analgesia y deriva a ORL o cirugía de forma oportuna; en deportistas de contacto se recomienda casco protector.

TABLA 14.3.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO COMPARATIVO DE INFECCIONES DEL OÍDO EXTERNO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PATOLOGÍA	FÁRMACOS DE ELECCIÓN	VÍA Y POSOLOGÍA	DURACIÓN Y MEDIDAS ADYUVANTES
Otitis Externa Difusa Leve	Solución ácida ótica (Ácido acético al 2%)	Gotas óticas: 3-4 gotas cada 8 horas	7 días · Restablecer pH ácido del CAE
Otitis Externa Difusa Moderada	Ciprofloxacino 0.3% + Dexametasona tópica	Gotas óticas: 3-4 gotas cada 8 a 12 horas	7 a 10 días · Aseo previo del conducto; calor seco
Otitis Externa con Celulitis	Ciprofloxacino oral + gotas tópicas	Ciprofloxacino 500 mg cada 12h oral + gotas	10 días · Monitoreo ambulatorio estrecho
Otitis Externa Maligna (OEM)	Ciprofloxacino EV o Ceftazidima EV	Ciprofloxacino 400 mg c/8-12h EV o Ceftazidima 2g c/8h EV	6 a 8 semanas continuas · Control cintigráfico / TAC

14.3. Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (OTITIS EXTERNA DIFUSA VS OTITIS EXTERNA MALIGNA EN DIABÉTICOS)

- La otitis externa difusa aguda (oído de nadador) se trata con aseo del CAE y gotas óticas de Ciprofloxacino; NO requiere antibióticos orales.
- La Otitis Externa Maligna es una osteomielitis de la base del cráneo causada por Pseudomonas aeruginosa en pacientes diabéticos descompensados.
- El VII par craneal (facial) es el nervio craneano que se compromete con mayor frecuencia en la otitis externa maligna.
- El tratamiento de la OEM requiere hospitalización y antibioticoterapia EV prolongada (Ciprofloxacino o Ceftazidima) durante 6 a 8 semanas.
- El dolor exquisito a la presión del trago (Signo del Trago +) y tracción del pabellón es característico de patología del CAE.
- El hallazgo físico patognomónico de la otitis externa maligna es el tejido de granulación en el piso del conducto auditivo externo.
- El estudio imagenológico de confirmación de OEM es el TAC de peñasco con contraste para evaluar osteólisis ósea.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

14.3

Un hombre de 74 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de evolución con mal control metabólico (última HbA1c de 10.2%), consulta en el servicio de urgencia por otalgia izquierda progresiva de 3 semanas de evolución, que se ha hecho intolerable en las últimas noches, impidiéndole dormir. Ha recibido dos ciclos de gotas óticas de polimixina-neomicina sin mejoría. Al examen físico se aprecia lúcido pero adolorido; presenta asimetría facial izquierda evidente con imposibilidad para ocluir el ojo izquierdo y borramiento del surco nasogeniano homolateral. A la otoscopía se observa conducto auditivo externo izquierdo con secreción purulenta fétida y una proliferación de tejido rojizo friable de granulación en el piso del CAE, en la unión osteocartilaginosa.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una Otitis Externa Maligna (OEM) o necrotizante izquierda complicada con parálisis facial periférica ipsilateral (compromiso del VII par craneal). Los factores de riesgo (adulto mayor con diabetes descompensada), el dolor nocturno severo refractario y el hallazgo patognomónico de tejido de granulación en el piso del CAE conforman el diagnóstico clínico clásico. La presencia de parálisis facial indica extensión ósea hacia el foramen estilomastoideo y empeora el pronóstico. La conducta de elección obligatoria es la hospitalización inmediata, solicitud de TAC de peñasco y base de cráneo con contraste para evaluar osteomielitis, toma de cultivo del tejido de granulación para Pseudomonas aeruginosa, optimización del control glicémico con insulina y el inicio urgente de Ciprofloxacino o Ceftazidima por vía endovenosa en dosis altas durante un mínimo de 6 a 8 semanas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.019

1. Un joven de 22 años, aficionado al surf, consulta por dolor intenso en el oído derecho de 48 horas de evolución, acompañado de sensación de oído tapado y prurito. No ha tenido fiebre ni síntomas respiratorios. Al examen físico, la movilización del pabellón auricular y la palpación del trago provocan un dolor muy intenso. La otoscopía revela edema circunferencial eritematoso del conducto auditivo externo con detritos blanquecinos abundantes, sin permitir ver con claridad el tímpano. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?

A) Amoxicilina con ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por vía oral por 10 días.
B) Aseo ótico y gotas óticas de ciprofloxacino con corticoide tópico por 7 a 10 días, asociado a analgesia oral.
C) Ciprofloxacino oral 500 mg cada 12 horas por 14 días y reposo laboral.
D) Lavado de oídos con abundante agua tibia a presión para despejar el conducto.
E) Hospitalización inmediata para administración de ceftriaxona endovenosa.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.019

2. ¿Cuál es el microorganismo causal más frecuente tanto de la otitis externa difusa aguda como de la otitis externa maligna necrotizante?

A) Staphylococcus epidermidis
B) Pseudomonas aeruginosa
C) Streptococcus pneumoniae
D) Haemophilus influenzae
E) Moraxella catarrhalis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.019

3. Una mujer de 78 años, diabética de larga data con mal apego al tratamiento, consulta por otalgia derecha intensa de predominio nocturno, refractaria a paracetamol y tramadol, asociada a otorrea purulenta fétida. A la otoscopía se evidencia marcado edema del CAE con presencia de tejido de granulación eritematoso en el piso del conducto en la unión osteocartilaginosa. Al examen neurológico presenta desviación de la comisura bucal hacia la izquierda y lagoftalmos derecho. ¿Cuál es el examen inicial de elección para evaluar la extensión ósea de este cuadro?

A) Radiografía simple de cráneo en proyección de Schüller.
B) Tomografía computarizada (TAC) de peñasco y base de cráneo con contraste.
C) Resonancia magnética nuclear de encéfalo sin contraste.
D) Ecografía de partes blandas de la región parotídea y retroauricular.
E) Audiometría tonal y potenciales evocados auditivos de tronco encefálico.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.019

4. ¿Cuál es la complicación neurológica por compromiso de pares craneales que se observa con mayor frecuencia en la evolución de la otitis externa maligna?

A) Parálisis del nervio hipogloso (XII par).
B) Parálisis del nervio facial (VII par).
C) Parálisis del nervio abducens (VI par).
D) Neuropatía del nervio trigémino (V par).
E) Parálisis del nervio accesorio espinal (XI par).

Más preguntas online de Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos →

14.4. Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.03.2.001 6.03.1.022 6.03.5.001

¿POR QUÉ?

La mastoiditis aguda es la complicación intratemporal supurativa más frecuente de la otitis media aguda en la infancia. Se produce cuando la infección de las celdas mastoideas destruye las trabéculas óseas (mastoiditis coalescente) y se abre paso hacia el periostio formando un absceso subperióstico. En el EUNACOM se evalúa de manera regular el reconocimiento del signo del pabellón despegado/empujado hacia adelante, el borramiento del surco retroauricular, la solicitud inmediata de TAC de peñasco y la hospitalización para antibióticos endovenosos y eventual mastoidectomía.

1. FISIOPATOLOGÍA DE LA MASTOIDITIS COALESCENTE

Toda otitis media aguda se acompaña de un grado variable de inflamación de la mucosa de las celdas mastoideas por continuidad anatómica a través del *aditus ad antrum*. Sin embargo, se denomina **Mastoiditis Aguda** propiamente tal a la progresión purulenta que genera **hiperpresión, necrosis isquémica y lisis de las trabéculas óseas mastoideas (mastoiditis coalescente)**. **(ver Imagen 14.4B)** 6.03.2.001

Los patógenos implicados son idénticos a los de la OMA: *Streptococcus pneumoniae* (el más agresivo y común), *Streptococcus pyogenes*, *Haemophilus influenzae* y *Staphylococcus aureus*. La acumulación de pus bajo presión puede romper la cortical externa del hueso temporal generando un **absceso subperióstico**, o extenderse hacia la fosa craneal posterior o media causando meningitis, absceso cerebral o **tromboflebitis séptica del seno lateral/sigmoide**. 6.03.2.001 6.03.1.022

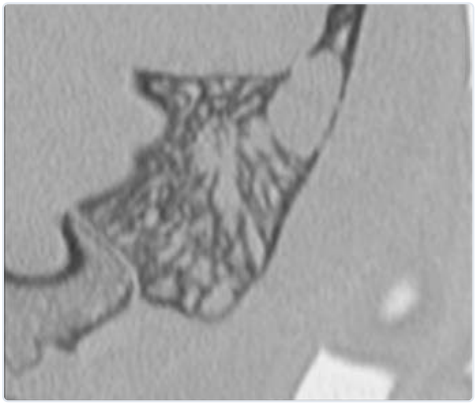
2. PRESENTACIÓN CLÍNICA CARDINAL: LA TRÍADA RETROAURICULAR

La mastoiditis aguda se observa con mayor frecuencia en niños menores de 2 años. La clínica se caracteriza por la reaparición o empeoramiento de fiebre alta, compromiso del estado general y dolor retroauricular pulsátil intenso tras un episodio reciente de OMA. 6.03.2.001

Al examen físico destacan tres signos patognomónicos: (1) **Eritema, edema y aumento de volumen doloroso sobre la región mastoidea**; (2) **Borramiento del surco retroauricular**; y (3) **Desplazamiento anteroinferior del pabellón auricular ('oreja despegada o en asa')**. A la otoscopía se confirma el abombamiento o perforación timpánica con otorrea purulenta profusa, asociado con frecuencia a la caída o abombamiento de la pared posterosuperior del conducto auditivo externo. **(ver Imagen 14.4A)**

3. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES Y TROMBOFLEBITIS DEL SENO LATERAL

Ante la sospecha clínica de mastoiditis aguda, el examen de elección indiscutido es el **TAC de peñasco y cerebro con contraste endovenoso**. El TAC permite confirmar la ocupación completa de las celdas mastoideas, la pérdida de las trabéculas óseas (coalescencia), la presencia de absceso subperióstico y descartar complicaciones intracraneales. 6.03.2.001



Mastoiditis coalescente en TC de peñasco

La **tromboflebitis séptica del seno lateral (seno sigmoide)** es una complicación temible caracterizada por picos febriles en agujas ('fiebre en picos de sierra'), calofríos intensos, cefalea y signos de hipertensión endocraneana. En el TAC o angio-TAC con contraste se evidencia el clásico **signo del delta vacío** (defecto de llene central en el seno venoso rodeado de realce dural). 6.03.2.001 6.03.1.022

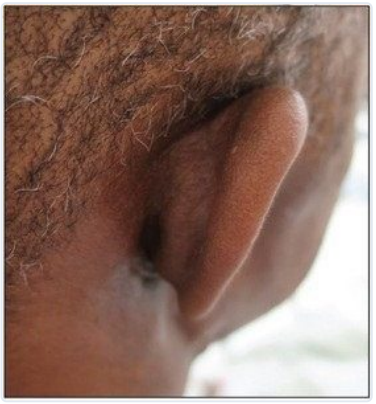
4. MANEJO TERAPÉUTICO HOSPITALARIO Y CRITERIOS QUIRÚRGICOS

El manejo de la mastoiditis aguda exige **hospitalización inmediata**. Las medidas fundamentales son: (1) **Antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro**: de primera línea **Ceftriaxona (100 mg/kg/día EV)** asociada a Clindamicina (o Vancomicina si hay sospecha de neumococo resistente o S. aureus meticilino-resistente); (2) **Miringotomía descompresiva** con aspiración del pus de oído medio para cultivo y descompresión; 6.03.2.001 6.03.1.022 6.03.5.001

Si el paciente presenta un **absceso subperióstico fluctuante documentado, o no responde tras 24 a 48 horas de antibióticos endovenosos, o presenta complicaciones neurológicas**, está indicada la intervención quirúrgica inmediata por otorrinolaringólogo mediante **mastoidecmotía simple (cortical) con drenaje de colecciones**.

5. ABSCESO MASTOÍDEO: CONDUCTA INICIAL Y DERIVACIÓN PARA DRENAJE

El **drenaje del absceso mastoídeo** es un procedimiento que se **deriva** a especialista. La sospecha clínica es la **mastoiditis aguda con absceso subperióstico**: tumefacción fluctuante, dolorosa y eritematosa retroauricular, con **pabellón desplazado hacia adelante y afuera**, fiebre y antecedente de otitis media. La conducta del médico general es **hospitalizar o trasladar de urgencia**, iniciar antibiótico endovenoso (ceftriaxona), solicitar TAC de oídos con contraste si hay signos de complicación (cefalea intensa, signos meníngeos, parálisis facial, vértigo) y no puncionar ni incidir la colección en el nivel primario. 6.03.5.001



Mastoiditis: pabellón desplazado hacia adelante y edema retroauricular

El especialista realiza **miringotomía con colocación de tubo de ventilación** y, en el absceso subperióstico o la mastoiditis coalescente, **mastoidectomía** con drenaje de la colección. Las complicaciones que justifican la urgencia son la trombosis del seno sigmoides, el absceso cerebeloso o temporal, la meningitis y la parálisis facial.



A. PABELLÓN DESPEGADO

B. TAC: MASTOIDITIS COALESCENTE

Imagen 14.4

FIGURA 14.4 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA URGENTE EN MASTOIDITIS AGUDA PEDIÁTRICA

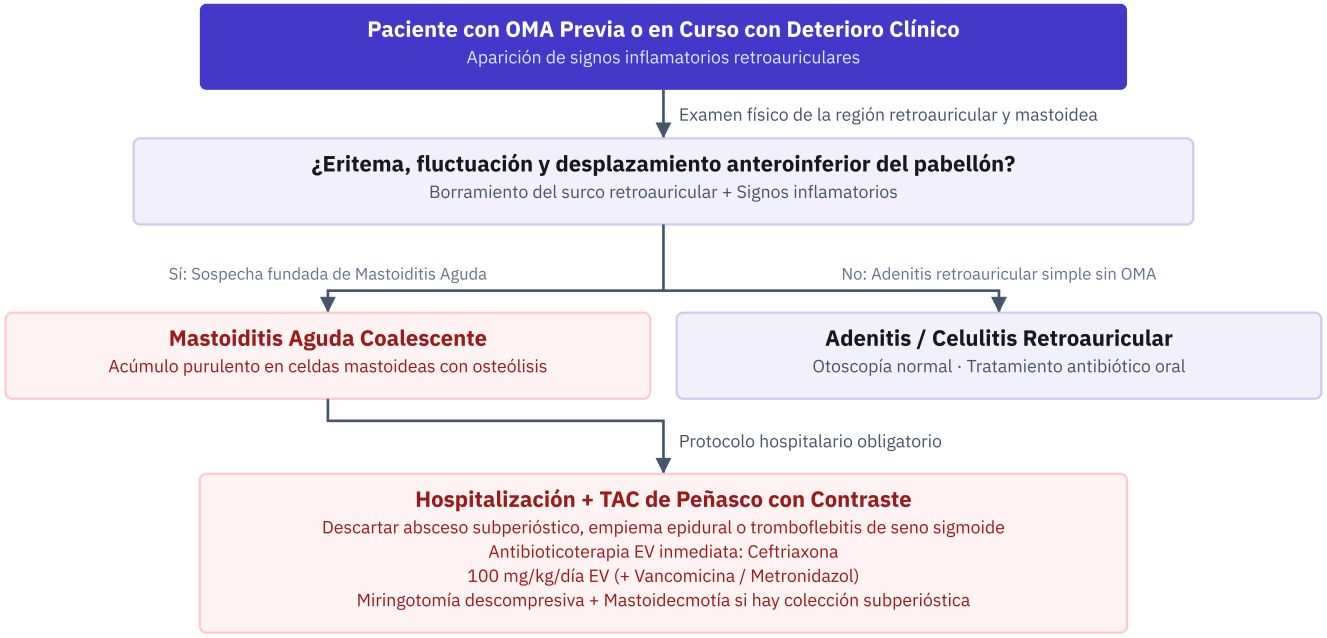


TABLA 14.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: MASTOIDITIS AGUDA VS ADENITIS RETROAURICULAR

6.03.2.001, 6.03.1.022, 6.03.5.001

CRITERIO DE EVALUACIÓN	MASTOIDITIS AGUDA COALESCENTE	ADENITIS RETROAURICULAR / CELULITIS
Otoscopía	OMA evidente: tímpano abombado o perforado con otorrea	Otoscopía rigurosamente normal (tímpano sano)
Surco Retroauricular	Borrado por el edema y colección subperióstica	Respetado; el ganglio es móvil o delimitado sobre el surco
Posición del Pabellón	Desplazado hacia adelante y hacia abajo ('oreja en asa')	Posición anatómica normal del pabellón auricular
TAC de Peñasco	Pérdida de trabéculas óseas y coalescencia mastoidea	Celdas mastoideas bien aireadas sin osteólisis
Conducta Médica	Hospitalización + Ceftriaxona EV + TAC de peñasco urgente	Ambulatorio: antibióticos orales (Cloxacilina o Cefadroxilo)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 14.4

Un lactante de 16 meses es llevado al servicio de urgencia por su madre por presentar fiebre alta de hasta 39.5°C, irritabilidad y llanto continuo de 48 horas de evolución. La madre refiere que hace 8 días completó un ciclo de 7 días de amoxicilina por otitis media aguda con mejoría transitoria. Al examen físico, el niño se encuentra febril, decaído. En la región retroauricular derecha se palpa una masa intensamente eritematosa, empastada, caliente y fluctuante al tacto, con borramiento del surco retroauricular y desplazamiento anteroinferior del pabellón auricular derecho. La otoscopía derecha muestra conducto estrechado por edema posterosuperior y membrana timpánica eritematosa y abombada.

Conducta oficial. El cuadro clínico reúne la totalidad de los elementos diagnósticos de una Mastoiditis Aguda derecha coalescente con probable absceso subperióstico, que se desarrolló como complicación de una OMA mal controlada. El borramiento del surco retroauricular junto a la fluctuación local y el desplazamiento hacia adelante y abajo de la oreja son patognomónicos. La conducta inmediata mandatoria es la hospitalización urgente en pediatría, la toma de hemocultivos, la solicitud de un TAC de peñascos y encéfalo con contraste para confirmar la colección ósea y descartar trombosis de seno sigmoide o empiema, y el inicio inmediato de antibioticoterapia parenteral con Ceftriaxona endovenosa en dosis meningeas (100 mg/kg/día) asociada a clindamicina o vancomicina. La presencia de fluctuación obliga a interconsulta urgente a ORL para drenaje quirúrgico mediante miringotomía y mastoidectomía.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La mastoiditis aguda es la complicación intratemporal más común de la OMA en la infancia.
- La tríada clínica definitoria es eritema/dolor retroauricular, borramiento del surco retroauricular y desplazamiento del pabellón auricular hacia adelante.
- Toda sospecha de mastoiditis aguda exige hospitalización inmediata.
- El TAC de peñasco con contraste es el patrón de oro imagenológico para confirmar la coalescencia ósea y descartar complicaciones endocraneales.
- El tratamiento inicial consiste en Ceftriaxona endovenosa en dosis altas (100 mg/kg/día) más miringotomía descompresiva.
- La presencia de absceso subperióstico fluctuante o falta de respuesta a antibióticos a las 24-48h indica mastoidectomía quirúrgica urgente.
- La tromboflebitis del seno sigmoide se sospecha ante fiebre en picos de sierra y cefalea; en el TAC muestra el signo del delta vacío.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.001

1. Un niño de 2 años presenta fiebre de 39.3°C, irritabilidad y tumefacción retroauricular izquierda dolorosa y eritematosa que desplaza el pabellón auricular hacia adelante y borra el surco retroauricular. La otoscopía muestra tímpano izquierdo abombado e hiperémico. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica inicial más adecuada?

A) Indicar amoxicilina con ácido clavulánico oral por 14 días y citar a control ambulatorio en 48 horas.
B) Solicitar ecografía de partes blandas y dar de alta con antiinflamatorios no esteroidales.
C) Hospitalizar de inmediato, solicitar TAC de peñasco con contraste e iniciar ceftriaxona endovenosa.
D) Realizar drenaje por punción ambulatoria en sala de procedimientos e indicar cefadroxilo oral.
E) Instilar gotas óticas de ciprofloxacino y solicitar radiografía de cráneo simple.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.022

2. ¿Cuál de los siguientes signos imagenológicos en el angio-TAC de cráneo o TAC con contraste es característico de la trombosis séptica del seno sigmoide como complicación de una otitis media o mastoiditis?

A) Signo de la cuerda en la arteria cerebral media.
B) Signo del delta vacío (defecto de llene central en el seno venoso dural).
C) Realce leptomeníngeo difuso en base de cráneo sin colecciones.
D) Hiperdensidad espontánea del clivus y del agujero magno.
E) Neumoencéfalo espontáneo en cisterna perimesencefálica.

Más preguntas online de Complicaciones de Otitis →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 14.1 A 14.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	El abombamiento de la membrana timpánica es el signo otoscópico cardinal más específico...	**El tratamiento antimicrobiano de primera línea es la Amoxicilina oral a 80-90 mg/kg/día...**	El cuadro clínico y otoscópico es patognomónico de una Otitis Media Aguda (OMA) derecha...
Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa	La OME es la causa más común de hipoacusia conductiva en preescolares y se maneja con...	**En OME no deben indicarse antibióticos, antihistamínicos ni corticoides de rutina.**	—
Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos	La otitis externa difusa aguda (oído de nadador) se trata con aseo del CAE y gotas...	**El dolor exquisito a la presión del trago (Signo del Trago +) y tracción del pabellón...**	El hallazgo físico patognomónico de la otitis externa maligna es el tejido de...
Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis	La mastoiditis aguda es la complicación intratemporal más común de la OMA en la...	**La tríada clínica definitoria es eritema/dolor retroauricular, borramiento del surco...**	El TAC de peñasco con contraste es el patrón de oro imagenológico para confirmar la...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El abombamiento de la membrana timpánica es el signo otoscópico cardinal más específico para el diagnóstico de OMA supurada.

El tratamiento antimicrobiano de primera línea es la Amoxicilina oral a 80-90 mg/kg/día dividida cada 12 horas.

Si no existe mejoría clínica tras 48 a 72 horas de amoxicilina, la conducta mandataria es cambiar a Amoxicilina + Ácido...

La presencia de otorrea espontánea calma transitoriamente la otalgia debido a la descompresión mecánica del tímpano.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El tratamiento antimicrobiano de primera línea es la Amoxicilina oral a 80-90 mg/kg/día dividida cada 12 horas.
- Si no existe mejoría clínica tras 48 a 72 horas de amoxicilina, la conducta mandataria es cambiar a Amoxicilina + Ácido Clavulánico (80-90 mg/kg/día).
- En OME no deben indicarse antibióticos, antihistamínicos ni corticoides de rutina.
- La OMC simple se caracteriza por perforación timpánica central que respeta el annulus, con otorrea no fétida.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El abombamiento de la membrana timpánica es el signo otoscópico cardinal más específico para el diagnóstico de OMA...	Tema 14.1 →
La OME es la causa más común de hipoacusia conductiva en preescolares y se maneja con conducta expectante durante...	Tema 14.2 →
La otitis externa difusa aguda (oído de nadador) se trata con aseo del CAE y gotas óticas de Ciprofloxacino; NO...	Tema 14.3 →
La mastoiditis aguda es la complicación intratemporal más común de la OMA en la infancia.	Tema 14.4 →

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

AUDIOLOGÍA & TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO

4	12	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
14.5	Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)	25
14.6	Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia	28
14.7	Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	32
14.8	Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt	37

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
6.03.4.006, 6.03.4.008, 6.03.1.007, 6.03.1.008, 2.01.1.101	Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones	Específico	Inicial	Completo
6.03.2.018, 6.03.1.008, 6.03.2.006, 6.03.3.007, 6.03.1.031, 6.03.2.016, 6.03.4.011	Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia	Específico	Inicial	Específico
6.03.1.029, 6.03.2.017, 1.10.1.025	Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	Específico	Inicial	Específico
1.10.1.016, 1.10.1.009	Parálisis Facial Periférica	Específico	Inicial	Completo

BLOQUE 02 · AUDIOLOGÍA & TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
12 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- En el Test de Weber, el sonido lateraliza al oído enfermo en hipoacusia de conducción y al oído sano en hipoacusia sensorioneural.
- En el Test de Rinne, un resultado negativo (VO > VA) es patognomónico de hipoacusia de conducción.
- En la hipoacusia sensorioneural, el Test de Rinne sigue siendo positivo (VA > VO).
- La brecha u oscilación óseo-aérea (Gap ≥ 15 dB) en la audiometría tonal confirma compromiso mecánico del oído externo o medio.
- La curva B (plana) en la timpanometría es característica de Otitis Media con Efusión (líquido en la caja timpánica).
- La curva C (presión negativa < -100 daPa) es diagnóstica de disfunción de la trompa de Eustaquio.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones	EUNACOM Diciembre 2024 · #54 · EUNACOM Julio 2024 · #35 · EUNACOM Enero 2023 · #136
Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia	EUNACOM Julio 2025 · #123 · EUNACOM Julio 2024 · #90 · EUNACOM Enero 2023 · #138 · EUNACOM Diciembre 2022 · #110
Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	EUNACOM Julio 2025 · #154 · EUNACOM Julio 2024 · #101 · EUNACOM Enero 2023 · #137 · EUNACOM Diciembre 2022 · #168
Parálisis Facial Periférica	EUNACOM Julio 2024 · #5

14.5. Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.03.4.006 | 6.03.4.008 | 6.03.1.007 | 6.03.1.008 | 2.01.1.101

¿POR QUÉ?

La evaluación funcional auditiva es un pilar evaluado con frecuencia fija en el EUNACOM. La distinción semiológica entre una hipoacusia de conducción (oído externo/medio) y una hipoacusia sensorioneural (cóclea/nervio VIII) mediante diapasones de 512 Hz (Rinne y Weber) es una competencia clínica elemental que no tolera errores conceptuales. Asimismo, la interpretación de la audiometría tonal (gap óseo-aéreo) y las curvas timpanométricas de Jerger permite diagnosticar de forma precisa patologías como OME, otoesclerosis y disfunción de la trompa de Eustaquio.

1. ACUMETRÍA CLÍNICA CON DIAPASONES: TEST DE WEBER Y TEST DE RINNE

La **acumetría** utiliza un diapasón de 512 Hz (o 256 Hz) para diferenciar al lado de la cama del paciente una hipoacusia de conducción o transmisión de una sensorioneural o de percepción: 6.03.1.007 | 6.03.1.008 | 2.01.1.101

Test de Weber: Se coloca la base del diapasón vibrando en la línea media del cráneo (frente, vértex o incisivos superiores). En audición normal o hipoacusia simétrica, el sonido se percibe centrado en la línea media (sin lateralización). En **hipoacusia de conducción unilateral**, el sonido **lateraliza hacia el oído enfermo** (debido a que la alteración mecánica atenúa el ruido ambiente enmascarante y concentra la vibración ósea). En **hipoacusia sensorioneural unilateral**, el sonido **lateraliza hacia el oído sano** (porque la cóclea del oído afectado no es capaz de transducir la vibración). **(ver Imagen 14.5)**

Test de Rinne: Compara la audición por vía aérea (VA) frente al conducto auditivo externo con la audición por vía ósea (VO) sobre la apófisis mastoides. El **Rinne Positivo (VA > VO)** es el patrón normal (la vía aérea es fisiológicamente el doble de eficiente) y también se observa en la hipoacusia sensorioneural pura. El **Rinne Negativo (VO > VA)** ocurre cuando el sonido se oye mejor o por más tiempo en el hueso mastoideo que en el aire, lo cual es **patognomónico de hipoacusia de conducción**.

2. AUDIOMETRÍA TONAL: UMBRALES AUDITIVOS Y GAP ÓSEO-AÉREO

La **audiometría tonal liminar** cuantifica el umbral auditivo en decibeles (dB HL) a través de frecuencias entre 125 y 8000 Hz, evaluando por separado la vía aérea (auriculares) y la vía ósea (vibrador mastoideo): 6.03.4.006 | 2.01.1.101

Audición Normal: Umbrales de ambas vías entre 0 y 20-25 dB HL sin separación.

Hipoacusia de Conducción: La vía ósea está normal (≤ 20 dB), pero la vía aérea está descendida (> 20 dB). La diferencia entre ambas curvas se denomina **Gap o brecha óseo-aérea (≥ 15 dB)**, indicando patología obstructiva mecánica en CAE u oído medio (cerumen, OME, perforación, otoesclerosis). 6.03.4.006 | 6.03.1.007 | 2.01.1.101

Hipoacusia Sensorioneural: Ambas curvas (ósea y aérea) están descendidas paralelamente, superpuestas o con una diferencia menor a 10 dB (sin gap). Indica lesión en las células ciliadas del órgano de Corti o en el nervio coclear (presbiacusia, hipoacusia súbita, ototoxicidad, neurinoma del acústico). 6.03.4.006 | 6.03.1.008 | 2.01.1.101

Hipoacusia Mixta: Ambas curvas están descendidas, pero persiste un gap óseo-aéreo significativo (≥ 15 dB). 6.03.4.006 | 6.03.1.007 | 2.01.1.101

3. IMPEDANCIOMETRÍA Y CURVAS TIMPANOMÉTRICAS DE JERGER

La **impedanciometría** evalúa la compliance o distensibilidad del sistema tímpano-oscicular en respuesta a variaciones de presión de aire aplicadas en el CAE, generando el **timpanograma**, clasificado según James Jerger: 6.03.4.008

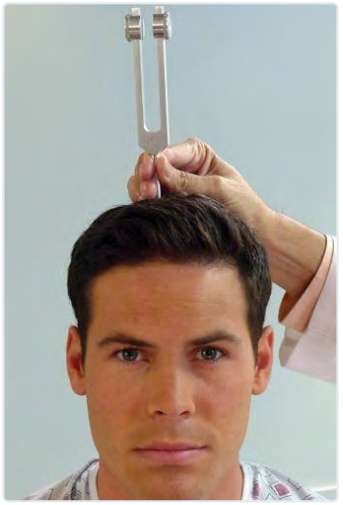
Curva A (Normal): Pico de compliance normal (0.3 a 1.6 ml) centrado entre -100 y +50 daPa. Oído medio sano y adecuadamente aireado.

Curva As (Shallow/Rígida): Pico centrado en 0 daPa pero de amplitud marcadamente reducida (< 0.3 ml). Típica de rigidez del sistema de huesecillos: **otoesclerosis** o timpanoesclerosis extensa.

Curva Ad (Deep/Flácida): Pico centrado pero de amplitud infinita o excesiva (> 1.6 ml). Indica **disyunción de la cadena oscicular** o membrana timpánica monomérica hiperflácida.

Curva B (Plana / Sin pico): No hay punto de máxima distensibilidad. El hallazgo clásico es **otitis media con efusión (líquido seroso retrotimpánico)**. Si el volumen del conducto es anormalmente alto (> 2.5 ml), indica perforación timpánica amplia o colleras permeables.

Curva C (Presión negativa): Pico de distensibilidad desplazado hacia presiones marcadamente negativas (< -100 a -150 daPa). Diagnóstica de **disfunción de la trompa de Eustaquio** (obstrucción tubárica).



PRUEBA DE WEBER

Imagen 14.5

FIGURA 14.5 · ALGORITMO DE INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA DE DIAPASONES, AUDIOMETRÍA Y TIMPANOMETRÍA

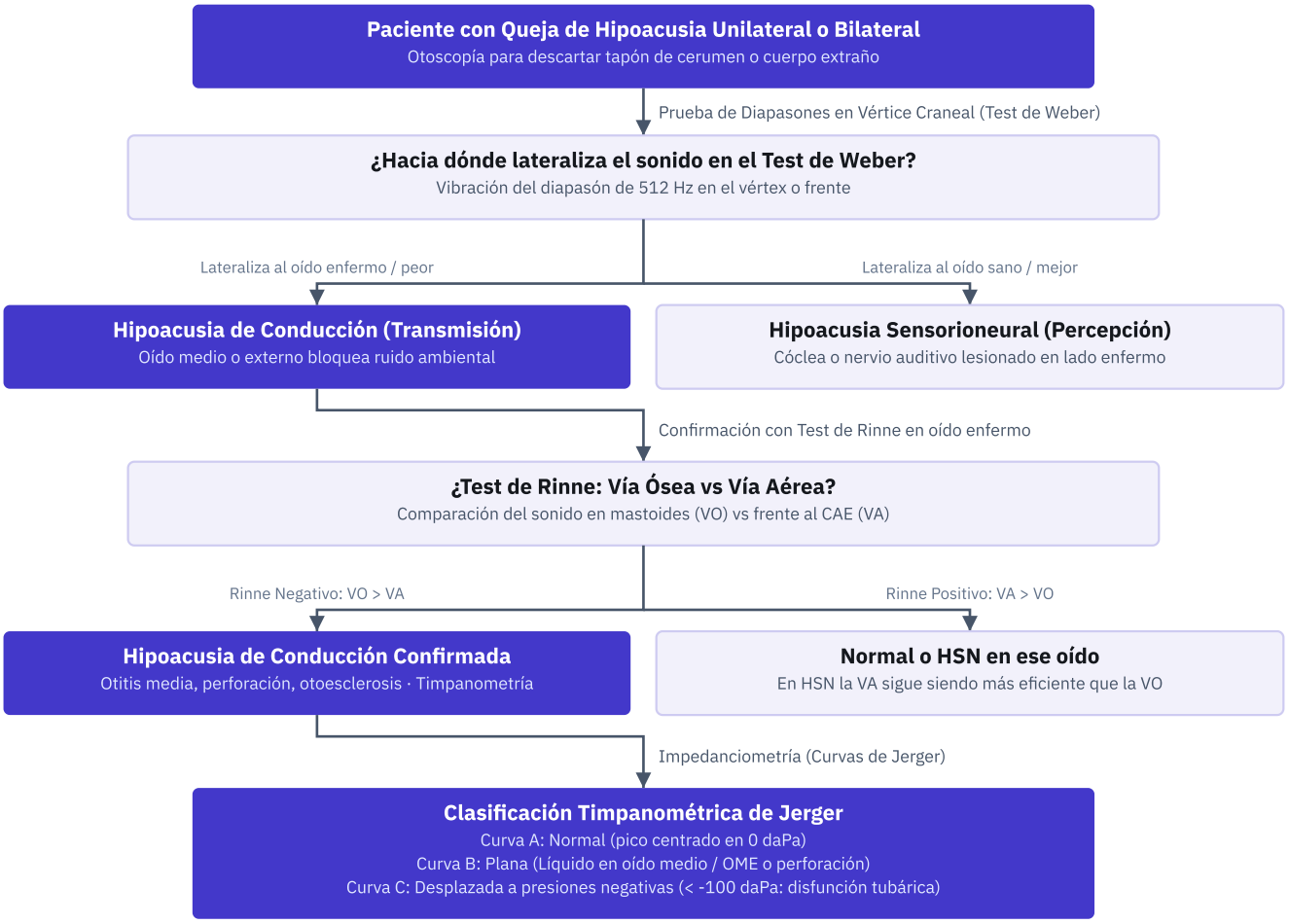


TABLA 14.5 · SÍNTESIS SEMIOLOGÍA DE PRUEBAS AUDITIVAS: DIAPASONES, AUDIOMETRÍA Y TIMPANOMETRÍA `6.03.4.006, 6.03.4.008, 6.03.1.007, 6.03.1.008, 2.01.1.101`

PARÁMETRO / PRUEBA	AUDICIÓN NORMAL	HIPOACUSIA DE CONDUCCIÓN	HIPOACUSIA SENSORIONEURAL
Test de Weber	Indiferente / Centrado en línea media	Lateraliza al oído enfermo (peor audición)	Lateraliza al oído sano (mejor audición)
Test de Rinne	Positivo bilateral (VA > VO)	Negativo en oído enfermo (VO > VA)	Positivo en oído enfermo (VA > VO)
Audiometría Tonal	Ambas curvas ≤ 20 dB HL	Vía ósea normal + Vía aérea descendida (Gap ≥ 15 dB)	Ambas curvas descendidas juntas (Sin Gap)
Timpanograma Típico	Curva A de Jerger (Pico centrado en 0)	Curva B (plana por líquido) o Curva C (tubárica) o As	Curva A de Jerger rigurosamente normal
Reflejo Estapedial	Presente bilateralmente	Ausente al estimular el oído con patología de conducción	Presente si HSN es leve-moderada (con reclutamiento)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 14.5

Una mujer de 34 años, previamente sana y sin antecedentes de otorrea ni trauma, consulta por hipoacusia progresiva del oído derecho de 1 año de evolución, que empeoró tras el parto de su segundo hijo. No presenta dolor ni acúfenos pulsátiles. Al examen otoscópico, ambos conductos auditivos externos están limpios y las membranas timpánicas son transparentes, íntegras y normales. Al examen con diapasón de 512 Hz, la prueba de Weber lateraliza claramente hacia el oído derecho. La prueba de Rinne es negativo en el oído derecho (VO > VA) y positivo en el oído izquierdo (VA > VO). El timpanograma muestra una curva As en el oído derecho.

Conducta oficial. Los hallazgos semiológicos con diapasón demuestran de forma inequívoca una hipoacusia de conducción del oído derecho: el Weber lateraliza al oído afectado (derecho) y el Rinne es negativo (la audición por vía ósea sobrepasa a la aérea por bloqueo de la transmisión en el oído medio). Dado que la otoscopía es rigurosamente normal (tímpano sano sin perforación ni líquido) y la paciente es una mujer joven cuyo cuadro progresó en el puerperio, asociada a una curva timpanométrica As (rigidez de la cadena oscicular), el diagnóstico más probable es una Otoesclerosis con fijación de la platina del estribo a la ventana oval. La conducta médica es solicitar audiometría tonal confirmatoria y derivar a ORL para estudio y eventual estapedostomía quirúrgica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En el Test de Weber, el sonido lateraliza al oído enfermo en hipoacusia de conducción y al oído sano en hipoacusia sensorioneural.
- En el Test de Rinne, un resultado negativo (VO > VA) es patognomónico de hipoacusia de conducción.
- En la hipoacusia sensorioneural, el Test de Rinne sigue siendo positivo (VA > VO).
- La brecha u oscilación óseo-aérea (Gap ≥ 15 dB) en la audiometría tonal confirma compromiso mecánico del oído externo o medio.
- La curva B (plana) en la timpanometría es característica de Otitis Media con Efusión (líquido en la caja timpánica).
- La curva C (presión negativa < -100 daPa) es diagnóstica de disfunción de la trompa de Eustaquio.
- La curva As (baja compliance) con otoscopía normal en mujer joven orienta fuertemente a Otoesclerosis.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.008

1. Un paciente consulta por hipoacusia en el oído izquierdo. Al examen con diapasón de 512 Hz, la prueba de Weber lateraliza hacia el oído derecho y la prueba de Rinne es positiva bilateralmente (VA > VO en ambos oídos). ¿A cuál de los siguientes diagnósticos orienta este patrón semiológico?

A) Hipoacusia de conducción del oído izquierdo.
B) Hipoacusia sensorioneural del oído izquierdo.
C) Hipoacusia de conducción del oído derecho.
D) Audición perfectamente normal en ambos oídos.
E) Tapón de cerumen ocluyente en el conducto auditivo izquierdo.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.4.008

2. ¿Cuál de las siguientes curvas de la clasificación de Jerger en la timpanometría se asocia de forma característica a la presencia de líquido seroso intratimpánico en la otitis media con efusión (OME)?

A) Curva A (pico centrado a 0 daPa con amplitud normal).
B) Curva As (amplitud disminuida con presión normal).
C) Curva B (curva aplanada sin punto de máxima compliance).
D) Curva C (pico desplazado a presiones negativas menores a -100 daPa).
E) Curva Ad (amplitud muy aumentada por discontinuidad de cadena).

Más preguntas online de Evaluación Auditiva →

14.6. Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.03.2.018 | 6.03.1.008 | 6.03.2.006 | 6.03.3.007 | 6.03.1.031 | 6.03.2.016 | 6.03.4.011

¿POR QUÉ?

La Hipoacusia Sensorioneural Súbita (HSNS) idiopática es una de las verdaderas emergencias de la especialidad otorrinolaringológica: el pronóstico funcional de recuperación auditiva depende directamente de la precocidad con que se instaure la corticoterapia oral en altas dosis (dentro de los primeros 7 a 14 días). El examen EUNACOM castiga severamente el error de confundir una HSNS con un 'oído tapado por cerumen' o 'catarro tubárico' y diferir el tratamiento. Asimismo, la presbiacusia senil se evalúa como la patología auditiva más prevalente del adulto mayor en el régimen GES.

1. HIPOACUSIA SENSORIONEURAL SÚBITA (HSNS): DEFINICIÓN Y URGENCIA MÉDICA

La **Hipoacusia Sensorioneural Súbita (HSNS)** se define formalmente según criterios de consenso internacional como una **disminución de la audición de tipo sensorioneural de al menos 30 dB en al menos tres frecuencias audiométricas consecutivas, instaurada en un período menor a 72 horas**. **(ver Imagen 14.6B)** 6.03.2.018 6.03.1.008

En más del 90% de los casos es idiopática, postulándose mecanismos virales (reactivación de virus herpes simplex en la cóclea), microvasculares (isquemia o microtrombosis de la arteria auditiva interna/laberíntica) o fenómenos inmunomediados. Afecta habitualmente a un solo oído (98% unilateral). El paciente relata despertar con el oído 'ensordecido', acompañado de un acúfeno agudo intenso de tono agudo y sensación de taponamiento o plenitud ótica, asociándose a inestabilidad o vértigo leve en 30-40% de los casos. 6.03.2.018

2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y ERROR FRECUENTE EN URGENCIA

El **error más grave y frecuente en la atención primaria** es atribuir la hipoacusia súbita a un tapón de cerumen 'invisible' o a una disfunción tubárica por resfriado, indicando lavados de oído o descongestionantes y postergando la evaluación audiológica. Esto hace perder la ventana de oportunidad terapéutica, resultando en sordera neurosensorial definitiva e irreversible. 6.03.2.018

Al examen físico, la **otoscopía es rigurosamente normal**. La prueba de diapasones revela **Weber lateralizado hacia el oído sano** y **Rinne positivo en el oído enfermo (VA > VO)**. Toda sospecha exige audiometría urgente en las primeras 24-48 horas. Una vez estabilizado el paciente, debe realizarse una **Resonancia Magnética de conducto auditivo interno y ángulo pontocerebeloso** para descartar de forma fehaciente un *Schwannoma vestibular (neurinoma del acústico)*, presente en el 1 al 3% de los casos. **(ver Imagen 14.6A)** 6.03.2.018 6.03.4.011

TABLA 14.6.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HIPOACUSIA SÚBITA VS TRAUMA ACÚSTICO VS PRESBIACUSIA 6.03.2.018, 6.03.1.008, 6.03.2.006, 6.03.3.007, 6.03.1.031, 6.03.2.016, 6.03.4.011

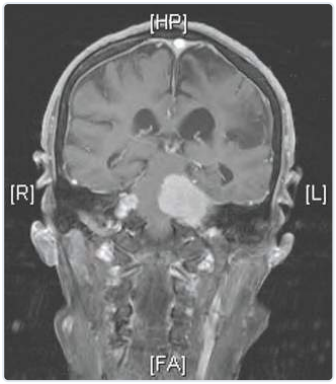
ENTIDAD CLÍNICA	ETIOLOGÍA / FISIOPATOLOGÍA	PATRÓN AUDIOMÉTRICO TÍPICO	TRATAMIENTO / COBERTURA
Hipoacusia Sensorioneural Súbita	Idiopática (viral / microvascular) · Lesión coclear aguda	Caída HSN ≥ 30 dB en ≥ 3 frecuencias consecutivas unilateral	URGENCIA: Prednisona oral 1 mg/kg/día x 10-14 días precoz
Trauma Acústico Crónico	Exposición ocupacional repetida a ruido industrial > 85 dB	Muesca o escotoma sensorial selectivo en frecuencia 4000 Hz	Prevención: Protectores auditivos; daño ya instalado es irreversible
Presbiacusia del Adulto Mayor	Envejecimiento y degeneración de células ciliadas y estría vascular	HSN bilateral y simétrica descendente en frecuencias agudas	Garantía GES en ≥ 65 años: Implementación de audífonos
Neurinoma del Acústico (VIII)	Schwannoma benigno del nervio vestibular en el CAI	HSN unilateral progresiva con discriminación muy deteriorada	RMN con gadolinio · Microcirugía o radiocirugía estereotáxica

14.6. Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TERAPIA CON CORTICOIDES Y FACTORES PRONÓSTICOS

El **único tratamiento con evidencia sólida de eficacia es la corticoterapia precoz en dosis altas**. Se debe indicar de inmediato: **Prednisona oral a 1 mg/kg/día (máximo 60 mg/día) durante 10 a 14 días**, seguido de una pauta de descenso progresivo en 7 a 10 días. Si existen contraindicaciones sistémicas para corticoides orales (diabetes lábil, úlcera péptica activa, hipertensión severa refractaria) o si la respuesta es incompleta, el especialista ORL aplica **inyecciones intratimpánicas de dexametasona o metilprednisolona** a través de la membrana timpánica. 6.03.2.018

Los factores de mal pronóstico son: retraso en el inicio del tratamiento (> 14 días), hipoacusia profunda o cofosis inicial (> 90 dB), edad avanzada (> 65 años), curva audiométrica descendente en frecuencias agudas y presencia de vértigo severo asociado.



A. SCHWANNOMA VESTIBULAR EN RM



B. AUDÍFONO RETROAURICULAR

Imagen 14.6

FIGURA 14.6 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE URGENCIA EN HIPOACUSIA SENSORIONEURAL SÚBITA

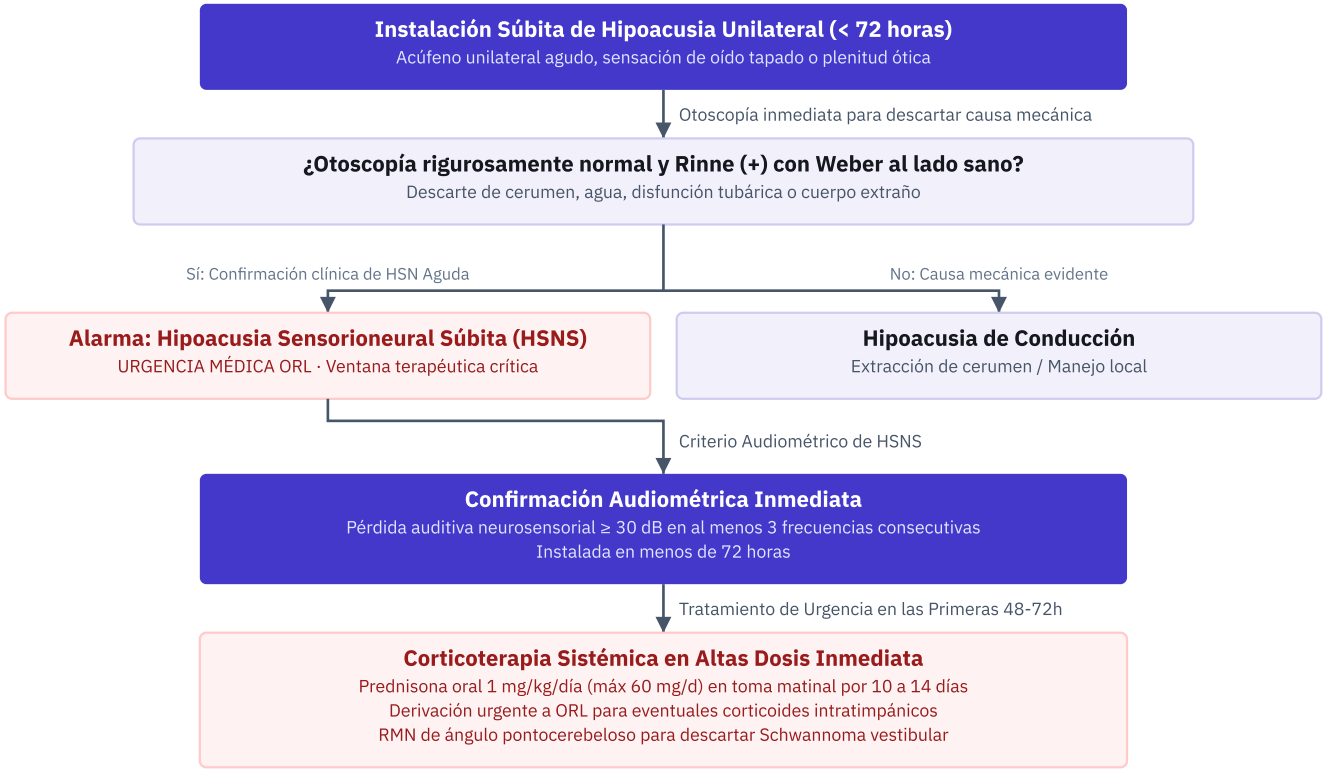


TABLA 14.6.B · ESTRATIFICACIÓN DE GRAVEDAD Y PRONÓSTICO EN HIPOACUSIA SENSORIONEURAL SÚBITA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRADO DE PÉRDIDA AUDITIVA	UMBRAL PROMEDIO TONAL	TASA DE RECUPERACIÓN CON CORTICOIDES	CONDUCTA TERAPÉUTICA INMEDIATA
Leve a Moderada	26 a 55 dB HL	Alta (70-80% recuperación funcional)	Prednisona oral 1 mg/kg/día en monoterapia x 14 días
Severa	56 a 89 dB HL	Intermedia (40-50% con tratamiento precoz)	Prednisona oral + Derivación precoz para rescate intratimpánico
Profunda / Cofosis	≥ 90 dB HL (anacusia funcional)	Baja (< 20-30%) · Alto riesgo de secuela permanente	Corticoides orales + Inyecciones intratimpánicas urgentes + RMN

14.6. Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TRAUMA ACÚSTICO Y PRESBIACUSIA: PERFIL AUDIOMÉTRICO Y GES

Trauma Acústico Agudo vs Crónico: El trauma acústico agudo resulta de una exposición breve a un ruido de alta intensidad (> 140 dB, ej. explosión o disparo), causando rotura de uniones ciliares o desprendimiento del órgano de Corti con acúfeno agudo permanente. El **trauma acústico crónico (hipoacusia laboral por ruido)** se genera por exposición prolongada a ruidos industriales (> 85 dB); su sello patognomónico en la audiometría es una **muesca o escotoma acústico simétrico a los 4000 Hz** (con recuperación parcial a los 8000 Hz). 6.03.1.008 6.03.2.006 6.03.3.007

Presbiacusia: Es el deterioro fisiológico coclear asociado a la edad (> 65 años), con degeneración de células ciliadas basales y atrofia de la estría vascular. Se caracteriza por una **hipoacusia sensorioneural bilateral, simétrica, progresiva, de predominio en frecuencias agudas (3000-8000 Hz)**. La queja principal es: *'escucho que me hablan, pero no entiendo lo que dicen'* (marcada alteración en la discriminación del lenguaje en ambientes ruidosos). En Chile, es una **patología con Garantía Explícita en Salud (GES N° 56)** para personas de 65 años y más, garantizando la entrega e implementación de **audífonos bilaterales** y rehabilitación auditiva. 6.03.1.008

5. TINITUS: ENFOQUE DEL ACÚFENO

El **tinitus (acúfeno)** es la percepción de un sonido sin fuente externa. Se distingue el **subjetivo** (el 95 %, solo lo percibe el paciente: hipoacusia neurosensorial, presbiacusia, trauma acústico, Ménière, ototóxicos como AAS en dosis altas, aminoglucósidos, furosemida y cisplatino, cerumen, otosclerosis) del **objetivo**, audible por el examinador. El tinitus **pulsátil** (sincrónico con el pulso) orienta a causa vascular: tumor glómico, estenosis carotídea, malformación arteriovenosa, hipertensión intracraneal idiopática; el tinitus «de clic» sugiere mioclonías del paladar o del estapedio. 6.03.1.031

Manejo inicial (nivel sospecha/inicial): otoscopía para retirar tapón de cerumen o detectar otitis media, **suspender el fármaco ototóxico**, audiometría y tratamiento de la causa; explicar que es benigno en la mayoría, evitar el silencio absoluto (ruido de fondo o enmascaramiento), reducir cafeína y tabaco y tratar ansiedad e insomnio. No existe fármaco curativo. **Se deriva a ORL** el tinitus **unilateral o asimétrico** (descartar schwannoma vestibular con RM), pulsátil, acompañado de hipoacusia súbita, vértigo o signos neurológicos, o muy invalidante.

6. BAROTRAUMA ÓTICO, PERFORACIÓN TIMPÁNICA TRAUMÁTICA Y PREVENCIÓN DEL TRAUMA ACÚSTICO

El **barotrauma ótico** ocurre por disfunción de la trompa de Eustaquio durante cambios de presión (descenso en avión, buceo, ascensor): la presión negativa del oído medio retrae el tímpano. Clínica: otalgia, plenitud ótica, hipoacusia de conducción y a veces acúfeno o vértigo; la otoscopía muestra retracción timpánica, inyección de los vasos del mango del martillo, **hemotímpano** u otorragia. Tratamiento inicial: maniobras de Valsalva suave o Toynbee, **descongestionante nasal tópico ≤3 días**, corticoide nasal, analgesia y evitar volar o bucear hasta la resolución. Vértigo o hipoacusia neurosensorial tras buceo sugieren **fístula perilinfática o enfermedad por descompresión del oído interno**: urgencia, se deriva. Prevención: deglutir o masticar en el descenso, no volar con congestión nasal. 6.03.2.006

La **perforación timpánica traumática** (hisopo, bofetada o golpe en el oído, explosión, barotrauma, quemadura, fractura del temporal) se presenta con otalgia súbita intensa, otorragia escasa, hipoacusia de conducción leve a moderada y acúfeno; la otoscopía muestra perforación de **bordes irregulares y a menudo con coágulos**. Manejo inicial: **mantener el oído seco** (tapón de algodón con vaselina al ducharse), **no lavar ni irrigar**, no instilar gotas potencialmente ototóxicas (si se necesita, solo ciprofloxacino ótico), antibiótico solo si hay infección y audiometría de control. Más del 90 % de las perforaciones pequeñas cierran solas en 4 a 8 semanas. Se **deriva** si hay vértigo o hipoacusia neurosensorial (lesión del oído interno), parálisis facial, perforación extensa o falta de cierre a los 3 meses (timpanoplastía). 6.03.2.016

La **prevención del trauma acústico** se organiza según la jerarquía de control: reducir el ruido en la fuente, aislar el puesto y, como último recurso, entregar **protectores auditivos** (tapones u orejeras) con capacitación de uso. En Chile, el DS 594 fija el límite de exposición ponderada de **85 dB(A) por 8 horas** (cada 3 dB de aumento reduce a la mitad el tiempo permitido) y el protocolo **PREXOR** del MINSAL establece la vigilancia ambiental y de la salud del trabajador expuesto, con **audiometrías periódicas**; la hipoacusia neurosensorial laboral es enfermedad profesional (Ley 16.744). En la población general se educa sobre el uso de audífonos (regla 60/60: hasta 60 % del volumen, máximo 60 minutos seguidos) y de música a alto volumen. 6.03.3.007

7. ESTUDIO DEL VIII PAR CRANEAL

El **estudio del VIII par** integra audiometría tonal y logoaudiometría, impedanciometría con reflejos estapediales, **potenciales evocados auditivos de tronco (PEAT)**, resonancia magnética de conducto auditivo interno y ángulo pontocerebeloso con gadolinio y pruebas vestibulares (videonistagmografía, prueba calórica, vHIT). El médico general debe *emplear el informe*: la sospecha de lesión **retrococlear** se plantea con hipoacusia neurosensorial **asimétrica** (diferencia ≥15 dB en frecuencias contiguas), discriminación del habla desproporcionadamente baja, ausencia de reflejo estapedial, prolongación de las latencias interondas I-III o I-V en los PEAT y tinitus unilateral. La **RM con gadolinio es el estándar** para descartar schwannoma vestibular; en la hipoacusia súbita también se solicita para excluir una causa retrococlear. 6.03.4.011

TABLA 14.6.C · ESQUEMA FARMACOLÓGICO DE RESCATE EN HIPOACUSIA SENSORIONEURAL SÚBITA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE DEL TRATAMIENTO	FÁRMACO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	DOSIS Y PAUTA DE ADMINISTRACIÓN	OBJETIVO CLÍNICO
Ataque Sistémico Inmediato	Prednisona oral	1 mg/kg/día (máx 60 mg/d) dosis única matinal x 10-14 días	Inhibición de respuesta inflamatoria e inmunológica coclear
Protección Gástrica	Omeprazol oral	20 mg al día en ayunas durante la corticoterapia	Prevención de úlcera péptica inducida por corticoides
Descenso Progresivo	Prednisona oral	Reducción de 10-20 mg cada 3 a 5 días hasta suspender	Prevención de insuficiencia suprarrenal aguda
Rescate Transtimpánico (ORL)	Dexametasona / Metilprednisolona	Inyección intratimpánica semanal (3 a 4 sesiones)	Altas concentraciones perilinfáticas sin toxicidad sistémica

14.6. Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (HIPOACUSIA SENSORIONEURAL SÚBITA, TRAUMA ACÚSTICO Y PRESBIACUSIA)

- La Hipoacusia Sensorioneural Súbita es una URGENCIA MÉDICA definida por una caída ≥ 30 dB en ≥ 3 frecuencias en < 72 horas.
- El único tratamiento con eficacia comprobada son los corticoides sistémicos en altas dosis (Prednisona 1 mg/kg/día por 10-14 días).
- Todo paciente con HSNS debe ser estudiado con RMN de ángulo pontocerebeloso para descartar Schwannoma vestibular.
- La presbiacusia produce hipoacusia HSN bilateral, simétrica y de tonos agudos en > 65 años, cubierta por el programa GES N° 56.
- Ante una hipoacusia brusca con otoscopía normal, el error más grave es atribuirla a cerumen o disfunción tubárica y observar.
- La ventana de máxima eficacia para el inicio de corticoides son las primeras 48 a 72 horas del cuadro.
- El trauma acústico crónico ocupacional se manifiesta con una muesca o escotoma clásico en la frecuencia 4000 Hz.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

14.6

Un abogado de 48 años, sin antecedentes de trauma acústico ni enfermedades crónicas, consulta en el servicio de urgencia relatando que al despertar hace 36 horas notó que 'no oye nada' por el oído izquierdo y que siente un pito agudo continuo (tinnitus) y sensación de presión en ese oído. Pensó que era un tapón de cera y se aplicó gotas de glicerina sin mejoría. Al examen físico no hay fiebre ni mareos. La otoscopía de ambos oídos es rigurosamente normal, con tímpanos íntegros y nacarados. Al examen con diapasón, el Weber lateraliza hacia el oído derecho (sano) y el Rinne es positivo en ambos oídos (VA > VO).

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico corresponde a una Hipoacusia Sensorioneural Súbita (HSNS) del oído izquierdo. La semiología con diapasón confirma la etiología neurosensorial: Weber al oído sano y Rinne positivo bilateral (sin gap de conducción mecánico). Ante una otoscopía normal y un cuadro de inicio menor a 72 horas, estamos frente a una urgencia otorrinolaringológica mayor. La conducta médica prioritaria es no demorar el tratamiento: se debe iniciar de inmediato Prednisona oral en dosis altas (1 mg/kg/día, típicamente 60 mg/día) con protección gástrica y solicitar de forma prioritaria una audiometría tonal confirmatoria. Además, una vez iniciado el tratamiento, se debe programar una RMN de ángulo pontocerebeloso con gadolinio para descartar neurinoma del acústico.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.018

1. Un hombre de 52 años consulta por pérdida súbita de la audición del oído derecho que notó al despertar hoy en la mañana, asociada a tinnitus agudo. No refiere dolor, fiebre ni secreción. A la otoscopía, ambos conductos auditivos externos están limpios y las membranas timpánicas son de aspecto normal. La prueba de Weber lateraliza al oído izquierdo y el Rinne es positivo en ambos oídos. ¿Cuál es la conducta inicial de elección que debe instaurarse de forma inmediata?

A) Realizar lavado de oído bilateral con agua tibia para retirar eventual tapón de cera profundo.
B) Indicar descongestionantes orales y citar a control ambulatorio en 3 semanas.
C) Iniciar de inmediato prednisona oral en dosis de 1 mg/kg/día y solicitar audiometría urgente.
D) Prescribir gotas óticas de ciprofloxacino con hidrocortisona cada 8 horas por 7 días.
E) Tranquilizar al paciente indicando que se trata de un cuadro viral autolimitado que no requiere fármacos.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.008

2. Un paciente de 72 años consulta porque desde hace 3 años presenta dificultad para entender las conversaciones cuando asiste a reuniones familiares o en lugares con ruido de fondo, refiriendo que 'oye pero no entiende'. No tiene otalgia ni vértigo. La audiometría demuestra una hipoacusia sensorioneural bilateral y simétrica, con mayor caída en los tonos agudos (3000 a 8000 Hz) y caída de la discriminación de la palabra al 60%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el beneficio en el sistema de salud chileno?

A) Otoesclerosis bilateral; resolución quirúrgica con estapedectomía GES.
B) Presbiacusia; patología con Garantía Explícita en Salud (GES) con indicación de audífonos bilaterales.
C) Enfermedad de Ménière bilateral; tratamiento con restricción de sal y acetazolamida.
D) Trauma acústico crónico; derivación a mutualidad de seguridad laboral para indemnización.
E) Neurinoma del acústico bilateral; estudio genético urgente para Neurofibromatosis tipo 1.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.006

3. Un calderero industrial de 45 años, con 20 años de labor en maestranza sin uso constante de protectores auditivos, se realiza una audiometría ocupacional periódica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos audiométricos es característico y patognomónico del trauma acústico crónico por ruido laboral?

A) Pérdida auditiva de conducción con curva timpanométrica tipo B.
B) Caída del umbral auditivo neurosensorial en las frecuencias graves (250 a 500 Hz).
C) Muesca o escotoma neurosensorial bilateral selectivo en la frecuencia de 4000 Hz.
D) Brecha óseo-aérea de 30 dB en todas las frecuencias con vía ósea normal.
E) Caída plana sensorioneural de 90 dB en todas las frecuencias del oído derecho únicamente.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.018

4. En un paciente con hipoacusia sensorioneural súbita idiopática de 48 horas de evolución, ¿cuál de los siguientes estudios de neuroimagen es el de elección para descartar de forma definitiva una patología retrococlear como el neurinoma del acústico (schwannoma vestibular)?

A) Radiografía de cráneo en proyección transorbitaria.
B) Tomografía computarizada (TAC) de cerebro sin contraste.
C) Resonancia magnética nuclear (RMN) de cerebro y ángulo pontocerebeloso con gadolinio.
D) Angiografía cerebral por sustracción digital de arteria basilar.
E) Ecografía Doppler de arterias carótidas y vertebrales.

Más preguntas online de Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia →

14.7. Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.03.1.029 6.03.2.017 1.10.1.025

¿POR QUÉ?

El síndrome vertiginoso es un motivo de consulta crítico donde el médico debe cumplir dos objetivos prioritarios: (1) Descartar precozmente un evento cerebrovascular isquémico de fosa posterior mediante el protocolo HINTS al lado de la cama; y (2) Diagnosticar con precisión las tres grandes patologías vestibulares periféricas: VPPB (crisis de segundos con Dix-Hallpike positivo que cura con maniobra de Epley sin fármacos), Neuronitis Vestibular (vértigo continuo de días sin hipoacusia) y Enfermedad de Ménière (crisis de horas con hipoacusia sensorioneural fluctuante y plenitud ótica).

1. VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO (VPPB): CANALITIASIS Y MANIOBRAS

El **VPPB** es la causa más frecuente de vértigo vestibular periférico en el mundo (hasta 50% de los casos). Es causado por **canalitiasis**: desprendimiento de otoconias u otolitos de carbonato de calcio desde la mácula del utrículo hacia los canales semicirculares (en el 85-90% de los casos hacia el **canal semicircular posterior**). 6.03.1.029 1.10.1.025

Clínica: Episodios breves de **vértigo ilusorio de giro de objetos que duran típicamente entre 10 y 60 segundos**, desencadenados exclusivamente por cambios posicionales de la cabeza respecto a la gravedad (girar en la cama, acostarse, agacharse a atarse los zapatos o mirar hacia arriba). No hay hipoacusia ni acúfenos.

Diagnóstico: Se confirma mediante la **Maniobra de Dix-Hallpike**: al acostar al paciente con la cabeza rotada 45° y extendida 20°, se desencadena tras una *latencia de 2 a 5 segundos* un vértigo intenso y un **nistagmo torsional y vertical geotrópico hacia arriba que se fatiga y agota en < 30-45 segundos**. **(ver Imagen 14.7)**

Tratamiento: El tratamiento de elección **NO son los fármacos sedantes vestibulares ni la cinarizina**, sino las **maniobras de reposición canalicular de Epley o Semont**, las cuales logran la curación completa en más del 90% de los casos en la misma consulta al retornar los otolitos al utrículo.

2. NEURONITIS VESTIBULAR AGUDA: DÉFICIT UNILATERAL SIN HIPOACUSIA

La **Neuronitis Vestibular** (o neuritis vestibular) es un cuadro inflamatorio agudo del nervio vestibular (habitualmente de origen viral por reactivación de HSV-1 o post-infección respiratoria alta). 6.03.1.029 1.10.1.025

Se manifiesta como un **síndrome vestibular agudo: crisis de vértigo rotatorio continuo, intenso e invalidante que dura entre 2 y 5 días**, acompañado de náuseas, vómitos profusos, palidez, sudoración e inestabilidad para la marcha con lateropulsión hacia el lado lesionado. **Ausencia estricta de hipoacusia o acúfenos** (si se acompaña de hipoacusia súbita se denomina *laberintitis aguda*). 6.03.1.029 1.10.1.025 6.03.2.017

Al examen destaca un **nistagmo espontáneo unidireccional, horizontal-rotatorio, que bate hacia el oído sano**, cuya intensidad aumenta al mirar hacia el lado de batido (Ley de Alexander) y disminuye con la fijación visual. El tratamiento en las primeras 48 horas incluye **antieméticos y sedantes vestibulares (Dimenhidrinato, Lorazepam) solo por 48 horas** para no frenar la compensación central, junto a **corticoides orales (Metilprednisolona o Prednisona 1 mg/kg/día x 7 días)** para acelerar la recuperación vestibular.

TABLA 14.7.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO DE LOS PRINCIPALES SÍNDROMES VERTIGINOSOS PERIFÉRICOS 6.03.1.029, 6.03.2.017, 1.10.1.025

CRITERIO COMPARATIVO	VPPB	NEURONITIS VESTIBULAR	ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Duración de la Crisis	Segundos (10 a 60 segundos por episodio)	Días (2 a 5 días de vértigo continuo continuo)	Horas (20 minutos a 12 horas; típica 2-4h)
Gatillante Principal	Cambios posturales cefálicos (giros en la cama)	Espontáneo tras cuadro viral respiratorio alto	Espontáneo, precedido de acúfeno y presión ótica
Síntomas Auditivos	Ninguno (audición rigurosamente normal)	Ninguno (oído medio e interno coclear indemnes)	Hipoacusia sensorioneural fluctuante en tonos graves + tinnitus
Hallazgo al Examen	Dix-Hallpike (+): nistagmo torsional geotrópico	Nistagmo horizontal unidireccional a oído sano	Audiometría con caída en frecuencias graves
Tratamiento de Elección	Maniobra de Epley / Semont (¡sin fármacos!)	Corticoides orales + reposo (sedantes máx 48h)	Restricción de sal (< 2 g/d) + Diuréticos / Betahistina

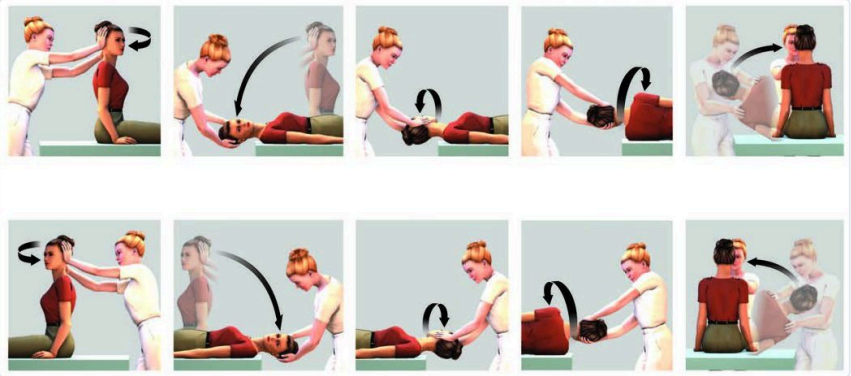
14.7. Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE: HIDROPS ENDOLINFÁTICO Y TRÍADA CLÁSICA

La **Enfermedad de Ménière** se produce por un **hidrops endolinfático** (distensión y aumento excesivo de presión de la endolinfa en el laberinto membranoso cocleovestibular por reabsorción deficiente en el saco endolinfático). 6.03.1.029 1.10.1.025

Se diagnostica por la presencia de una **tríada cardinal recurrente:** (1) **Crisis espontáneas de vértigo rotatorio que duran de 20 minutos a 12 horas** (habitualmente entre 2 y 4 horas); (2) **Hipoacusia sensorioneural fluctuante documentada**, típicamente en frecuencias graves y medias (250-1000 Hz) en etapas iniciales; y (3) **Acúfenos de tono grave y sensación de plenitud ótica o presión** en el oído afectado, que suelen preceder a las crisis como pródromo.

Tratamiento: En la crisis aguda: reposo y sedantes vestibulares. En el manejo intercrítico preventivo: **restricción estricta de sodio en la dieta (< 2 g/día)**, abandono de cafeína y tabaco, y uso de **diuréticos tiazídicos (Hidroclorotiazida 25-50 mg/día) o Betahistina (16-24 mg cada 12 horas)** para reducir el volumen endolinfático. En casos refractarios: inyecciones intratimpánicas de corticoides o gentamicina (laberintectomía química).



MANIOBRA DE EPLEY

Imagen 14.7

FIGURA 14.7 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME VERTIGINOSO PERIFÉRICO VS CENTRAL (PROTOCOLO HINTS)

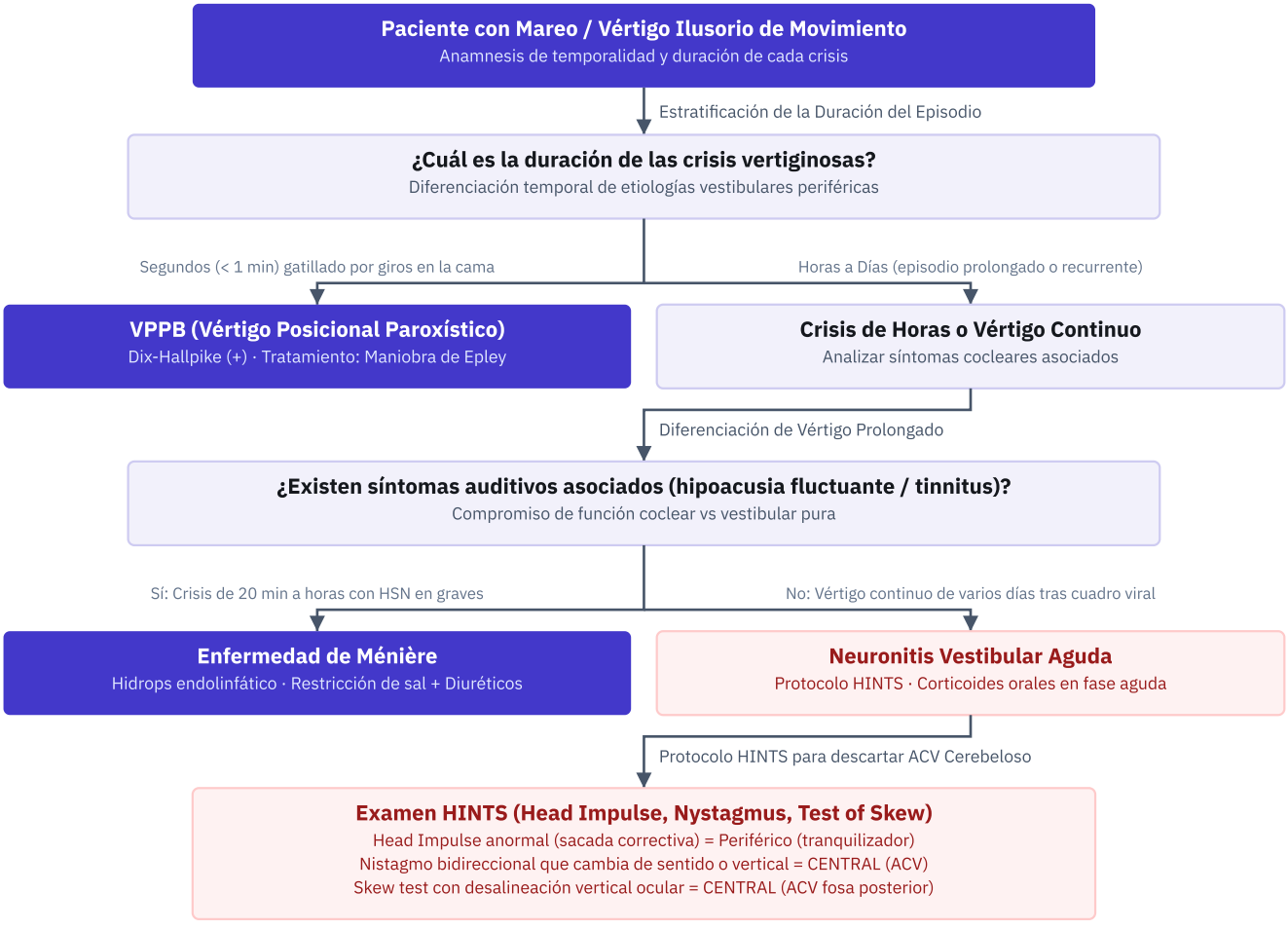


TABLA 14.7.B · PROTOCOLO HINTS PARA DIFERENCIACIÓN DE VÉRTIGO AGUDO: PERIFÉRICO VS CENTRAL (ACV) CRITERIOS DE GRAVEDAD

COMPONENTE DEL TEST HINTS	HALLAZGO EN VÉRTIGO PERIFÉRICO	HALLAZGO EN VÉRTIGO CENTRAL (ACV)	INTERPRETACIÓN CLÍNICA DE ALARMA
H: Head Impulse (Impulso Cefálico)	Anormal: Presencia de sacada correctiva de refijación	Normal: Ojos se mantienen en el objetivo sin sacada	Un impulso cefálico NORMAL ante vértigo continuo sugiere ACV central
N: Nystagmus (Tipo de Nistagmo)	Unidireccional horizontal (aumenta al mirar al lado del batido)	Bidireccional (cambia de sentido al cambiar la mirada) o Vertical	Nistagmo que cambia de dirección o vertical es estrictamente CENTRAL
TS: Test of Skew (Alineación Ocular)	Normal: Ojos alineados verticalmente sin movimiento de refijación	Anormal: Desalineación vertical con sacada correctiva vertical	Skew deviation positiva indica lesión del tronco encefálico (ACV)

14.7. Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PROTOCOLO HINTS: DESCARTE DE INFARTO CEREBELOSO / TRONCO ENCEFÁLICO

En un paciente que consulta en urgencia con un síndrome vestibular agudo (vértigo continuo y nistagmo), la prioridad clínica es descartar un **accidente cerebrovascular isquémico de fosa posterior (PICA o AICA)**. En las primeras 24-48 horas, la RMN de encéfalo puede tener hasta un 12-20% de falsos negativos; en cambio, el **protocolo semiológico HINTS tiene una sensibilidad del 100% y especificidad del 96%** (superior a la RM precoz) cuando es realizado por un médico entrenado.

El protocolo consta de 3 pruebas: (1) **Head Impulse Test (Impulso Cefálico):** Un impulso normal (sin sacada correctiva) en un paciente con vértigo continuo orienta fuertemente a causa *CENTRAL*; la presencia de sacada correctiva de refijación orienta a periférico; (2) **Nystagmus (Nistagmo):** El nistagmo central es *bidireccional* (cambia de dirección según hacia dónde mira el paciente) o puramente *vertical u oscilatorio*. El periférico es unidireccional y horizontal; (3) **Test of Skew (Desalineación vertical ocular):** La presencia de skew deviation (ojo que sube o baja al ocluir y desocluir alternativamente) es un signo inequívoco de patología *CENTRAL* (troncoencefálica). Ante cualquier signo de alarma HINTS (INFARCT: Impulse normal, Fast-phase alternating, Refixation on Cover Test), se debe hospitalizar de urgencia por ACV.

TABLA 14.7.C · ABORDAJE FARMACOLÓGICO Y FÍSICO DEL SÍNDROME VERTIGINOSO PERIFÉRICO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PATOLOGÍA VESTIBULAR	FASE / OBJETIVO	FÁRMACOS / MANIOBRAS DE ELECCIÓN	POSOLOGÍA Y RECOMENDACIONES
VPPB	Resolución mecánica	Maniobra de reposición de Epley o Semont	Realizada en box de atención · No usar cinarizina ni sedantes
Neuronitis Vestibular	Control agudo (primeras 48h)	Dimenhidrinato 50 mg c/8h o Lorazepam 1 mg SL	Suspender estrictamente a las 48h para permitir compensación central
Neuronitis Vestibular	Aceleración de recuperación	Prednisona oral 1 mg/kg/día x 7 días con descenso	Inicia en las primeras 72 horas del cuadro
Enfermedad de Ménière	Crisis aguda sintomática	Reposo en cama + Clorpromazina o Lorazepam EV	Manejo en sala de observación de urgencia
Enfermedad de Ménière	Prevención de recurrencias	Dieta hiposódica (< 2g/d) + Hidroclorotiazida 25-50 mg/d	Mantener de por vida; agregar Betahistina 24 mg c/12h

14.7. Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SÍNDROME VERTIGINOSO PERIFÉRICO)

- El VPPB es la causa más común de vértigo periférico; se caracteriza por crisis de segundos (< 1 min) desencadenadas por giros de la cabeza.
- El tratamiento del VPPB es mecánico mediante la maniobra de reposición de Epley; los fármacos están desaconsejados.
- Los sedantes vestibulares en la neuronitis solo deben usarse por 48 horas como máximo para no bloquear la compensación central.
- En el protocolo HINTS, un nistagmo bidireccional, un test de skew positivo o un impulso cefálico normal ante vértigo continuo alertan de un ACV cerebeloso.
- La maniobra de Dix-Hallpike confirma el VPPB al observar nistagmo torsional geotrópico con latencia y fatigabilidad.
- La Neuronitis Vestibular produce vértigo continuo de 2 a 5 días con nistagmo horizontal unidireccional y SIN hipoacusia.
- La Enfermedad de Ménière se distingue por crisis de 20 minutos a horas con hipoacusia fluctuante sensorioneural en tonos graves y acúfenos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

14.7

Una mujer de 62 años consulta en el policlínico por episodios reiterados de mareo intenso y sensación de giro de las paredes que se inician bruscamente cada vez que se da vuelta hacia el lado derecho en la cama o al mirar hacia los estantes altos de la cocina. Cada episodio dura alrededor de 30 a 40 segundos y cede completamente si se mantiene inmóvil. No refiere disminución de la audición, zumbidos ni dolor. El examen neurológico básico y la otoscopía son normales. Al realizar la maniobra de Dix-Hallpike hacia la derecha, luego de una latencia de 3 segundos, se desencadena un vértigo rotatorio violento y se observa un nistagmo torsional y vertical hacia arriba que se fatiga y desaparece a los 25 segundos.

Conducta oficial razonada. La historia clínica de crisis vertiginosas de segundos de duración desencadenadas por cambios posturales de la cabeza, junto a la presencia de un test de Dix-Hallpike positivo con nistagmo torsional geotrópico fatigable y latencia, es diagnóstica y patognomónica de un Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB) del canal semicircular posterior derecho. El mecanismo fisiopatológico es la canalitiasis (otolitos libres en la endolinfa del canal). La conducta médica de elección inmediata es realizar la maniobra de reposición de partículas de Epley en la misma camilla de atención, la cual desplaza las partículas cálcicas de vuelta hacia el utrículo. No está indicado el uso de fármacos sedantes vestibulares ni vasodilatadores como cinarizina o flunarizina, los cuales no resuelven la causa mecánica y causan somnolencia y parkinsonismo en adultos mayores.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.7 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.025

1. Una paciente de 58 años consulta por crisis breves de sensación de giro del entorno de 20 a 30 segundos de duración, que aparecen exclusivamente al acostarse en su cama o al darse vuelta hacia la izquierda. No ha presentado sordera, fiebre ni tinnitus. La maniobra de Dix-Hallpike izquierda provoca vértigo intenso y nistagmo torsional que bate hacia arriba y se agota a los 20 segundos. ¿Cuál es el tratamiento más indicado?

A) Indicar flunarizina 10 mg por la noche por 3 meses.
B) Realizar maniobra de reposición canalicular de Epley en la consulta.
C) Prescribir corticoides orales en dosis descendentes por 14 días.
D) Hospitalizar para tratamiento con betahistina endovenosa continua.
E) Solicitar tomografía computarizada de cerebro de urgencia y reposo absoluto en cama.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.025

2. Un hombre de 40 años presenta desde hace 24 horas un cuadro agudo de vértigo rotatorio continuo e invalidante, asociado a náuseas y vómitos reiterados, que le impide ponerse de pie. Tuvo un cuadro respiratorio viral hace una semana. Al examen físico destaca un nistagmo horizontal espontáneo que bate hacia la derecha, el cual aumenta de intensidad al mirar hacia la derecha y disminuye al fijar la vista. La otoscopía es normal y la audición con diapasón no muestra alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Ménière en etapa inicial.
B) Neuronitis vestibular izquierda.
C) Vértigo posicional paroxístico benigno.
D) Accidente cerebrovascular isquémico de arteria basilar.
E) Otoesclerosis laberíntica aguda.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.025

3. Un hombre de 50 años refiere episodios recurrentes de vértigo rotatorio que se prolongan por 3 a 4 horas cada vez, asociados a náuseas intensas. En las crisis nota una disminución de la audición del oído derecho y un zumbido grave continuo con sensación de presión ótica. Entre los episodios la audición mejora pero no vuelve completamente a la normalidad. ¿Cuál es el pilar farmacológico y dietético fundamental para la prevención a largo plazo de nuevas crisis en este paciente?

A) Antibioticoterapia profiláctica con azitromicina oral semanal.
B) Restricción de sodio en la dieta asociada a diuréticos como hidroclorotiazida.
C) Maniobras de Epley semanales de forma preventiva.
D) Suplementación con dosis altas de calcio y vitamina D.
E) Tratamiento anticoagulante permanente con acenocumarol.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.017

4. Al evaluar a un paciente de 67 años con factores de riesgo cardiovascular que consulta en urgencias por vértigo agudo continuo y nistagmo, ¿cuál de los siguientes hallazgos en la exploración física según el protocolo HINTS orienta con mayor fuerza a un origen CENTRAL (accidente cerebrovascular de fosa posterior) por sobre una causa periférica?

A) Prueba de impulso cefálico (Head Impulse Test) francamente anormal con sacada correctiva de refijación.
B) Nistagmo horizontal unidireccional que aumenta al mirar en la dirección del batido.
C) Presencia de nistagmo bidireccional que cambia de dirección según hacia dónde mire el paciente.
D) Ausencia de desviación en la alineación ocular vertical en el test de oclusión alternada (Test of Skew).
E) Otoscopía normal y audición conservada en ambos oídos.

Más preguntas online de Síndrome Vertiginoso Periférico →

14.8. Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.10.1.016 1.10.1.009

¿POR QUÉ?

La parálisis facial es un motivo de consulta que genera gran alarma en el paciente y exige una discriminación semiológica instantánea por parte del médico: la parálisis facial central respeta la musculatura de la frente por tener doble inervación hemisférica y obliga a descartar un ACV encefálico; en cambio, la parálisis periférica afecta tanto la mitad superior como inferior de la cara (imposibilidad de arrugar la frente y lagoftalmos). El tratamiento precoz con corticoides sistémicos y la protección ocular rigurosa son imperativos para evitar secuelas motoras y úlceras corneales.

1. SEMIOLOGÍA DIFERENCIAL: PARÁLISIS CENTRAL VS PARÁLISIS PERIFÉRICA

El **nervio facial (VII par craneal)** inerva todos los músculos de la mímica facial. El núcleo motor del facial en la protuberancia se divide en dos porciones: la porción superior (que inerva la frente y el músculo orbicular de los párpados) recibe fibras corticonucleares de **ambos hemisferios cerebrales** (inervación bilateral); mientras que la porción inferior (músculos peribucales y mejilla) solo recibe fibras cruzadas del hemisferio contralateral. 1.10.1.016

Por este principio anatómico elemental: (a) En una **Parálisis Facial Central (supranuclear)**, producida por un infarto o hemorragia cerebral, **se preserva la motilidad de la frente** (el paciente puede arrugar la frente y cerrar con fuerza los párpados de ambos lados) y solo existe asimetría en la mitad inferior de la cara (desviación de la comisura bucal); (b) En una **Parálisis Facial Periférica (infranuclear)**, existe una lesión del nervio facial en su trayecto o núcleo, con **compromiso total y homogéneo de todo el hemicara ipsilateral**: borramiento de arrugas frontales, lagoftalmos (imposibilidad de cerrar el ojo), caída de la comisura labial y signo de Bell (desviación del globo ocular hacia arriba y afuera al intentar cerrar el ojo). **(ver Imagen 14.8A y B)**

2. PARÁLISIS DE BELL (IDIOPÁTICA): CLÍNICA Y TRATAMIENTO PRECOZ

La **Parálisis de Bell** es la causa más común de parálisis facial periférica aguda (60-75% de los casos). Se debe a una inflamación y edema del nervio facial en su porción laberíntica intratemporal, atribuida a la reactivación del virus herpes simplex tipo 1 (HSV-1). Se instala típicamente en 24 a 48 horas, a menudo precedida de dolor mastoideo o retroauricular leve y disgeusia (alteración del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua por la cuerda del tímpano). 1.10.1.016

Tratamiento: El pilar terapéutico con mayor evidencia es el **inicio precoz (en las primeras 72 horas) de Corticoides Sistémicos en dosis altas: Prednisona 1 mg/kg/día oral (máximo 60 mg/día) durante 7 a 10 días**, con pauta de descenso posterior en 5 días. Los antivirales en monoterapia carecen de utilidad, y su adición a corticoides solo se reserva para casos severos (House-Brackmann grado IV-VI).

Protección Ocular Estricta: Debido al lagoftalmos y la falta de parpadeo, el riesgo de *queratitis por exposición y úlcera corneal grave* es muy alto. Es **obligatorio indicar lágrimas artificiales (carboximetilcelulosa o hipromelosa) cada 1-2 horas durante el día, gel lubricante oclusivo en la noche y oclusión del ojo con parche micropore nocturno**.

3. SÍNDROME DE RAMSAY HUNT (HERPES ZÓSTER ÓTICO): PRONÓSTICO Y MANEJO

El **Síndrome de Ramsay Hunt** es la segunda causa más frecuente de parálisis periférica y es producido por la **reactivación del virus varicela-zóster (VZV) latente en el ganglio geniculado** del nervio facial. 1.10.1.016 1.10.1.009

Se manifiesta por la tríada clásica de: (1) **Parálisis facial periférica severa**; (2) **Otalgia intensa, quemante e invalidante**; y (3) **Erupción de vesículas herpéticas eritematosas dolorosas en el pabellón auricular, concha, CAE o membrana timpánica (área de Ramsay Hunt)** y en ocasiones en el paladar blando. Frecuentemente compromete al nervio vestibulococlear (VIII par) por contigüidad, asociando hipoacusia sensorioneural y vértigo rotatorio agudo. **(ver Imagen 14.8C)**

Su pronóstico de recuperación motora es significativamente peor que el de la parálisis de Bell (solo 30-50% de recuperación completa sin terapia precoz). El tratamiento requiere la asociación inmediata de **Valaciclovir oral (1000 mg cada 8 horas por 7 a 10 días)** o Aciclovir (800 mg 5 veces al día) junto a **Prednisona oral a 1 mg/kg/día por 10 a 14 días**, asociado a analgesia potente por riesgo de neuralgia posherpética.

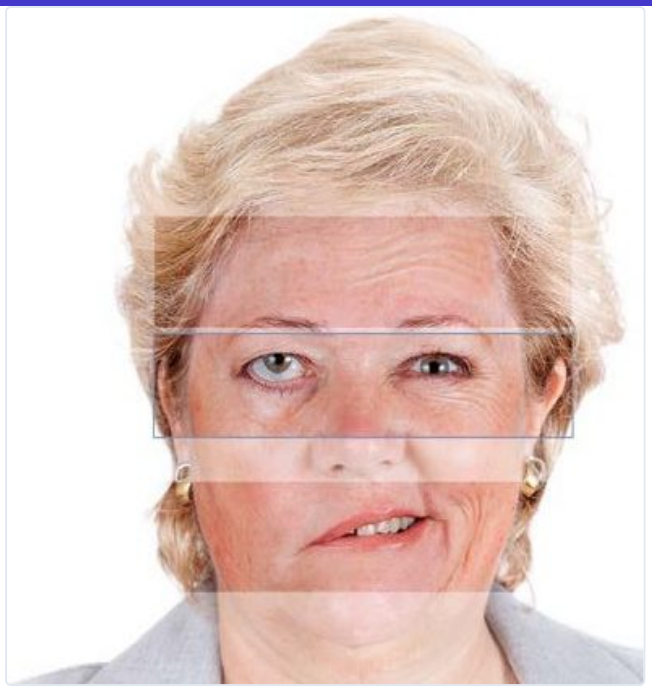
4. HERPES ZÓSTER: MANEJO GENERAL Y NEURALGIA POSHERPÉTICA

El **herpes zóster** es la reactivación del virus varicela-zóster latente en un ganglio sensitivo. Se manifiesta con dolor o parestesias prodrómicas y luego **vesículas agrupadas sobre base eritematosa en un dermatoma unilateral** que no cruza la línea media; el síndrome de Ramsay Hunt es su forma geniculada. Tratamiento (inicial ojalá en las primeras 72 horas, pero útil hasta que aparezcan lesiones nuevas): **aciclovir 800 mg cinco veces al día o valaciclovir 1 g cada 8 horas por 7 días**, analgesia escalonada y cuidado de las lesiones; en inmunosuprimidos con compromiso extenso o diseminado se usa aciclovir endovenoso. Las lesiones son contagiosas (varicela) para personas susceptibles hasta que se hacen costra. 1.10.1.009



Herpes zóster en un dermatoma lumbar

Se **deriva de urgencia a oftalmología** el zóster oftálmico (rama V1; el **signo de Hutchinson**, vesículas en la punta de la nariz, anuncia compromiso del ojo). La complicación más frecuente es la **neuralgia posherpética** (dolor persistente más de 3 meses tras la erupción), más común en mayores de 60 años; se trata con gabapentina o pregabalina, antidepresivos tricíclicos (amitriptilina) o parches de lidocaína. La vacuna recombinante contra el zóster está recomendada desde los 50 años.



A. BELL DERECHA: LAGOFTALMOS



B. COMISURA QUE NO SE ELEVA



C. VESÍCULAS EN LA CONCHA

Imagen 14.8

FIGURA 14.8 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA Y DESCARTE DE CAUSA CENTRAL

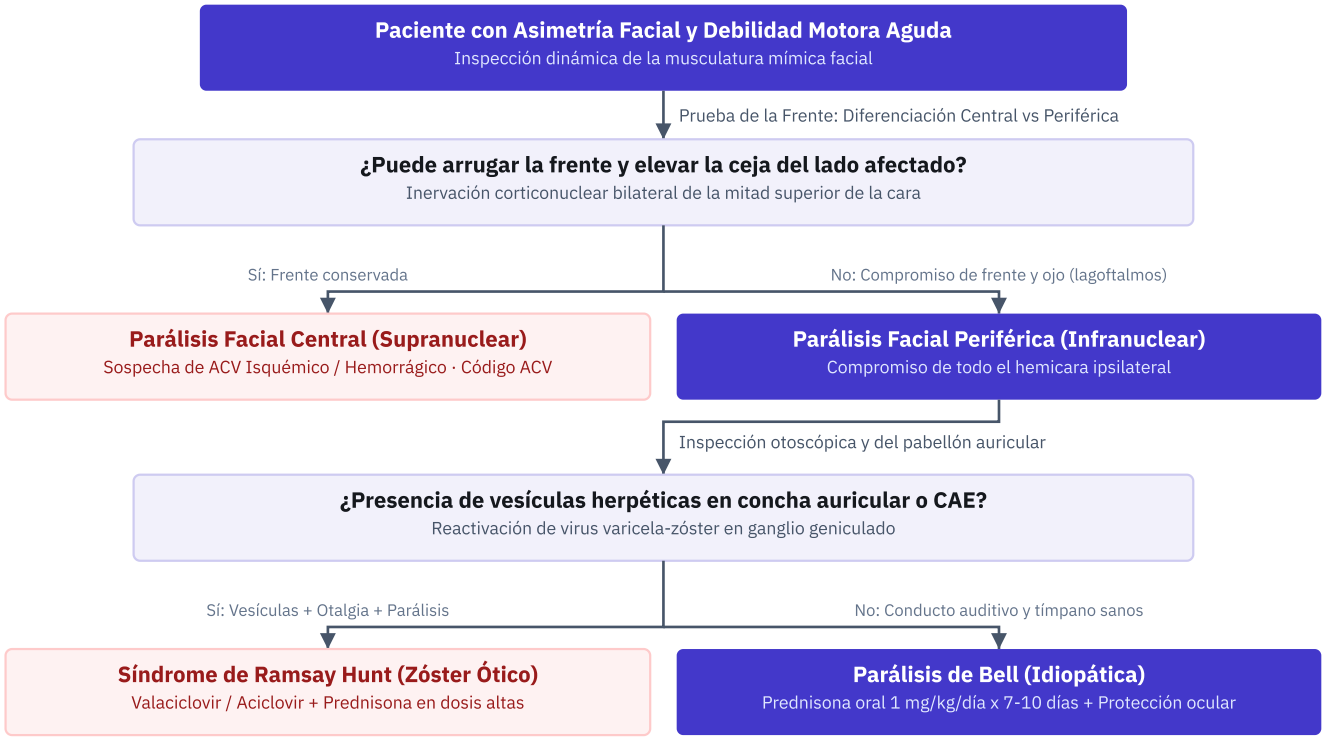


TABLA 14.8 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PARÁLISIS DE BELL VS SÍNDROME DE RAMSAY HUNT VS ACV CENTRAL `1.10.1.016, 1.10.1.009`

CARACTERÍSTICA	PARÁLISIS DE BELL (IDIOPÁTICA)	SÍNDROME DE RAMSAY HUNT	PARÁLISIS FACIAL CENTRAL (ACV)
Afectación de la Frente	Comprometida (No arruga frente ni eleva ceja)	Comprometida (No arruga frente ni eleva ceja)	RESPETADA (Arruga frente y eleva ambas cejas)
Cierre Ocular (Lagoftalmos)	Presente (Signo de Bell positivo)	Presente (Lagoftalmos severo doloroso)	Normal (Cierre ocular simétrico y completo)
Examen Otológico	Otoscopía y pabellón rigurosamente normales	Vesículas herpéticas dolorosas en concha/CAE	Normal · Puede tener déficit motor de extremidades
Etiología Principal	Reactivación HSV-1 en nervio intratemporal	Reactivación VZV en ganglio geniculado	Infarto o hemorragia de arteria cerebral media/cortical
Tratamiento de Elección	Prednisona oral 1 mg/kg/d x 7-10d + Gotas oculares	Valaciclovir 1g c/8h + Prednisona 1 mg/kg/d x 10d	Activación Código ACV · Neuroimagen urgente

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 14.8

Una mujer de 38 años consulta por asimetría facial de instalación rápida en las últimas 24 horas. Al mirarse al espejo esta mañana notó que no puede cerrar el ojo derecho y que al tomar líquidos se le escapan por la comisura derecha de la boca. Al examen neurológico se evidencia borramiento de los pliegues de la frente en el lado derecho con imposibilidad de arrugar la frente o levantar la ceja derecha, lagoftalmos derecho con exposición escleral y desviación de la comisura bucal hacia la izquierda al sonreír. El resto del examen neurológico y de pares craneales es rigurosamente normal. La otoscopía bilateral es normal y no se observan vesículas cutáneas.

Conducta oficial. La incapacidad para arrugar la frente ipsilateral junto con el lagoftalmos y la desviación de la comisura bucal confirma de manera inequívoca una Parálisis Facial Periférica (infranuclear) derecha. Al no encontrarse vesículas herpéticas en el pabellón o CAE (lo que descarta Ramsay Hunt), no haber antecedente de trauma ni signos de compromiso de otros pares craneanos, el diagnóstico es Parálisis de Bell (idiopática). La conducta terapéutica de elección inmediata, que debe iniciarse dentro de las primeras 72 horas del cuadro, es la administración de Prednisona oral a dosis de 1 mg/kg/día durante 7 a 10 días. Es de vital importancia prescribir medidas de protección corneal obligatorias: lágrimas artificiales frecuentes durante el día, ungüento oftálmico nocturno y oclusión palpebral nocturna con parche para evitar queratitis por exposición.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La parálisis facial periférica compromete la totalidad del hemicara ipsilateral, incluyendo la frente y el cierre ocular (lagoftalmos).
- La parálisis facial central respeta la musculatura de la frente gracias a la doble inervación corticonuclear bilateral.
- La Parálisis de Bell se trata con Prednisona oral a 1 mg/kg/día durante 7 a 10 días iniciada en las primeras 72 horas.
- La protección de la córnea mediante lágrimas artificiales, ungüento lubricante y parche nocturno es mandataria en toda parálisis periférica.
- El Síndrome de Ramsay Hunt asocia parálisis periférica con otalgia severa y vesículas herpéticas en concha auricular y CAE.
- El tratamiento de Ramsay Hunt requiere la combinación precoz de Valaciclovir (1000 mg c/8h) o Aciclovir con Prednisona oral.
- El signo de Bell consiste en la desviación del globo ocular hacia arriba y afuera al intentar cerrar el ojo parético.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.8

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.016

1. Un paciente de 60 años consulta en urgencia por desviación de la comisura bucal hacia la derecha y dificultad para pronunciar las palabras desde hace 2 horas. Al examen físico se aprecia incapacidad para elevar la comisura labial izquierda; sin embargo, el paciente arruga la frente de forma perfectamente simétrica y ocluye ambos ojos con fuerza normal sin lagoftalmos. ¿Cuál es la localización topográfica más probable de la lesión y la conducta inmediata?

A) Lesión del nervio facial periférico izquierdo en el foramen estilomastoideo; indicar prednisona oral ambulatoria.
B) Lesión corticonuclear o hemisférica cerebral derecha (parálisis facial central); activar código de sospecha de ACV y solicitar TAC de cerebro de urgencia.
C) Síndrome de Ramsay Hunt atípico; iniciar valaciclovir oral en altas dosis.
D) Parálisis de Bell de curso frustro; indicar reposo y control ambulatorio en una semana.
E) Otitis media aguda complicada con compresión del canal de Falopio; solicitar TAC de peñasco.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.009

2. Un paciente de 68 años consulta por intenso dolor en la oreja derecha de 3 días de evolución, asociándose hoy a parálisis facial derecha completa con imposibilidad para cerrar el ojo y mareo rotatorio. A la inspección del pabellón auricular y del conducto auditivo externo derecho se observan múltiples vesículas eritematosas, algunas de ellas con costras melicéricas, muy sensibles a la palpación. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Gotas óticas de ciprofloxacino asociadas a paracetamol oral por 7 días.
B) Valaciclovir oral 1000 mg cada 8 horas asociado a prednisona oral 1 mg/kg/día por 10 días y protección ocular.
C) Cefazolina endovenosa hospitalizada para cobertura de Staphylococcus aureus meticilino-sensible.
D) Carbamazepina oral en dosis crecientes como tratamiento exclusivo de neuralgia del trigémino.
E) Drenaje quirúrgico urgente de las vesículas en sala de procedimientos menores.

Más preguntas online de Parálisis Facial Periférica →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 14.5 A 14.8

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)	En el Test de Weber, el sonido lateraliza al oído enfermo en hipoacusia de conducción y...	**En el Test de Rinne, un resultado negativo (VO > VA) es patognomónico de hipoacusia de...**	—
Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia	La Hipoacusia Sensorioneural Súbita es una URGENCIA MÉDICA definida por una caída ≥ 30...	**Ante una hipoacusia brusca con otoscopía normal, el error más grave es atribuirla a...**	Todo paciente con HSNS debe ser estudiado con RMN de ángulo pontocerebeloso para...
Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	El VPPB es la causa más común de vértigo periférico; se caracteriza por crisis de...	**La maniobra de Dix-Hallpike confirma el VPPB al observar nistagmo torsional geotrópico...**	La historia clínica de crisis vertiginosas de segundos de duración desencadenadas por...
Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt	La parálisis facial periférica compromete la totalidad del hemicara ipsilateral...	**La parálisis facial central respeta la musculatura de la frente gracias a la doble...**	La incapacidad para arrugar la frente ipsilateral junto con el lagoftalmos y la...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

En el Test de Weber, el sonido lateraliza al oído enfermo en hipoacusia de conducción y al oído sano en hipoacusia...

En el Test de Rinne, un resultado negativo (VO > VA) es patognomónico de hipoacusia de conducción.

En la hipoacusia sensorioneural, el Test de Rinne sigue siendo positivo (VA > VO).

La brecha u oscilación óseo-aérea (Gap ≥ 15 dB) en la audiometría tonal confirma compromiso mecánico del oído externo o medio.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- En el Test de Rinne, un resultado negativo (VO > VA) es patognomónico de hipoacusia de conducción.
- En la hipoacusia sensorioneural, el Test de Rinne sigue siendo positivo (VA > VO).
- Ante una hipoacusia brusca con otoscopía normal, el error más grave es atribuirla a cerumen o disfunción tubárica y observar.
- El único tratamiento con eficacia comprobada son los corticoides sistémicos en altas dosis (Prednisona 1 mg/kg/día por 10-14 días).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

En el Test de Weber, el sonido lateraliza al oído enfermo en hipoacusia de conducción y al oído sano en hipoacusia...	Tema 14.5 →
La Hipoacusia Sensorioneural Súbita es una URGENCIA MÉDICA definida por una caída ≥ 30 dB en ≥ 3 frecuencias en <...	Tema 14.6 →
El VPPB es la causa más común de vértigo periférico; se caracteriza por crisis de segundos (< 1 min)...	Tema 14.7 →
La parálisis facial periférica compromete la totalidad del hemicara ipsilateral, incluyendo la frente y el cierre...	Tema 14.8 →

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

03 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES

4	12	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
14.9	Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales	44
14.10	Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias	47
14.11	Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos	51
14.12	Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal	56

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
6.03.1.001, 2.01.1.103, 6.03.1.025, 1.05.4.013, 6.03.3.003, 6.03.4.010	Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales	Específico	Completo	Completo
2.01.1.029, 6.03.1.026, 2.01.1.005, 2.01.4.008, 1.05.1.022, 6.03.1.030, 6.03.4.001, 6.03.4.003	Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias	Específico	Completo	Completo
6.03.1.012, 6.03.2.011, 6.03.5.012, 6.03.5.014, 2.01.1.099, 2.01.2.008, 6.03.1.011	Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos	Específico	Inicial	Completo
6.03.1.024, 6.03.1.016, 6.03.2.012, 6.03.2.013, 6.03.5.004	Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal	Específico	Inicial	Específico

BLOQUE 03 · RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
12 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

La clasificación ARIA divide la rinitis alérgica en intermitente (< 4d/sem o < 4 sem) vs persistente (≥ 4d/sem y ≥ 4 sem).
La afectación del sueño, actividades o rendimiento laboral/escolar define a la rinitis como Moderada a Severa.
Los corticoides intranasales (fluticasona, mometasona) son el fármaco de primera línea más eficaz para la rinitis alérgica moderada-severa.
Los antihistamínicos orales de 2ª generación (cetirizina, desloratadina) no son sedantes y controlan prurito y estornudos, pero poco la congestión.
La rinitis medicamentosa es causada por el uso de descongestionantes tópicos (oximetazolina) por más de 5 a 7 días.
El tratamiento de la rinitis medicamentosa es la suspensión inmediata del vasoconstrictor y el inicio de corticoides intranasales.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 4 TEMAS

Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales	EUNACOM Enero 2023 · #111 · EUNACOM Diciembre 2019 · #167 · EUNACOM Julio 2019 · #79 · EUNACOM Julio 2018 · #103
Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias	EUNACOM Diciembre 2025 · #67 · EUNACOM Enero 2023 · #14 · EUNACOM Enero 2023 · #13 · EUNACOM Diciembre 2022 · #139
Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal	EUNACOM Diciembre 2024 · #118 · EUNACOM Diciembre 2019 · #58 · EUNACOM Diciembre 2019 · #168 · EUNACOM Diciembre 2017 · #118

14.9. Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.03.1.001 2.01.1.103 6.03.1.025 1.05.4.013 6.03.3.003 6.03.4.010

¿POR QUÉ?

La rinitis alérgica es la enfermedad inmunológica crónica más prevalente en la población general y se asocia estrechamente al asma bronquial ('una sola vía aérea'). El examen EUNACOM evalúa de forma reiterada la prescripción de corticoides intranasales como el tratamiento de primera línea más eficaz para el control de la congestión y la inflamación de la mucosa, así como el descarte de rinitis no alérgica (vasomotora y medicamentosa por abuso de vasoconstrictores tópicos como la oximetazolina).

1. FISIOPATOLOGÍA, HIPERSENSIBILIDAD TIPO I Y CLÍNICA CARDINAL

6.03.1.001 2.01.1.103

La **rinitis alérgica** es una inflamación de la mucosa nasal mediada por inmunoglobulina E (IgE) tras la exposición a aeroalérgenos (ácaros del polvo doméstico *Dermatophagoides pteronyssinus*, pólenes de pastos/árboles, caspa de animales y hongos ambientales). Es una reacción de hipersensibilidad inmediata (tipo I de Gell y Coombs) donde los mastocitos sensibilizados liberan histamina, leucotrienos y prostaglandinas. **(ver Imagen 14.9)**

6.03.1.001 2.01.1.103 6.03.1.025

La tétrada clínica cardinal está constituida por: **(1) Rinorrea acuosa anterior y posterior ('goteo claro'); (2) Congestión u obstrucción nasal bilateral; (3) Prurito nasal, ocular y faríngeo ('saludo alérgico'); y (4) Estornudos en salva o paroxísticos**. Al examen físico (rinoscopía anterior) destaca la presencia de **mucosa nasal pálida, edematosa o de aspecto azulado/violáceo**, con hipertrofia de cornetes inferiores y secreción hialina líquida, asociada a ojeras alérgicas (pliegues de Dennie-Morgan).

2. CLASIFICACIÓN DE CONSENSO ARIA (ALLERGIC RHINITIS AND ITS IMPACT ON ASTHMA)

6.03.1.001 2.01.1.103

Las guías internacionales ARIA han sustituido la antigua clasificación de 'estacional vs perenne' por un enfoque clínico basado en la frecuencia y la severidad:

Frecuencia: (a) *Intermitente:* Síntomas presentes menos de 4 días a la semana O durante menos de 4 semanas consecutivas; (b) *Persistente:* Síntomas presentes 4 o más días a la semana Y durante 4 o más semanas consecutivas.

Severidad: Se clasifica en *Leve* si no existe ninguna alteración funcional. Se clasifica en **Moderada a Severa** si está presente **al menos uno** de los siguientes criterios: (1) Alteración del patrón del sueño; (2) Interferencia en actividades cotidianas, de ocio o deportivas; (3) Deterioro del rendimiento laboral o escolar; o (4) Síntomas intensamente molestos para el paciente.

3. TERAPIA FARMACOLÓGICA: SUPREMACÍA DE LOS CORTICOIDES INTRANASALES

6.03.1.001 2.01.1.103

El **fármaco de primera línea más potente y eficaz para todas las formas moderadas a severas y persistentes son los Corticoides Intranasales (CIN)**: Furoato de fluticasona, Propionato de fluticasona o Furoato de mometasona (1 a 2 pulverizaciones en cada fosa nasal una vez al día). Los CIN son los únicos agentes que controlan eficazmente la *obstrucción nasal* además del prurito y los estornudos, gracias a su acción genómica antiinflamatoria. Poseen una biodisponibilidad sistémica insignificante (< 1%) y no causan supresión del eje hipotálamo-hipofisario.

Los **antihistamínicos orales de 2ª generación (H1 no sedantes)**: Cetirizina (10 mg/d), Desloratadina (5 mg/d), Levocetirizina o Loratadina son de elección en formas intermitentes leves o como coadyuvantes en fases de crisis de prurito y rinorrea, careciendo de efecto sedante ni anticolinérgico.

6.03.1.001 2.01.1.103 6.03.1.025

Rinitis Medicamentosa (Alerta EUNACOM): Ocurre por el uso abusivo o prolongado (> 5 a 7 días consecutivos) de descongestionantes nasales tópicos imidazólicos (Oximetazolina, Tramazolina). Genera un efecto rebote por *taquifilaxia y downregulation de receptores alfa-1 adrenérgicos*, provocando vasodilatación masiva y necrosis mucosa. Su tratamiento consiste en la **suspensión inmediata del vasoconstrictor y el inicio de corticoides intranasales** en dosis altas para desinflamar la mucosa.

4. PRUEBAS CUTÁNEAS DE ALERGIA, CONTROL AMBIENTAL Y RINORREA CRÓNICA

1.05.4.013 6.03.4.010

Las **pruebas cutáneas de alergia (prick test)** identifican la sensibilización IgE a aeroalérgenos (ácaros, pólenes, epitelios, hongos). Se indican en la rinitis persistente o moderada-grave, en la que no responde al tratamiento o antes de plantear inmunoterapia. Técnica: una gota de extracto estandarizado en el antebrazo, punción superficial con lanceta, **control positivo con histamina y control negativo con suero fisiológico**, lectura a los **15 a 20 minutos**; es positiva una **pápula ≥3 mm mayor que el control negativo**. Se suspenden los antihistamínicos 5 a 7 días antes (los corticoides nasales no interfieren) y no se realiza con dermatografismo o dermatitis extensa en el sitio, ni con betabloqueadores o riesgo de anafilaxia. Un resultado positivo solo indica **sensibilización** y debe correlacionarse con la clínica; si no es posible hacerla, se solicita IgE específica sérica.

6.03.3.003

La **prevención de las alergias nasosinusales** descansa en el control ambiental del alérgeno identificado: contra los **ácaros**, fundas antiácaros para colchón y almohada, lavado semanal de ropa de cama a más de 55 °C, retirar alfombras, cortinas gruesas y peluches y mantener humedad <50 %; contra **epitelios**, alejar las mascotas del dormitorio; contra los **pólenes**, ventanas cerradas en temporada y lavado nasal con suero al volver a casa; contra **hongos**, ventilar y corregir humedad. Se evita el tabaquismo pasivo y se refuerza la adherencia a los lavados nasales salinos.

6.03.1.025

La **rinorrea crónica** (más de 12 semanas) se enfoca según su aspecto y lateralidad. **Acuosa bilateral**: rinitis alérgica, vasomotora, medicamentosa u hormonal. **Mucopurulenta**: rinosinusitis crónica, poliposis. **Unilateral**: en un niño, cuerpo extraño; en adultos, desviación septal, tumor o **fístula de líquido cefalorraquídeo** (rinorrea acuosa clara tras trauma o cirugía, que aumenta al inclinarse; se confirma con beta-2 transferrina). Manejo inicial: lavados nasales, corticoide nasal, antihistamínico y evitar descongestionantes tópicos más de 5 días; se **deriva** la rinorrea unilateral, sanguinolenta, con sospecha de LCR o sin respuesta a 4 semanas de tratamiento.



FACIES DE RINITIS ALÉRGICA

Imagen 14.9

FIGURA 14.9 · ALGORITMO TERAPÉUTICO ESCALONADO DE LA RINITIS ALÉRGICA SEGÚN GUÍAS ARIA

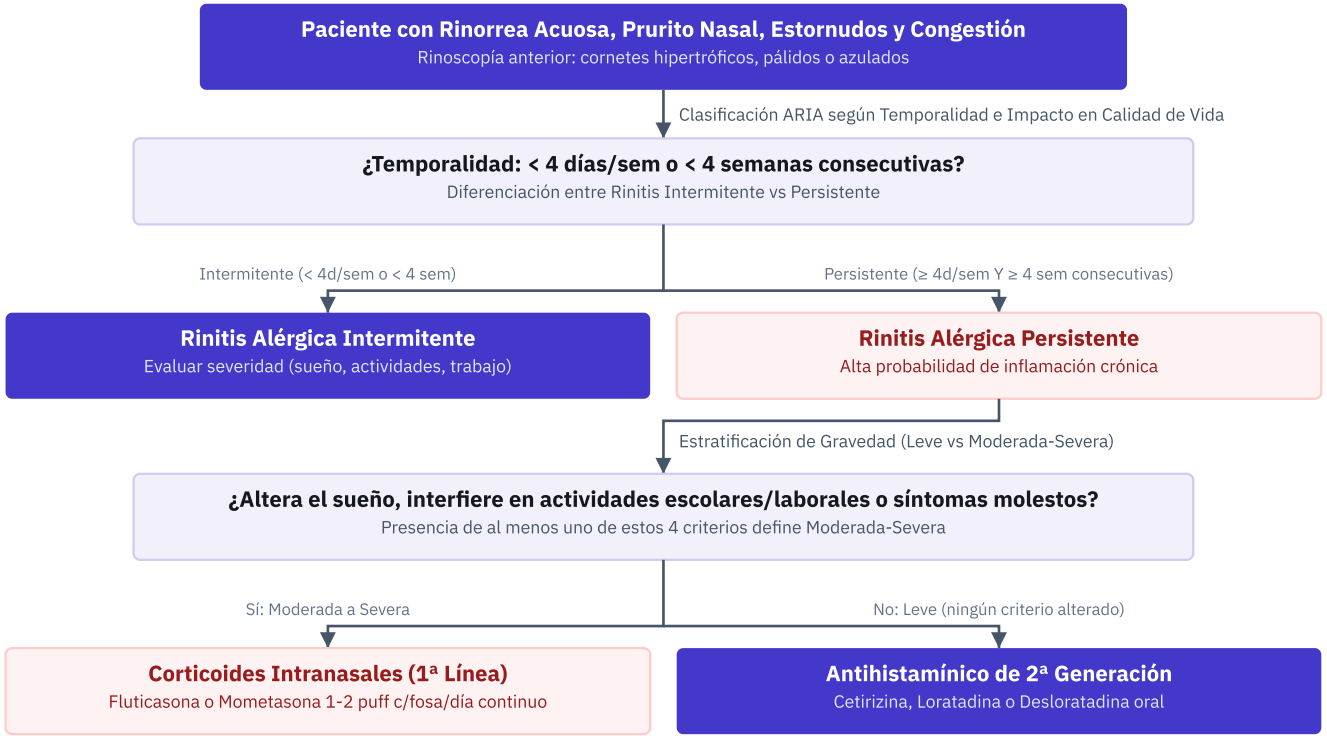


TABLA 14.9 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: RINITIS ALÉRGICA VS RINITIS NO ALÉRGICAS

6.03.1.001, 2.01.1.103, 6.03.1.025, 1.05.4.013, 6.03.3.003, 6.03.4.010

ENTIDAD CLÍNICA	FISIOPATOLOGÍA / GATILLANTE	HALLAZGO CLÍNICO CLAVE	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Rinitis Alérgica	Mediada por IgE contra aeroalérgenos (pólenes, ácaros)	Prurito, estornudos en salva, mucosa pálida/edematosa	Corticoides intranasales (Fluticasona/Mometasona) ± Antihistamínicos H1
Rinitis Medicamentosa	Abuso crónico de oximetazolina tópica (> 5-7 días)	Congestión nasal severa de rebote, mucosa eritematosa violácea	Suspensión tajante del descongestionante tópico + Corticoides intranasales
Rinitis Vasomotora	Hiperreactividad parasimpática ante cambios de temperatura/olores	Rinorrea acuosa profusa al comer (gustatoria) o al frío, sin prurito	Bromuro de ipratropio intranasal en spray tópico
Rinitis Infecciosa Aguda	Infección viral aguda (Rinovirus, Coronavirus)	Rinorrea inicialmente mucosa luego mucopurulenta, odinofagia, fiebre	Lavados nasales con suero fisiológico + Paracetamol · Autolimitada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 14.9

Un joven de 19 años consulta por obstrucción nasal bilateral constante, estornudos frecuentes por las mañanas y goteo nasal transparente desde hace 2 meses. Refiere que no logra dormir bien debido a la nariz tapada y que durante las clases universitarias siente sueño y desconcentración. Como antecedente, durante las últimas 3 semanas ha estado aplicándose spray de oximetazolina 4 veces al día, notando que al principio se destapaba la nariz de inmediato, pero ahora apenas le dura una hora el efecto y se le vuelve a tapar peor que antes. A la rinoscopía anterior se aprecian cornetes inferiores sumamente engrosados, hipertróficos y eritematosos que contactan el tabique.

Conducta oficial. El paciente presenta una Rinitis Alérgica Persistente Moderada-Severa (síntomas > 4 días/semana por > 4 semanas con alteración del sueño y rendimiento diurno) sobre la cual se ha desarrollado una Rinitis Medicamentosa iatrogénica secundaria al uso excesivo de descongestionantes tópicos (oximetazolina > 5 días consecutivos). La pérdida de eficacia y el empeoramiento de la obstrucción responden a la taquifilaxia y vasodilatación de rebote característica. La conducta clínica prioritaria es: (1) Explicar al paciente el mecanismo y suspender de forma tajante e inmediata el uso de oximetazolina; (2) Iniciar tratamiento con Corticoides Intranasales en dosis plenas (Furoato de fluticasona o Mometasona 2 puff en cada fosa nasal al día) durante al menos 1 a 2 meses para desinflamar la mucosa nasal; y (3) Asociar lavados nasales diarios con solución salina hipertónica o fisiológica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La clasificación ARIA divide la rinitis alérgica en intermitente (< 4d/sem o < 4 sem) vs persistente (≥ 4d/sem y ≥ 4 sem).
- La afectación del sueño, actividades o rendimiento laboral/escolar define a la rinitis como Moderada a Severa.
- Los corticoides intranasales (fluticasona, mometasona) son el fármaco de primera línea más eficaz para la rinitis alérgica moderada-severa.
- Los antihistamínicos orales de 2ª generación (cetirizina, desloratadina) no son sedantes y controlan prurito y estornudos, pero poco la congestión.
- La rinitis medicamentosa es causada por el uso de descongestionantes tópicos (oximetazolina) por más de 5 a 7 días.
- El tratamiento de la rinitis medicamentosa es la suspensión inmediata del vasoconstrictor y el inicio de corticoides intranasales.
- La rinitis vasomotora cursa con rinorrea acuosa ante cambios de temperatura sin prurito ni estornudos, tratándose con bromuro de ipratropio tópico.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.9

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.103

1. Un estudiante de 24 años consulta por rinorrea acuosa profusa, prurito ocular y nasal intenso y salvas de estornudos que se presentan durante 5 a 6 días a la semana desde hace 2 meses coincidiendo con la primavera. Relata que se despierta en la noche con la nariz totalmente obstruida y que esto afecta su concentración para estudiar. A la rinoscopía anterior se aprecian cornetes inferiores hipertróficos y pálidos. De acuerdo con las guías clínicas internacionales (ARIA), ¿cuál es la clasificación de su enfermedad y el tratamiento de primera línea más adecuado?

A) Rinitis alérgica intermitente leve; clorfenamina oral 4 mg cada 8 horas.
B) Rinitis alérgica persistente moderada-severa; corticoide intranasal en spray diario (ej. fluticasona o mometasona).
C) Rinitis vasomotora pura; bromuro de ipratropio nasal según necesidad.
D) Rinosinusitis crónica poliposa; amoxicilina oral con ácido clavulánico por 21 días.
E) Rinitis alérgica persistente leve; oximetazolina nasal tópica cada 12 horas por 1 mes.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.025

2. ¿Cuál es la causa subyacente y la conducta terapéutica correcta ante un paciente que presenta congestión nasal severa y empeoramiento clínico progresivo tras haber utilizado spray nasal de oximetazolina de venta libre de manera continua durante 4 semanas?

A) Sobreinfección bacteriana por Pseudomonas; indicar ciprofloxacino oral.
B) Rinitis medicamentosa por rebote vasomotor; suspender la oximetazolina e iniciar corticoides intranasales.
C) Poliposis nasal inducida por descongestionantes; derivar a cirugía endoscópica inmediata.
D) Desensibilización alérgica; aumentar la frecuencia de aplicación de oximetazolina a cada 4 horas.
E) Perforación del tabique nasal por toxicidad; realizar cauterización química urgente.

Más preguntas online de Rinitis Alérgica vs No Alérgica →

14.10. Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.029 6.03.1.026 2.01.1.005 2.01.4.008 1.05.1.022 6.03.1.030 6.03.4.001 6.03.4.003

¿POR QUÉ?

La inmensa mayoría de las rinosinusitis agudas son de origen viral (> 98%) y autolimitadas. Uno de los mayores desafíos en la práctica clínica ambulatoria es evitar la prescripción innecesaria de antibióticos en resfriados comunes. El EUNACOM exige reconocer con precisión los 3 criterios clínicos de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA) que confirman una etiología bacteriana (duración ≥ 10 días, doble caída o inicio severo) y diagnosticar de forma inmediata las complicaciones orbitarias (clasificación de Chandler) que amenazan la visión.

1. DEFINICIÓN Y FISIOPATOLOGÍA DE LA RINOSINUSITIS

2.01.1.029 6.03.1.026 1.05.1.022

La **Rinosinusitis Aguda (RSA)** se define como la inflamación de la mucosa de la cavidad nasal y de los senos paranasales de menos de 4 semanas de evolución, caracterizada por la presencia de al menos dos de los siguientes síntomas: (1) **Obstrucción/congestión nasal**; (2) **Rinorrea purulenta (anterior o descarga posterior)**; (3) **Dolor o sensación de presión facial** (frontal, maxilar o retroocular); y/o (4) **Hiposmia o anosmia**.

La causa desencadenante en más del 98% de los episodios es un **resfriado común viral** (rinovirus, influenza, parainfluenza) que inflama la mucosa del complejo ostiomeatal, obstruye los ostium de drenaje de los senos paranasales, paraliza el transporte mucociliar y altera la presión parcial de oxígeno intratélica, favoreciendo la sobreinfección bacteriana secundaria únicamente en el 0.5 a 2% de los casos.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE RINOSINUSITIS BACTERIANA AGUDA (RSBA)

2.01.1.029 6.03.1.026 1.05.1.022

Para evitar el sobreuso de antimicrobianos, las guías internacionales (IDSA/EPOS) establecen que la **Rinosinusitis Bacteriana Aguda (RSBA)** solo puede diagnosticarse de forma fundada si el paciente cumple **al menos uno de los tres siguientes criterios clínicos**:

1. Síntomas persistentes sin mejoría por ≥ 10 días: Obstrucción nasal, rinorrea purulenta o dolor facial que no muestran ningún signo de resolución tras 10 días de evolución.

2. Empeoramiento de síntomas ('Doble caída' o 'Double sickening'): Paciente que tras un cuadro de resfriado viral típico de 4-5 días comienza a mejorar, pero súbitamente presenta una recaída aguda con fiebre reaparecida, aumento de la cefalea y rinorrea francamente purulenta.

3. Inicio severo: Presencia concomitante de **fiebre alta (≥ 39°C) y rinorrea purulenta o dolor facial intenso durante al menos 3 a 4 días consecutivos** al inicio de la enfermedad.

2.01.1.029 6.03.1.026 1.05.1.022 2.01.4.008 6.03.4.001

El color verde o purulento de la secreción nasal por sí solo NO es diagnóstico de infección bacteriana, ya que la lisis de neutrófilos en cuadros virales genera coloración amarillenta o verdosa. **La radiografía simple de senos paranasales NO está indicada** debido a su baja especificidad y altos falsos positivos.

3. TERAPIA ANTIMICROBIANA ESCALONADA EN RSBA

2.01.1.029 6.03.1.026 1.05.1.022

Los microorganismos causales de RSBA son idénticos a los de la OMA: *Streptococcus pneumoniae* (30-40%), *Haemophilus influenzae* no tipificable (30%) y *Moraxella catarrhalis* (10%).

El antibiótico de **primera línea de elección es la Amoxicilina oral en dosis de 80-90 mg/kg/día en niños y 875/125 mg cada 12 horas o 1 g cada 12 horas en adultos** durante 7 a 10 días (5-7 días en adultos con buena respuesta). Si existe riesgo de cepas productoras de betalactamasas (uso de antibióticos en los últimos 30 días, enfermedad crónica o falla a las 48-72h), se indica **Amoxicilina + Ácido Clavulánico** oral. Como terapia coadyuvante son de gran utilidad los lavados nasales con solución salina fisiológica y los corticoides intranasales.

4. COMPLICACIONES ORBITARIAS: CLASIFICACIÓN DE CHANDLER Y URGENCIA

2.01.1.005

Debido a la extrema delgadez de la **lámina papirácea del etmoides**, los senos etmoidales son el punto de partida del 80-90% de las complicaciones orbitarias en niños. Se clasifican según Hubert Chandler:

Grupo I: Celulitis Preseptal (Periorbitaria): Edema y eritema palpebral por delante del septum orbitario; la agudeza visual, los movimientos oculares y la pupila son **rigurosamente normales, sin proptosis**. Tratamiento ambulatorio u hospitalario con antibióticos orales o EV. **(ver Imagen 14.10A)**

Grupo II: Celulitis Orbitaria (Postseptal): Infección difusa de la grasa orbitaria. Se caracteriza por **proptosis (exoftalmos), oftalmoplejía dolorosa y quemosis conjuntival**.

Grupo III: Absceso Subperióstico: Colección purulenta entre la lámina papirácea y el periostio orbitario, desplazando el globo ocular hacia abajo y afuera. **(ver Imagen 14.10B)**

Grupo IV: Absceso Orbitario: Colección purulenta intraparenquimatosa orbitaria con grave deterioro de la agudeza visual y defecto pupilar aferente relativo.

Grupo V: Trombosis del Seno Cavernoso: Complicación fatal con afección orbitaria bilateral rápidamente progresiva, parálisis de los pares craneales III, IV, V1, V2 y VI y signos de sepsis.

2.01.1.005 6.03.4.003

Ante cualquier signo de alarma orbitaria (proptosis, limitación de movimientos oculares o caída de la visión), la conducta obligatoria es la **hospitalización inmediata, TAC de senos y órbitas con contraste y Ceftriaxona EV + Vancomicina**, con drenaje quirúrgico urgente por ORL si existe colección.

5. RINOSINUSITIS CRÓNICA, IMÁGENES DE SENOS PARANASALES E INFECCIONES DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR

6.03.1.030

Las **sinusopatías crónicas** (rinosinusitis crónica, con o sin pólipos) se definen por síntomas que duran **12 semanas o más**: al menos dos entre obstrucción o congestión nasal, rinorrea mucopurulenta o goteo posterior, dolor o presión facial e hiposmia, con inflamación demostrada por endoscopía o TAC. Se asocian a rinitis alérgica, desviación septal, infección dentaria, fibrosis quística, inmunodeficiencias y a la triada de Samter (poliposis, asma, intolerancia a AAS). Manejo inicial: **lavados nasales salinos de alto volumen y corticoide nasal diario**, control del alérgeno; el antibiótico se reserva para las exacerbaciones bacterianas. Se **deriva** a ORL por falla de 8 a 12 semanas de tratamiento, enfermedad unilateral, sospecha de tumor o complicación, para endoscopía, TAC y eventual cirugía endoscópica funcional.

2.01.4.008 6.03.4.001

La **radiografía de senos paranasales** (proyecciones de Waters o mentonasoplaca para los maxilares, Caldwell para frontoetmoidales y lateral) muestra **velamiento, nivel hidroaéreo o engrosamiento mucoso**. Su rendimiento es bajo (sensibilidad y especificidad limitadas): **no se pide en la rinosinusitis aguda**, cuyo diagnóstico es clínico, y un velamiento puede aparecer en un resfrío viral. En menores de 6 años el seno frontal no está desarrollado y los maxilares son pequeños, lo que dificulta la lectura. Se reserva para entornos sin acceso a TAC, y un nivel hidroaéreo tras un traumatismo sugiere hemosinus.

La **TAC de cavidades perinasales** es el examen de imagen de elección y se solicita en rinosinusitis crónica refractaria, planificación quirúrgica, enfermedad unilateral y sospecha de complicación (con contraste si hay compromiso orbitario o intracraneal). El informe describe el engrosamiento mucoso, niveles hidroaéreos, ocupación del **complejo osteomeatal**, pólipos, desviación septal, concha bullosa y erosión ósea (tumor, mucormicosis, mucocele), y suele cuantificarse con la escala de Lund-Mackay (0 a 24). Hallazgos en la TAC son frecuentes en personas asintomáticas: siempre se correlacionan con la clínica. 6.03.4.003

Las **infecciones de las vías aéreas superiores** (resfrío común, faringoamigdalitis, rinosinusitis, laringitis, otitis media) son en su gran mayoría virales y autolimitadas (7 a 10 días); se manejan con hidratación, lavados nasales, antipiréticos y reposo, **sin antibióticos**. En las **rinorreas agudas**, la secreción mucopurulenta no implica etiología bacteriana por sí sola: se sospecha bacteriana si persiste más de 10 días sin mejoría, hay doble empeoramiento o fiebre alta con secreción purulenta por 3 a 4 días. Otras causas de rinorrea aguda son la rinitis alérgica estacional, el cuerpo extraño nasal (unilateral y fétida en niños) y la fístula de LCR (acuosa unilateral tras trauma). 1.05.1.022 6.03.1.026



A. EDEMA PALPEBRAL, ETMOIDITIS



B. TAC: ABSCESO SUBPERIÓSTICO

Imagen 14.10

FIGURA 14.10 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE RINOSINUSITIS AGUDA Y MANEJO DE COMPLICACIONES

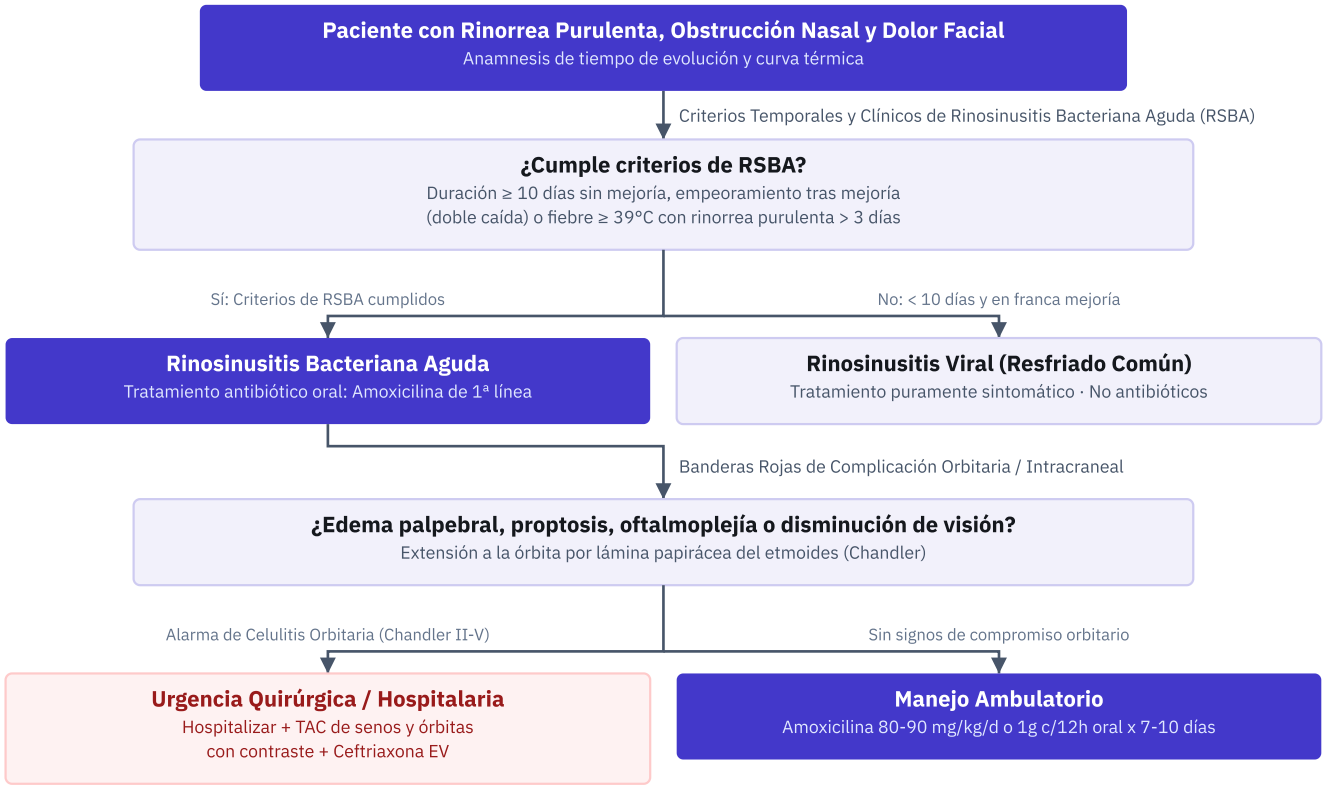


TABLA 14.10 · CLASIFICACIÓN DE CHANDLER DE COMPLICACIONES ORBITARIAS DE LA RINOSINUSITIS

2.01.1.029, 6.03.1.026, 2.01.1.005, 2.01.4.008, 1.05.1.022, 6.03.1.030, 6.03.4.001, 6.03.4.003

ESTADIO CHANDLER	AFECTACIÓN ANATÓMICA	SIGNOS CLÍNICOS CLAVE	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
I: Celulitis Preseptal	Tejido celular subcutáneo anterior al septum orbitario	Edema y eritema palpebral · Motilidad y visión normales	Amoxicilina-Clavulánico oral o Cefazolina EV si lactante
II: Celulitis Orbitaria	Grasa orbitaria profunda (posterior al septum)	Proptosis, oftalmoplejía dolorosa y quemosis	Hospitalización urgente + TAC de órbitas + Ceftriaxona EV
III: Absceso Subperióstico	Colección purulenta bajo el periostio orbitario / etmoides	Globo ocular desplazado hacia abajo y afuera, diplopía	TAC con contraste + Drenaje quirúrgico urgente por ORL
IV: Absceso Orbitario	Pus en el espacio conal/intraconal de la órbita	Oftalmoplejía completa, pérdida visual severa, amaurosis	Drenaje quirúrgico descompresivo de emergencia + Antibióticos EV
V: Trombosis Seno Cavernoso	Extensión retrógrada séptica a través de venas oftálmicas	Proptosis bilateral, compromiso pares III, IV, V1, VI, estupor	UCI, Ceftriaxona + Vancomicina + Heparina anticoagulante

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 14.10

Un niño de 7 años presenta cuadro de 6 días de rinorrea mucopurulenta bilateral y congestión nasal tratado sintomáticamente como resfriado común. En las últimas 24 horas presenta fiebre alta de 39.4°C y su madre nota tumefacción progresiva en el ojo izquierdo. Al examen físico se aprecia edema y eritema palpebral marcado en el ojo izquierdo, junto con proptosis evidente del globo ocular y limitación muy dolorosa a la abducción y elevación de dicho ojo. La agudeza visual se encuentra conservada por el momento.

Conducta oficial. El paciente presenta una Celulitis Orbitaria (postseptal, Chandler grado II) del ojo izquierdo desarrollada como complicación aguda de una rinosinusitis etmoidal. La presencia de proptosis y oftalmoplejía dolorosa confirma de forma indiscutible que el proceso infeccioso ha franqueado el septum orbitario a través de la lámina papirácea hacia la cavidad orbitaria profunda, diferenciándola de una celulitis preseptal simple. Esta condición es una emergencia otorrinolaringológica y oftalmológica por el alto riesgo de absceso orbitario, amaurosis irreversible por compresión del nervio óptico y trombosis del seno cavernoso. La conducta inmediata mandataria es la hospitalización urgente, toma de hemocultivos, solicitud de Tomografía Computarizada (TAC) de cavidades paranasales y órbitas con contraste endovenoso, e inicio inmediato de antibioticoterapia parenteral de amplio espectro (Ceftriaxona EV asociada a Clindamicina o Vancomicina).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La rinosinusitis bacteriana se diagnostica con: síntomas ≥ 10 días, o empeoramiento tras mejoría (doble caída), o fiebre ≥ 39°C con secreción purulenta > 3 días.
- El color verdoso o purulento de la mucosidad nasal NO indica por sí solo infección bacteriana ni justifica antibióticos.
- La radiografía de senos paranasales está en desuso y no se recomienda para el diagnóstico de rinosinusitis aguda no complicada.
- El antibiótico oral de primera línea para la RSBA es la Amoxicilina (o Amoxicilina con Ácido Clavulánico) por 7 a 10 días.
- La celulitis preseptal presenta párpado inflamado con motilidad ocular y agudeza visual rigurosamente normales.
- La celulitis orbitaria se distingue por proptosis (exoftalmos), oftalmoplejía dolorosa y quemosis conjuntival.
- Toda sospecha de complicación orbitaria exige hospitalización inmediata, TAC de órbitas y senos con contraste y antibióticos EV.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.10

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.029

1. Un hombre de 32 años consulta por cuadro de congestión nasal, rinorrea amarillenta espesa y cefalea frontal opresiva de 12 días de evolución sin mejoría. Refiere haber utilizado paracetamol e inhalaciones de vapor sin experimentar alivio. No presenta fiebre actual ni alteraciones visuales. Al examen físico se aprecia descarga mucopurulenta en el meato medio a la rinoscopía anterior y sensibilidad a la palpación sobre ambos senos maxilares. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta de elección?

A) Rinitis alérgica estacional; iniciar antihistamínicos orales y derivar a inmunoterapia.
B) Rinosinusitis viral no complicada; mantener analgesia sintomática exclusiva por 10 días más.
C) Rinosinusitis bacteriana aguda; iniciar tratamiento con amoxicilina oral por 7 a 10 días.
D) Sinusitis fúngica invasora; hospitalizar para debridamiento quirúrgico inmediato.
E) Poliposis nasal sobreinfectada; solicitar radiografía simple de cráneo en proyección de Waters.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.005

2. Un escolar de 8 años con rinosinusitis aguda presenta aumento de volumen y eritema palpebral izquierdo. Al examen físico se comprueba limitación en la aducción y abducción del ojo izquierdo, diplopía y proptosis del globo ocular. La agudeza visual se mantiene conservada. ¿A cuál de los siguientes estadios de la clasificación de Chandler corresponde este cuadro clínico?

A) Estadio I: Celulitis preseptal o periorbitaria.
B) Estadio II: Celulitis orbitaria postseptal.
C) Estadio III: Absceso subperióstico.
D) Estadio IV: Absceso orbitario con pérdida visual.
E) Estadio V: Trombosis séptica del seno cavernoso.

Más preguntas online de Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana →

14.11. Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.03.1.012 | 6.03.2.011 | 6.03.5.012 | 6.03.5.014 | 2.01.1.099 | 2.01.2.008 | 6.03.1.011

¿POR QUÉ?

La epistaxis es una de las urgencias otorrinolaringológicas más prevalentes en servicios de urgencia y atención primaria. El examen EUNACOM evalúa rigurosamente el escalonamiento terapéutico estandarizado: compresión digital firme con cabeza hacia adelante -> aplicación de vasoconstrictores tópicos -> cauterización química puntual con nitrato de plata -> taponamiento anterior. Asimismo, se evalúa la identificación de la epistaxis posterior (origen en arteria esfenopalatina en adultos mayores hipertensos), la cual es potencialmente letal y exige taponamiento posterior con sonda Foley, hospitalización obligatoria y cobertura antibiótica profiláctica para evitar el síndrome de shock tóxico.

1. ANATOMÍA VASCULAR NASAL: PLEXO DE KIESSELBACH VS ARTERIA ESFENOPALATINA

La vascularización nasal proviene de ramas de los sistemas de la arteria carótida externa e interna:

Epistaxis Anterior (> 90% de los casos): Se origina en el **Plexo de Kiesselbach (Área de Little)**, ubicado en la porción anteroinferior del tabique nasal cartilaginoso. Es una anastomosis ricamente vascularizada entre: la arteria labial superior (rama de la facial), la arteria palatina mayor, la arteria esfenopalatina (rama terminal de la maxilar interna) y las arterias etmoidales anteriores. Es la forma clásica en niños, adolescentes y adultos jóvenes, habitualmente benigna, autolimitada y secundaria a microtraumatismos (hurgado nasal digital), resequedad ambiental o rinitis alérgica. **(ver Imagen 14.11)** 2.01.1.099 | 2.01.2.008 | 6.03.1.012

Epistaxis Posterior (5-10% de los casos): Se origina predominantemente en las ramas posteriores de la **Arteria Esfenopalatina** o en el plexo de Woodruff (pared posterolateral de la cavidad nasal). Ocurre típicamente en **adultos mayores con hipertensión arterial crónica, ateroesclerosis o coagulopatías/anticoagulación**. El sangrado es profuso, incoercible, bilateral y fluye de forma constante hacia la orofaringe y vía aérea digestiva, con alto riesgo de shock hipovolémico y aspiración. 2.01.1.099 | 2.01.2.008 | 6.03.2.011

2. MANEJO ESCALONADO DE URGENCIA EN EPISTAXIS ANTERIOR

El enfrentamiento de la epistaxis anterior sigue una secuencia protocolizada ineludible: 2.01.1.099 | 2.01.2.008 | 6.03.1.012

Paso 1: Medidas Generales y Compresión Digital: Paciente sentado con el tronco y la **cabeza inclinados ligeramente hacia adelante** (¡nunca hacia atrás, para evitar la deglución de sangre que induce vómitos y broncoaspiración!). Se indica al paciente sonarse suavemente para expulsar coágulos y se aplica **compresión digital bimanual firme sobre el tercio inferior cartilaginoso de la nariz (alas nasales contra el tabique) durante 10 a 15 minutos continuos de reloj**. Esta medida resuelve el 70-80% de los episodios.

Paso 2: Vasoconstrictor Tópico: Si persiste el sangrado, se coloca un algodón embebido en solución anestésica y vasoconstrictora (Lidocaína al 2% con adrenalina o nafazolina/oximetazolina) a presión moderada en la fosa nasal por 5 a 10 minutos.

Paso 3: Cauterización Química o Eléctrica: Al retirar el algodón, si se visualiza el vaso sangrante en el plexo de Kiesselbach, se procede a la **cauterización química con barra de Nitrato de Plata al 75%**, aplicándola suavemente en forma concéntrica alrededor del vaso sangrante durante unos segundos. *Regla de Oro: ¡PROHIBIDO cauterizar ambos lados del tabique nasal simultáneamente!* (riesgo inminente de necrosis isquémica del cartílago y perforación septal permanente).

Paso 4: Taponamiento Anterior: Si no se logra ubicar el vaso o la cauterización fracasa, se realiza un **taponamiento nasal anterior** utilizando gasa orillada con vaselina sólida o esponjas hemostáticas expansibles de alcohol polivinílico (Merocel). Debe introducirse en capas de acordeón hacia el piso de la fosa nasal. Se mantiene colocado por **48 horas**, prescribiendo reposo relativo, lubricación tópica y no suspender analgesia. 2.01.1.099 | 2.01.2.008 | 6.03.1.012 | 6.03.5.012

TABLA 14.11.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y MANEJO: EPISTAXIS ANTERIOR VS EPISTAXIS POSTERIOR

6.03.1.012, 6.03.2.011, 6.03.5.012, 6.03.5.014, 2.01.1.099, 2.01.2.008, 6.03.1.011

PARÁMETRO CLÍNICO	EPISTAXIS ANTERIOR (KIESSELBACH)	EPISTAXIS POSTERIOR (ESFENOPALATINA)
Frecuencia Relativa	90 a 95% de todas las consultas por epistaxis	5 a 10% de los casos (alta gravedad clínica)
Población Típica	Niños, adolescentes y adultos jóvenes sanos	Adultos mayores (> 60 años), hipertensos crónicos, aterosclerosis
Vaso Sanguíneo Causal	Plexo de Kiesselbach (Área de Little anteroinferior)	Arteria Esfenopalatina o ramas de la maxilar interna
Inspección Faríngea	Escasa o nula sangre en pared posterior faríngea	Flujo continuo y profuso de sangre roja fresca en orofaringe
Manejo Inicial de Elección	Compresión digital x 15 min -> Nitrato de plata -> Taponamiento anterior	Taponamiento posterior con Sonda Foley insuflada + Taponamiento anterior
Destino del Paciente	Ambulatorio (retiro de Merocel a las 48 horas)	Hospitalización OBLIGATORIA + Antibióticos EV/orales profilácticos

14.11. Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos — Enfrentamiento Diagnóstico

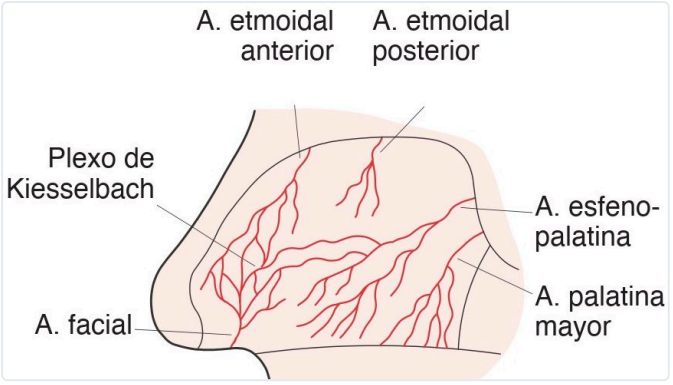
3. EPISTAXIS POSTERIOR: SONDA FOLEY, TAPONAMIENTO Y HOSPITALIZACIÓN

Se debe sospechar una **epistaxis posterior** cuando el taponamiento anterior bien realizado no detiene el sangrado y se observa un flujo constante de sangre roja fresca cayendo por la pared posterior de la faringe a través de la úvula, o en pacientes mayores con epistaxis masiva que compromete los signos vitales. 2.01.1.099 2.01.2.008 6.03.2.011

Taponamiento Posterior con Sonda Foley: En el box de urgencia, el procedimiento de elección es introducir por la fosa sangrante una **sonda vesical Foley N° 12 o 14 Fr lubricada** hasta que la punta sea visible en la orofaringe; se insufla el balón con **8 a 10 mL de agua destilada o suero** (nunca aire), se tracciona suavemente hacia adelante para impactar el balón en la coana posterior ocluida, y se fija a nivel de la columela con protección de gasa para evitar la necrosis alar. 2.01.1.099 2.01.2.008 6.03.2.011 6.03.5.014

Posteriormente, se complementa siempre con un **taponamiento anterior ipsilateral**.

Protocolo Hospitalario Mandatorio: Todo paciente con taponamiento posterior requiere: (1) **Hospitalización obligatoria** con monitorización hemodinámica continua (riesgo de hipoxemia, bradiarritmias por reflejo nasovagal y aspiración); (2) **Profilaxis antibiótica sistémica obligatoria** (Amoxicilina-Clavulánico o Cefazolina) para prevenir el **Síndrome de Shock Tóxico estafilocócico y la rinosinusitis secundaria** por obstrucción de ostium; y (3) Retiro programado del tapón a las 48-72 horas por especialista ORL (o ligadura endoscópica de arteria esfenopalatina en pabellón si hay fracaso). 2.01.1.099 2.01.2.008 6.03.2.011



IRRIGACIÓN DEL TABIQUE

Imagen 14.11

FIGURA 14.11 · ALGORITMO DE MANEJO ESCALONADO DE URGENCIA EN EPISTAXIS ANTERIOR Y POSTERIOR

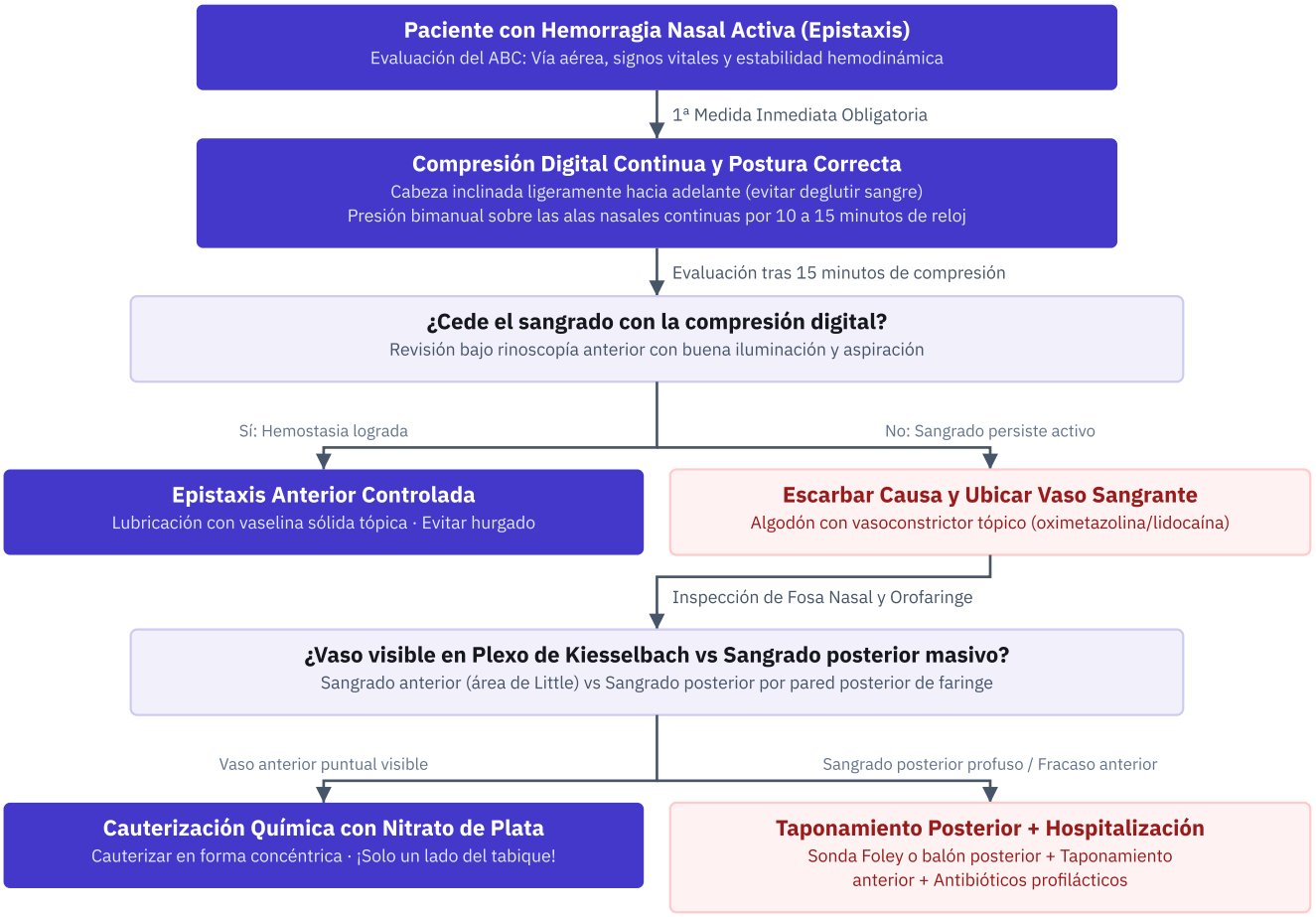


TABLA 14.11.B · ESTRATIFICACIÓN DE GRAVEDAD Y RIESGO HEMODINÁMICO EN EPISTAXIS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	SIGNOS CLÍNICOS / HEMODINÁMICOS	RIESGO COMPLICACIONES	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
Epistaxis Leve	Signos vitales normales, sangrado anterior unilateral autolimitado	Mínimo · Cese espontáneo	Compresión digital de alas nasales x 15 minutos en postura anterior
Epistaxis Moderada	Sangrado activo continuo, no cede a compresión digital, signos vitales estables	Anemización leve, recidiva	Vasoconstrictor tópico + Cauterización química con nitrato de plata o Merocel
Epistaxis Severa / Posterior	Sangrado profuso posterior, taquicardia, hipotensión, shock hipovolémico	Alto: Shock, paro hipóxico, broncoaspiración	ABC de reanimación, dos vías venosas, Sonda Foley posterior + Hospitalización urgente

14.11. Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. EPISTAXIS A REPETICIÓN: ESTUDIO DE CAUSAS

La **epistaxis a repetición** exige buscar la causa. Las **causas locales** más frecuentes son la sequedad e irritación del plexo de Kiesselbach, el rascado digital, la rinitis, la desviación septal y las telangiectasias de la **enfermedad de Rendu-Osler-Weber**; en un adolescente varón con epistaxis unilateral y obstrucción nasal se sospecha **angiofibroma nasofaríngeo juvenil** y en el adulto un tumor nasosinusal. Las **causas sistémicas** son hipertensión arterial, coagulopatías (enfermedad de von Willebrand, hemofilia), trombocitopenia, hepatopatía, insuficiencia renal, leucemias y fármacos (anticoagulantes, antiagregantes, AINE). 6.03.1.011

Estudio inicial: presión arterial, rinoscopía anterior, **hemograma con recuento de plaquetas, TP/INR y TTPK**, función hepática y renal, y revisión de fármacos. Tratamiento del punto sangrante visible: **cauterización con nitrato de plata**, pomadas emolientes o antibióticas, humidificación y lavados con suero; evitar el rascado. Se **deriva** para endoscopía nasal si es unilateral y recurrente, sin foco evidente, ante sospecha de tumor o si se asocia a otras manifestaciones hemorrágicas.

TABLA 14.11.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO EN EPISTAXIS DE URGENCIA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESCALÓN TERAPÉUTICO	INTERVENCIÓN CLÍNICA	DETALLES TÉCNICOS Y FÁRMACOS	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Escalón 1	Compresión digital directa	Pinzar alas nasales contra tabique x 15 min continuos	Cabeza hacia adelante · Respirar por la boca
Escalón 2	Vasoconstricción tópica	Cotón con Lidocaína al 2% + Adrenalina u Oximetazolina	Dejar colocado 5-10 minutos en la fosa nasal
Escalón 3	Cauterización química puntual	Nitrato de Plata al 75% en bastón concéntrico	PROHIBIDO cauterizar ambos lados del tabique (perforación)
Escalón 4	Taponamiento anterior	Gasa vaselinada o esponja de Merocel x 48 horas	Colocar en plano horizontal hacia el piso nasal
Escalón 5	Taponamiento posterior	Sonda Foley N° 12-14 insuflada con 8-10 mL de agua	Hospitalizar + Amoxicilina-Clavulánico profiláctico obligatorio

14.11. Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (EPISTAXIS ANTERIOR VS POSTERIOR)

- El 90% de las epistaxis son anteriores y se originan en el Plexo de Kiesselbach (Área de Little) en el tabique anteroinferior.
- Está terminantemente prohibido cauterizar ambos lados del tabique nasal simultáneamente por riesgo de perforación septal.
- La epistaxis posterior proviene habitualmente de la arteria esfenopalatina en adultos mayores hipertensos y fluye hacia la orofaringe.
- Todo taponamiento posterior requiere profilaxis antibiótica (amoxicilina-clavulánico) para prevenir el Síndrome de Shock Tóxico estafilocócico.
- La primera medida obligatoria en epistaxis anterior es la compresión digital de las alas nasales con cabeza inclinada hacia adelante por 15 minutos.
- El taponamiento anterior (Merocel o gasa) se retira habitualmente a las 48 horas.
- El taponamiento posterior se realiza con sonda Foley insuflada con agua en la nasofaringe y exige HOSPITALIZACIÓN obligatoria.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

14.11

Un hombre de 71 años, hipertenso crónico en tratamiento irregular con enalapril, es traído al servicio de urgencia con sangrado nasal bilateral abundante de 1 hora de evolución. Al ingreso se encuentra pálido, sudoroso, con presión arterial de 190/105 mmHg y frecuencia cardíaca de 105 lpm. Se le realiza compresión digital de las alas nasales durante 15 minutos y se coloca taponamiento nasal anterior con Merocel bilateral sin éxito, observándose abundante sangre roja rutilante cayendo de manera continua por la pared posterior de la orofaringe que le provoca accesos de tos y arcadas.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico corresponde a una Epistaxis Posterior masiva, originada con altísima probabilidad en ramas de la arteria esfenopalatina en un paciente adulto mayor hipertenso con crisis hipertensiva reactiva. La falla del taponamiento anterior y la persistencia de sangrado profuso hacia la orofaringe confirman el origen posterior. La conducta inmediata de elección para el control de la hemorragia es la realización de un Taponamiento Posterior mediante la colocación de una sonda vesical Foley insuflada con 8 a 10 mL de solución salina en la nasofaringe, traccionada y anclada en la coana, asociada a nuevo taponamiento anterior ipsilateral. El paciente debe ser obligatoriamente hospitalizado en cama monitorizada, iniciar control paulatino de la presión arterial, solicitar pruebas de coagulación y hemograma, e instaurar antibioticoterapia profiláctica oral o EV con Amoxicilina-Clavulánico para prevenir el síndrome de shock tóxico y rinosinusitis aguda mientras permanezca el tapón (48-72 horas).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.11 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.012

1. Un niño de 9 años consulta en el servicio de urgencia por sangrado nasal derecho activo tras hurgarse la nariz. Al examen físico se encuentra hemodinámicamente estable. Se realiza compresión bimanual de las alas nasales durante 15 minutos continuos con cabeza hacia adelante, pero al soltar persiste sangrado leve. Al colocar un algodón con vasoconstrictor y retirar bajo buena luz con espéculo nasal, se visualiza claramente un vaso sangrante superficial en la porción anteroinferior del tabique nasal derecho. ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección a continuación?

A) Realizar taponamiento nasal posterior con sonda Foley de urgencia.
B) Cauterización química del vaso sangrante con bastón de nitrato de plata.
C) Indicar ácido tranexámico endovenoso y hospitalizar para observación.
D) Cauterización bilateral simultánea de ambas caras del tabique nasal.
E) Indicar al paciente mantener la cabeza inclinada hacia atrás durante las próximas 4 horas.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.011

2. Una paciente de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial presenta epistaxis masiva que no ha cedido tras taponamiento anterior bilateral con Merocel, evidenciándose sangrado activo continuo y abundante por la faringe posterior. Se decide realizar taponamiento nasal posterior con sonda Foley. Respecto al manejo integral de esta paciente, ¿cuál de las siguientes medidas es una indicación OBLIGATORIA?

A) Alta inmediata a domicilio con indicación de retirar la sonda Foley a las 12 horas.
B) Hospitalización con monitorización de signos vitales e inicio de antibióticos profilácticos sistémicos.
C) Insuflar el balón de la sonda Foley con 25 mL de aire para asegurar hemostasia máxima.
D) Suspensión absoluta de toda hidratación parenteral y mantener presión arterial sistólica sobre 180 mmHg.
E) Realizar cauterización a ciegas con nitrato de plata de la pared posterior de la orofaringe.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.012

3. ¿Cuál es la anastomosis arterial responsable de la gran mayoría de las epistaxis anteriores en niños y adultos jóvenes, localizada en la región anteroinferior del tabique nasal?

A) Plexo venoso pampiniforme.
B) Plexo de Kiesselbach (Área de Little).
C) Plexo venoso de Woodruff.
D) Arteria carótida interna terminal.
E) Arteria meníngea media.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.012

4. ¿Por qué motivo está formalmente contraindicado realizar cauterización con nitrato de plata en ambas caras del tabique nasal de forma simultánea en una misma sesión?

A) Porque induce una crisis hipertensiva severa mediada por barorreceptores.
B) Por el riesgo de provocar isquemia, necrosis avascular y perforación septal permanente.
C) Porque aumenta el riesgo de desarrollar poliposis nasal alérgica difusa.
D) Porque desencadena parálisis del nervio olfatorio con anosmia irreversible.
E) Porque genera una sobreinfección inmediata por Pseudomonas aeruginosa.

Más preguntas online de Epistaxis Anterior vs Posterior →

14.12. Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.03.1.024 6.03.1.016 6.03.2.012 6.03.2.013 6.03.5.004

¿POR QUÉ?

Las alteraciones estructurales e inflamatorias crónicas de la cavidad nasal comparten el síntoma cardinal de insuficiencia ventilatoria nasal. En el traumatismo nasal agudo, la máxima prioridad que evalúa el EUNACOM es el descarte obligatorio del hematoma septal mediante rinoscopía, el cual constituye una urgencia quirúrgica inmediata para evitar la necrosis del cartílago y la 'nariz en silla de montar'. Por otra parte, la poliposis nasal bilateral exige investigar la tríada de Samter (poliposis, asma bronquial y broncoespasmo grave por AINEs), mientras que un pólipo unilateral siempre obliga a descartar papiloma invertido o neoplasia maligna.

1. FRACTURA NASAL Y LA URGENCIA DEL HEMATOMA SEPTAL

La **fractura nasal** es la fractura facial más frecuente. Se manifiesta clínicamente por epistaxis inicial, dolor local, edema de partes blandas, deformidad o laterorrinia evidente y crepitación ósea a la palpación cuidadosa del dorso nasal. La radiografía simple de huesos propios de la nariz tiene valor médico-legal pero el diagnóstico y la indicación quirúrgica son **estrictamente clínicos**. **(ver Imagen 14.12A)** 6.03.2.012

Hematoma Septal (Urgencia Máxima): En todo paciente con trauma nasal es **obligatorio realizar una rinoscopía anterior para descartar un hematoma del tabique**. Se produce por la rotura de vasos submucosos con acumulación de sangre entre el cartílago cuadrangular y el pericondrio, observándose como un **abombamiento fluctuante, rojo-violáceo o azulado, blando al tacto, habitualmente bilateral en el tabique que ocluye las fosas nasales**. **(ver Imagen 14.12B)** 6.03.2.013



Hematoma septal bilateral

Conducta Inmediata: Dado que el cartílago septal carece de irrigación propia y se nutre por difusión desde el pericondrio, el hematoma provoca **isquemia y necrosis avascular del cartílago en 24 a 48 horas**, con riesgo de sobreinfección (absceso septal) y pérdida definitiva del soporte nasal dorsal (**deformidad en silla de montar**). Su tratamiento es el **drenaje quirúrgico urgente por incisión y aspiración de los coágulos, seguido de taponamiento nasal bilateral compresivo y cobertura antibiótica**. 6.03.2.013 6.03.5.004

2. POLIPOSIS NASAL Y TRÍADA DE WIDAL / SAMTER (ENFERMEDAD RESPIRATORIA EXACERBADA POR ASPIRINA)

Los **pólipos nasales** son formaciones tumorales benignas y edematosas de la mucosa de los senos paranasales (principalmente etmoidales) que prolapsan hacia la cavidad nasal. A la rinoscopía anterior o nasofibroscopía se aprecian como **masas lisas, brillantes, translúcidas de color blanco-grisáceo o perlado ('aspecto de uva pelada'), indoloras a la palpación e insensibles al tacto**, a diferencia de los cornetes que son rojizos y muy sensibles. 6.03.1.024 6.03.1.016



Pólipos nasales extensos que asoman a la orofaringe

La **Tríada de Samter (o de Widal / EREA: Enfermedad Respiratoria Exacerbada por Aspirina)** es una entidad clínica de altísima relevancia para el EUNACOM caracterizada por la asociación de: **(1) Poliposis nasal bilateral extensa; (2) Asma bronquial de difícil control; y (3) Intolerancia o broncoespasmo grave inducido por Aspirina (AAS) y antiinflamatorios no esteroidales (AINEs)**. 6.03.1.024

Tratamiento de la Poliposis: Primera línea: **Corticoides intranasales en dosis altas continuos** (mometasona o fluticasona) asociados a ciclos breves de corticoides orales (prednisona). En casos refractarios o con obstrucción total: **Cirugía Endoscópica Funcional de Senos Paranasales (FESS)** o terapias biológicas anti-IL-4/IL-13 (Dupilumab). 6.03.1.024 6.03.1.016

Alerta EUNACOM: Todo **pólipo nasal unilateral en un adulto** debe considerarse sospechoso de **Papiloma Invertido** (tumor epitelial benigno pero localmente invasivo con 10% de degeneración maligna a carcinoma espinocelular) o adenocarcinoma, exigiendo biopsia y TAC. **(ver Imagen 14.12C)** 6.03.1.024

3. DESVIACIÓN DEL TABIQUE NASAL E HIPERTROFIA COMPENSATORIA

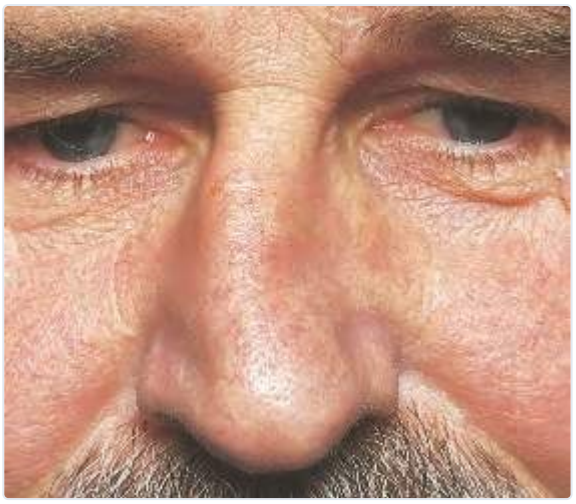
La **desviación septal** es una deformidad congénita o postraumática del tabique nasal óseo o cartilaginoso. Produce una obstrucción ventilatoria nasal mecánica fija y constante, predominantemente unilateral. 6.03.1.016

De forma fisiopatológica clásica, la fosa nasal contralateral (más ancha) desarrolla una **hipertrofia compensatoria del cornete inferior** para regular la resistencia nasal y acondicionar el aire inspirado. El tratamiento sintomático inicial incluye corticoides intranasales; la corrección definitiva es quirúrgica mediante **septoplastia electiva** (asociada habitualmente a turbinoplastia del cornete hipertrófico) cuando la obstrucción genera síntomas invalidantes o se asocia a rinosinusitis recurrente o SAHOS.

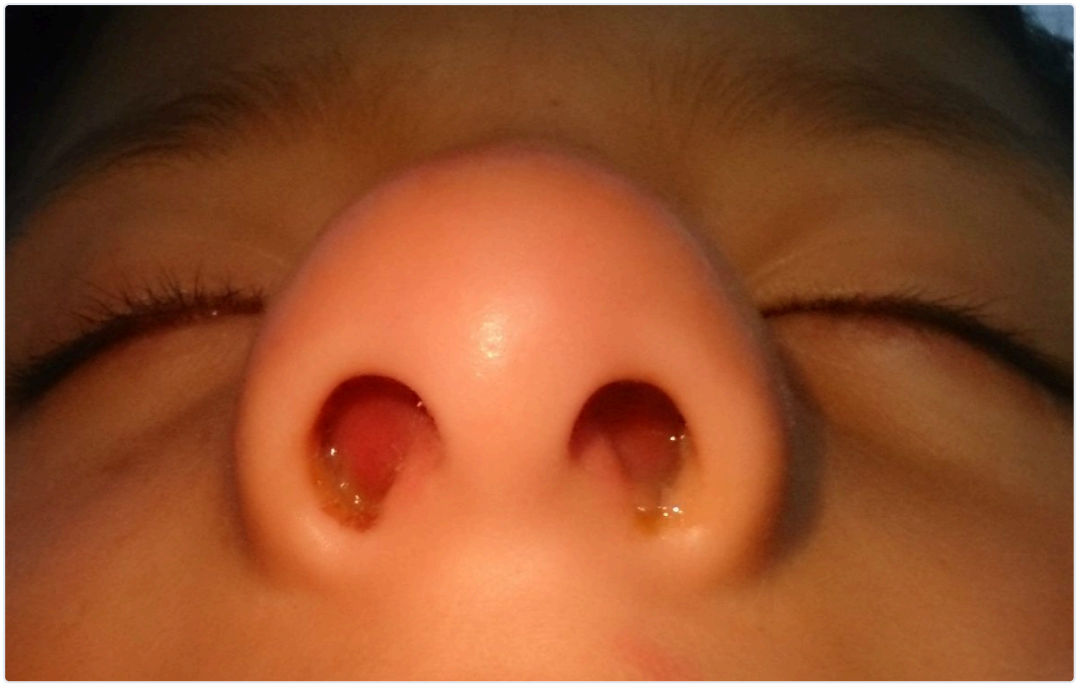
4. HEMATOMA NASOSEPTAL: CONDUCTA INICIAL Y DERIVACIÓN PARA SU DRENAJE

El **drenaje del hematoma nasoseptal** se deriva a especialista y debe hacerse con urgencia, idealmente en las primeras 24 horas, porque el cartílago septal depende del pericondrio para su irrigación y se necrosa. El médico general sospecha el hematoma ante un trauma nasal con obstrucción nasal bilateral y un abultamiento rojo-azulado y blando del tabique que no se retrae con descongestionante; mientras se traslada indica analgesia, hielo local, cabecera elevada y antibiótico profiláctico (amoxicilina-ácido clavulánico). El especialista incide el mucopericondrio, evacúa la sangre y deja **taponamiento bilateral** o una lámina de silicona. Si se demora, aparecen absceso septal, **nariz en silla de montar**, perforación 6.03.5.004

septal y complicaciones intracraneales (meningitis, trombosis del seno cavernoso).



A. LATERORRINIA TRAS UN GOLPE



B. HEMATOMA SEPTAL BILATERAL



C. PÓLIPO HASTA LA OROFARINGE

Imagen 14.12

FIGURA 14.12 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO EN PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y OBSTRUCTIVA NASAL

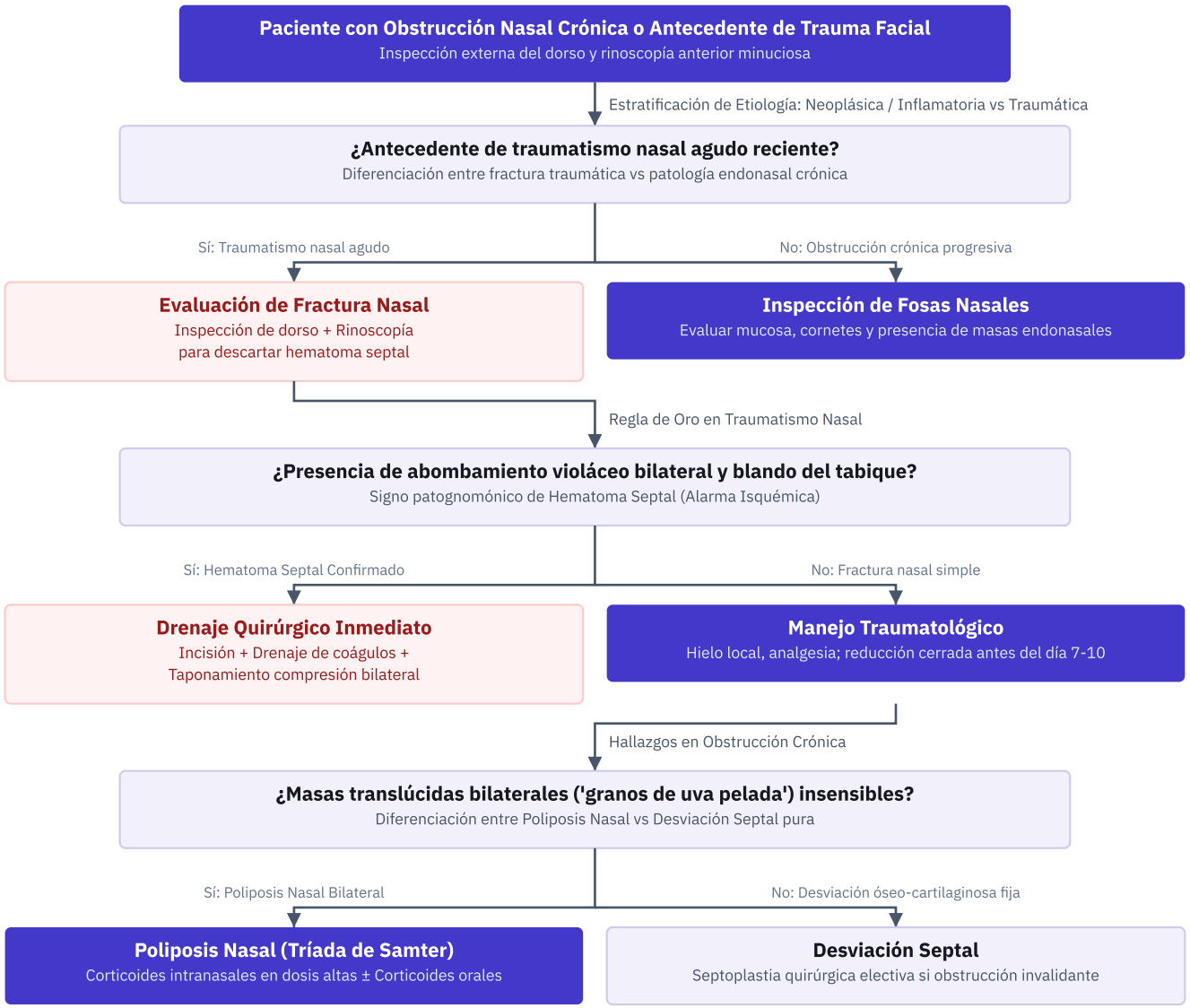


TABLA 14.12 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: POLIPOSIS NASAL VS CORNETE HIPERTRÓFICO VS HEMATOMA SEPTAL

6.03.1.024, 6.03.1.016, 6.03.2.012, 6.03.2.013, 6.03.5.004

LESIÓN ENDONASAL	ASPECTO A LA RINOSCOPÍA	SENSIBILIDAD AL TACTO	CONDUCTA TERAPÉUTICA INMEDIATA
Pólipo Nasal Benigno	Masa translúcida brillante, blanco-grisácea ('uva pelada')	COMPLETAMENTE INDOLORO y no sangra al tacto suave	Corticoides intranasales en altas dosis · Cirugía FESS si refractario
Cornete Inferior Hipertrófico	Mucosa eritematosa o rosada, consistencia firme elástica	MUY DOLOROSO y sensible al contacto con el estilete	Corticoides intranasales / Descongestionantes / Turbinoplastia
Hematoma Septal Agudo	Tumefacción abombada violácea, fluctuante y blanda en tabique	Doloroso a la palpación local tras antecedente traumático	URGENCIA: Drenaje quirúrgico inmediato + Taponamiento compresivo bilateral
Papiloma Invertido	Masa unilateral de aspecto cerebiforme o vegetante carnosa	Sangra con facilidad · Destrucción ósea local	Biopsia + Resección quirúrgica amplia por riesgo de carcinoma (10%)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 14.12

Un joven de 17 años acude al servicio de urgencia 3 horas después de haber recibido un golpe de puño en la nariz durante un partido de fútbol. Refiere dolor nasal intenso y epistaxis que ya cesó. Al examen físico se evidencia marcado edema del dorso nasal con discreta laterorrinia hacia la derecha y equimosis periorbitaria. A la rinoscopía anterior con buena iluminación, se observa en ambas fosas nasales un abombamiento rojo-violáceo, liso y fluctuante que se origina desde el tabique nasal y que ocluye casi por completo el paso de aire.

Conducta oficial. El hallazgo de una masa violácea fluctuante bilateral que compromete el tabique nasal tras un traumatismo facial agudo es patognomónico de un Hematoma Septal (del tabique nasal). La presencia de un hematoma septal constituye una verdadera urgencia médica y quirúrgica. Debido a que el cartílago cuadrangular se nutre exclusivamente por difusión desde el pericondrio, el hematoma diseca el pericondrio privando al cartílago de su irrigación, lo que desencadena necrosis avascular y reabsorción del cartílago septal en 24 a 48 horas, con secuela permanente de deformidad nasal en 'silla de montar' o formación de un absceso septal. La conducta de elección que no admite demora es el drenaje quirúrgico inmediato mediante incisión del mucopericondrio y aspiración de los coágulos, seguido de taponamiento nasal anterior compresivo bilateral y cobertura antibiótica oral.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En todo traumatismo nasal es obligatorio descartar hematoma septal mediante rinoscopía anterior.
- El hematoma septal se visualiza como un abombamiento fluctuante violáceo en el tabique y exige DRENAJE QUIRÚRGICO INMEDIATO.
- La falta de drenaje de un hematoma septal conduce a necrosis isquémica del cartílago y deformidad en 'silla de montar'.
- Los pólipos nasales son masas bilaterales translúcidas, indoloras e insensibles al tacto ('aspecto de uva pelada').
- La Tríada de Samter (o Widal) consiste en: poliposis nasal bilateral + asma bronquial + intolerancia severa a la Aspirina y AINEs.
- En la tríada de Samter están estrictamente prohibidos la aspirina y los AINEs por riesgo de broncoespasmo fatal.
- Todo pólipo nasal UNILATERAL en un adulto debe ser biopsiado para descartar Papiloma Invertido o neoplasia maligna.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.12

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.013

1. Un adolescente de 15 años sufre un pelotazo en la cara durante un partido de básquetbol, presentando deformidad nasal y epistaxis que cede espontáneamente. Al ser examinado en el policlínico de choque 6 horas más tarde, el médico realiza una rinoscopía anterior y constata un abombamiento violáceo, blando y bilateral en el tabique nasal que obstruye ambas fosas nasales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inmediata que debe adoptarse?

A) Hipertrofia compensatoria de cornetes; indicar descongestionantes tópicos por 7 días.
B) Hematoma septal; realizar incisión, drenaje quirúrgico inmediato y taponamiento nasal bilateral compresivo.
C) Fractura nasal simple no desplazada; solicitar radiografía de huesos propios y citar a control en 10 días.
D) Poliposis nasal postraumática aguda; iniciar prednisona oral en dosis altas.
E) Desviación septal cartilaginosa fija; programar septoplastia electiva en 6 meses.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.024

2. Una paciente de 46 años con antecedentes de asma bronquial de difícil control consulta por obstrucción nasal bilateral progresiva y anosmia. A la rinoscopía anterior se observan múltiples masas translúcidas, brillantes, de color grisáceo y consistencia blanda, completamente insensibles al tacto, que prolapsan desde el meato medio hacia ambas fosas nasales. Refiere además que hace un año presentó un episodio de broncoespasmo severo que requirió ingreso a UCI tras ingerir ketorolaco. ¿Cuál es el diagnóstico sindromático de esta paciente y qué clase de analgésicos debe evitar estrictamente?

A) Granulomatosis con poliangeítis; debe evitar el uso de paracetamol.
B) Síndrome de Churg-Strauss; debe evitar los antibióticos betalactámicos.
C) Tríada de Samter (Enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina); debe evitar estrictamente la aspirina y todos los AINEs.
D) Papilomatosis respiratoria recurrente; debe evitar el uso de corticoides intranasales.
E) Rinitis medicamentosa; debe evitar los descongestionantes tópicos y antihistamínicos.

Más preguntas online de Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 14.9 A 14.12

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales	La clasificación ARIA divide la rinitis alérgica en intermitente (< 4d/sem o < 4 sem)...	**La afectación del sueño, actividades o rendimiento laboral/escolar define a la rinitis...**	—
Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias	La rinosinusitis bacteriana se diagnostica con: síntomas ≥ 10 días, o empeoramiento...	**El color verdoso o purulento de la mucosidad nasal NO indica por sí solo infección...**	—
Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos	El 90% de las epistaxis son anteriores y se originan en el Plexo de Kiesselbach (Área...	**La primera medida obligatoria en epistaxis anterior es la compresión digital de las...**	Está terminantemente prohibido cauterizar ambos lados del tabique nasal simultáneamente...
Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal	En todo traumatismo nasal es obligatorio descartar hematoma septal mediante rinoscopía...	**El hematoma septal se visualiza como un abombamiento fluctuante violáceo en el tabique...**	En la tríada de Samter están estrictamente prohibidos la aspirina y los AINEs por...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La clasificación ARIA divide la rinitis alérgica en intermitente (< 4d/sem o < 4 sem) vs persistente (≥ 4d/sem y ≥ 4 sem).

La afectación del sueño, actividades o rendimiento laboral/escolar define a la rinitis como Moderada a Severa.

Los corticoides intranasales (fluticasona, mometasona) son el fármaco de primera línea más eficaz para la rinitis alérgica...

Los antihistamínicos orales de 2ª generación (cetirizina, desloratadina) no son sedantes y controlan prurito y estornudos, pero...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- La afectación del sueño, actividades o rendimiento laboral/escolar define a la rinitis como Moderada a Severa.
- Los corticoides intranasales (fluticasona, mometasona) son el fármaco de primera línea más eficaz para la rinitis alérgica moderada-severa.
- El color verdoso o purulento de la mucosidad nasal NO indica por sí solo infección bacteriana ni justifica antibióticos.
- La radiografía de senos paranasales está en desuso y no se recomienda para el diagnóstico de rinosinusitis aguda no complicada.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La clasificación ARIA divide la rinitis alérgica en intermitente (< 4d/sem o < 4 sem) vs persistente (≥ 4d/sem y ≥...	Tema 14.9 →
La rinosinusitis bacteriana se diagnostica con: síntomas ≥ 10 días, o empeoramiento tras mejoría (doble caída), o...	Tema 14.10 →
El 90% de las epistaxis son anteriores y se originan en el Plexo de Kiesselbach (Área de Little) en el tabique...	Tema 14.11 →
En todo traumatismo nasal es obligatorio descartar hematoma septal mediante rinoscopía anterior.	Tema 14.12 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR

5	17	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
14.13	Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina	63
14.14	Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	68
14.15	Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas	73
14.16	Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke	77
14.17	Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia	81

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
6.03.1.002, 6.03.1.017, 2.01.1.023, 1.04.1.025, 2.01.1.027, 1.01.1.008, 1.01.3.005, 1.04.4.014	Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina	Específico	Completo	Completo
6.03.2.002, 6.03.5.002, 6.03.2.004, 6.03.2.003, 2.01.2.002, 6.03.4.004, 6.03.5.003	Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	Específico	Inicial	Específico
2.01.1.100, 6.03.1.027, 6.03.1.028, 2.01.4.004, 6.03.1.003, 6.03.4.002	Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas	Específico	Inicial	Específico
6.03.1.010, 6.03.5.009, 6.03.1.009	Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke	Específico	Inicial	Específico
2.01.1.025, 2.01.2.018, 6.03.1.013, 2.01.1.117	Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 04 · FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
17 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

! **TRAMPA** · La presencia de tos, rinorrea, disfonía o conjuntivitis prácticamente descarta SBHGA y confirma etiología viral.

Los 4 criterios de Centor son: fiebre > 38°C, exudado amigdalino, adenopatías cervicales anteriores dolorosas y ausencia de tos.

La escala de McIsaac añade el factor edad: 3-14 años (+1), 15-44 años (0), ≥ 45 años (-1).

El tratamiento de primera línea es Penicilina Benzatina IM dosis única o Amoxicilina oral por 10 DÍAS COMPLETOS.

El objetivo prioritario del tratamiento antibiótico es la prevención de la Fiebre Reumática Aguda.

El tratamiento antibiótico NO previene la Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina	EUNACOM Diciembre 2025 · #107 · EUNACOM Diciembre 2025 · #54 · EUNACOM Diciembre 2024 · #178 · EUNACOM Diciembre 2024 · #169
Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	EUNACOM Julio 2025 · #48 · EUNACOM Diciembre 2024 · #148 · EUNACOM Julio 2017 · #170 · EUNACOM Diciembre 2017 · #119
Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas	EUNACOM Diciembre 2025 · #23 · EUNACOM Julio 2017 · #48
Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke	EUNACOM Diciembre 2025 · #149 · EUNACOM Diciembre 2019 · #2 · EUNACOM Julio 2015 · #103
Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia	EUNACOM Julio 2024 · #133 · EUNACOM Diciembre 2024 · #86 · EUNACOM Diciembre 2018 · #158 · EUNACOM Diciembre 2018 · #162

14.13. Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.03.1.002 6.03.1.017 2.01.1.023 1.04.1.025 2.01.1.027 1.01.1.008 1.01.3.005 1.04.4.014

¿POR QUÉ?

La faringoamigdalitis aguda es uno de los motivos de consulta más frecuentes en todas las edades. La inmensa mayoría de las faringitis en menores de 3 años y en adultos son de causa viral (rinovirus, adenovirus, EBV). El objetivo prioritario evaluado de forma incisiva en el EUNACOM es identificar al Streptococcus pyogenes (estreptococo betahemolítico del grupo A - SBHGA) mediante la escala de Centor/McIsaac para evitar el sobreuso de antibióticos en cuadros virales, y prescribir Penicilina Benzatina o Amoxicilina por 10 días completos con el propósito fundamental de prevenir la fiebre reumática aguda y complicaciones supurativas.

1. ETIOLOGÍA VIRAL VS BACTERIANA: EL SBHGA COMO BLANCO TERAPÉUTICO

Más del 70-85% de las faringitis agudas en adultos y > 50-70% en niños son de **etiología viral** (adenovirus, rinovirus, coronavirus, virus influenza, virus Epstein-Barr causante de mononucleosis infecciosa). Los signos que orientan fuertemente a causa viral son: **tos, coriza/rinorrea, disfonía, conjuntivitis, aftas orales y diarrea**. **(ver Imagen 14.13B)** 6.03.1.002 6.03.1.017 2.01.1.023

El único patógeno bacteriano común que justifica tratamiento antibiótico formal es el ***Streptococcus pyogenes*** **(Estreptococo Betahemolítico del Grupo A - SBHGA)**, responsable del 15-30% de los casos en niños de 3 a 14 años y solo del 5-10% en adultos. En niños menores de 3 años, la faringitis estreptocócica es extraordinariamente rara y casi nunca se asocia a fiebre reumática.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE CENTOR MODIFICADO POR MCISAAC

Dado que el exudado pultáceo blanco en las amígdalas puede presentarse tanto en infecciones bacterianas como en virales (especialmente por adenovirus o mononucleosis por EBV), se utiliza la **Escala de McIsaac** para estimar la probabilidad de SBHGA y normar la conducta: **(ver Imagen 14.13A y C)** 6.03.1.002 6.03.1.017 2.01.1.023

Criterios (1 punto cada uno): (1) Fiebre cuantificada > 38.0°C axilar; (2) Exudado amigdalino o amígdalas intensamente tumefactas; (3) Adenopatías cervicales anteriores dolorosas a la palpación; (4) Ausencia de tos; y (5) Factor edad: 3 a 14 años (+1 punto), 15 a 44 años (0 puntos), ≥ 45 años (-1 punto).

Conducta según Puntaje Total:

- **0 a 1 punto (Riesgo < 5-10%):** No realizar pruebas diagnósticas ni indicar antibióticos; manejo puramente sintomático con analgésicos.
- **2 a 3 puntos (Riesgo 15-30%):** Realizar test de detección rápida de antígeno estreptocócico (Strep-test) o cultivo faríngeo; tratar solo si resulta positivo. 6.03.1.002 6.03.1.017 2.01.1.023 1.04.4.014
- **4 a 5 puntos (Riesgo 50-60%):** Indicación de test rápido/cultivo o inicio empírico inmediato de tratamiento antibiótico bactericida.

TABLA 14.13.A · CRITERIOS CLÍNICOS DE MCISAAC Y PROBABILIDAD DE FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA (SBHGA) 6.03.1.002, 6.03.1.017, 2.01.1.023, 1.04.1.025, 2.01.1.027, 1.01.1.008, 1.01.3.005, 1.04.4.014

PUNTUACIÓN TOTAL	PROBABILIDAD DE SBHGA	CONDUCTA DIAGNÓSTICA OFICIAL	TRATAMIENTO RECOMENDADO
0 a 1 punto	< 5% en adultos; < 10% en niños	No requiere test microbiológico ni cultivo	Sintomático exclusivo: Paracetamol / Ibuprofeno
2 puntos	10 a 17%	Test rápido de antígeno estreptocócico o cultivo	Tratar solo si el test de laboratorio es positivo
3 puntos	25 a 35%	Test rápido de antígeno estreptocócico o cultivo	Tratar solo si el test de laboratorio es positivo
4 a 5 puntos	50 a 60%	Test rápido / Cultivo o Tratamiento empírico directo	Penicilina Benzatina IM dosis única o Amoxicilina x 10 días

14.13. Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ESQUEMA ANTIMICROBIANO DE ELECCIÓN: PREVENCIÓN DE FIEBRE REUMÁTICA

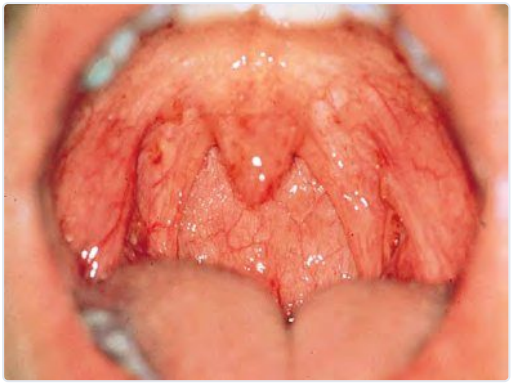
El *Streptococcus pyogenes* conserva una **sensibilidad del 100% a la penicilina** en todo el mundo (no existen cepas resistentes a penicilinas descritas en la historia de la medicina). Por tanto, los antibióticos de primera línea indiscutidos son: 6.03.1.002 6.03.1.017 2.01.1.023

Opción 1 (Asegura cumplimiento): Penicilina Benzatina intramuscular en dosis única: 1.200.000 UI IM en pacientes con peso > 27 kg o adultos; **600.000 UI IM** en niños con peso < 27 kg. 6.03.1.002 6.03.1.017

Opción 2: Amoxicilina oral: 50 mg/kg/día dividida cada 12 o 24 horas (máximo 1 g/día) durante 10 días completos. Se requieren obligatoriamente 10 días para erradicar el germen de la orofaringe y prevenir la fiebre reumática aguda (los esquemas de 5 o 7 días no aseguran prevención de carditis reumática). 2.01.1.023 1.01.3.005 1.01.1.008

Alergia a Penicilina: En pacientes con alergia demostrada no anafiláctica se utilizan cefalosporinas de 1ª generación (Cefadroxilo 30 mg/kg/d x 10d). En pacientes con antecedente de *anafilaxia o alergia mediada por IgE*, el fármaco de elección es un macrólido: **Azitromicina (12 mg/kg/día en niños o 500 mg/día en adultos por 5 días)** o Claritromicina (15 mg/kg/día x 10 días). 6.03.1.002 6.03.1.017 2.01.1.023

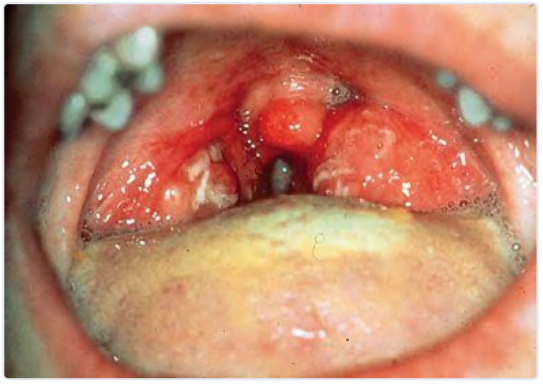
Nota clave EUNACOM: La antibioticoterapia previene eficazmente la **fiebre reumática aguda** y los abscesos periamigdalinos, pero **NO previene la glomerulonefritis postestreptocócica (GNPE)**, la cual se desencadena por inmunocomplejos independientemente del tratamiento. 6.03.1.002 6.03.1.017 2.01.1.023 1.01.3.005 1.01.1.008



A. FARINGE ROJA SIN EXUDADO



B. PLACAS EN LAS CRIPTAS



C. GARGANTA ROJA CON EXUDADO

Imagen 14.13

FIGURA 14.13 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA FARINGITIS AGUDA SEGÚN ESCALA DE MCISAAC

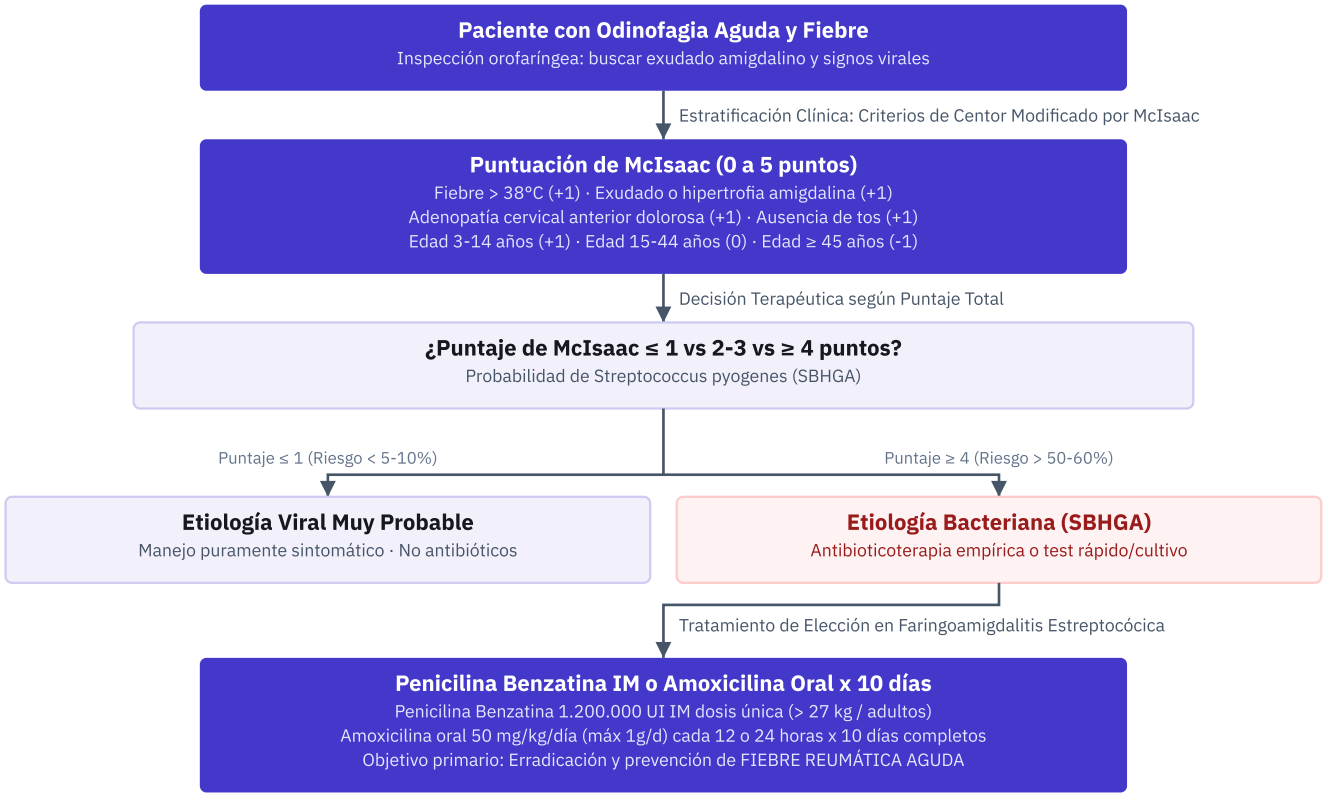


TABLA 14.13.B · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: FARINGITIS VIRAL VS ESTREPTOCÓCICA VS MONONUCLEOSIS

CRITERIOS DE GRAVEDAD

CARACTERÍSTICA	FARINGITIS VIRAL COMÚN	FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA (SBHGA)	MONONUCLEOSIS INFECCIOSA (EBV)
Síntomas de Vía Aérea	Tos presente, rinorrea, disfonía, aftas orales	AUSENCIA RIGUROSA DE TOS, coriza o disfonía	Ausencia de tos; odinofagia muy intensa y prolongada
Exudado Amigdalino	Raro o puntiforme fino (adenovirus)	Exudado blanquecino en placas confluentes pultáceas	Exudado blanco-grisáceo extenso con membranas gruesas
Adenopatías	Submandibulares pequeñas no dolorosas	Yugulodigástricas anteriores muy dolorosas	Adenopatías cervicales POSTERIORES, axilares y esplenomegalia
Efecto de Amoxicilina	Sin cambios en la evolución natural	Curación rápida en 24-48 horas sin recidivas	EXANTEMA MÁCULO-PAPULAR PRURIGINOSO SEVERO (rash por amoxicilina)

14.13. Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MONONUCLEOSIS INFECCIOSA, RESFRÍO COMÚN, FIEBRE REUMÁTICA Y TEST RÁPIDO PARA ESTREPTOCOCO

El **síndrome mononucleósico** por virus de Epstein-Barr afecta 1.04.1.025 sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes: fiebre, **faringoamigdalitis exudativa**, adenopatías cervicales (incluidas las posteriores), fatiga y esplenomegalia en 30 a 50 %. Se confirma con hemograma (linfocitosis con más de 10 % de linfocitos atípicos) y prueba de anticuerpos heterófilos (Paul-Bunnell/Monospot; puede ser falsa negativa en niños pequeños) o IgM anti-VCA. El tratamiento es de soporte; **se evita la amoxicilina** (exantema en la mayoría de los pacientes), se indica **no hacer deporte de contacto por 3 a 4 semanas** por el riesgo de rotura esplénica y se reservan los corticoides para la obstrucción de la vía aérea, la anemia hemolítica o la trombocitopenia graves.

El **resfrío común** pediátrico es una infección viral (rinovirus, 2.01.1.027 VRS, adenovirus) con 6 a 8 episodios al año en preescolares, rinorrea, obstrucción nasal, tos y fiebre baja que dura 7 a 10 días (la tos hasta 2 semanas). Manejo: **lavados nasales con suero fisiológico**, hidratación, paracetamol o ibuprofeno y vigilancia; **no se usan antibióticos, antitusivos, descongestionantes ni mucolíticos** en menores de 6 años. Son signos de alarma la dificultad respiratoria, la fiebre persistente más de 3 días, la otalgia, el rechazo alimentario y las pausas respiratorias en el lactante, por posibles complicaciones (otitis media, sinusitis, bronquiolitis, neumonía).

La **enfermedad reumática activa** es una secuela inmune de 1.01.1.008 la faringitis por *Streptococcus* del grupo A. El diagnóstico usa los **criterios de Jones**: evidencia de infección estreptocócica previa (ASO, anti-DNasa B, cultivo o test rápido) más **2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores**. Mayores: carditis, poliartritis migratoria, corea de Sydenham, eritema marginado y nódulos subcutáneos; menores: fiebre, artralgias, VHS o PCR elevadas y PR prolongado. Tratamiento: reposo, **penicilina benzatina** para erradicar el estreptococo, **AAS** en la artritis y corticoides en la carditis moderada a grave, y manejo sintomático de la corea. Después se mantiene la **profilaxis secundaria con penicilina benzatina cada 3 semanas** por años (hasta los 21 años como mínimo, más tiempo si quedó daño valvular).

El **test rápido de detección de antígeno estreptocócico** tiene 1.04.4.014 **especificidad mayor de 95 % y sensibilidad de 70 a 90 %**. Se aplica cuando el puntaje de McIsaac es intermedio (2 a 3 puntos): un resultado positivo confirma la faringitis estreptocócica y justifica tratar sin cultivo; un resultado negativo en un adulto permite asumir etiología viral, pero **en un niño con sospecha alta se confirma con cultivo faríngeo** por la menor sensibilidad. Un puntaje de McIsaac ≥4 puede tratarse empíricamente.

TABLA 14.13.C · ESQUEMA ANTIMICROBIANO OFICIAL EN FARINGOAMIGDALITIS POR SBHGA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO Y PRESENTACIÓN	POBLACIÓN Y VÍA	DOSIS Y POSOLOGÍA	DURACIÓN Y OBJETIVO
Penicilina Benzatina IM	Adultos y niños > 27 kg	1.200.000 UI intramuscular profunda	Dosis ÚNICA · Máxima adherencia y erradicación garantizada
Penicilina Benzatina IM	Niños < 27 kg	600.000 UI intramuscular profunda	Dosis ÚNICA · Prevención de fiebre reumática aguda
Amoxicilina oral	Pediátrico y adultos	50 mg/kg/día cada 12h o 24h (adultos 500 mg c/12h o 1g/d)	10 DÍAS COMPLETOS OBLIGATORIOS · Tasa de curación > 95%
Azitromicina oral (Alergia IgE)	Alérgicos a penicilina	12 mg/kg/día en niños (adultos 500 mg/día)	5 días consecutivos · Rescate estricto en anafilaxia confirmada

14.13. Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (FARINGOAMIGDALITIS AGUDA BACTERIANA)

- La presencia de tos, rinorrea, disfonía o conjuntivitis prácticamente descarta SBHGA y confirma etiología viral.
- La escala de McIsaac añade el factor edad: 3-14 años (+1), 15-44 años (0), ≥ 45 años (-1).
- El objetivo prioritario del tratamiento antibiótico es la prevención de la Fiebre Reumática Aguda.
- La amoxicilina en un paciente con mononucleosis por EBV desencadena un exantema máculo-papular característico en > 90% de los casos.
- Los 4 criterios de Centor son: fiebre > 38°C, exudado amigdalino, adenopatías cervicales anteriores dolorosas y ausencia de tos.
- El tratamiento de primera línea es Penicilina Benzatina IM dosis única o Amoxicilina oral por 10 DÍAS COMPLETOS.
- El tratamiento antibiótico NO previene la Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

14.13

Un niño de 8 años es llevado al consultorio por su madre debido a fiebre de 38.9°C y odinofagia intensa de 24 horas de evolución que le dificulta tragar la saliva. No presenta tos, rinorrea ni deposiciones líquidas. Al examen físico se encuentra febril, sin dificultad respiratoria. A la inspección de la orofaringe se evidencian amígdalas palatinas aumentadas de volumen, hiperémicas, con exudado pultáceo blanquecino abundante en placas sobre las criptas, y petequias en el paladar blando. A la palpación cervical se detectan adenopatías submandibulares y yugulodigástricas anteriores bilaterales de 2 cm, sumamente sensibles. El resto del examen físico es normal.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana por Streptococcus pyogenes (SBHGA). Al evaluar los criterios de McIsaac: edad 3-14 años (+1), fiebre > 38°C (+1), exudado amigdalino (+1), adenopatías cervicales anteriores sensibles (+1) y ausencia de tos (+1), alcanza una puntuación de 5 puntos (máxima probabilidad clínica > 50-60% de infección estreptocócica). La presencia de petequias en el paladar blando refuerza la sospecha. La conducta médica de elección inmediata es el tratamiento con Penicilina Benzatina 600.000 UI IM en dosis única (o 1.200.000 UI si pesa > 27 kg) o Amoxicilina oral 50 mg/kg/día dividida cada 12 horas durante 10 días completos. El objetivo fundamental de completar el tratamiento es prevenir la carditis y artritis de la fiebre reumática aguda y los abscesos cervicales supurativos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.13 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.002

1. Un escolar de 7 años es traído a la consulta por fiebre de 38.6°C y odinofagia de 2 días de evolución. No tiene tos ni mucosidad nasal. Al examen físico destaca faringe eritematosa con amígdalas aumentadas de tamaño con exudado pultáceo y adenopatías cervicales anteriores bilaterales muy sensibles a la palpación. Según los criterios de Centor modificados por McIsaac, ¿cuántos puntos tiene y cuál es la conducta de elección?

A) 2 puntos; manejo puramente sintomático con paracetamol oral.
B) 3 puntos; solicitar hemograma con frotis y radiografía de tórax.
C) 5 puntos; iniciar tratamiento antibiótico con penicilina benzatina IM o amoxicilina oral por 10 días.
D) 4 puntos; iniciar ciprofloxacino oral por 5 días para evitar nefropatía.
E) 1 punto; indicar gárgaras con sal y citar a control en 7 días si persiste con fiebre.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.002

2. Respecto a las complicaciones de la faringoamigdalitis aguda por Streptococcus pyogenes (estreptococo betahemolítico del grupo A), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

A) El tratamiento antibiótico precoz previene eficazmente la glomerulonefritis aguda postestreptocócica.
B) El tratamiento antibiótico con penicilina benzatina o amoxicilina por 10 días previene la fiebre reumática aguda.
C) La penicilina benzatina no tiene efecto en la prevención de abscesos periamigdalinos supurativos.
D) La glomerulonefritis solo se presenta tras infecciones estreptocócicas de la piel y nunca tras faringitis.
E) Se ha comprobado una tasa de resistencia a penicilina superior al 20% en cepas chilenas de Streptococcus pyogenes.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.04.1.025

3. Un adolescente de 16 años consulta por odinofagia severa de 5 días de evolución, astenia marcada y fiebre. El médico sospecha amigdalitis bacteriana y le prescribe amoxicilina 875 mg cada 12 horas. Al tercer día de amoxicilina, el paciente acude a urgencias por la aparición de un exantema máculo-papular eritematoso difuso y pruriginoso en tronco y extremidades. Al examen actual presenta amígdalas hipertróficas con exudado blanco-grisáceo, adenopatías cervicales posteriores y epitrocleares palpables y esplenomegalia a 3 cm bajo el reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Alergia anafiláctica grave a la amoxicilina mediada por IgE.
B) Mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr (EBV).
C) Escarlatina estreptocócica clásica con signo de Pastia.
D) Infección aguda por citomegalovirus refractaria a penicilina.
E) Shock tóxico estreptocócico fulminante.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.002

4. En un paciente de 25 años con faringoamigdalitis estreptocócica confirmada por test rápido, con antecedente de reacción anafiláctica severa previa a la penicilina (edema de glotis y colapso circulatorio), ¿cuál de los siguientes antibióticos es la opción terapéutica de primera línea más adecuada?

A) Amoxicilina con ácido clavulánico oral.
B) Cefadroxilo oral en dosis altas.
C) Azitromicina oral por 5 días.
D) Ceftriaxona intramuscular en dosis única.
E) Ampicilina oral por 10 días.

Más preguntas online de Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana →

14.14. Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.03.2.002 | 6.03.5.002 | 6.03.2.004 | 6.03.2.003 | 2.01.2.002 | 6.03.4.004 | 6.03.5.003

¿POR QUÉ?

Las infecciones supurativas de los espacios profundos del cuello representan verdaderas urgencias quirúrgicas en otorrinolaringología por su potencial letalidad debido a obstrucción mecánica de la vía aérea y diseminación hacia el mediastino posterior (mediastinitis necrotizante descendente). En el EUNACOM se evalúa de manera fija el reconocimiento inmediato de la tríada cardinal del absceso periamigdalino (trismus por espasmo del músculo pterigoideo interno, voz de papa caliente y desviación contralateral de la úvula), su drenaje por punción e inicio de antibióticos endovenosos.

1. ABSCESO PERIAMIGDALINO (QUINSY): CLÍNICA Y TRÍADA CLÁSICA

El **absceso periamigdalino** es la infección profunda del cuello más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Se produce por la diseminación de una faringoamigdalitis aguda supurada que atraviesa la cápsula amigdalina hacia el espacio virtual periamigdalino (entre la cápsula y el músculo constrictor superior de la faringe). La microbiología es típicamente polimicrobiana: mezcla de *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus anginosus* y bacterias anaerobias orales (*Fusobacterium necrophorum*, *Prevotella*, *Peptostreptococcus*). 6.03.2.002 2.01.2.002

La **tríada semiológica clásica patognomónica** está constituida por: (1) **Trismus intenso** (dificultad o imposibilidad para abrir la boca debido a la irritación y espasmo inflamatorio del músculo pterigoideo interno adyacente); (2) **Voz en 'papa caliente' o voz gangosa/apagada** (rinolalia cerrada); y (3) **Desviación manifiesta de la úvula hacia el lado CONTRALATERAL**, producida por el abombamiento asimétrico del pilar amigdalino anterior y del paladar blando superior que empuja la amígdala hacia la línea media. **(ver Imagen 14.14A)**



Absceso periamigdalino: abombamiento del pilar y úvula desviada

El cuadro se acompaña de odinofagia unilateral intolerable, otalgia refleja ipsilateral (por el nervio glosofaríngeo), sialorrea profusa por imposibilidad de deglutir y fiebre alta con aliento fétido.

2. MANEJO TERAPÉUTICO DEL ABSCESO PERIAMIGDALINO: DRENAJE Y ANTIBIÓTICOS

El tratamiento del absceso periamigdalino comprende tres pilares esenciales e inmediatos: 6.03.2.002 2.01.2.002

1. Drenaje Mecánico (Paso Crucial): Si existe colección fluctuante, la descompresión es mandatoria. En el box de urgencia se realiza **punción con aguja gruesa (trocar 18G con tope) o incisión y drenaje** en el punto de máxima prominencia del pilar amigdalino anterior superior (previa anestesia tópica e infiltrativa). El drenaje proporciona un alivio sintomático y del trismus casi instantáneo y permite la toma de cultivo bacteriológico. 6.03.2.002 2.01.2.002 6.03.5.002

2. Antibioticoterapia Endovenosa de Amplio Espectro: Debido a la presencia de anaerobios, los esquemas de elección son: **Amoxicilina + Ácido Clavulánico EV (1.2 g c/8h)**, o **Penicilina Sódica (2 a 4 millones UI c/4h EV) + Metronidazol (500 mg c/8h EV)**, o **Ceftriaxona (2 g/día EV) + Clindamicina (600 mg c/8h EV)**. 6.03.2.002 2.01.2.002

3. Corticoterapia y Analgesia: Una dosis endovenosa de Dexametasona (8 a 10 mg EV) acelera notablemente la reducción del edema tisular y la resolución del trismus.

Amigdalectomía: La amigdalectomía en caliente (en la fase aguda) solo se reserva si falla el drenaje o hay compromiso de vía aérea. Si el paciente tiene antecedentes de amigdalitis recurrentes, se programa una amigdalectomía electiva ('en frío') a las 4 a 6 semanas.

TABLA 14.14.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE INFECCIONES CERVICALES PROFUNDAS 6.03.2.002, 6.03.5.002, 6.03.2.004, 6.03.2.003, 2.01.2.002, 6.03.4.004, 6.03.5.003

ENTIDAD INFECCIOSA	POBLACIÓN TÍPICA	SIGNOS CLÍNICOS CARDINALES	COMPLICACIÓN MAYOR / CONDUCTA
Absceso Periamigdalino	Adolescentes y adultos jóvenes (15-35 años)	Trismus, voz en papa caliente, úvula desviada al lado sano	Punción/drenaje con aguja en box + Penicilina+Metronidazol EV
Absceso Retrofaríngeo	Lactantes y preescolares (< 5 años)	Tortícolis, estridor, abombamiento pared posterior faríngea	Mediastinitis descendente · TAC con contraste + Pabellón urgente
Absceso Parafaríngeo	Cualquier edad tras faringitis u otitis	Trismus, tumefacción bajo ángulo mandibular, masa cervical	Erosión carotídea y Síndrome de Lemierre · Drenaje quirúrgico
Angina de Ludwig	Adultos con infección de molares inferiores	Induración leñosa de piso de boca con elevación de la lengua	ASFIXIA INMINENTE: Asegurar vía aérea + Traqueostomía + Drenaje

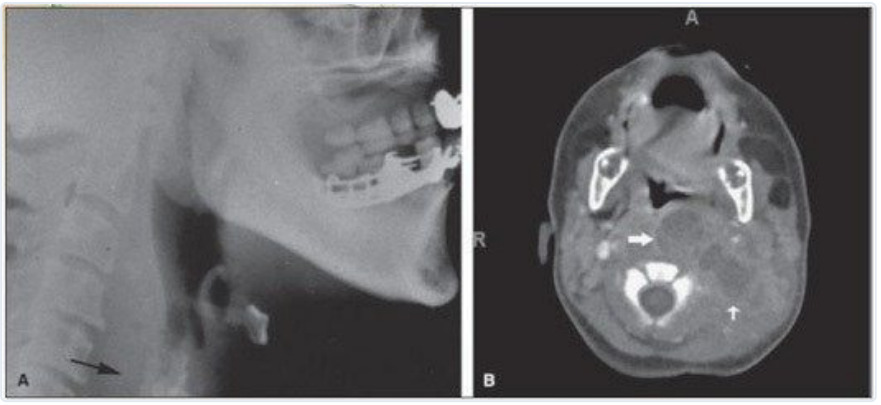
14.14. Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ABSCESO RETROFARÍNGEO: URGENCIA PEDIÁTRICA Y ENSANCHAMIENTO PREVERTEBRAL

El **absceso retrofaríngeo** se produce en el espacio localizado entre la fascia bucofaríngea y la fascia alar prevertebral. Este espacio contiene los **ganglios linfáticos retrofaríngeos de Gilette**, los cuales drenan las adenoides, fosas nasales y senos paranasales, y sufren una atrofia fisiológica progresiva hasta desaparecer alrededor de los 4 a 5 años de edad. Por ello, el **absceso retrofaríngeo es casi exclusivo de lactantes y niños menores de 5 años** (en adultos se debe a cuerpos extraños clavados como espinas de pescado o trauma instrumental). **(ver Imagen 14.14B)** 6.03.2.004 6.03.2.003

Clínica: Fiebre alta, rechazo alimentario, sialorrea, rigidez de nuca y **tortícolis dolorosa**, voz apagada (estridor inspiratorio o respiración estertorosa con cabeza en hiperextensión). A diferencia del absceso periamigdalino, *la orofaringe anterior suele verse normal*, observándose un abombamiento en la pared posterior de la faringe.

Diagnóstico y Radiografía: La **Radiografía lateral de cuello en hiperextensión e inspiración** demuestra el **ensanchamiento patológico del espacio de partes blandas prevertebrales** (más del ancho de un cuerpo vertebral cervical en C2 o más del doble del cuerpo vertebral en C6), con pérdida de la lordosis cervical y presencia de aire/nivel hidroaéreo. El **TAC de cuello con contraste** es el examen definitivo. 6.03.2.004 6.03.2.003 6.03.4.004

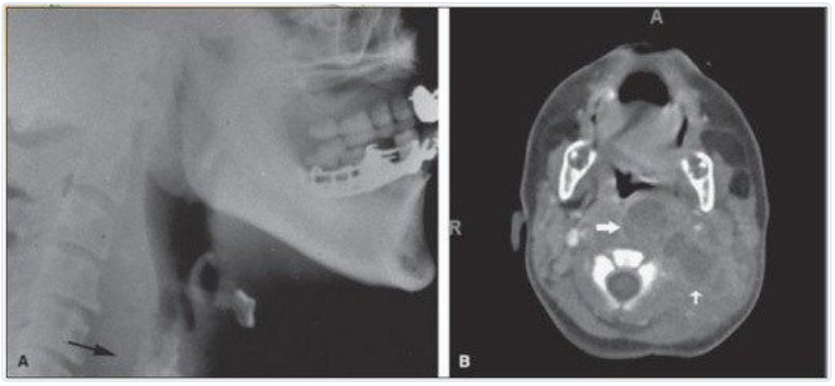


Absceso retrofaríngeo: espacio prevertebral ensanchado (Rx y TC)

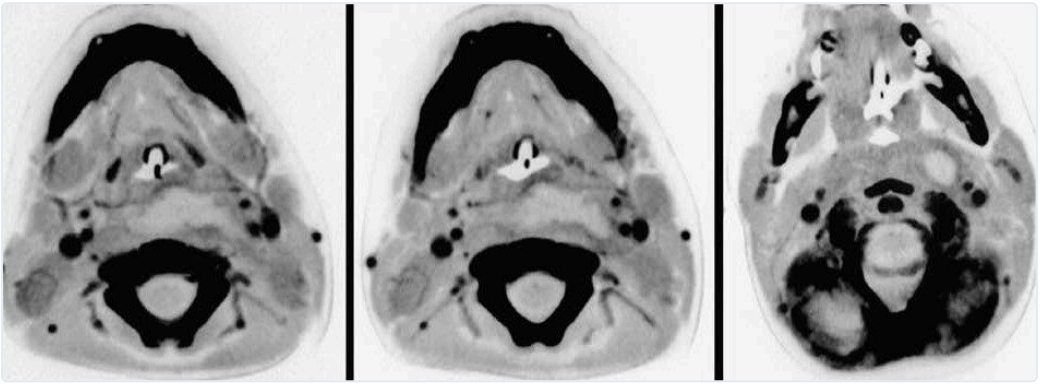
Tratamiento: Es una **emergencia quirúrgica absoluta** por el altísimo riesgo de asfixia y **Mediastinitis Necrotizante Descendente** (el espacio retrofaríngeo se comunica directamente con el mediastino posterior a través del 'espacio peligroso' o *danger space*). Exige hospitalización en UCI, intubación cuidadosa y **drenaje quirúrgico urgente en pabellón** bajo anestesia general junto a Ceftriaxona + Clindamicina EV. 6.03.2.004 6.03.2.003 6.03.5.003



A. PILAR ABOMBADO Y ÚVULA



B. RX Y TC: PREVERTEBRAL ANCHO



C. TC: ABSCESO PARAFARÍNGEO

Imagen 14.14

FIGURA 14.14 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE INFECCIONES PROFUNDAS DEL CUELLO Y ESPACIOS FASCIALES

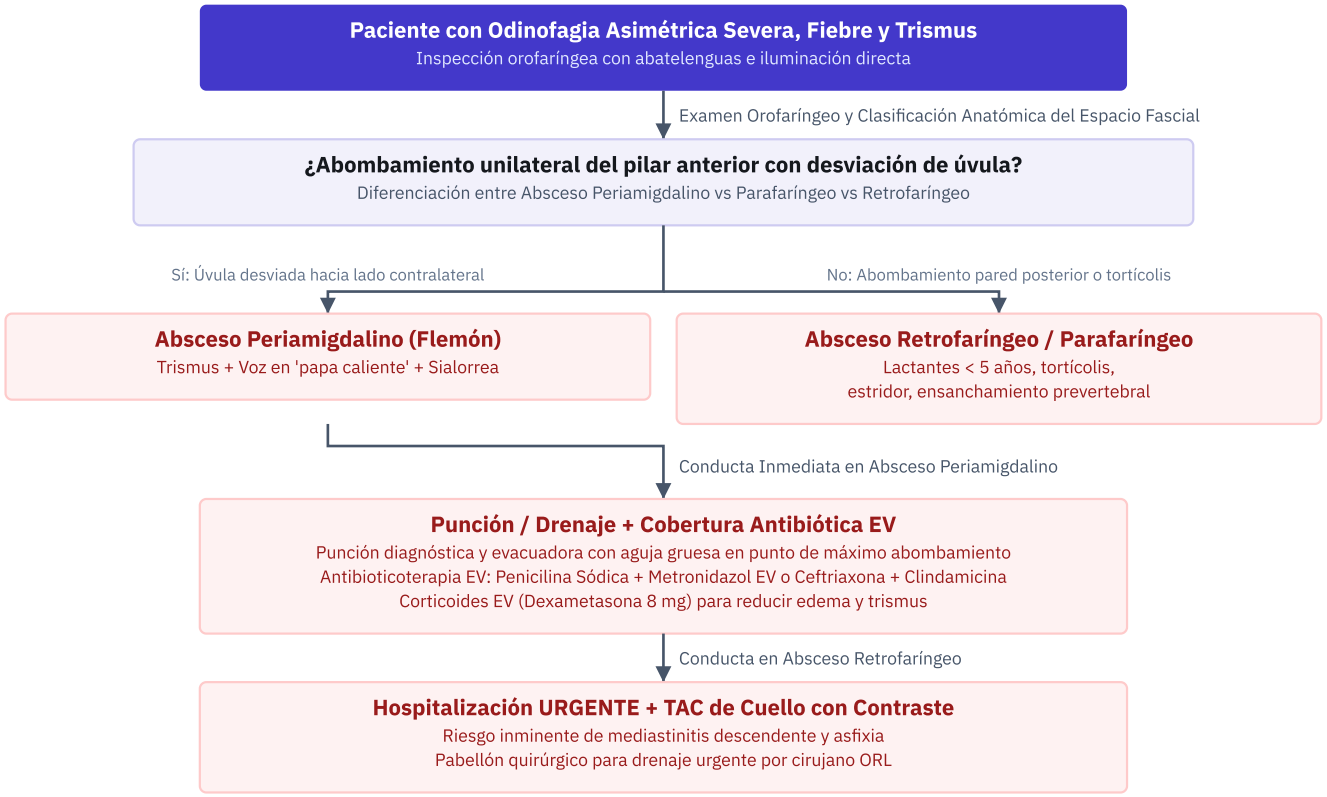


TABLA 14.14.B · CRITERIOS DE GRAVEDAD E INDICACIÓN DE VÍA AÉREA QUIRÚRGICA EN INFECCIONES DE CUELLO

CRITERIOS DE GRAVEDAD

SIGNO DE ALARMA	MECANISMO PATOGÉNICO	RIESGO INMINENTE	ACCIÓN INMEDIATA
Estridor / Disnea inspiratoria	Edema y compresión del espacio supraglótico y laringe	Paro cardiorrespiratorio por asfixia mecánica aguda	Intubación con fibrobroncoscopio o Traqueostomía de urgencia
Induración leñosa submandibular	Compromiso de espacios sublingual y submandibular	Retropulsión completa de la base de lengua	Asegurar vía aérea antes de cualquier manipulación orofaríngea
Ensanchamiento mediastínico en TAC	Diseminación a través del 'danger space' prevertebral	Mediastinitis necrotizante descendente (mortalidad > 40%)	Toracotomía / Mediastinotomía y drenaje cervical por equipo de tórax

14.14. Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo — Manejo Terapéutico y Urgencias

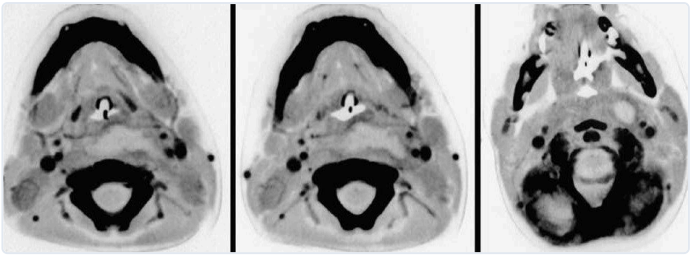
4. ABSCESO PARAFARÍNGEO Y ANGINA DE LUDWIG

Absceso Parafaríngeo: Afecta el espacio faringomaxilar lateral (con sus compartimentos preestíleo y retroestíleo). Clínicamente produce trismus severo, desplazamiento medial de la pared lateral faríngea y amígdala (sin inflamación primaria amigdalina) y tumefacción dolorosa en el ángulo de la mandíbula. Su mayor peligro es la **erosión de la arteria carótida interna** y la **tromboflebitis séptica de la vena yugular interna (Síndrome de Lemierre)** por *Fusobacterium necrophorum*. **(ver Imagen 14.14C)** 6.03.2.003

Angina de Ludwig: Es una celulitis gangrenosa rápidamente progresiva y potencialmente mortal que compromete bilateralmente los **espacios submandibular, sublingual y submentoniano**, originada en el 80% de los casos a partir de **infecciones odontogénicas de los molares inferiores (2° y 3° molar)**. Se manifiesta por una induración leñosa del piso de la boca sin fluctuación palpable, con **elevación y protrusión forzada de la lengua hacia atrás** que ocluye la orofaringe y causa asfixia súbita. El manejo prioritario indiscutido es el **aseguramiento inmediato de la vía aérea (a menudo mediante traqueostomía o intubación con fibrobroncoscopio)**, seguido de descompresión quirúrgica y antibióticos EV.

5. TAC CERVICAL CON CONTRASTE: CÓMO SE INFORMA UN ABSCESO PROFUNDO

La **TAC cervical con contraste** es el examen de elección ante la sospecha de absceso periamigdalino complicado, retrofaríngeo o parafaríngeo (trismus, rigidez cervical, abombamiento faríngeo, disfagia, estridor o desplazamiento uvular sin respuesta al manejo). El informe diferencia el **flemón** (inflamación difusa sin colección, de manejo médico) del **absceso** (colección hipodensa con **realce periférico en anillo**, a veces con gas, que requiere drenaje). Otros hallazgos orientan a gravedad: **ensanchamiento del espacio prevertebral** (en el retrofaríngeo), desplazamiento y estrechez de la vía aérea, extensión al espacio parafaríngeo o mediastino, trombosis de la vena yugular interna (síndrome de Lemierre) y compromiso de la carótida. 6.03.4.004



Absceso parafaríngeo en TC con contraste

TABLA 14.14.C · ESQUEMAS ANTIMICROBIANOS ENDOVENOSOS EN INFECCIONES PROFUNDAS DEL CUELLO PROTOCOLO TERAPÉUTICO

INFECCIÓN ESPACIAL	ESQUEMA ANTIMICROBIANO EV	DOSIS HABITUAL ADULTO	DOSIS PEDIÁTRICA
Absceso Periamigdalino	Amoxicilina + Ácido Clavulánico EV	1.2 g cada 8 horas EV	100 mg/kg/día de amoxicilina dividida c/8h
Absceso Periamigdalino (Alternativa)	Penicilina Sódica + Metronidazol EV	Penicilina 4 millones c/4h + Metronidazol 500mg c/8h	Penicilina 200.000 UI/kg/d + Metronidazol 30 mg/kg/d
Absceso Retrofaríngeo / Parafaríngeo	Ceftriaxona + Clindamicina EV	Ceftriaxona 2 g/día + Clindamicina 600 mg c/8h	Ceftriaxona 100 mg/kg/día + Clindamicina 40 mg/kg/d
Angina de Ludwig Odontogénica	Ceftriaxona + Metronidazol o Meropenem	Ceftriaxona 2g/d + Metronidazol 500mg c/8h EV	Meropenem 2g c/8h si shock o inmunodeprimido

14.14. Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (COMPLICACIONES SUPURATIVAS)

- La tríada del absceso periamigdalino es: trismus, voz en 'papa caliente' y desviación de la úvula hacia el lado contralateral.
- El tratamiento inicial mandatario del absceso periamigdalino es la punción o incisión y drenaje en el punto de mayor abombamiento.
- El absceso retrofaríngeo es típico de niños < 5 años por supuración de ganglios de Gilette; se manifiesta con tortícolis, estridor y ensanchamiento prevertebral.
- La Angina de Ludwig es una celulitis del piso de la boca que eleva la lengua; la prioridad absoluta es ASEGURAR LA VÍA AÉREA.
- El trismus se produce por irritación inflamatoria del músculo pterigoideo interno contiguo al pilar amigdalino.
- El esquema antibiótico del absceso periamigdalino debe cubrir estreptococos y anaerobios orales (Amoxicilina-Clavulánico o Penicilina + Metronidazol).
- El mayor peligro del absceso retrofaríngeo es la mediastinitis necrotizante descendente a través del danger space.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

14.14

Un joven de 20 años consulta en el servicio de urgencia por odinofagia severa unilateral izquierda de 4 días de evolución que le impide tragar sus alimentos y su propia saliva, la cual se le escapa por la comisura labial. Al intentar interrogarlo, habla con una voz engorrosa y apagada ('en papa caliente') y refiere gran dificultad y dolor para abrir la boca. Al examen físico se constata temperatura de 38.8°C axilar y trismus moderado con apertura bucal limitada a 1.5 cm. Con adecuada iluminación y abatelenguas, se observa marcado aumento de volumen eritematoso del pilar amigdalino anterior izquierdo y paladar blando homolateral, el cual sobrepasa la línea media desplazando la úvula hacia la derecha. La amígdala izquierda se encuentra desplazada inferomedialmente con exudado.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta un Absceso Periamigdalino izquierdo (infección supurada del espacio periamigdalino). El cuadro clínico reúne la tríada patognomónica completa: (1) Trismus por irritación refleja del músculo pterigoideo interno; (2) Voz apagada en 'papa caliente'; y (3) Desviación de la úvula hacia el lado contralateral (derecho) provocada por el abombamiento asimétrico del pilar anterior izquierdo. La conducta inmediata de elección para confirmar el diagnóstico y lograr el alivio sintomático y descompresión de la vía aérea es realizar la punción aspirativa con aguja gruesa (o incisión y drenaje) en el punto de máximo abombamiento del pilar amigdalino anterior izquierdo, obteniéndose material francamente purulento. Se debe iniciar simultáneamente antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro activa contra cocos grampositivos y anaerobios orales (Amoxicilina-Ácido Clavulánico EV o Penicilina Sódica + Metronidazol EV) asociada a analgesia y corticoides endovenosos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.14 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.5.002

1. Un joven de 19 años con diagnóstico de amigdalitis aguda en tratamiento oral con amoxicilina desde hace 3 días consulta por agravamiento del cuadro. Presenta fiebre alta, odinofagia unilateral derecha intolerable, sialorrea profusa y marcada dificultad para abrir la boca. Al hablar se expresa con voz engorrosa apagada ('en papa caliente'). A la inspección orofaríngea se aprecia protrusión del pilar amigdalino anterior derecho con desplazamiento de la úvula hacia la izquierda. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico y terapéutico de elección que debe realizarse de inmediato?

A) Aumentar la dosis de amoxicilina oral al doble y asociar ketorolaco sublingual.
B) Punción con aguja o incisión y drenaje del espacio periamigdalino derecho e inicio de antibióticos endovenosos.
C) Solicitar tomografía computarizada de tórax ambulatoria para descartar masa tímica.
D) Intubación orotraqueal de urgencia y amigdalectomía bilateral en caliente inmediata.
E) Realizar laringoscopía indirecta con espejo para evaluar la movilidad de las cuerdas vocales.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.004

2. Un lactante de 2 años presenta fiebre alta de 39.2°C, irritabilidad, rechazo alimentario, sialorrea y una postura fija del cuello en extensión con tortícolis dolorosa y estridor inspiratorio leve. En la radiografía lateral de cuello se evidencia un marcado ensanchamiento del espacio de partes blandas prevertebrales a nivel cervical. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la complicación más temida de no mediar tratamiento urgente?

A) Absceso retrofaríngeo; mediastinitis necrotizante descendente.
B) Croup viral laringotraqueal; estenosis subglótica adquirida.
C) Epiglotitis aguda; fístula traqueoesofágica espontánea.
D) Absceso periamigdalino bilateral; trombosis de arteria basilar.
E) Mononucleosis infecciosa severa; rotura esplénica retardada.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.002

3. ¿Cuál es la causa del trismus (dificultad para la apertura bucal) característico que acompaña al absceso periamigdalino y al absceso parafaríngeo?

A) Parálisis del nervio facial a nivel del canal estilomastoideo.
B) Compromiso inflamatorio y espasmo reflejo del músculo pterigoideo interno (medial).
C) Luxación traumática de la articulación temporomandibular.
D) Compresión directa del tronco del nervio trigémino en la fosa media.
E) Trombosis de la arteria carótida externa ipsilateral.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.003

4. Un paciente de 55 años con antecedentes de mala higiene dental consulta por aumento de volumen cervical anterior y submandibular bilateral de consistencia dura 'en madera', con dolor intenso. Al examen físico destaca fiebre, dificultad respiratoria, incapacidad para tragar la saliva y elevación forzada de la lengua que se encuentra empujada hacia el paladar y hacia atrás. ¿Cuál es la prioridad absoluta en el manejo médico inmediato de este paciente?

A) Extracción inmediata en box de las piezas dentarias cariadas bajo anestesia local.
B) Asegurar y proteger la vía aérea de forma precoz (intubación guiada o traqueostomía).
C) Administración de corticoides orales en altas dosis y reposo en domicilio.
D) Solicitud de radiografía panorámica dental ambulatoria.
E) Punción evacuadora con trocar en el piso de la boca sin anestesia.

Más preguntas online de Complicaciones Supurativas →

14.15. Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

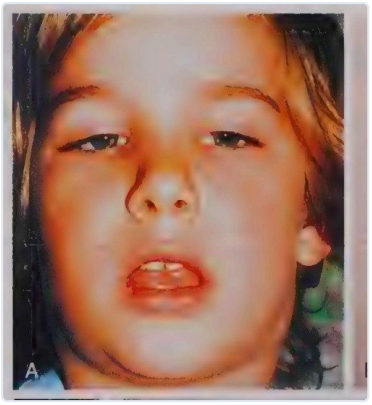
CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.100 6.03.1.027 6.03.1.028 2.01.4.004 6.03.1.003 6.03.4.002

¿POR QUÉ?

La hipertrofia del tejido linfoide del anillo de Waldeyer (amígdalas palatinas y adenoides) es la causa principal de obstrucción de la vía aérea superior en pediatría. En el EUNACOM se evalúa de manera prioritaria la indicación quirúrgica absoluta de adenoamigdalectomía en el Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) infantil para prevenir el cor pulmonale y alteraciones del neurodesarrollo, así como el conocimiento riguroso de los criterios de Paradise para la amigdalectomía por infecciones bacterianas recurrentes.

1. FISIOPATOLOGÍA DEL RESPIRADOR BUCAL Y FACIES ADENOIDEA

El **anillo linfático de Waldeyer** alcanza su mayor desarrollo inmunológico fisiológico entre los 2 y los 6 años de edad. Cuando la proliferación de las adenoides (amígdala faríngea en el cavum) y de las amígdalas palatinas es desproporcionada, produce una obstrucción mecánica fija de la vía aerodigestiva superior. 2.01.1.100 6.03.1.028



Facies adenoidea: boca abierta, respirador bucal

La respiración bucal crónica condiciona una alteración del desarrollo craneofacial conocida como **Facies Adenoidea**: rostro alargado y estrecho, boca constantemente entreabierta, labio superior corto y retraído, labio inferior evertido, paladar ojival alto, micrognatia mandibular, maloclusión dentaria clase II y ojeras oscuras crónicas por estasis venosa. **(ver Imagen 14.15A)**

2. SAHOS INFANTIL: CRITERIOS CLÍNICOS Y CONSECUENCIAS SISTÉMICAS

El **Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)** en niños se caracteriza por episodios recurrentes de obstrucción parcial prolongada o colapso completo intermitente de la vía aérea superior durante el sueño. Se manifiesta por **ronquido nocturno ruidoso, pausas respiratorias audibles seguidas de ronquido de rescate, sueño inquieto y fragmentado, sudoración nocturna profusa, enuresis secundaria** y posturas anormales para dormir (hiperextensión del cuello). 6.03.1.027

A diferencia del adulto (que suele presentar hipersomnolencia diurna marcada), los niños con SAHOS manifiestan frecuentemente **hiperactividad paradójica, irritabilidad diurna, dificultades de concentración y bajo rendimiento escolar** (a menudo diagnosticados erróneamente como TDAH), asociados a retraso pondoestatural por gasto calórico aumentado y disminución de la secreción nocturna de hormona de crecimiento. En casos graves y prolongados, la hipoxemia alveolar nocturna y la hipercapnia desencadenan vasoconstricción pulmonar refleja y **Cor Pulmonale crónico con hipertrofia ventricular derecha**.

3. INDICACIONES DE AMIGDALECTOMÍA Y CRITERIOS DE PARADISE

Las indicaciones quirúrgicas de amigdalectomía y adenoidectomía se clasifican en absolutas y relativas: 2.01.1.100

Indicaciones Absolutas:

1. **SAHOS infantil documentado o hipertrofia amigdalina severa (Grado 4: 'amígdalas en beso')** que produce apneas del sueño obstructivas, cor pulmonale o alteraciones graves del crecimiento craneofacial. **(ver Imagen 14.15B)** 2.01.1.100 6.03.1.027



Amígdalas que se tocan en la línea media (grado 4)

2. **Sospecha fundada de neoplasia maligna amigdalina unilateral** (asimetría amigdalina marcada, ulceración, induración pétrea por sospecha de Linfoma o Carcinoma). 2.01.1.100

3. **Hemorragia amigdalina severa recurrente**.

Indicaciones Relativas (Infecciones Recurrentes / Criterios de Paradise): 2.01.1.100 6.03.1.003

Se indica amigdalectomía por infecciones bacterianas cuando se cumplen los **Criterios de Paradise** (episodios de faringoamigdalitis bien documentados clínicamente, con fiebre > 38.3°C, exudado o cultivo positivo para SBHGA, y tratados adecuadamente con antibióticos):

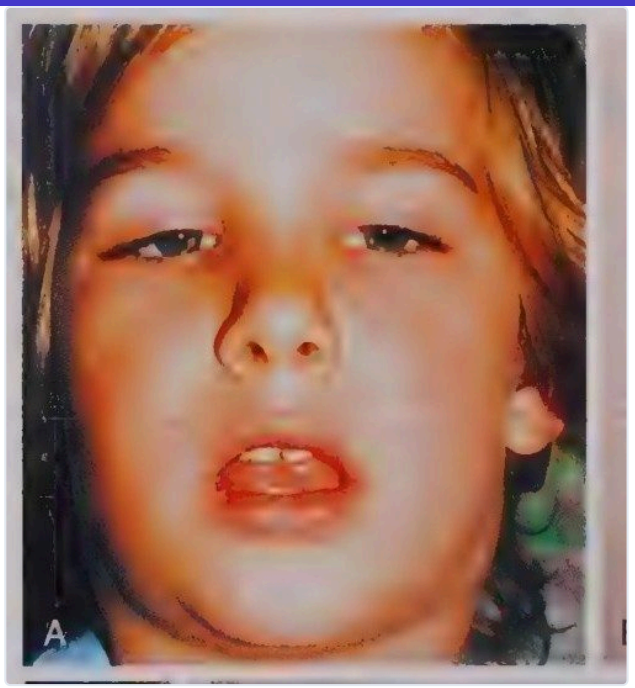
- **≥ 7 episodios documentados en el último año**, O 6.03.1.003
- **≥ 5 episodios al año durante los últimos 2 años consecutivos**, O
- **≥ 3 episodios al año durante los últimos 3 años consecutivos**.

Otras indicaciones relativas son: antecedente de dos abscesos periamigdalinos previos o amigdalitis hemorrágica.

4. RADIOGRAFÍA DE CAVUM Y MANEJO DEL RESPIRADOR BUCAL

La **radiografía lateral de cavum** (cuello en leve extensión, boca cerrada, respirando por la nariz) permite estimar el tamaño de las adenoides respecto de la nasofaringe: se informa la **columna de aire nasofaríngea reducida o ausente** y la relación adenoides/nasofaringe (índice de Fujioka), considerándose obstructiva una relación mayor de 0,8. Es útil para apoyar el diagnóstico de hipertrofia adenoidea en el niño con respiración bucal, ronquido y otitis media con efusión, pero depende de la colaboración del paciente y de la técnica; la **nasofibroscopía** es más precisa. En el adulto con obstrucción nasal unilateral u otitis media con efusión unilateral no se solicita radiografía: se hace endoscopía para descartar un tumor de cavum. 2.01.4.004 6.03.4.002

El manejo del **síndrome del respirador bucal** parte de identificar la causa de la obstrucción: hipertrofia adenoidea y amigdalina, rinitis alérgica, desviación septal, pólipos o atresia de coanas. Sus consecuencias son la **facies adenoidea**, el paladar ojival, la maloclusión, el sueño inquieto con ronquido y apneas, la otitis media con efusión y el bajo rendimiento escolar. Tratamiento: corticoide nasal y lavados en la rinitis alérgica, **adenoamigdalectomía** si hay obstrucción importante, apnea o infecciones recurrentes, y rehabilitación miofuncional y ortodoncia. Se deriva a ORL ante ronquido persistente, apnea del sueño u otitis media con efusión recurrente. 6.03.1.028



A. FACIES ADENOIDEA



B. AMÍGDALAS GRADO 4

Imagen 14.15

FIGURA 14.15 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS QUIRÚRGICOS EN HIPERTROFIA ADENOTONSILAR Y SAHOS

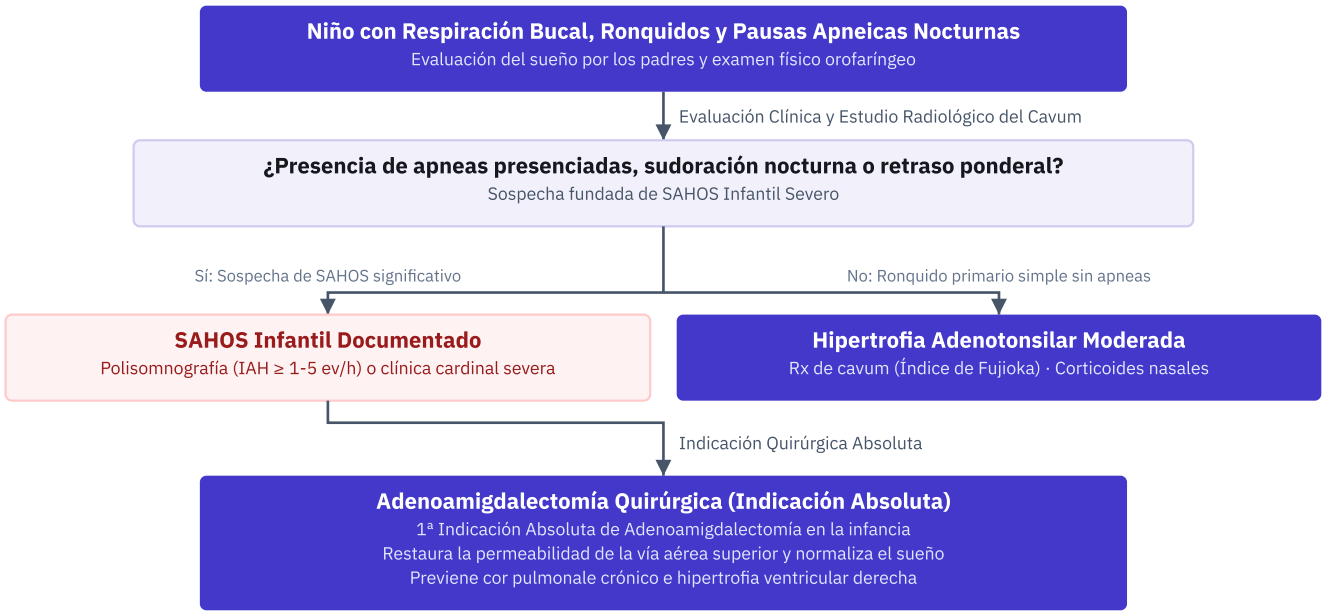


TABLA 14.15 · ESCALA DE BRODSKY PARA CLASIFICACIÓN DE LA HIPERTROFIA DE AMÍGDALAS PALATINAS

2.01.1.100, 6.03.1.027, 6.03.1.028, 2.01.4.004, 6.03.1.003, 6.03.4.002

GRADO DE BRODSKY	OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA	HALLAZGO FÍSICO EN OROFARINGE	RELEVANCIA QUIRÚRGICA
Grado 0	0% (Amígdalas ausentes)	Amigdalectomía previa o amígdalas en fosas profundas	Sin repercusión clínica
Grado 1	< 25% de la orofaringe	Amígdalas confinadas a las fosas amigdalinas	Normal fisiológico
Grado 2	25 a 50% de la orofaringe	Amígdalas sobrepasan los pilares anteriores pero no tocan línea media	Común en niños · Observación
Grado 3	50 a 75% de la orofaringe	Amígdalas ocupan más de la mitad del espacio orofaríngeo	Frecuente respirador bucal · Evaluar SAHOS
Grado 4	> 75% ('Amígdalas en beso')	Amígdalas se tocan entre sí en la línea media	ALTA indicación quirúrgica por riesgo de apneas obstructivas

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 14.15

Un preescolar de 4 años es traído al policlínico por sus padres debido a ronquidos ruidosos todas las noches y respiración con la boca abierta. La madre relata angustiada que en las noches observa cómo el niño deja de respirar por lapsos de 10 a 15 segundos, tras lo cual emite un ronquido áspero de esfuerzo y se mueve bruscamente en la cama, despertando con la almohada empapada de sudor. Durante el día es sumamente irritable, hiperactivo y en el jardín infantil no logra concentrarse. Al examen físico destaca un niño delgado, con ojeras prominentes, puente nasal ancho, mordida abierta anterior y presencia de amígdalas palatinas gigantescas que se contactan en la línea media (Grado 4 de Brodsky, 'amígdalas en beso'), dejando una luz faríngea mínima.

Conducta oficial. El cuadro clínico es patognomónico de un Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) infantil severo secundario a hipertrofia adenotonsilar grado 4 ('amígdalas en beso'). La presencia de pausas apneicas presenciadas, sudoración nocturna, sueño fragmentado y alteraciones del comportamiento diurno (hiperactividad e irritabilidad) son altamente concordantes. El SAHOS pediátrico constituye la primera y más clara indicación quirúrgica absoluta de Adenoamigdalectomía en la infancia. La corrección quirúrgica desobstruye de forma inmediata la vía aérea superior, erradica las apneas obstructivas, previene el desarrollo de cor pulmonale crónico y revierte las alteraciones de conducta y retraso del crecimiento.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La hipertrofia adenotonsilar es la causa más común de SAHOS en niños entre 2 y 6 años.
- El SAHOS infantil se manifiesta por ronquido nocturno, apneas presenciadas, sudoración y facies adenoidea.
- A diferencia del adulto, los niños con SAHOS presentan hiperactividad e irritabilidad diurna más que somnolencia.
- El SAHOS infantil severo es la indicación absoluta número uno de adenoamigdalectomía quirúrgica.
- Las amígdalas grado 4 de Brodsky ('amígdalas en beso') se tocan entre sí en la línea media ocluyendo > 75% de la vía aérea.
- Los criterios de Paradise para amigdalectomía por infecciones son: ≥ 7 en 1 año, ≥ 5/año en 2 años, o ≥ 3/año en 3 años.
- Una asimetría amigdalina progresiva indolora en un adulto obliga a descartar linfoma o carcinoma epidermoide.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.15

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.027

1. Un niño de 5 años presenta ronquidos nocturnos de 6 meses de evolución y pausas respiratorias nocturnas documentadas por sus padres de hasta 15 segundos con despertares sobresaltados y sudoración profusa. En el día respira con la boca abierta y presenta retraso pondoestatural. Al examen orofaríngeo se observan amígdalas palatinas grado 4 de Brodsky que contactan en la línea media. ¿Cuál es la conducta médica de elección más indicada?

A) Tratamiento prolongado con antibióticos orales profilácticos por 6 meses.
B) Indicación quirúrgica de adenoamigdalectomía bilateral.
C) Uso exclusivo de descongestionantes nasales tópicos nocturnos.
D) Observación expectante hasta los 12 años esperando la involución fisiológica espontánea.
E) Tratamiento con estimulantes del sistema nervioso central para la hiperactividad.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.100

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas constituye una indicación formal para considerar una amigdalectomía quirúrgica en un paciente pediátrico de acuerdo con los criterios de Paradise?

A) Haber presentado 2 episodios de amigdalitis bacteriana en el último año.
B) Presentar 7 episodios documentados de faringoamigdalitis bacteriana en el último año tratados con antibióticos.
C) Presentar ronquido nasal esporádico únicamente durante los resfriados comunes.
D) Presencia de placas de caseum amigdalino fétido en criptas sin fiebre ni odinofagia.
E) Un único episodio de amigdalitis viral asociada a conjuntivitis por adenovirus.

Más preguntas online de Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil →

14.16. Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.03.1.010 6.03.5.009 6.03.1.009

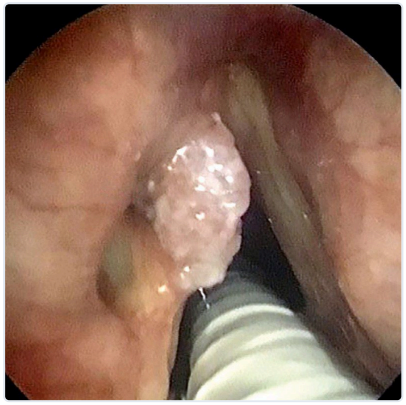
¿POR QUÉ?

La disfonía es una causa común de consulta en atención ambulatoria. El médico debe manejar con precisión dos preceptos fundamentales evaluados en el EUNACOM: (1) La 'Bandera Roja' de que toda disfonía persistente por más de 15 a 20 días en un adulto (especialmente si es fumador) exige visualización directa de la laringe para descartar cáncer escamoso; y (2) La diferenciación de las lesiones benignas de la mucosa de la cuerda vocal: los nódulos son bilaterales simétricos y se tratan con rehabilitación fonoaudiológica (la cirugía está desaconsejada de inicio); los pólipos son unilaterales y requieren resección quirúrgica; y el edema de Reinke es propio de mujeres fumadoras con voz grave.

1. REGLA DE ORO EN DISFONÍA Y BANDERAS ROJAS NEOPLÁSICAS

Se define **disfonía** como la alteración en una o más de las cualidades acústicas de la voz (tono, timbre, intensidad o fatiga vocal). La inmensa mayoría de las disfonías agudas (< 2 semanas) son laringitis virales o fonotraumáticas autolimitadas. 6.03.1.009

Regla de Oro EUNACOM: Toda disfonía que se prolongue por **más de 2 a 3 semanas de evolución** debe ser considerada sospechosa de neoplasia maligna de cuerda vocal (carcinoma epidermoide de laringe) hasta demostrar lo contrario, siendo **mandatoria la realización de una telelaringoscopía rígida o nasofibroscopía flexible** por el especialista otorrinolaringólogo. Los factores de riesgo de máxima alarma son el tabaquismo activo prolongado y el consumo de alcohol. **(ver Imagen 14.16A)** 6.03.1.010 6.03.5.009



Carcinoma de cuerda vocal en la laringoscopía

2. NÓDULOS VOCALES: LOS 'CALLOS' DE LA VOZ Y SU MANEJO FONOAUDIOLÓGICO

Los **nódulos de cuerda vocal** son las lesiones benignas más frecuentes en profesionales de la voz (profesoras de educación básica, educadoras de párvulos, cantantes, monitores). Se producen por un **microtraumatismo fonatorio repetido y crónico** (abuso o mal uso vocal), que genera edema y posterior hialinización fibrosa en el punto de máximo impacto mecánico vibratorio. 6.03.1.010

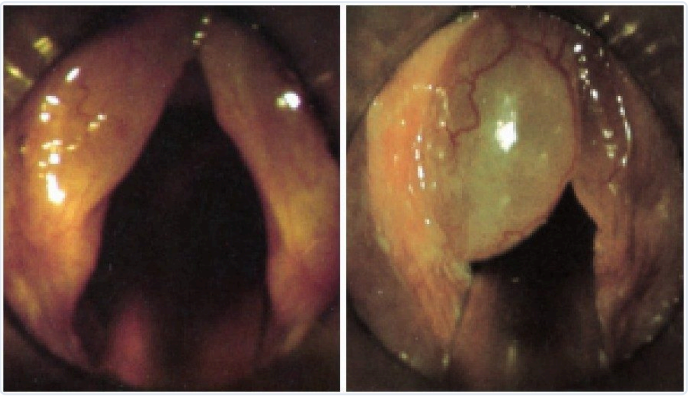
Laringoscopía: Se observan como **engrosamientos o nódulos blanquecinos o rosados, típicamente BILATERALES y SIMÉTRICOS, localizados en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores del borde libre de ambas cuerdas vocales**. Impiden el cierre glótico completo ('cierre en reloj de arena'), provocando voz soplada y escape de aire. **(ver Imagen 14.16B)** 6.03.1.010 6.03.5.009

Tratamiento de Elección: El pilar terapéutico de primera línea es la **Rehabilitación Fonoaudiológica (terapia de la voz)** para reeducar la técnica fonatoria y eliminar el sobresfuerzo. *La cirugía inicial está formalmente contraindicada*, ya que si no se corrige el vicio de emisión vocal, los nódulos recidivan invariablemente. La microcirugía laríngea solo se reserva para nódulos fibrosos antiguos refractarios a foniatría prolongada. 6.03.1.010

3. PÓLIPO VOCAL Y EDEMA DE REINKE: CARACTERÍSTICAS Y CIRUGÍA

Pólipo de Cuerda Vocal: Es una lesión benigna pediculada o sésil, casi invariablemente **UNILATERAL**, que se desarrolla en el espacio de Reinke tras un **traumatismo vocal agudo violento** (un grito desgarrador, un acceso violento de tos o cantar forzado), con rotura de un capilar submucoso y formación de un hematoma organizado. Provoca disfonía constante con voz bitonal o diplofonía. A diferencia de los nódulos, el pólipo **NO responde a la terapia fonoaudiológica y su tratamiento de elección es la Microcirugía Laríngea (Fonocirugía)** para exéresis de la lesión, complementada posteriormente con fonoaudiología. **(ver Imagen 14.16C)** 6.03.1.010

Edema de Reinke: Es una degeneración polipoidea difusa caracterizada por el acúmulo de líquido mucoide gelatinoso en todo el espacio de Reinke (lámina propia superficial) de ambas cuerdas vocales. Ocurre casi exclusivamente en **mujeres adultas o mayores con tabaquismo crónico intenso** asociado a reflujo faringolaríngeo y sobreesfuerzo vocal. Clínicamente se manifiesta como una **voz marcadamente grave, áspera y virilizada ('voz de tabernero')**, que en grados avanzados causa disnea y estridor por colapso glótico. El tratamiento requiere el **abandono radical del hábito tabáquico** (el tabaco perpetúa el edema) y **decorticación quirúrgica de cuerdas vocales (cordotomía y aspiración del exudado gelatinoso)**.

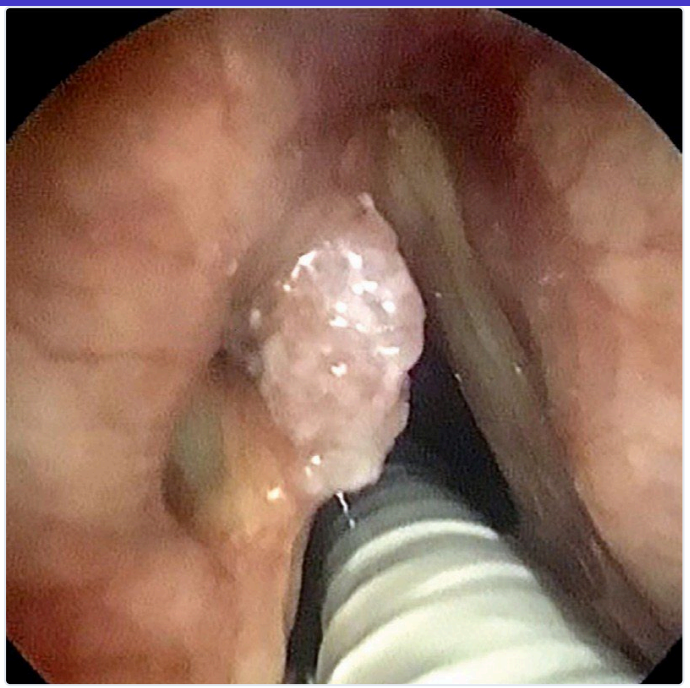


Edema de Reinke en la laringoscopía

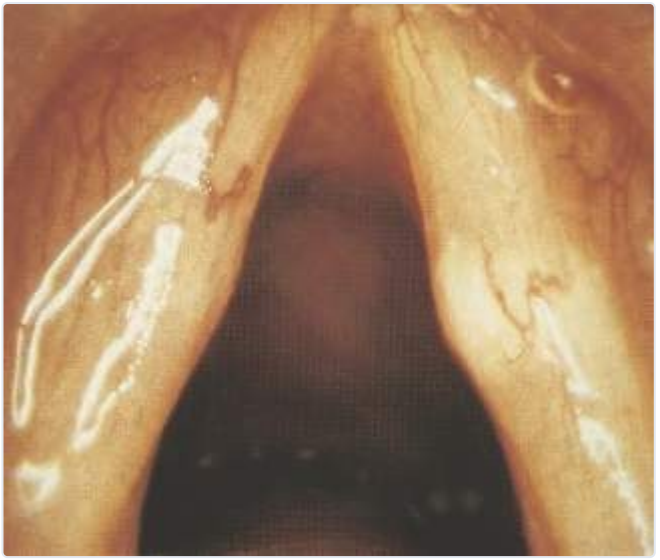
4. LARINGOSCOPÍA INDIRECTA Y MANEJO DE LA DISFONÍA AGUDA

La **laringoscopía indirecta** se realiza con un espejo laríngeo precalentado, luz frontal y la lengua traccionada con una gasa; con el paciente diciendo «iii» se visualizan epiglotis, repliegues, bandas ventriculares, **cuerdas vocales**, aritenoides y senos piriformes. Está limitada por el reflejo nauseoso y la epiglotis en omega, y hoy se complementa o reemplaza con la **nasofibrolaringoscopía flexible** o la telelaringoscopía rígida. Es un procedimiento que el médico general **deriva** a ORL: ante una disfonía de más de 3 a 4 semanas, o antes si hay tabaquismo, odinofagia, disfagia, hemoptisis, masa cervical o antecedente de intubación o cirugía cervical. 6.03.5.009

La **disfonía aguda** es en general una laringitis viral o por fonotrauma (abuso vocal) y se maneja con **reposo vocal relativo** (evitar gritar y susurrar), hidratación, humidificación, supresión del tabaco y de irritantes, y analgesia; **no requiere antibióticos**. Se identifica y trata el reflujo laringofaríngeo cuando existe. Los corticoides en ciclo breve solo se plantean en voces profesionales por indicación del especialista. La **hemorragia de una cuerda vocal** en un cantante exige reposo vocal absoluto y derivación. Si no mejora en 3 a 4 semanas, se estudia con laringoscopía. 6.03.1.009



A. CARCINOMA DE CUERDA VOCAL



B. NÓDULOS VOCALES



C. PÓLIPO VOCAL

Imagen 14.16

FIGURA 14.16 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA EN DISFONÍA CRÓNICA Y LESIONES BENIGNAS DE CUERDAS VOCALES

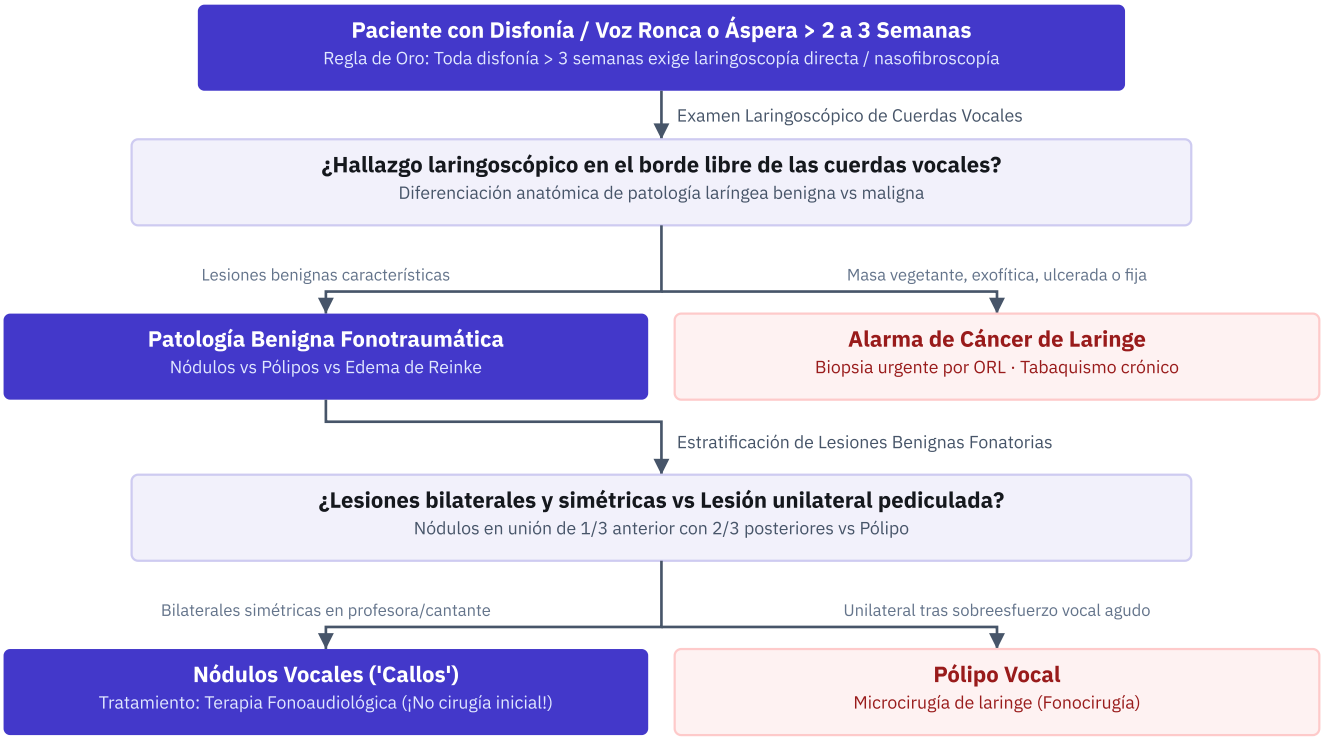


TABLA 14.16 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: NÓDULOS VOCALES VS PÓLIPO VOCAL VS EDEMA DE REINKE 6.03.1.010, 6.03.5.009, 6.03.1.009

LESIÓN DE CUERDA VOCAL	LATERALIDAD Y UBICACIÓN	POBLACIÓN Y CAUSA PRINCIPAL	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Nódulos Vocales	BILATERALES y simétricos · Unión 1/3 anterior con 2/3 posteriores	Profesores, cantantes · Mal uso y abuso vocal crónico	REHABILITACIÓN FONOAUDIOLÓGICA (Cirugía inicialmente desaconsejada)
Pólipo Vocal	UNILATERAL · Pediculado o sésil en borde libre	Hombres adultos · Esfuerzo vocal agudo violento (grito)	MICROCIRUGÍA LARÍNGEA (Fonocirugía) + Fonoaudiología postoperatoria
Edema de Reinke	Bilateral difuso · Cuerdas vocales gelatinosas abombadas	Mujeres fumadoras crónicas severas · Reflujo ácido	Cese estricto del tabaco + Decorticación quirúrgica / Aspiración
Úlcera / Granuloma de Contacto	Unilateral o bilateral sobre la apófisis vocal del aritenoides	Intubación endotraqueal previa traumática o reflujo severo	Inhibidores de bomba de protones (Omeprazol) + Reposo vocal

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 14.16

Una profesora de enseñanza básica de 32 años consulta por disfonía progresiva de 3 meses de evolución que empeora notoriamente los viernes al finalizar la jornada laboral y mejora parcialmente durante los fines de semana. Refiere que siente fatiga al hablar y que su voz se escucha 'soplada' y sin volumen. No fuma ni consume alcohol. Al examen otorrinolaringológico mediante nasofibroscopía se visualizan ambas cuerdas vocales móviles, apreciándose dos pequeñas lesiones blanquecinas puntiformes bien delimitadas, ubicadas de forma estrictamente simétrica y enfrentada en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores del borde libre de ambas cuerdas vocales, las cuales contactan impidiendo el cierre glótico completo.

Conducta oficial. El cuadro clínico y los hallazgos laringoscópicos son característicos de Nódulos de Cuerdas Vocales bilaterales. El perfil epidemiológico (profesora de básica con sobreesfuerzo vocal continuo), la fluctuación de los síntomas y la localización clásica en espejo sobre la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores del borde libre confirman la génesis fonotraumática ('callosidades vocales'). La conducta terapéutica de primera línea mandataria es la derivación a Terapia de Rehabilitación Fonoaudiológica para corregir la técnica vocal, enseñar higiene fonatoria y eliminar el sobreesfuerzo muscular. La extirpación quirúrgica no está indicada como abordaje inicial porque si la paciente no aprende la técnica fonatoria correcta, las lesiones recidivan rápidamente.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Toda disfonía que dure más de 2 a 3 semanas exige laringoscopía para descartar cáncer escamoso de laringe.
- Los nódulos vocales son bilaterales y simétricos, localizados en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores.
- El tratamiento de primera línea de los nódulos vocales es la TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA (no la cirugía).
- El pólipo vocal es unilateral y requiere microcirugía laríngea resectiva.
- El edema de Reinke produce voz grave 'de hombre' en mujeres con tabaquismo crónico masivo; se trata con cese del tabaco y cirugía.
- El granuloma de contacto se localiza en la apófisis vocal posterior del cartílago aritenoides, asociado a intubación previa o RGE.
- La parálisis de cuerda vocal unilateral en posición paramediana orienta a lesión del nervio laríngeo recurrente (sospechar cáncer de tiroides o pulmón).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.16

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.010

1. Una educadora de párvulos de 28 años consulta por disfonía crónica de 4 meses de evolución que se acentúa en las tardes. No fuma. La nasofibroscopía revela la presencia de dos lesiones nodulares blanquecinas pequeñas, bilaterales y simétricas, ubicadas en el borde libre de ambas cuerdas vocales en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores, que provocan un defecto de cierre glótico en reloj de arena. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?

A) Microcirugía laríngea con láser de CO2 inmediata.
B) Terapia de rehabilitación fonoaudiológica y pautas de higiene vocal.
C) Ciclo de corticoides orales en dosis altas por 21 días.
D) Inyección de toxina botulínica en el músculo tiroaritenoideo bilateral.
E) Reposo vocal absoluto (mutismo) prolongado por 6 meses seguidos.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.5.009

2. Un hombre de 62 años, fumador activo de 40 paquetes/año y consumidor habitual de alcohol, consulta en el centro de salud por disfonía progresiva e indolora de 6 semanas de evolución. No ha presentado fiebre, tos ni síntomas de reflujo. ¿Cuál es la conducta inmediata que debe adoptar el médico general?

A) Indicar reposo de la voz y omeprazol oral 40 mg al día por 1 mes para prueba terapéutica de reflujo.
B) Solicitar interconsulta prioritaria a otorrinolaringología para visualización de cuerdas vocales mediante laringoscopía o nasofibroscopía.
C) Prescribir amoxicilina con ácido clavulánico oral por 10 días ante sospecha de laringitis bacteriana.
D) Tranquilizar al paciente explicando que se trata de cambios vocales seniles fisiológicos propios de la edad.
E) Indicar nebulizaciones con suero fisiológico y corticoides inhalados por 2 semanas.

Más preguntas online de Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales →

14.17. Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.025 | 2.01.2.018 | 6.03.1.013 | 2.01.1.117

¿POR QUÉ?

La laringitis aguda obstructiva (croup) es la causa más común de obstrucción respiratoria alta aguda en pediatría. En el EUNACOM se evalúan de forma invariable dos dominios clínicos: (1) El manejo farmacológico del croup según la escala de Taussig: el uso mandatorio de Dexametasona (0.15-0.6 mg/kg) en todos los pacientes (incluso leves), sumado a la Adrenalina racémica o corriente nebulizada ante estridor de reposo, con observación por 2 horas para descartar efecto rebote; y (2) El diagnóstico de la Epiglotitis Aguda, cuadro bacteriano fulminante donde está terminantemente prohibido utilizar bajalenguas por riesgo de espasmo laríngeo fatal.

1. FISIOPATOLOGÍA DEL CROUP VIRAL Y TRIADA CLÍNICA

La **Laringitis Obstructiva Aguda o Croup** es una infección viral de la vía aérea subglótica que compromete la laringe y la tráquea (laringotraqueítis). El agente causal dominante en > 75-80% de los casos es el **Virus Parainfluenza tipo 1** (seguido de Parainfluenza tipo 2 y 3, VRS, Adenovirus y virus Influenza). Afecta predominantemente a niños entre los **6 meses y los 3 años de edad**, con pico de incidencia en otoño e invierno. **(ver Imagen 14.17C)** 2.01.1.025

El edema inflamatorio se concentra en la **región subglótica** (delimitada por el anillo cartilaginoso cricoides inelástico). Debido a la ley de Poiseuille, una reducción de solo 1 mm del diámetro subglótico en un lactante reduce el área de la vía aérea en un 75% y multiplica la resistencia al flujo aéreo por 16. **(ver Imagen 14.17A)** 2.01.1.025 | 2.01.2.018

Tríada Cardinal del Croup: (1) **Tos perruna, seca o metálica** ('tos de perro o de foca'); (2) **Estridor inspiratorio** rudo; y (3) **Disfonía o afonía**, típicamente precedidos de coriza y fiebre baja de 1 a 2 días. 2.01.1.025 | 2.01.2.018 | 6.03.1.013

2. ESCALA DE TAUSSIG Y MANEJO FARMACOLÓGICO ESCALONADO

La severidad de la obstrucción se estratifica mediante la **Escala de Taussig Modificada** (evalúa estridor, retracciones intercostales, entrada de aire, color de piel y estado de conciencia): 2.01.1.025

Grado I (Leve): Estridor inspiratorio ausente en reposo (solo audible al llorar o agitarse), tos perruna presente, retracciones mínimas o ausentes, murmullo vesicular simétrico. *Conducta:* **Dexametasona oral en dosis única de 0.15 a 0.6 mg/kg (máx 10-16 mg)**. Alta a domicilio con analgesia y educación de signos de alarma. 2.01.1.025 | 2.01.2.018 | 6.03.1.013

Grado II (Moderado): Estridor inspiratorio continuo audible en reposo, tiraje supraesternal e intercostal evidente pero sin aleteo nasal ni cianosis. *Conducta:* **Dexametasona oral o EV (0.6 mg/kg) + Nebulización con Adrenalina corriente (1:1.000) 4 a 5 mL (o adrenalina racémica al 2.25% 0.5 mL en 3 mL de suero)** con oxígeno a flujo alto (4-6 L/min).

Grado III (Severo): Estridor inspiratorio y espiratorio marcado en reposo, tiraje severo con cabeceo y disnea intensa, disminución de la entrada de aire bilateral, irritabilidad o agitación psicomotora. *Conducta:* Adrenalina nebulizada inmediata + Dexametasona EV + Oxígeno suplementario. 2.01.1.025 | 2.01.2.018

Grado IV (Agotamiento / Asfixia): Palidez, cianosis, disminución progresiva del estridor por colapso de la ventilación ('silencio auscultatorio'), depresión del sensorio o estupor. *Conducta:* Asistencia ventilatoria de emergencia e intubación orotraqueal con tubo endotraqueal medio número menor.

TABLA 14.17.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LARINGITIS OBSTRUCTIVA (CROUP) VS EPIGLOTITIS AGUDA 2.01.1.025, 2.01.2.018, 6.03.1.013, 2.01.1.117

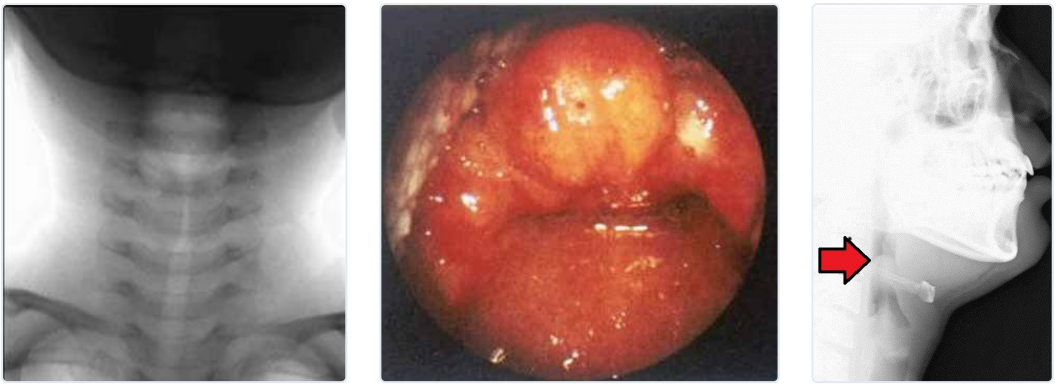
PARÁMETRO CLÍNICO	LARINGITIS OBSTRUCTIVA AGUDA (CROUP)	EPIGLOTITIS AGUDA FULMINANTE
Etiología Principal	Viral: Virus Parainfluenza tipo 1 (75%)	Bacteriana: H. influenzae tipo b, S. pyogenes, S. pneumoniae
Edad Típica	6 meses a 3 años (pico en otoño/invierno)	2 a 7 años y adultos jóvenes
Comienzo / Pródromo	Progresivo (1-2 días de coriza y febrícula)	Hiperagudo y fulminante (horas de evolución con fiebre alta)
Tos y Voz	TOS PERRUNA áspera, disfonía marcada	AUSENCIA DE TOS; voz gangosa o apagada ('voz de papa caliente')
Signos Patognomónicos	Estridor inspiratorio rudo con tos metálica	SIALORREA / BABEO continuo y POSTURA EN TRÍPODE
Examen Físico Orofaríngeo	Faringe ligeramente congestiva (seguro de examinar)	¡TERMINANTEMENTE PROHIBIDO DEPRIMIR LA LENGUA!
Tratamiento de Urgencia	Dexametasona oral/EV + Adrenalina nebulizada	Aseguramiento de vía aérea en quirófano + Ceftriaxona EV

14.17. Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ADRENALINA NEBULIZADA, EFECTO REBOTE Y TIEMPO DE OBSERVACIÓN

La **Adrenalina nebulizada** ejerce una vasoconstricción alfa-1 adrenérgica arteriolar intensa en la mucosa capilar subglótica, disminuyendo el `2.01.1.025` edema y reduciendo el estridor en menos de 10 a 30 minutos.

Sin embargo, su efecto clínico desaparece a las 2 horas. Puede ocurrir un **efecto rebote (reaparición del edema y del estridor)**. Por tanto, **todo niño que recibe adrenalina nebulizada debe permanecer en observación médica en el servicio de urgencia durante un mínimo estricto de 2 a 4 horas**. Si al cabo de 2-4 horas el niño se encuentra sin estridor en reposo, con buena entrada de aire y saturación normal, puede egresar gracias a que el corticoide (dexametasona) ya inició su efecto antiinflamatorio genómico sistémico (el cual inicia a las 2-3 horas y dura hasta 48-72 horas). Si persiste con estridor de reposo, debe hospitalizarse.



A. ESTRECHAMIENTO SUBGLÓTICO **B.** EPIGLOTIS ROJO CEREZA **C.** SIGNO DEL PULGAR

Imagen 14.17

FIGURA 14.17 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE EMERGENCIA EN LARINGITIS OBSTRUCTIVA AGUDA (CROUP)

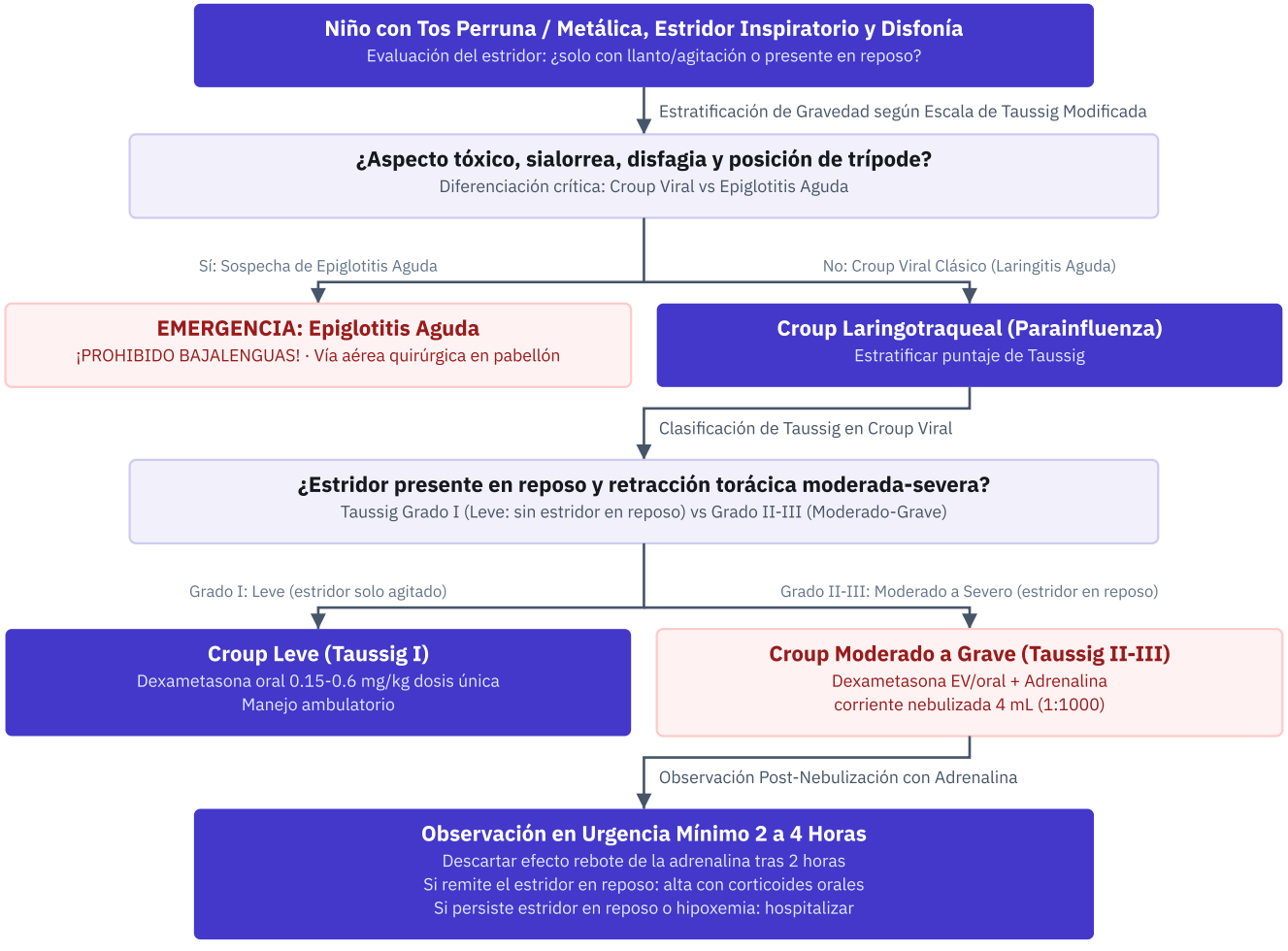


TABLA 14.17.B · ESCALA DE TAUSSIG MODIFICADA PARA CLASIFICACIÓN DEL CROUP EN URGENCIA CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRADO CLÍNICO	ESTRIDOR INSPIRATORIO	TIRAJE Y RETRACCIONES	ENTRADA DE AIRE	CONDUCTA TERAPÉUTICA INMEDIATA
Grado I (Leve)	Solo con llanto o agitación física (ausente en reposo)	Ausente o tiraje subcostal leve	Normal y simétrica	Dexametasona oral 0.15-0.6 mg/kg dosis única · Manejo ambulatorio
Grado II (Moderado)	Estridor audible en reposo continuo	Tiraje supraesternal e intercostal moderado	Levemente disminuida	Dexametasona oral/EV + Adrenalina nebulizada · Observación 2h
Grado III (Severo)	Estridor inspiratorio y espiratorio marcado en reposo	Tiraje severo generalizado con aleteo y cabeceo	Marcadamente disminuida	Adrenalina nebulizada + Dexametasona EV + O2 · Hospitalización
Grado IV (Agotamiento)	Disminuido por colapso inspiratorio (silencio)	Agotamiento respiratorio extremo	Apenas audible / Tórax silente	Intubación orotraqueal con tubo fino + Ventilación en UCI

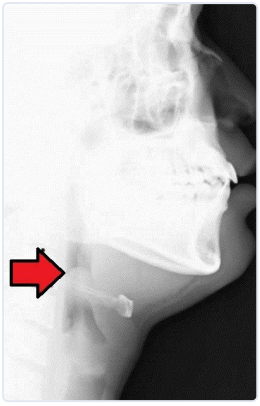
14.17. Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. EPIGLOTITIS AGUDA: EMERGENCIA QUIRÚRGICA Y REGLA DE ORO

La **Epiglotitis Aguda** es una infección bacteriana invasiva y fulminante de la epiglotis y repliegues aritenoepiglóticos que amenaza la vida en cuestión de minutos por oclusión mecánica completa de la laringe. **(ver Imagen 14.17B)** 2.01.2.018

El agente etiológico histórico clásico era *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib). Gracias a la vacuna pentavalente del PNI, su incidencia se ha reducido drásticamente, siendo provocada actualmente por *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes* o *Staphylococcus aureus* en niños mayores (2 a 7 años) o adultos.

Clínica de Alarma: Instalación súbita e hiperaguda con **fiebre alta muy tóxica (> 39-40°C), aspecto séptico, odinofagia intolerable que impide deglutir la saliva provocando sialorrea o babeo continuo, estridor inspiratorio apagado y postura en trípode** (niño sentado, inclinado hacia adelante con el cuello en hiperextensión y la boca abierta para respirar). **No hay tos perruna ni disfonía franca**. 2.01.2.018 6.03.1.013

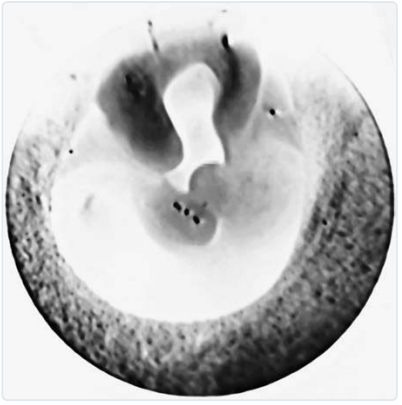


Epiglotitis: signo del pulgar en Rx lateral de cuello

REGLA DE ORO VITAL EUNACOM: *¡ESTÁ FORMALMENTE PROHIBIDO UTILIZAR BAJALENGUAS O INTENTAR VISUALIZAR LA FARINGE!* La estimulación mecánica del reflejo nauseoso con un abatelenguas puede desencadenar un **laringoespasmo fatal inmediato con paro cardiorrespiratorio**. El paciente debe ser trasladado de inmediato al quirófano junto a un anestesiólogo o cirujano para intubación orotraqueal directa o traqueostomía de emergencia bajo anestesia inhalatoria, e iniciar Ceftriaxona endovenosa. 2.01.2.018

5. ESTRIDOR CONGÉNITO Y LARINGOMALACIA

La **laringomalacia** es la causa más frecuente de **estridor congénito** (60 a 75 %): estridor **inspiratorio agudo**, intermitente, que aparece en las primeras 2 a 4 semanas, empeora con el llanto, la alimentación y el decúbito dorsal y mejora en prono, por colapso de las estructuras supraglóticas (epiglotis en omega, aritenoides redundantes). Los niños suelen ganar peso bien; el reflujo gastroesofágico es frecuente. El pico de síntomas ocurre hacia los 6 meses y se resuelve en el 90 % antes de los 12 a 18 meses. Manejo inicial: observación, posición, tratamiento del reflujo y control del crecimiento. 2.01.1.117 6.03.1.013



Laringomalacia: en la inspiración los repliegues de la epiglotis colapsan hacia la vía aérea

Se **deriva a ORL** (nasofibroscopía) el estridor con tiraje marcado, cianosis, apneas, dificultad para alimentarse, falla de medro o estridor atípico: **bifásico** o de inicio al nacer (parálisis de cuerdas vocales, estenosis subglótica), **espiratorio** (traqueomalacia, anillos vasculares) o asociado a **hemangioma cutáneo en la zona de la barba** (hemangioma subglótico, que responde a propranolol). La supraglotoplastía se reserva para los casos graves. 6.03.1.013 2.01.1.117

TABLA 14.17.C · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO EN LARINGITIS OBSTRUCTIVA AGUDA (CROUP) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / INTERVENCIÓN	DOSIS Y POSOLOGÍA PEDIÁTRICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	MECANISMO Y OBSERVACIONES
Dexametasona (Obligatoria)	0.15 a 0.6 mg/kg (dosis máxima 10 a 16 mg)	Oral (de elección) o Endovenosa	Dosis ÚNICA · Reduce hospitalizaciones y recidivas
Adrenalina Corriente (1:1.000)	4 a 5 mL pura sin diluir (o 0.5 mL/kg, máx 5 mL)	Nebulizada con oxígeno a 6 L/min	Vasoconstricción alfa-1 en mucosa subglótica · Efecto en 15 min
Adrenalina Racémica (2.25%)	0.05 mL/kg/dosis (máximo 0.5 mL) en 3 mL SF	Nebulizada con oxígeno	Eficacia idéntica a la adrenalina corriente 1:1.000
Tiempo de Observación Urgencia	Mínimo 2 horas (habitual 2 a 4 horas)	En sala de observación de urgencia	Descartar efecto rebote de la adrenalina tras 120 minutos

14.17. Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (CROUP / LARINGITIS OBSTRUCTIVA VS EPIGLOTITIS AGUDA)

- El Croup viral (laringotraqueítis) es causado en > 75% por Virus Parainfluenza tipo 1 en niños de 6 meses a 3 años.
- La Dexametasona oral (0.15 a 0.6 mg/kg) en dosis única es obligatoria en TODOS los grados de croup (incluso leves).
- Todo niño nebulizado con adrenalina debe observarse por un mínimo estricto de 2 a 4 horas para descartar efecto rebote.
- En la sospecha de epiglotitis aguda está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO usar bajalenguas por riesgo de laringoespasmo fatal.
- La tríada del croup es: tos perruna, estridor inspiratorio y disfonía.
- La Adrenalina nebulizada (corriente 1:1.000 4 mL o racémica) está indicada ante estridor presente en REPOSO (Taussig ≥ II).
- La Epiglotitis Aguda es una emergencia bacteriana fulminante con fiebre tóxica, sialorrea/babeo y posición en trípode sin tos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

14.17

Un lactante de 14 meses es llevado al servicio de urgencia a las 2:00 AM por presentar tos ronca 'perruna' de inicio brusco en la noche y dificultad respiratoria. Tuvo congestión nasal leve en los últimos 2 días. Al examen físico en la camilla se aprecia despierto, tranquilo en brazos de su madre, afebril (37.2°C axilar). Mientras se encuentra tranquilo en reposo, se ausculta un estridor inspiratorio rudo continuo, con retracción supraesternal e intercostal moderada y frecuencia respiratoria de 38 rpm, saturando 96% ambiental. El murmullo pulmonar se encuentra simétrico.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una Laringitis Obstructiva Aguda (Croup) de grado moderado (Taussig Grado II), caracterizada por la presencia de estridor inspiratorio audible en reposo continuo asociado a tiraje moderado en un lactante previamente resfriado. La etiología dominante es viral (Virus Parainfluenza). La conducta médica de elección inmediata consiste en: (1) Administrar Dexametasona en dosis única oral (o EV si no tolera) a 0.15-0.6 mg/kg (habitualmente 0.6 mg/kg), la cual reduce el edema subglótico a partir de las 2-3 horas; (2) Iniciar nebulización inmediata con Adrenalina corriente (1:1.000) 4 mL con flujo de oxígeno a 4-6 L/min para lograr una rápida vasoconstricción y alivio en 15 minutos; y (3) Mantener al niño en observación médica en el servicio de urgencia durante un mínimo de 2 a 4 horas para descartar un eventual efecto rebote tras el cese de la acción adrenérgica. Si al término del período de observación el estridor de reposo ha desaparecido completamente, el paciente puede ser dado de alta a su hogar con seguridad.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.17 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.025

1. Un niño de 2 años presenta cuadro de 24 horas de tos perruna y disfonía. Al examen físico en urgencia se encuentra en reposo, en brazos de su madre, afebril, con estridor inspiratorio claramente audible sin llanto y tiraje supraesternal moderado. Saturación de O2 96% al aire ambiental. ¿Cuál es el tratamiento inmediato más adecuado según las guías clínicas?

A) Amoxicilina con ácido clavulánico oral por 10 días y envío a domicilio.
B) Nebulización con adrenalina corriente con oxígeno y administración de dexametasona oral en dosis única, dejando en observación por 2 a 4 horas.
C) Salbutamol en aerosol con aerocámara cada 20 minutos por una hora y alta médica.
D) Intubación orotraqueal de urgencia inmediata bajo sedación profunda.
E) Nebulización exclusiva con suero fisiológico frío y control en el consultorio al día siguiente.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.018

2. Un preescolar de 3 años es llevado a urgencia por cuadro fulminante de 4 horas de evolución caracterizado por fiebre alta de 39.8°C, aspecto intensamente tóxico y gran dificultad para respirar. No presenta tos. Al examen físico se encuentra sentado, inclinado hacia adelante con el cuello extendido (postura en trípode), con la boca entreabierta y abundante sialorrea que cae sobre su ropa al ser incapaz de deglutir. Emite un estridor inspiratorio apagado. ¿Cuál de las siguientes acciones está FORMALMENTE CONTRAINDICADA?

A) Administración de oxígeno suplementario humidificado sin invadir al paciente.
B) Traslado inmediato a pabellón quirúrgico acompañado por un anestesiólogo.
C) Deprimir la lengua con un abatelenguas para inspeccionar la faringe en el box de atención.
D) Iniciar antibioticoterapia empírica endovenosa con ceftriaxona tras asegurar la vía aérea.
E) Permitir que la madre permanezca junto al niño para minimizar el llanto y la agitación.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.025

3. ¿Cuál es la razón principal por la cual un niño con laringitis obstructiva que recibe nebulización con adrenalina debe permanecer en observación médica en el servicio de urgencia durante un período de al menos 2 a 4 horas?

A) Para vigilar el desarrollo de hipertensión intracraneana secundaria a la adrenalina.
B) Para detectar el efecto rebote (reaparición del edema y del estridor) al decaer el efecto de la adrenalina.
C) Porque la adrenalina nebulizada tarda 3 horas en comenzar a ejercer su acción terapéutica.
D) Para esperar los resultados de la radiografía de tórax y hemograma de rutina.
E) Porque la dexametasona pierde su efecto clínico a las 2 horas de su administración.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.025

4. ¿Cuál de los siguientes agentes patógenos es el causante más frecuente de la laringotraqueítis aguda (croup viral) en la infancia?

A) Virus Parainfluenza tipo 1
B) Haemophilus influenzae tipo b
C) Streptococcus pneumoniae
D) Virus Epstein-Barr
E) Bordetella pertussis

Más preguntas online de Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 14.13 A 14.17

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina	La presencia de tos, rinorrea, disfonía o conjuntivitis prácticamente descarta SBHGA y...	**Los 4 criterios de Centor son: fiebre > 38°C, exudado amigdalino, adenopatías...**	—
Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	La tríada del absceso periamigdalino es: trismus, voz en 'papa caliente' y desviación...	**El trismus se produce por irritación inflamatoria del músculo pterigoideo interno...**	El esquema antibiótico del absceso periamigdalino debe cubrir estreptococos y...
Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas	La hipertrofia adenotonsilar es la causa más común de SAHOS en niños entre 2 y 6 años.	**El SAHOS infantil se manifiesta por ronquido nocturno, apneas presenciadas, sudoración...**	Una asimetría amigdalina progresiva indolora en un adulto obliga a descartar linfoma o...
Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke	Toda disfonía que dure más de 2 a 3 semanas exige laringoscopía para descartar cáncer...	**Los nódulos vocales son bilaterales y simétricos, localizados en la unión del tercio...**	El cuadro clínico y los hallazgos laringoscópicos son característicos de Nódulos de...
Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia	El Croup viral (laringotraqueítis) es causado en > 75% por Virus Parainfluenza tipo 1...	**La tríada del croup es: tos perruna, estridor inspiratorio y disfonía.**	Todo niño nebulizado con adrenalina debe observarse por un mínimo estricto de 2 a 4...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La presencia de tos, rinorrea, disfonía o conjuntivitis prácticamente descarta SBHGA y confirma etiología viral.

Los 4 criterios de Centor son: fiebre > 38°C, exudado amigdalino, adenopatías cervicales anteriores dolorosas y ausencia de tos.

La escala de McIsaac añade el factor edad: 3-14 años (+1), 15-44 años (0), ≥ 45 años (-1).

El tratamiento de primera línea es Penicilina Benzatina IM dosis única o Amoxicilina oral por 10 DÍAS COMPLETOS.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Los 4 criterios de Centor son: fiebre > 38°C, exudado amigdalino, adenopatías cervicales anteriores dolorosas y ausencia de tos.
- La escala de McIsaac añade el factor edad: 3-14 años (+1), 15-44 años (0), ≥ 45 años (-1).
- El trismus se produce por irritación inflamatoria del músculo pterigoideo interno contiguo al pilar amigdalino.
- El tratamiento inicial mandatario del absceso periamigdalino es la punción o incisión y drenaje en el punto de mayor abombamiento.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La presencia de tos, rinorrea, disfonía o conjuntivitis prácticamente descarta SBHGA y confirma etiología viral.	Tema 14.13 →
La tríada del absceso periamigdalino es: trismus, voz en 'papa caliente' y desviación de la úvula hacia el lado...	Tema 14.14 →
La hipertrofia adenotonsilar es la causa más común de SAHOS en niños entre 2 y 6 años.	Tema 14.15 →
Toda disfonía que dure más de 2 a 3 semanas exige laringoscopía para descartar cáncer escamoso de laringe.	Tema 14.16 →
El Croup viral (laringotraqueítis) es causado en > 75% por Virus Parainfluenza tipo 1 en niños de 6 meses a 3 años.	Tema 14.17 →

perfil v3 asofamech
3 CÓDIGOS OFICIALES

05

BLOQUE TEMÁTICO
3 clases

CUERPOS EXTRAÑOS, GLÁNDULAS SALIVALES & ONCOLOGÍA CERVICAL

3	8	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
14.18	Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	89
14.19	Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo	93
14.20	Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	97

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

3 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
6.03.2.008, 6.03.2.010, 6.03.2.007, 6.03.2.009, 6.03.3.005, 6.03.5.006, 6.03.5.007	Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	Específico	Inicial	Completo
6.03.1.023, 4.01.1.001	Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo	Específico	Inicial	Específico
6.03.1.004, 6.03.1.015, 6.03.1.005, 4.01.1.032, 2.01.1.004, 6.03.1.006, 6.03.1.018, 6.03.3.004	Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	Específico	Inicial	Específico

BLOQUE 05 · CUERPOS EXTRAÑOS, GLÁNDULAS SALIVALES & ONCOLOGÍA CERVICAL

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
8 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

La pila de botón en fosa nasal o CAE es una emergencia quirúrgica absoluta por riesgo de perforación y necrosis en < 2 horas.

! TRAMPA · En cuerpos extraños por pilas de botón está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO irrigar con agua o suero.

Un niño pequeño con rinorrea purulenta unilateral y de mal olor tiene un CUERPO EXTRAÑO NASAL hasta demostrar lo contrario.

! TRAMPA · En cuerpos extraños esféricos nasales se usa un gancho romo por detrás; están contraindicadas las pinzas quirúrgicas lisas.

! TRAMPA · En cuerpos extraños vegetales (semillas, porotos) en el CAE está prohibido el lavado con agua porque se hinchan.

Ante un insecto vivo en el CAE, la primera medida obligatoria es ahogarlo con vaselina líquida o lidocaína.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 3 TEMAS

Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	EUNACOM Diciembre 2017 · #94
Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo	EUNACOM Diciembre 2025 · #168 · EUNACOM Julio 2024 · #178 · EUNACOM Julio 2016 · #71
Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	EUNACOM Diciembre 2025 · #31 · EUNACOM Diciembre 2025 · #92 · EUNACOM Julio 2025 · #47 · EUNACOM Enero 2023 · #80

14.18. Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

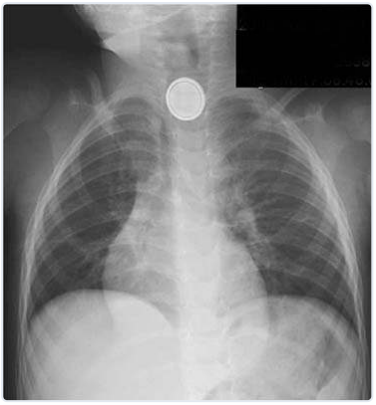
CÓDIGO PERFIL V3 6.03.2.008 | 6.03.2.010 | 6.03.2.007 | 6.03.2.009 | 6.03.3.005 | 6.03.5.006 | 6.03.5.007

¿POR QUÉ?

Los cuerpos extraños en el territorio otorrinolaringológico son sumamente comunes en niños preescolares (1 a 4 años). En el EUNACOM se evalúan tres escenarios clínicos de máxima rentabilidad: (1) La PILA DE BOTÓN en fosa nasal o CAE: constituye una emergencia quirúrgica absoluta debido a que genera necrosis electroquímica por licuefacción y perforación septal o timpánica en menos de 2 a 4 horas; ¡está terminantemente prohibido irrigar con agua!; (2) La sospecha de cuerpo extraño nasal inadvertido de larga data ante un niño con rinorrea purulenta unilateral fétida; y (3) La aspiración de cuerpo extraño en vía aérea con síndrome de penetración y asimetría auscultatoria.

1. PILA DE BOTÓN EN ORL: LA MÁXIMA EMERGENCIA QUIRÚRGICA

La presencia de una **pila de botón (batería de disco)** en fosas nasales, conducto auditivo externo o esófago es una **EMERGENCIA QUIRÚRGICA ABSOLUTA** que debe resolverse en cuestión de minutos. Las baterías de litio generan daño tisular catastrófico mediante tres mecanismos simultáneos: (a) Generación de una corriente eléctrica continua que descompone el agua tisular en iones hidroxilo (OH-), generando una quemadura alcalina extrema; (b) Fuga cáustica de hidróxido de potasio concentrado; y (c) Necrosis por presión isquémica. **(ver Imagen 14.18B y C)** 6.03.2.008



Pila de botón en el esófago (Rx de tórax)

La **necrosis por licuefacción y la perforación del cartílago septal o de la membrana timpánica pueden ocurrir en tan solo 2 horas** desde el contacto. A la radiografía se identifica el patognomónico **'signo del doble contorno' o 'signo del halo'**. **(ver Imagen 14.18A)**

REGLAS DE ORO VITALES EUNACOM:

• **Extracción Inmediata:** Debe extraerse de urgencia por un especialista ORL mediante instrumental específico bajo visión directa o en pabellón con anestesia general si no hay cooperación.

• **¡PROHIBIDO IRRIGAR O REALIZAR LAVADO CON AGUA O SOLUCIONES SALINAS!** La instilación de cualquier líquido conduce la corriente eléctrica, acelera la electrólisis cáustica y desintegra los tejidos de forma fulminante.

2. CUERPOS EXTRAÑOS NASALES Y LA REGLA DE LA RINORREA UNILATERAL FÉTIDA

Los cuerpos extraños nasales (trozos de esponja, papeles, semillas, perlas, juguetes de plástico) son colocados por los propios niños en la fosa nasal (más común en la fosa derecha). 6.03.2.010

Alerta EUNACOM: Todo niño pequeño (habitualmente entre 2 y 5 años) que consulta por **Rinorrea purulenta, espesa, unilateral y con intenso olor fétido**, asociada o no a obstrucción nasal y epistaxis unilateral leve, tiene un **CUERPO EXTRAÑO NASAL hasta demostrar lo contrario**.

Técnica de Extracción: Se realiza tras instilar vasoconstrictor tópico (oximetazolina) bajo rinoscopía anterior, utilizando un **gancho romo de punta angulada** que se introduce por arriba y detrás del objeto para traccionarlo hacia adelante por el piso de la fosa. Está *desaconsejado el uso de pinzas quirúrgicas lisas* en objetos redondos o esféricos, ya que al apretarlos resbalan y son empujados hacia la rinofaringe con grave riesgo de aspiración traqueobronquial. 6.03.2.010 | 6.03.5.007

3. CUERPOS EXTRAÑOS EN CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO (CAE)

Semillas o Legumbres Orgánicas (porotos, lentejas, arvejas): *¡Está TERMINANTEMENTE CONTRAINDICADO el lavado de oídos con agua!* Los cuerpos orgánicos deshidratados absorben agua rápidamente, aumentando su volumen en pocas horas, lo que impacta el objeto contra las paredes óseas del CAE y la membrana timpánica provocando dolor intolerable y necrosis cutánea. Se extraen con instrumental seco (gancho romo o microaspirador). 6.03.2.007 | 6.03.5.006

Insectos Vivos Móviles: El movimiento y aleteo del insecto contra el tímpano genera un dolor y angustia desesperante. La primera medida obligatoria es **matar e inmovilizar al insecto instilando inmediatamente en el CAE gotas de vaselina líquida, aceite mineral o lidocaína al 2%**. Una vez que el insecto está muerto e inmóvil, se procede a su extracción con lavado de oído con agua tibia a 37°C o pinza cocodrilo.

4. ASPIRACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN LA VÍA AÉREA

La aspiración de un cuerpo extraño (maní, frutos secos, fragmentos de juguetes) a la vía aérea inferior es una de las principales causas de muerte accidental en lactantes y preescolares. Se inicia típicamente con el **Síndrome de Penetración**: un acceso paroxístico violento de tos asfíctica súbita, cianosis, náuseas y estridor mientras el niño comía o jugaba. 6.03.2.009

El objeto se aloja con mayor frecuencia en el **bronquio principal derecho** (por su trayecto más vertical, amplio y en línea recta con la tráquea). Al examen físico se constata **asimetría auscultatoria con disminución marcada del murmullo pulmonar y sibilancias unilaterales**.

En la radiografía de tórax (la mayoría de los frutos secos son radiolúcidos) se observa el **signo de atrapamiento aéreo unilateral** (hiperinsuflación del pulmón afectado con aplanamiento del hemidiafragma y desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral en espiración) o atelectasia obstructiva. El procedimiento diagnóstico y terapéutico de elección indiscutido es la **Broncoscopía Rígida de Urgencia en pabellón bajo anestesia general**.

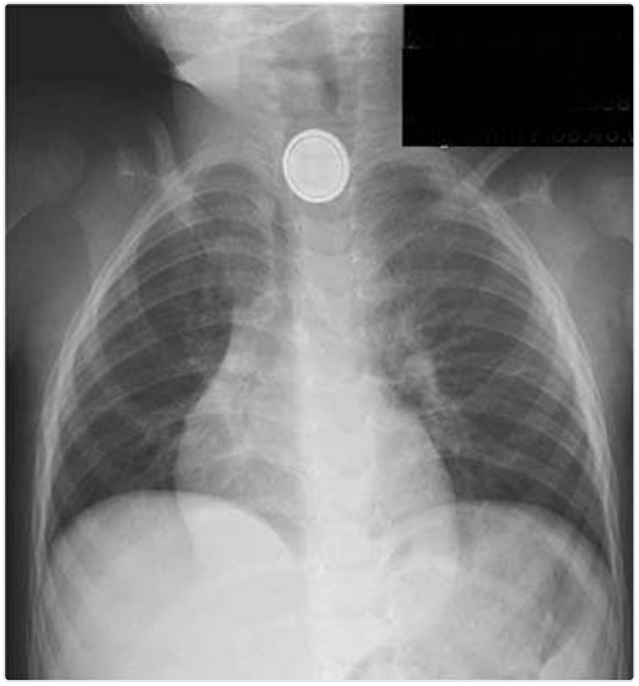
5. CUERPO EXTRAÑO ESOFÁGICO EN LA PRÁCTICA Y PREVENCIÓN EN NIÑOS

El **cuerpo extraño esofágico** más frecuente en el niño es la **moneda**, que se detiene en el esófago superior (cricofaríngeo); en el adulto, la **impactación alimentaria** (bolo de carne), que obliga a descartar esofagitis eosinofílica, estenosis péptica o anillo de Schatzki. Clínica: disfagia, odinofagia, sialorrea, vómitos, rechazo alimentario y, si comprime la vía aérea, estridor o tos. Se estudia con **radiografía de cuello y tórax en proyecciones anteroposterior y lateral**: la moneda esofágica se ve *de frente* en la proyección anteroposterior (de canto en la vía aérea). Si la moneda es asintomática y está en el esófago distal puede observarse hasta 24 horas; si hay síntomas, está en el esófago proximal o persiste, se extrae por **endoscopía**. 6.03.2.008

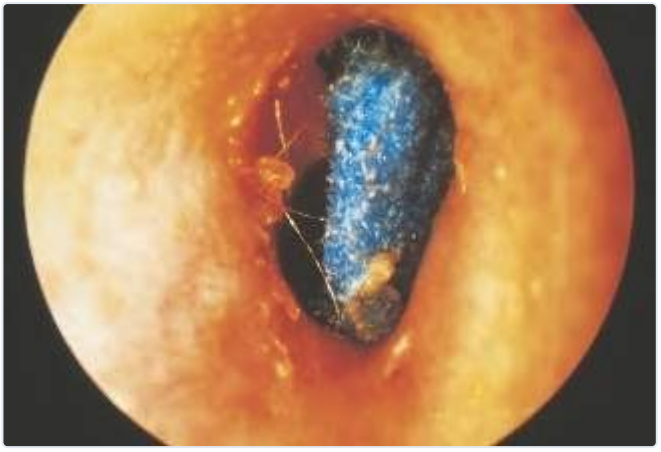
Son **urgencias de extracción inmediata** las baterías de botón, los imanes múltiples, los objetos cortopunzantes y la obstrucción completa con sialorrea; la impactación alimentaria se extrae por endoscopía dentro de 24 horas (6 si es completa). Está contraindicado inducir el vómito, empujar el objeto o intentar extraerlo a ciegas. La complicación temida es la perforación con mediastinitis.

La **prevención del cuerpo extraño en niños** se basa en educación a los cuidadores: no dar **frutos secos, uvas enteras, maní, zanahoria cruda ni cabritas** a menores de 5 años, cortar los alimentos, hacerlos comer sentados y sin correr, reír ni hablar; elegir juguetes sin piezas pequeñas (que pasen por un rollo de papel higiénico), guardar **pilas de botón, imanes y monedas** fuera de su alcance y enseñar a no introducir objetos en la nariz ni en los oídos. Se enseña a los cuidadores la maniobra de desobstrucción de la vía aérea.

6.03.3.005



A. PILA: DOBLE CONTORNO



B. OBJETO EN EL CONDUCTO



C. INSPIRACIÓN

Imagen 14.18

FIGURA 14.18 · ALGORITMO DE MANEJO Y URGENCIA EN CUERPOS EXTRAÑOS DE OÍDO, NARIZ Y VÍA AÉREA



TABLA 14.18 · SÍNTESIS DE CONDUCTA DE URGENCIA EN CUERPOS EXTRAÑOS OTORRINOLARINGOLÓGICOS

6.03.2.008, 6.03.2.010, 6.03.2.007, 6.03.2.009, 6.03.3.005, 6.03.5.006, 6.03.5.007

TIPO DE CUERPO EXTRAÑO	LOCALIZACIÓN	PELIGRO INMINENTE / SIGNO CLAVE	CONDUCTA MÉDICA OFICIAL
Pila de Botón (Batería)	Fosa nasal o CAE	Necrosis alcalina y perforación septal/timpánica en < 2h	URGENCIA MÁXIMA: Extracción inmediata · ¡PROHIBIDO IRRIGAR!
Cuerpo Extraño Desapercibido	Fosa nasal unilateral	Rinorrea purulenta UNILATERAL FÉTIDA en preescolar	Rinoscopía anterior y extracción con gancho romo por detrás
Semilla / Poroto vegetal	Conducto Auditivo Externo	Maceración e hinchazón masiva si entra en contacto con agua	¡PROHIBIDO LAVADO CON AGUA! Extracción con instrumental seco
Insecto Vivo Móvil	Conducto Auditivo Externo	Dolor atroz por aleteo contra el tímpano	Instilar vaselina líquida o lidocaína para ahogarlo, luego lavar
Fruto Seco (Maní / Nuez)	Bronquio principal derecho	Síndrome de penetración, sibilancias unilaterales, atelectasia	BRONCOSCOPÍA RÍGIDA DE URGENCIA en pabellón quirúrgico

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 14.18

La madre de una niña de 3 años consulta en urgencia porque hace 2 horas sorprendió a su hija introduciéndose un objeto metálico plano en la fosa nasal derecha que extrajo del control remoto de la televisión. La niña se queja de dolor nasal y presenta secreción sanguinolenta escasa por la narina derecha. Al examen físico, mediante rinoscopía anterior con espéculo nasal, se visualiza a 1.5 cm del vestíbulo una superficie metálica circular brillante correspondiente a una batería de botón pequeña, observándose la mucosa septal circundante intensamente edematosa y con áreas de palidez y tinte negruzco.

Conducta oficial. La presencia de una pila de botón en una fosa nasal constituye una de las emergencias médico-quirúrgicas más apremiantes en la especialidad otorrinolaringológica pediátrica. La corriente generada por el polo negativo descompone el agua tisular liberando iones hidroxilo con formación rápida de hidróxido de potasio, produciendo una quemadura cáustica por licuefacción capaz de destruir el tabique nasal cartilaginoso en menos de 2 a 4 horas. La conducta inmediata mandatoria es: (1) NUNCA irrigar la fosa nasal con soluciones salinas ni agua corriente (ya que aceleran la reacción electrolítica cáustica de forma explosiva); y (2) Realizar la extracción inmediata de la batería de disco mediante instrumental apropiado (gancho romo colocado por detrás del objeto o aspiración) por médico entrenado o derivación inmediata a pabellón con especialista ORL si la niña no coopera.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La pila de botón en fosa nasal o CAE es una emergencia quirúrgica absoluta por riesgo de perforación y necrosis en < 2 horas.
- En cuerpos extraños por pilas de botón está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO irrigar con agua o suero.
- Un niño pequeño con rinorrea purulenta unilateral y de mal olor tiene un CUERPO EXTRAÑO NASAL hasta demostrar lo contrario.
- En cuerpos extraños esféricos nasales se usa un gancho romo por detrás; están contraindicadas las pinzas quirúrgicas lisas.
- En cuerpos extraños vegetales (semillas, porotos) en el CAE está prohibido el lavado con agua porque se hinchan.
- Ante un insecto vivo en el CAE, la primera medida obligatoria es ahogarlo con vaselina líquida o lidocaína.
- El cuerpo extraño en vía aérea se aloja con mayor frecuencia en el bronquio principal derecho y se extrae con broncoscopía rígida.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.18

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.010

1. Una madre acude al servicio de urgencia con su hijo de 3 años refiriendo que el niño se introdujo en la fosa nasal izquierda una pila de botón extraída de un juguete hace aproximadamente una hora. El niño presenta llanto y sangrado nasal escaso. Al examen se confirma la presencia de la batería en la fosa nasal. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada?

A) Realizar lavado profuso de la fosa nasal con solución salina para neutralizar el pH y expulsar la pila.
B) Extracción inmediata del cuerpo extraño con gancho romo o derivación urgente a pabellón quirúrgico, sin realizar ninguna irrigación líquida.
C) Indicar descongestionantes orales y citar al policlínico de otorrinolaringología en 48 horas.
D) Instilar gotas de vaselina líquida para facilitar que la pila deslice hacia la nasofaringe.
E) Realizar compresión digital bimanual externa sobre el dorso nasal para aplastar la batería.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.010

2. Un niño de 4 años es traído a la consulta médica ambulatoria porque desde hace 3 semanas presenta mucosidad purulenta amarillenta que sale exclusivamente por la fosa nasal derecha, asociada a un olor fétido muy intenso. La madre refiere que ha sido tratado previamente con amoxicilina oral por sospecha de rinosinusitis sin ninguna mejoría. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable que debe descartarse en primer lugar?

A) Rinitis alérgica estacional unilateral.
B) Cuerpo extraño nasal desapercibido en la fosa nasal derecha.
C) Atresia de coanas bilateral congénita tardía.
D) Fibrosis quística con sobreinfección por Pseudomonas.
E) Desviación septal cartilaginosa pura sin componente inflamatorio.

Más preguntas online de Cuerpos Extraños en ORL →

14.19. Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.03.1.023 4.01.1.001

¿POR QUÉ?

Las glándulas salivales mayores (parótidas, submandibulares y sublinguales) son asiento de patologías litiásicas, infecciosas y tumorales con perfiles clínicos muy diferenciados. En el EUNACOM se evalúan tres cuadros típicos: (1) La Sialolitiasis, localizada en el 85% de los casos en la glándula submandibular (conducto de Wharton) que cursa con cólico salival postprandial; (2) La Parotiditis bacteriana aguda supurada en pacientes ancianos deshidratados con salida de pus por el conducto de Stenon; y (3) El Adenoma Pleomorfo, el tumor más común de la glándula parótida, de curso benigno pero con indicación quirúrgica por riesgo de malignización a carcinoma ex-adenoma pleomorfo.

1. SIALOLITIASIS: LA GLÁNDULA SUBMANDIBULAR Y EL CONDUCTO DE WHARTON

La **sialolitiasis** es la formación de cálculos en los conductos de las glándulas salivales mayores. El **80 a 90% de todos los litos se localizan en la Glándula Submandibular y su conducto excretor (Conducto de Wharton)**, debido a factores anatómicos y fisicoquímicos: (a) Su trayecto es largo, ascendente y antigravitatorio con una curva pronunciada sobre el músculo milohioideo; (b) La saliva submandibular es rica en mucina (más viscosa y espesa); y (c) Contiene mayor concentración de calcio y fosfatos con pH alcalino. 6.03.1.023 4.01.1.001

Clínica Patognomónica: 'Cólico Salival': aumento de volumen súbito y dolor agudo en la región submandibular que aparece de forma paroxística **durante las comidas o ante el estímulo olfatorio/visual de alimentos**, cediendo gradualmente 1 a 2 horas después de comer a medida que la saliva vence parcialmente la obstrucción o disminuye su producción.

Diagnóstico y Manejo: A la palpación bimanual del piso de boca se puede palpar el cálculo en el conducto de Wharton. La ecografía de cuello o radiografía oclusal de piso de boca confirma el lito. El tratamiento inicial incluye **hidratación oral abundante, calor local, masajes glandulares y sialogogos naturales (gotas de limón, caramelos ácidos)** para estimular el flujo salival. Cálculos mayores a 5 mm requieren **extracción quirúrgica transoral por incisión del conducto (marsupialización) o sialoendoscopía**. **(ver Imagen 14.19A)**

2. PAROTIDITIS BACTERIANA AGUDA SUPURADA EN EL PACIENTE GERIÁTRICO

La **parotiditis aguda supurada** es una infección bacteriana ascendente retrógrada a través del conducto de Stenon. Ocurre típicamente en **ancianos deshidratados, pacientes postoperados graves en ayuno prolongado o usuarios de fármacos anticolinérgicos** que inducen hiposialia marcada y mala higiene bucal. **(ver Imagen 14.19B)** 6.03.1.023 4.01.1.001

El microorganismo causal en > 80% de los casos es *Staphylococcus aureus*.

Se manifiesta por dolor intenso, aumento de volumen eritematoso y caliente de la región parotídea y preauricular, fiebre y trismus. El signo exploratorio patognomónico es la **expresión manual de la glándula parótida hacia adelante, lo cual provoca la salida de pus franco a través de la papila del conducto de Stenon** (ubicada en la mucosa yugal frente al segundo molar superior).

El tratamiento requiere **hospitalización, rehidratación endovenosa vigorosa y antibioticoterapia endovenosa antiestafilocócica: Cloxacilina EV (2 g c/4-6h) o Cefazolina EV** (Vancomicina si sospecha de SAMR).

3. TUMORES DE GLÁNDULAS SALIVALES: REGLA DEL 80% Y ADENOMA PLEOMORFO

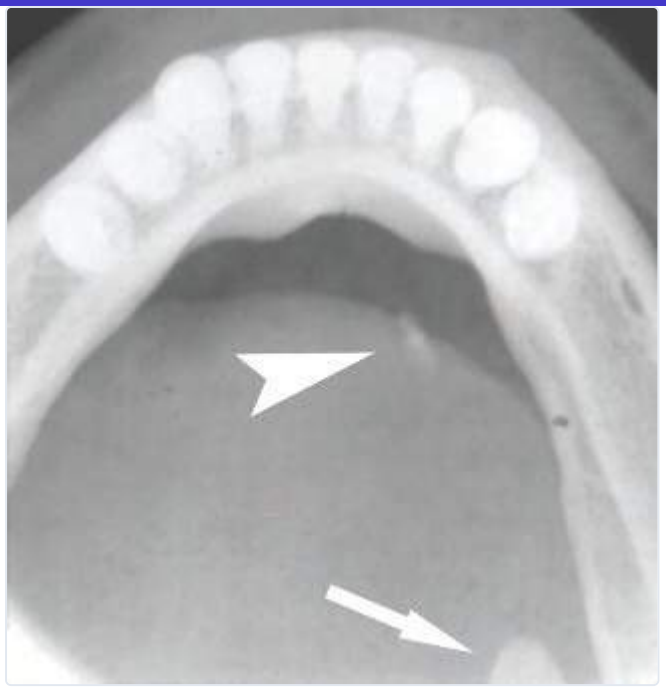
Regla del 80% en Oncología Salival:

- El **80% de los tumores de glándulas salivales asientan en la Glándula Parótida**. 6.03.1.023 4.01.1.001
- El **80% de los tumores parotídeos son BENIGNOS**.
- El **80% de los tumores benignos parotídeos corresponden a ADENOMA PLEOMORFO**.

Regla inversa de malignidad: Cuanto más pequeña es la glándula salival, mayor es la probabilidad de que un tumor sea maligno (parótida 20% malignos, submandibular 50% malignos, glándulas salivales menores en paladar 80% malignos).

Adenoma Pleomorfo (Tumor Mixto Benigno): Tumor epitelial y mesenquimático benigno. Clínicamente se manifiesta como una **masa o nódulo parotídeo de consistencia firme, gomosa, de superficie lisa o discretamente lobulada, móvil, de crecimiento lento e indoloro durante meses o años**. *Rigurosa AUSENCIA de parálisis del nervio facial (VII par)* (la presencia de parálisis facial en una masa parotídea es signo inequívoco de CÁNCER MALIGNO como carcinoma adenoide quístico o mucoepidermoide). **(ver Imagen 14.19C)**

Conducta Terapéutica: El estudio inicial de elección es la **Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía** y RMN/TAC de cuello. El tratamiento de elección es la **Parotidectomía superficial con disección y preservación obligatoria del nervio facial**. La enucleación simple está prohibida por presentar una tasa de recurrencia local superior al 40% debido a pseudópodos microscópicos, existiendo además un riesgo de transformación maligna a *Carcinoma ex-adenoma pleomorfo* (5-10% a los 15-20 años).



A. CÁLCULO EN EL WHARTON



B. SIALADENITIS SUPURADA



C. TUMOR PAROTÍDEO BENIGNO

Imagen 14.19

FIGURA 14.19 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN PATOLOGÍA DE GLÁNDULAS SALIVALES

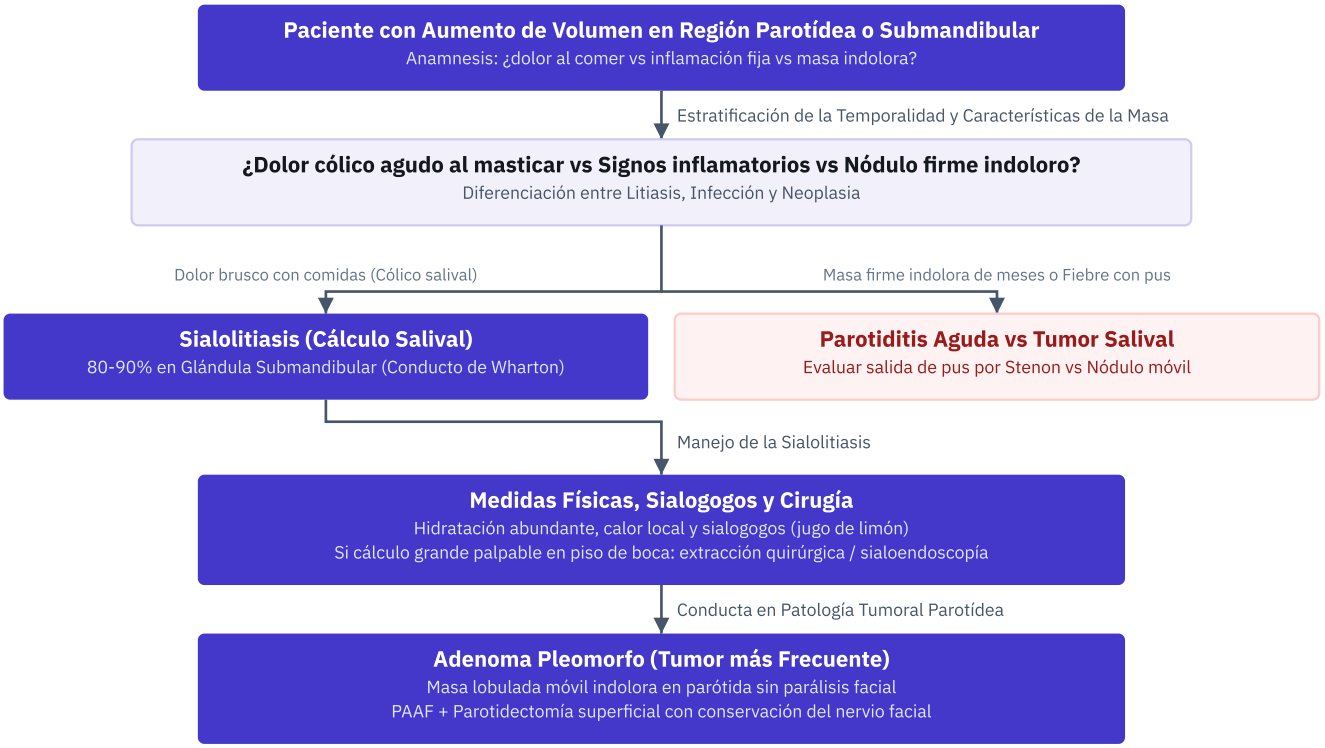


TABLA 14.19 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: SIALOLITIASIS VS PAROTIDITIS AGUDA VS ADENOMA PLEOMORFO `6.03.1.023, 4.01.1.001`

ENTIDAD SALIVAL	GLÁNDULA AFECTADA PRINCIPAL	PRESENTACIÓN CLÍNICA Y TEMPORALIDAD	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Sialolitiasis	Glándula Submandibular (85% en Wharton)	Cólico salival agudo desencadenado con las comidas	Hidratación + Sialogogos (limón) · Extracción quirúrgica
Parotiditis Supurada	Glándula Parótida (Conducto de Stenon)	Inflamación aguda, fiebre, salida de pus por papila de Stenon	Hospitalización + Cloxacilina / Cefazolina EV + Hidratación
Adenoma Pleomorfo	Glándula Parótida (Lóbulo superficial)	Nódulo parotídeo indoloro, móvil, crecimiento lento de años	PAAF + Parotidectomía superficial con preservación del VII par
Carcinoma Maligno	Submandibular / Menores (o Parótida)	Masa pétrea fija, dolorosa, PARÁLISIS FACIAL IPSILATERAL	Parotidectomía total + Resección de facial y vaciamiento cervical

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 14.19

Un hombre de 45 años consulta por presentar desde hace 2 meses dolor intenso y sensación de tensión súbita en la región submandibular izquierda cada vez que se sienta a almorzar o cenar. Refiere que durante los primeros bocados de comida nota un aumento de volumen marcado 'como un huevo' debajo de la mandíbula izquierda, el cual disminuye progresivamente de tamaño una o dos horas después de terminar de comer. Al examen físico en ayunas, la glándula submandibular izquierda se palpa ligeramente sensible y al realizar la palpación bimanual del piso de la boca a lo largo del conducto de Wharton se palpa una formación dura de consistencia pétrea de unos 4 mm cerca del frenillo lingual.

Conducta oficial. El cuadro clínico corresponde a una Sialolitiasis de la glándula submandibular izquierda con localización del cálculo en el conducto de Wharton. El dolor cólico paroxístico y la tumefacción glandular desencadenados de forma reproducible con las comidas ('cólico salival') representan la fisiopatología clásica de la obstrucción mecánica del flujo de saliva estimulado por la ingesta de alimentos. La glándula submandibular es la localización más frecuente (80-90% de las litiasis salivales) por la composición mucosa y alcalina de su secreción y el trayecto antigravitatorio ascendente del conducto de Wharton. Al ser un cálculo palpable en el segmento distal del conducto en el piso de boca, la conducta de elección consiste en estimulación con sialogogos naturales (gotas de limón), hidratación abundante, y si no expulsa espontáneamente, extracción quirúrgica transoral simple mediante sialolitotomía directa bajo anestesia local en la mucosa del piso de boca.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El 80-90% de las sialolitiasis se localizan en la Glándula Submandibular a lo largo del conducto de Wharton.
- El cólico salival se caracteriza por dolor y aumento de volumen súbito submandibular durante la ingesta de alimentos.
- La parotiditis bacteriana aguda por S. aureus se presenta en ancianos deshidratados con salida de pus por el conducto de Stenon.
- El 80% de los tumores de glándulas salivales asientan en la parótida, el 80% son benignos y el 80% son adenomas pleomorfos.
- El adenoma pleomorfo es una masa parotídea móvil e indolora de crecimiento lento que NUNCA compromete el nervio facial.
- La presencia de parálisis del nervio facial en una masa parotídea es signo patognomónico de CÁNCER MALIGNO.
- El tratamiento del adenoma pleomorfo es la parotidectomía superficial con preservación estricta del nervio facial (la enucleación simple está prohibida).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.19

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.023

1. Un paciente de 50 años consulta por dolor y aumento de volumen agudo recurrente en la región submandibular derecha que aparece típicamente al comenzar a comer y cede gradualmente dos horas después. La palpación bimanual del piso de la boca revela una zona indurada milimétrica dolorosa a lo largo del trayecto del conducto salival. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el conducto excretor involucrado?

A) Parotiditis viral urliana; conducto de Stenon.
B) Sialolitiasis submandibular; conducto de Wharton.
C) Adenoma pleomorfo submandibular; conducto de Rivinus.
D) Ranula sublingual simple; conducto de Bartolino.
E) Angina de Ludwig inicial; conducto tireogloso persistente.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.023

2. Una paciente de 42 años consulta por un nódulo indoloro en la región parotídea derecha que notó hace aproximadamente 1 año, de crecimiento muy lento. Al examen físico se palpa un nódulo de 2.5 cm en el polo inferior de la parótida derecha, de consistencia firme-elástica, superficie lisa, móvil, no adherido a planos profundos ni a la piel. La motilidad de la musculatura mímica facial es rigurosamente normal y simétrica en ambos lados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento quirúrgico de elección?

A) Carcinoma mucoepidermoide de alto grado; parotidectomía radical con sección del nervio facial y radioterapia.
B) Adenoma pleomorfo; parotidectomía superficial con disección y preservación del nervio facial.
C) Quiste branquial infectado; drenaje percutáneo ambulatorio e inicio de cloxacilina.
D) Sialometaplasia necrotizante; enucleación tumoral simple con bisturí frío en el box.
E) Parotiditis bacteriana crónica; tratamiento prolongado con amoxicilina-ácido clavulánico.

Más preguntas online de Patología de Glándulas Salivales →

14.20. Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.03.1.004 | 6.03.1.015 | 6.03.1.005 | 4.01.1.032 | 2.01.1.004 | 6.03.1.006 | 6.03.1.018 | 6.03.3.004

¿POR QUÉ?

El cáncer de cabeza y cuello comprende los tumores malignos originados en el epitelio de la mucosa del tracto aerodigestivo superior (laringe, orofaringe, cavidad oral, hipofaringe y nasofaringe). El tipo histológico en más del 90% es el Carcinoma de Células Escamosas (espinocelular). En el examen EUNACOM se evalúa de manera fija el axioma oncológico fundamental: toda adenopatía o masa cervical asintomática en un adulto mayor de 40 años con historia de tabaquismo y alcohol es una metástasis ganglionar de carcinoma escamoso hasta demostrar lo contrario. El método diagnóstico inicial de elección es la PAAF bajo ecografía, estando formalmente prohibida la biopsia incisional ganglionar.

1. EPIDEMIOLOGÍA, FACTORES DE RIESGO Y CARCINOMA ESCAMOSO

Más del **90 al 95% de las neoplasias malignas de cabeza y cuello corresponden a Carcinomas de Células Escamosas (carcinoma epidermoide o espinocelular)**. **(ver Imagen 14.20A y B)** 6.03.1.004 6.03.1.005

Los factores etiológicos dominantes tradicionales son el **tabaquismo crónico y el consumo nocivo de alcohol**, los cuales actúan de manera intensamente sinérgica multiplicando el riesgo relativo hasta por 30 veces. En las últimas dos décadas ha emergido un segundo grupo epidemiológico: carcinomas de orofaringe (amígdala palatina y base de lengua) en adultos más jóvenes sin tabaquismo pesado, impulsados por la **infección por Virus del Papiloma Humano oncogénico (VPH-16 en > 85% de los casos)**, los cuales se asocian a mejor pronóstico y alta respuesta a radioterapia. 6.03.1.004 6.03.1.005 6.03.3.004

2. BANDERAS ROJAS ONCOLÓGICAS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA

El médico de atención primaria y urgencias debe identificar con máxima agudeza los siguientes signos y síntomas de alarma que exigen derivación prioritaria inmediata a ORL:

- **Disfonía persistente por más de 2 a 3 semanas** en adulto fumador (alarma de cáncer de cuerda vocal / laringe). 6.03.1.005 6.03.3.004
- **Otalgia refleja unilateral persistente con otoscopía rigurosamente normal:** Se produce por irradiación dolorosa a través de ramas de los nervios glosofaríngeo (IX par / nervio de Jacobson) o vago (X par / nervio de Arnold) ante tumores de la base de la lengua, amígdala, hipofaringe o laringe.
- **Úlcera indurada, placa roja (eritroplasia) o blanca (leucoplasia) en lengua o cavidad oral** que no cicatriza tras 2 semanas. 6.03.1.004
- **Odinofagia o disfagia unilateral progresiva** con sensación de cuerpo extraño faríngeo constante. 6.03.1.018
- **Obstrucción nasal unilateral, epistaxis recurrente unilateral o hipoacusia por OME unilateral en un adulto** (alarma de Cáncer de Cavum / Nasofaringe por Virus Epstein-Barr que ocluye la trompa de Eustaquio). 6.03.1.006

3. AXIOMA DE LA MASA CERVICAL EN EL ADULTO Y EL ROL DE LA PAAF

Regla de los 80 de Skandalakis: En un adulto mayor de 40 años que presenta una masa cervical no tiroidea persistente por más de 3 semanas: **(ver Imagen 14.20C)** 6.03.1.015 4.01.1.032

- El **80% de las masas cervicales son NEOPLÁSICAS** (solo 20% son benignas/infecciosas).
- De las masas neoplásicas, el **80% son MALIGNAS**.
- De las masas malignas, el **80% son METÁSTASIS GANGLIONARES** (y solo 20% tumores primarios como linfomas).
- De las metástasis ganglionares, el **80% provienen de un CARCINOMA ESCAMOSO primario situado en la vía aerodigestiva superior** (por encima de las clavículas).

Secuencia Diagnóstica y REGLA DE ORO PROHIBITIVA EUNACOM:

1. **Examen ORL Completo:** Nasofibroscopía flexible minuciosa de toda la mucosa de cavum, orofaringe, hipofaringe y laringe para identificar el tumor primario.
2. **Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía:** Es el método de confirmación citológica de primera línea, con sensibilidad y especificidad > 95%, sin alterar la anatomía ganglionar.
3. *¡ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO REALIZAR BIOPSIA INCISIONAL O ESCISIONAL ABIERTA DEL GANGLIO EN PABELLÓN SIN ESTUDIO PREVIO!* La cirugía abierta de una adenopatía metastásica viola las barreras fasciales del cuello, siembra células tumorales en el tejido celular subcutáneo, empeora la sobrevida global y multiplica drásticamente la tasa de recidiva tumoral cervical.



Masa cervical lateral metastásica

4. CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO: SOSPECHA, PREVENCIÓN Y ADENITIS CERVICAL

El **cáncer de boca, labios y orofaringe** se sospecha ante una úlcera o lesión que no cicatriza en 2 a 3 semanas, leucoplasia o eritroplasia, induración, sangrado o adenopatía cervical dura; los factores de riesgo son tabaco, alcohol, masticar betel y, en la orofaringe (amígdala, base de lengua), el **VPH 16**. Manejo inicial: palpar la lesión y el cuello, retirar irritantes y prótesis traumáticas, tratar candidiasis o infección y reevaluar a las 2 semanas; si persiste, **se deriva para biopsia**. 6.03.1.004

El **cáncer laríngeo** (en su mayoría carcinoma escamoso, glótico el más frecuente) se sospecha con **disfonía persistente más de 3 semanas** en un fumador, y más tarde disfagia, odinofagia, otalgia refleja, hemoptisis, estridor o masa cervical. El médico general no lo maneja sino que lo **deriva para laringoscopía y biopsia**; el estudio de extensión incluye TAC o RM. En etapas precoces se trata con radioterapia o cirugía endoscópica conservadora de la voz, y en las avanzadas con quimiorradioterapia o laringectomía total. La **prevención del cáncer laríngeo** se basa en la cesación del tabaco (consejería breve, terapia de reemplazo con nicotina, vareniclina) y la reducción del alcohol, que potencian su efecto, además del control del reflujo y la protección en la exposición ocupacional (asbesto, polvos). 6.03.1.005 6.03.3.004

El **cáncer nasosinusal** es raro, se asocia a exposición ocupacional (polvo de madera y cuero, níquel, cromo) y al tabaco, y se sospecha ante **obstrucción nasal unilateral persistente, epistaxis unilateral recurrente, rinorrea sanguinolenta**, dolor o hipoestesia en la mejilla, ensanchamiento facial, proptosis o diplopía. Se deriva 6.03.1.006 6.03.1.018

para nasofibroscopía, imágenes y biopsia. La **odinofagia crónica** (más de 3 a 4 semanas) tiene causas benignas (amigdalitis crónica, reflujo laringofaríngeo, candidiasis orofaríngea, neuralgia glosofaríngea, síndrome de Eagle) pero también el cáncer de orofaringe o hipofaringe; son banderas rojas la odinofagia **unilateral**, la otalgia refleja, la masa cervical, la pérdida de peso y el tabaquismo, que obligan a derivar para endoscopía.

La **adenitis cervical** en el niño suele ser reactiva o viral. La 2.01.1.004 **adenitis bacteriana aguda** (*S. aureus*, *S. pyogenes*) se presenta con un ganglio unilateral doloroso, caliente y eritematoso, con fiebre, y se trata 10 días con amoxicilina-ácido clavulánico o cefadroxilo; si fluctúa, se solicita ecografía y drenaje. La adenopatía subaguda o crónica (más de 3 semanas) obliga a pensar en **micobacterias atípicas, tuberculosis ganglionar, enfermedad por arañazo de gato (*Bartonella*), toxoplasmosis, CMV y VEB**. Son señales de alarma de neoplasia (linfoma, leucemia) el ganglio mayor de 2 cm, duro, indoloro y fijo, supraclavicular, de crecimiento progresivo, o con fiebre, baja de peso y hepatoesplenomegalia: se solicitan hemograma, ecografía, PPD y biopsia, y **no se dan corticoides antes de tener un diagnóstico**.



A. CARCINOMA DE LENGUA



B. LEUCOPLAQUIA CON DISPLASIA



C. MASA CERVICAL LATERAL

Imagen 14.20

FIGURA 14.20 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y BANDERAS ROJAS EN EL ENFRENTAMIENTO DE LA MASA CERVICAL EN EL ADULTO

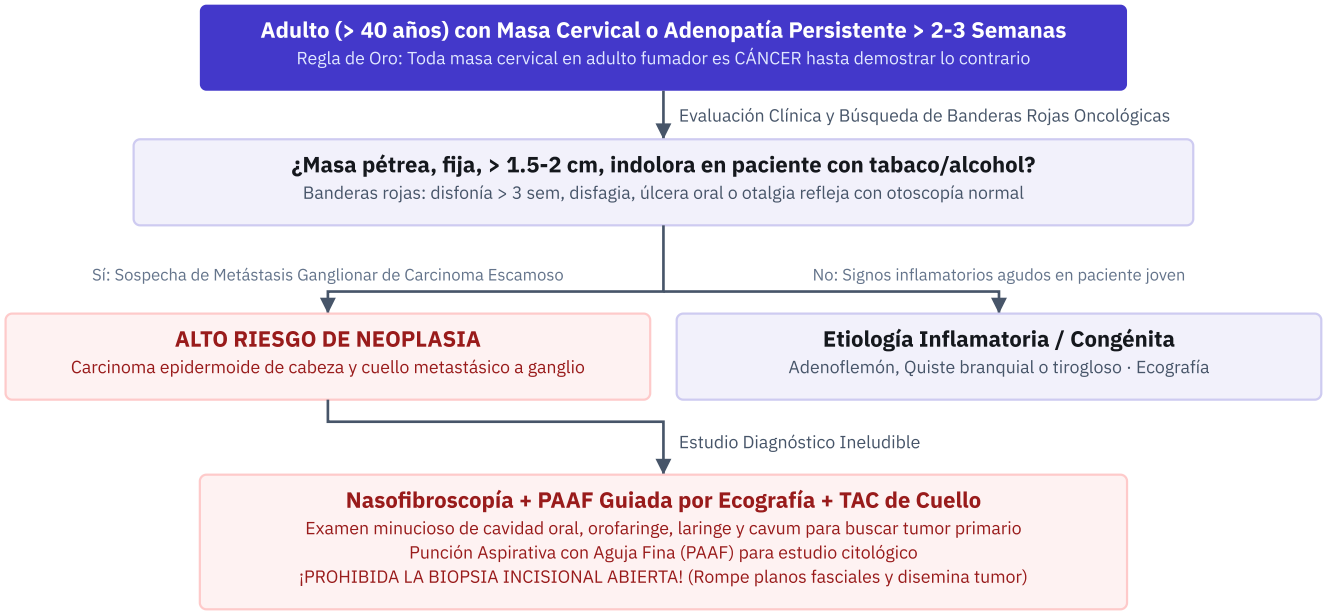


TABLA 14.20 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ETIOLÓGICO DE LA MASA CERVICAL SEGÚN GRUPO ETARIO

6.03.1.004, 6.03.1.015, 6.03.1.005, 4.01.1.032, 2.01.1.004, 6.03.1.006, 6.03.1.018, 6.03.3.004

GRUPO ETARIO	ETIOLOGÍA MÁS FRECUENTE (80%)	EJEMPLOS TÍPICOS	CONDUCTA INICIAL
Niños (< 15 años)	Infecciosa / Inflamatoria	Adenitis reactiva bacteriana o viral, adenoflemón	Antibióticos orales · Ecografía si no cede
Adultos Jóvenes (16-40 años)	Congénita / Infecciosa / Linfoma	Quiste del conducto tirogloso, quiste branquial, mononucleosis	Ecografía de cuello + PAAF si sospecha de Linfoma
Adultos Mayores (> 40 años)	NEOPLÁSICA MALIGNA (80%)	Metástasis de Carcinoma Escamoso de orofaringe/laringe	PAAF bajo ecografía + Nasofibroscopía urgente (¡NO BIOPSIA ABIERTA!)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 14.20

Un hombre de 58 años, fumador de 30 cigarrillos al día durante 35 años y consumidor diario de vino, consulta por la aparición de un aumento de volumen indoloro en la región lateral derecha del cuello que notó hace 1 mes y que ha crecido progresivamente. Refiere además que desde hace 3 semanas siente un dolor punzante leve en el oído derecho que aparece al tragar, pero no tiene secreción ni sordera. Al examen físico se palpa una masa adenopática de 3.5 cm en el nivel II yugulodigástrico derecho, de consistencia pétrea, dura, adherida a planos profundos e indolora. La otoscopía de ambos oídos es rigurosamente normal, con tímpanos translúcidos y sanos.

Conducta oficial. El paciente presenta una Masa Cervical de alto riesgo oncológico en un adulto mayor con factores de riesgo mayores (tabaquismo pesado y alcoholismo crónico). La consistencia pétrea, la fijación a planos profundos y el tamaño > 3 cm son signos patognomónicos de metástasis ganglionar de Carcinoma Escamoso de la vía aerodigestiva superior. La otalgia refleja derecha con otoscopía normal (conducida por el nervio glosofaríngeo o vago) es una bandera roja de primer orden que orienta a la presencia de un tumor primario oculto en la orofaringe (base de la lengua o amígdala) o hipofaringe. La conducta médica correcta e inmediata es: (1) Realizar un examen ORL completo con nasofibroscopía flexible para buscar minuciosamente el tumor primario en la mucosa; (2) Solicitar Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) de la adenopatía guiada por ecografía para confirmación citológica; y (3) Tomografía Computarizada (TAC) de cuello y tórax con contraste para etapificación. Está formalmente contraindicado extirpar el ganglio mediante biopsia incisional o abierta sin estudio completo previo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El Carcinoma de Células Escamosas (espinocelular) representa > 90% de los cánceres de cabeza y cuello.
- Toda masa cervical o adenopatía pétrea fija en un adulto > 40 años fumador es CÁNCER hasta demostrar lo contrario.
- La otalgia refleja con otoscopía rigurosamente normal es una bandera roja mayor de tumor de faringe o laringe.
- Una disfonía persistente por más de 2 a 3 semanas en un fumador exige laringoscopía para descartar cáncer de cuerda vocal.
- El método diagnóstico de elección para la masa cervical es la PAAF (Punción con Aguja Fina) guiada por ecografía.
- Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO realizar una biopsia incisional abierta de una masa cervical sin estudio previo.
- El VPH-16 es un factor etiológico mayor emergente de cáncer de orofaringe (amígdala y base de lengua) en pacientes jóvenes.
- La obstrucción nasal y otitis con efusión unilateral en un adulto mayor orienta a Carcinoma de Cavum (nasofaringe).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 14.20

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.015

1. Un hombre de 62 años, fumador crónico, consulta por una masa en la región lateral izquierda del cuello de 4 semanas de evolución, indolora y de consistencia pétrea de 3 cm de diámetro. Refiere además otalgia refleja izquierda ocasional con otoscopía rigurosamente normal. Respecto a la conducta diagnóstica inicial más apropiada, ¿cuál de los siguientes procedimientos es el método de elección para la confirmación anatomopatológica y qué procedimiento está formalmente contraindicado?

A) Método de elección: Biopsia incisional abierta en pabellón bajo anestesia local. Procedimiento contraindicado: PAAF bajo ecografía.
B) Método de elección: Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía. Procedimiento contraindicado: Biopsia ganglionar abierta antes de descartar tumor primario en vía aérea superior.
C) Método de elección: Drenaje por aspiración con trócar grueso pensando en quiste sebáceo. Procedimiento contraindicado: Tomografía computarizada.
D) Método de elección: Exéresis completa de la glándula tiroides de urgencia. Procedimiento contraindicado: Nasofibroscopía flexible.
E) Método de elección: Ciclo empírico de cefadroxilo oral por 21 días. Procedimiento contraindicado: Evaluación por otorrinolaringólogo.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.005

2. ¿Cuál de los siguientes síntomas constituye una bandera roja de sospecha oncológica que obliga a descartar prioritariamente un carcinoma escamoso de la base de la lengua, hipofaringe o laringe mediante nasofibroscopía?

A) Prurito ótico bilateral con descamación del conducto auditivo externo.
B) Otalgia persistente unilateral con examen otoscópico rigurosamente normal.
C) Hipoacusia de conducción que lateraliza al oído afectado en el test de Weber.
D) Estornudos en salva y rinorrea acuosa bilateral matinal.
E) Salida de secreción mucosa bilateral no fétida con tímpanos íntegros.

Más preguntas online de Cáncer de Cabeza y Cuello →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 14.18 A 14.20

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	La pila de botón en fosa nasal o CAE es una emergencia quirúrgica absoluta por riesgo...	**En cuerpos extraños por pilas de botón está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO irrigar con agua...**	En cuerpos extraños esféricos nasales se usa un gancho romo por detrás; están...
Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo	El 80-90% de las sialolitiasis se localizan en la Glándula Submandibular a lo largo del...	**El cólico salival se caracteriza por dolor y aumento de volumen súbito submandibular...**	El adenoma pleomorfo es una masa parotídea móvil e indolora de crecimiento lento que...
Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	El Carcinoma de Células Escamosas (espinocelular) representa > 90% de los cánceres de...	**Toda masa cervical o adenopatía pétrea fija en un adulto > 40 años fumador es CÁNCER...**	Una disfonía persistente por más de 2 a 3 semanas en un fumador exige laringoscopía...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La pila de botón en fosa nasal o CAE es una emergencia quirúrgica absoluta por riesgo de perforación y necrosis en < 2 horas.

En cuerpos extraños por pilas de botón está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO irrigar con agua o suero.

Un niño pequeño con rinorrea purulenta unilateral y de mal olor tiene un CUERPO EXTRAÑO NASAL hasta demostrar lo contrario.

En cuerpos extraños esféricos nasales se usa un gancho romo por detrás; están contraindicadas las pinzas quirúrgicas lisas.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- En cuerpos extraños por pilas de botón está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO irrigar con agua o suero.
- Un niño pequeño con rinorrea purulenta unilateral y de mal olor tiene un CUERPO EXTRAÑO NASAL hasta demostrar lo contrario.
- El cólico salival se caracteriza por dolor y aumento de volumen súbito submandibular durante la ingesta de alimentos.
- La parotiditis bacteriana aguda por S. aureus se presenta en ancianos deshidratados con salida de pus por el conducto de Stenon.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La pila de botón en fosa nasal o CAE es una emergencia quirúrgica absoluta por riesgo de perforación y necrosis en...	Tema 14.18 →
El 80-90% de las sialolitiasis se localizan en la Glándula Submandibular a lo largo del conducto de Wharton.	Tema 14.19 →
El Carcinoma de Células Escamosas (espinocelular) representa > 90% de los cánceres de cabeza y cuello.	Tema 14.20 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 14.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.020

Un lactante de 14 meses es diagnosticado de otitis media aguda derecha y se le prescribe amoxicilina en dosis de 85...

CLAVE B **Cambiar el tratamiento antimicrobiano a amoxicilina con ácido clavulánico oral.**

La opción correcta es la B. La persistencia de fiebre y otalgia con persistencia de signos otoscópicos a las 48-72 horas de tratamiento con amoxicilina a dosis altas constituye una falla terapéutica de primera línea. El mecanismo fisiopatológico principal es la infección por cepas de Haemophilus influenzae no tipificable o Moraxella catarrhalis productoras de betalactamasas. La conducta estandarizada por MINSAL y guías internacionales es el cambio inmediato a amoxicilina-ácido clavulánico (80-90 mg/kg/día de componente amoxicilina en relación 14:1). Opción A: Incorrecta, dosis superiores de amoxicilina sola no superan la resistencia por betalactamasas. Opción C: Incorrecta, las gotas óticas no penetran a través de una membrana timpánica íntegra. Opción D: Incorrecta, la timpanocentesis se reserva para mastoiditis, sepsis o recién nacidos. Opción E:

Perla. Incorrecta, la falta de respuesta a las 72h exige cambio de antibiótico.

TEMA 14.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.026

Un niño de 4 años presenta cuadro de 2 días de rinorrea serosa y fiebre leve. Su madre nota que no responde...

CLAVE B **Otitis media con efusión; conducta expectante y control en 3 meses.**

La opción correcta es la B. La presencia de líquido o burbujas en el oído medio con membrana timpánica retraída o en posición neutra, sin signos inflamatorios agudos (sin eritema ni abombamiento) y sin sintomatología aguda (sin otalgia ni fiebre alta), define a la Otitis Media con Efusión (OME u otitis serosa). La inmensa mayoría de los casos resuelve espontáneamente en un período de 8 a 12 semanas. La conducta recomendada por guías clínicas es la observación expectante durante 3 meses. Ni los antibióticos, ni los corticoides, ni los antihistamínicos han demostrado beneficio y están desaconsejados.

Perla. Si la efusión persiste pasados los 3 meses y se acompaña de hipoacusia bilateral significativa (> 20-30 dB), se indica la colocación de tubos de ventilación timpánica.

TEMA 14.1 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.020

¿Cuál de los siguientes microorganismos es el agente etiológico aislado con mayor frecuencia en la otitis media aguda...

CLAVE B **Streptococcus pneumoniae**

La opción correcta es la B. Streptococcus pneumoniae (neumococo) continúa siendo el patógeno bacteriano más frecuente y clínicamente agresivo en OMA, responsable del 35-40% de los casos confirmados por timpanocentesis, seguido de Haemophilus influenzae no tipificable (30-35%) y Moraxella catarrhalis (10-15%).

Perla. Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus son agentes de otitis externa o de otitis media crónica supurada, no de OMA no complicada.

TEMA 14.1 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.102

Un lactante de 11 meses presenta su tercer episodio de otitis media aguda supurada en los últimos 4 meses, respondiendo...

CLAVE B **Cumple criterios de otitis media recurrente y debe ser derivado al especialista otorrinolaringólogo para evaluación de tubos de ventilación.**

La opción correcta es la B. La OMA recurrente se define como la presencia de ≥ 3 episodios bien documentados de OMA en 6 meses, o ≥ 4 episodios en 12 meses (con al menos 1 en los últimos 6 meses). Este paciente (3 episodios en 4 meses) cumple cabalmente la definición y debe ser derivado a ORL para evaluar inserción de tubos de ventilación timpánica (colleras), lo cual previene nuevos episodios y protege la función auditiva.

Trampa. La quimioprofilaxis antibiótica prolongada está contraindicada por generar resistencia bacteriana.

TEMA 14.2 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.021

Un escolar de 6 años es evaluado en el policlínico por sospecha de déficit atencional, ya que en el colegio la...

CLAVE C **Inserción bilateral de tubos de ventilación timpánica (colleras).**

La opción correcta es la C. El paciente presenta una Otitis Media con Efusión (OME) crónica persistente por más de 3 meses, acompañada de hipoacusia conductiva bilateral documentada que está interfiriendo en su rendimiento escolar y comunicación. Cuando la OME persiste más allá del período de observación de 3 meses con impacto auditivo (> 20-25 dB), la indicación formal y de elección es la miringotomía con colocación de tubos de ventilación timpánica (colleras), la cual restablece la ventilación de la caja timpánica y normaliza los umbrales auditivos de inmediato. Las opciones A, B y E carecen de efectividad demostrada en guías clínicas y exponen a efectos adversos innecesarios.

Perla. La opción D es un procedimiento quirúrgico mayor para colesteatoma o mastoiditis, no para OME.

TEMA 14.2 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.022

¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen otoscópico orienta con mayor especificidad a una otitis media crónica...

CLAVE B **Presencia de escamas blanquecinas nacaradas en una perforación marginal en la pars flácida.**

La opción correcta es la B. Las características patognomónicas del colesteatoma en la otoscopía son la perforación marginal (que compromete el reborde óseo o annulus), habitualmente localizada en la pars flácida (ático) o cuadrante posterosuperior, a través de la cual protruyen detritos blanquecinos de queratina (escamas nacaradas) y pólipos inflamatorios con secreción purulenta de olor fétido. En contraste, la OMC simple presenta perforación central en la pars tensa respetando el annulus con otorrea mucosa no fétida (opciones A y D).

Perla. La opción C describe una OMA supurada hiperaguda y la opción E describe una OME serosa.

TEMA 14.3 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.019

Un joven de 22 años, aficionado al surf, consulta por dolor intenso en el oído derecho de 48 horas de evolución...

CLAVE B **Aseo ótico y gotas óticas de ciprofloxacino con corticoide tópico por 7 a 10 días, asociado a analgesia oral.**

La opción correcta es la B. El caso corresponde a una clásica Otitis Externa Difusa Aguda (oído de nadador), producida habitualmente por Pseudomonas aeruginosa y favorecida por la exposición al agua. El signo del trago intensamente positivo es el sello clínico. En ausencia de signos de diseminación periauricular o inmunosupresión, el tratamiento de elección es estrictamente local: aspiración o aseo suave de los detritos del CAE y aplicación de gotas óticas que contengan fluoroquinolonas (Ciprofloxacino) asociadas o no a corticoides (Dexametasona) para reducir el edema, junto a analgesia oral con AINEs y protección estricta del agua. Los antibióticos orales (opciones A y C) no son necesarios y tienen menor eficacia local.

Trampa. El lavado con agua a presión (opción D) está contraindicado ya que agrava la inflamación y puede lesionar el conducto o el tímpano.

TEMA 14.3 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.019

¿Cuál es el microorganismo causal más frecuente tanto de la otitis externa difusa aguda como de la otitis externa...

CLAVE B **Pseudomonas aeruginosa**

La opción correcta es la B. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gramnegativa que causa más del 70-80% de las otitis externas difusas y más del 95% de las otitis externas malignas necrotizantes en pacientes diabéticos.

Perla. Su afinidad por medios húmedos y su producción de exotoxinas y proteasas facilitan la invasión dermoepidérmica y la osteólisis del hueso temporal.

TEMA 14.3 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.019

Una mujer de 78 años, diabética de larga data con mal apego al tratamiento, consulta por otalgia derecha intensa de...

CLAVE B **Tomografía computarizada (TAC) de peñasco y base de cráneo con contraste.**

La opción correcta es la B. El cuadro corresponde a una Otitis Externa Maligna (OEM) necrotizante complicada con parálisis del VII par craneal. El estudio inicial de elección para diagnosticar la osteólisis, evaluar el compromiso cortical del peñasco, el foramen estilomastoideo y la base del cráneo es la Tomografía Computarizada (TAC) de peñasco y base de cráneo con contraste.

Perla. La radiografía simple carece de resolución suficiente y la RM es útil posteriormente para evaluar partes blandas endocraneales, pero el TAC define la osteólisis ósea.

TEMA 14.3 · PREGUNTA 10 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.019

¿Cuál es la complicación neurológica por compromiso de pares craneales que se observa con mayor frecuencia en la...

CLAVE B **Parálisis del nervio facial (VII par).**

La opción correcta es la B. El nervio facial (VII par craneal) emerge por el agujero estilomastoideo, inmediatamente adyacente a la porción posterior e inferior del conducto auditivo externo.

Perla. Por esta estrecha vecindad anatómica, es el primer y más frecuente par craneal afectado en la otitis externa maligna (hasta en el 50% de los casos avanzados), manifestándose como una parálisis facial periférica ipsilateral.

TEMA 14.4 · PREGUNTA 11 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.001

Un niño de 2 años presenta fiebre de 39.3°C, irritabilidad y tumefacción retroauricular izquierda dolorosa y...

CLAVE C **Hospitalizar de inmediato, solicitar TAC de peñasco con contraste e iniciar ceftriaxona endovenosa.**

La opción correcta es la C. El paciente presenta una Mastoiditis Aguda izquierda, complicación supurativa mayor de la OMA. Constituye una urgencia médica que exige hospitalización inmediata. El examen imagenológico de elección es el TAC de peñasco y cráneo con contraste endovenoso para confirmar la coalescencia de las celdas mastoideas y descartar absceso subperióstico o trombosis de senos durales. El tratamiento inicial mandatario es antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro (Ceftriaxona EV) asociada a evaluación urgente por especialista otorrinolaringólogo para miringotomía o mastoidectomía.

Perla. El manejo ambulatorio con antibióticos orales (opciones A y B) es una negligencia médica ante una infección osteolítica del hueso temporal.

TEMA 14.4 · PREGUNTA 12 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.022

¿Cuál de los siguientes signos imagenológicos en el angio-TAC de cráneo o TAC con contraste es característico de la...

CLAVE B **Signo del delta vacío (defecto de llene central en el seno venoso dural).**

La opción correcta es la B. El 'signo del delta vacío' (empty delta sign) es el hallazgo clásico en el TAC de cerebro con contraste o angio-TAC venoso, caracterizado por un defecto de repleción intraluminal (el trombo que no capta contraste) rodeado por el realce de la pared dural ricamente vascularizada del seno sigmoide o sagital.

Perla. Es altamente indicativo de tromboflebitis séptica de los senos venosos durales secundaria a infecciones óticas contiguas.

TEMA 14.5 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.008

Un paciente consulta por hipoacusia en el oído izquierdo. Al examen con diapasón de 512 Hz, la prueba de Weber...

CLAVE B **Hipoacusia sensorioneural del oído izquierdo.**

La opción correcta es la B. En el Test de Weber, el sonido lateraliza hacia el oído contralateral (sano) en las hipoacusias sensorioneurales; al lateralizar al oído derecho, indica que el oído izquierdo es el hipoacúsico sensorioneural. Además, el Test de Rinne positivo bilateral (VA > VO) confirma que no hay alteración de la conducción en el oído izquierdo, ya que las hipoacusias sensorioneurales conservan un Rinne positivo (la vía aérea sigue siendo más eficiente que la vía ósea, aunque ambas estén proporcionalmente descendidas).

Perla. Una hipoacusia de conducción izquierda (opciones A y E) mostraría Weber al oído izquierdo y Rinne negativo izquierdo.

TEMA 14.5 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.4.008

¿Cuál de las siguientes curvas de la clasificación de Jerger en la timpanometría se asocia de forma característica a la...

CLAVE C **Curva B (curva aplanada sin punto de máxima compliance).**

La opción correcta es la C. La curva tipo B de Jerger es una curva plana, caracterizada por la ausencia de un pico móvil de compliance timpánica debido a la presencia de líquido no compresible (exudado o transudado seroso) en la cavidad del oído medio que impide la movilidad del tímpano ante los cambios de presión. Es el hallazgo timpanométrico clásico de la Otitis Media con Efusión (OME).

Perla. La curva A es normal, la curva As indica rigidez (otoesclerosis), la curva C indica presión negativa por disfunción tubárica y la curva Ad indica luxación de cadena o tímpano monomérico.

TEMA 14.6 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.018

Un hombre de 52 años consulta por pérdida súbita de la audición del oído derecho que notó al despertar hoy en la...

CLAVE C **Iniciar de inmediato prednisona oral en dosis de 1 mg/kg/día y solicitar audiometría urgente.**

La opción correcta es la C. El paciente presenta una Hipoacusia Sensorioneural Súbita (HSNS) derecha, una verdadera emergencia médica en ORL. La otoscopía normal descarta patología de oído externo o perforaciones, y el Weber al oído contralateral (izquierdo) con Rinne positivo confirma daño sensorioneural en el oído derecho. La única terapia con sólida evidencia que previene la sordera permanente es la corticoterapia oral en altas dosis (Prednisona 1 mg/kg/día por 10-14 días) iniciada de manera precoz en las primeras horas, complementada con audiometría urgente.

Trampa. Las opciones A y D son errores graves en oído con tímpano sano, y diferir la conducta (opciones B y E) conlleva secuelas irreversibles.

TEMA 14.6 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.008

Un paciente de 72 años consulta porque desde hace 3 años presenta dificultad para entender las conversaciones cuando...

CLAVE B **Presbiacusia; patología con Garantía Explícita en Salud (GES) con indicación de audífonos bilaterales.**

La opción correcta es la B. La presbiacusia es la pérdida auditiva fisiológica relacionada con el envejecimiento, caracterizada por hipoacusia sensorioneural bilateral, simétrica y de predominio en frecuencias agudas, con dificultad desproporcionada para la discriminación fonémica en ambientes ruidosos.

Perla. En Chile, la hipoacusia en personas de 65 años y más cuenta con Garantía Explícita en Salud (GES N° 56), que asegura el acceso a confirmación diagnóstica, entrega e implementación de audífonos y rehabilitación auditiva integral.

TEMA 14.6 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.006

Un calderero industrial de 45 años, con 20 años de labor en maestranza sin uso constante de protectores auditivos, se...

CLAVE C **Muesca o escotoma neurosensorial bilateral selectivo en la frecuencia de 4000 Hz.**

La opción correcta es la C.

Perla. El trauma acústico crónico por exposición laboral a ruido de alta intensidad (> 85 dB) produce un daño selectivo irreversible en las células ciliadas externas basales de la cóclea, lo que se traduce típicamente en la audiometría tonal como una caída o muesca ('escotoma acústico') simétrica en la frecuencia de 4000 Hz (y en menor medida 3000 o 6000 Hz), con recuperación relativa en los 8000 Hz.

TEMA 14.6 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.018

En un paciente con hipoacusia sensorioneural súbita idiopática de 48 horas de evolución, ¿cuál de los siguientes...

CLAVE C **Resonancia magnética nuclear (RMN) de cerebro y ángulo pontocerebeloso con gadolinio.**

La opción correcta es la C.

Perla. La Resonancia Magnética (RMN) de peñasco, conducto auditivo interno y ángulo pontocerebeloso con medio de contraste (gadolinio) y secuencias finas potenciadas en T1 y T2 (CISS o FIESTA) es el examen de elección para detectar schwannomas vestibulares intracanaliculares incipientes (< 5 mm) que no son visibles en el TAC.

TEMA 14.7 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.025

Una paciente de 58 años consulta por crisis breves de sensación de giro del entorno de 20 a 30 segundos de duración...

CLAVE B **Realizar maniobra de reposición canalicular de Epley en la consulta.**

La opción correcta es la B. La clínica y la maniobra diagnóstica de Dix-Hallpike positiva con latencia y fatigabilidad son diagnósticas de Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB) del canal posterior izquierdo. El tratamiento curativo de primera línea indiscutido son las maniobras de reposición de partículas (maniobra de Epley o maniobra de Semont), que resuelven mecánicamente la canalitiasis en más del 85-90% de los casos en una sola sesión.

Perla. El uso de bloqueadores de canales de calcio como flunarizina (opción A) o sedantes vestibulares no corrige la alteración anatómica y está desaconsejado en guías clínicas.

TEMA 14.7 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.025

Un hombre de 40 años presenta desde hace 24 horas un cuadro agudo de vértigo rotatorio continuo e invalidante, asociado...

CLAVE B **Neuronitis vestibular izquierda.**

La opción correcta es la B. El cuadro corresponde a una Neuronitis Vestibular (en este caso izquierda). Se caracteriza por un síndrome vestibular agudo con vértigo prolongado continuo de días de evolución tras un pródromo viral, nistagmo periférico unidireccional que bate hacia el lado contralateral sano (bate a la derecha, por hipofunción vestibular izquierda) y rigurosa ausencia de síntomas cocleares (sin hipoacusia ni acúfenos).

Perla. El VPPB dura segundos, Ménière dura horas con hipoacusia y acúfenos, y los ACV típicamente presentan nistagmo central o déficit neurológico focal.

TEMA 14.7 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.025

Un hombre de 50 años refiere episodios recurrentes de vértigo rotatorio que se prolongan por 3 a 4 horas cada vez...

CLAVE B **Restricción de sodio en la dieta asociada a diuréticos como hidroclorotiazida.**

La opción correcta es la B. El paciente presenta la tríada clásica de la Enfermedad de Ménière: crisis de vértigo de horas de duración + hipoacusia fluctuante sensorioneural en tonos graves + acúfenos y plenitud ótica ipsilateral. La fisiopatología central es el hidrops endolinfático (exceso de líquido en el laberinto membranoso).

Perla. El tratamiento profiláctico de elección para reducir la frecuencia e intensidad de las crisis a largo plazo consiste en la restricción de sal en la dieta (< 2 g/día) y el uso de diuréticos (hidroclorotiazida o triamtereno) asociados a betahistina.

TEMA 14.7 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.017

Al evaluar a un paciente de 67 años con factores de riesgo cardiovascular que consulta en urgencias por vértigo agudo...

CLAVE C **Presencia de nistagmo bidireccional que cambia de dirección según hacia dónde mire el paciente.**

La opción correcta es la C. En el protocolo HINTS para el síndrome vestibular agudo, un nistagmo que cambia de dirección según la dirección de la mirada (bidireccional: bate a la derecha al mirar a la derecha y bate a la izquierda al mirar a la izquierda) o un nistagmo puramente vertical es estrictamente CENTRAL e indica isquemia del tronco encefálico o cerebelo (accidente cerebrovascular de fosa posterior).

Perla. Por el contrario, un nistagmo unidireccional (opción B) y un impulso cefálico anormal con sacada correctiva (opción A) son signos de disfunción vestibular periférica como la neuronitis.

TEMA 14.8 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.016

Un paciente de 60 años consulta en urgencia por desviación de la comisura bucal hacia la derecha y dificultad para...

CLAVE B **Lesión corticonuclear o hemisférica cerebral derecha (parálisis facial central); activar código de sospecha de ACV y solicitar TAC de cerebro de urgencia.**

La opción correcta es la B. El hallazgo clave es la preservación completa de la motilidad de la frente (el paciente arruga la frente simétricamente y no tiene lagoftalmos) con debilidad limitada a la mitad inferior de la cara. Esto define una Parálisis Facial Central (supranuclear). Debido a que las fibras que inervan la musculatura frontal reciben inervación bilateral de la corteza motora, una lesión cerebral unilateral (habitualmente un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico en el hemisferio contralateral, en este caso derecho) respeta la frente. Requiere activación inmediata del código de sospecha de ACV y realización urgente de neuroimagen (TAC de cerebro).

Trampa. Confundirla con una parálisis de Bell y derivar a domicilio con corticoides (opción A) es un error médico de máxima gravedad.

TEMA 14.8 · PREGUNTA 24 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.009

Un paciente de 68 años consulta por intenso dolor en la oreja derecha de 3 días de evolución, asociándose hoy a...

CLAVE B **Valaciclovir oral 1000 mg cada 8 horas asociado a prednisona oral 1 mg/kg/día por 10 días y protección ocular.**

La opción correcta es la B. El cuadro clínico corresponde al Síndrome de Ramsay Hunt (herpes zóster ótico), producido por la reactivación del virus varicela-zóster en el ganglio geniculado del nervio facial, con afectación concomitante del nervio vestibulococlear (vértigo). La tríada patognomónica es otalgia severa, parálisis facial periférica y vesículas herpéticas en la concha o conducto auditivo externo.

Perla. El tratamiento de elección consiste en la combinación precoz de un antiviral sistémico activo contra VZV (Valaciclovir 1 g cada 8 horas o Aciclovir 800 mg 5 veces al día) más Corticoides orales en altas dosis (Prednisona 1 mg/kg/día) por 10 a 14 días, sumado a medidas estrictas de lubricación y protección corneal.

TEMA 14.9 · PREGUNTA 25 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.103

Un estudiante de 24 años consulta por rinorrea acuosa profusa, prurito ocular y nasal intenso y salvas de estornudos...

CLAVE B **Rinitis alérgica persistente moderada-severa; corticoide intranasal en spray diario (ej. fluticasona o mometasona).**

La opción correcta es la B. De acuerdo con la clasificación de consenso ARIA, el paciente tiene síntomas ≥ 4 días a la semana durante ≥ 4 semanas (lo que define el patrón 'Persistente') y presenta alteración del sueño y deterioro de su rendimiento de estudio (lo que define la categoría 'Moderada a Severa').

Perla. Para la rinitis alérgica persistente moderada-severa, la terapia de primera línea más eficaz y recomendada son los Corticoides Intranasales (fluticasona, mometasona o ciclesonida), que actúan sobre todos los mediadores inflamatorios y son superiores a los antihistamínicos orales en el alivio de la obstrucción nasal.

TEMA 14.9 · PREGUNTA 26 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.025

¿Cuál es la causa subyacente y la conducta terapéutica correcta ante un paciente que presenta congestión nasal severa y...

CLAVE B **Rinitis medicamentosa por rebote vasomotor; suspender la oximetazolina e iniciar corticoides intranasales.**

La opción correcta es la B. Los vasoconstrictores tópicos alfa-adrenérgicos (oximetazolina, tramazolina, fenilefrina) producen taquifilaxia y vasodilatación paradójica de rebote ('rinitis medicamentosa') si se utilizan por más de 5 a 7 días consecutivos.

Perla. La conducta obligatoria consiste en la suspensión inmediata y definitiva del fármaco vasoconstrictor y el inicio de corticoides tópicos intranasales (como fluticasona o mometasona) para reducir la hipertrofia e inflamación endotelial de los cornetes.

TEMA 14.10 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.029

Un hombre de 32 años consulta por cuadro de congestión nasal, rinorrea amarillenta espesa y cefalea frontal opresiva de...

CLAVE C **Rinosinusitis bacteriana aguda; iniciar tratamiento con amoxicilina oral por 7 a 10 días.**

La opción correcta es la C. El paciente cumple el criterio diagnóstico formal de Rinosinusitis Bacteriana Aguda (RSBA) al presentar síntomas cardinales de rinosinusitis (obstrucción, rinorrea purulenta, dolor facial) persistentes por más de 10 días sin ninguna evidencia de mejoría clínica. Este criterio temporal de persistencia es el más sensible para diagnosticar sobreinfección bacteriana secundaria. La conducta de primera línea establecida por las guías clínicas es iniciar tratamiento antibiótico oral con Amoxicilina (o amoxicilina con ácido clavulánico) por 7 a 10 días, asociada a lavados con solución salina.

Perla. Mantener solo analgésicos a los 12 días (opción B) prolonga el cuadro y expone a complicaciones.

TEMA 14.10 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.005

Un escolar de 8 años con rinosinusitis aguda presenta aumento de volumen y eritema palpebral izquierdo. Al examen...

CLAVE B **Estadio II: Celulitis orbitaria postseptal.**

La opción correcta es la B. La presencia de signos de afección postseptal como proptosis (exoftalmos) y oftalmoplejía con diplopía dolorosa, en ausencia de una colección delimitada visible o amaurosis, define el Estadio II de Chandler (Celulitis Orbitaria postseptal). En el Estadio I (celulitis preseptal), el edema se confina a la dermis palpebral anterior y los movimientos oculares están rigurosamente conservados sin proptosis.

Perla. Requiere hospitalización inmediata, TAC con contraste y antibióticos endovenosos de amplio espectro.

TEMA 14.11 · PREGUNTA 29 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.012

Un niño de 9 años consulta en el servicio de urgencia por sangrado nasal derecho activo tras hurgarse la nariz. Al...

CLAVE B **Cauterización química del vaso sangrante con bastón de nitrato de plata.**

La opción correcta es la B. Una vez identificado el punto sangrante específico en el plexo de Kiesselbach (porción anteroinferior del tabique nasal) tras una compresión digital no resolutiva y preparación con vasoconstrictor tópico, el tratamiento estándar de elección es la cauterización química puntual del vaso con un bastón de nitrato de plata al 75%. La cauterización debe aplicarse de forma suave y concéntrica alrededor del vaso sangrante.

Trampa. La opción D es un grave error médico que causa necrosis y perforación del cartílago septal; la opción E induce deglución de sangre y vómitos; y las opciones A y C son medidas desproporcionadas para una epistaxis anterior puntual.

TEMA 14.11 · PREGUNTA 30 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.011

Una paciente de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial presenta epistaxis masiva que no ha cedido tras...

CLAVE B **Hospitalización con monitorización de signos vitales e inicio de antibióticos profilácticos sistémicos.**

La opción correcta es la B. La epistaxis posterior que requiere taponamiento con balón o sonda Foley es una situación clínica grave que exige HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA del paciente por riesgo de hipoxia, bradiarritmias por reflejo nasovagal y aspiración. Además, la presencia de taponamiento posterior ocluye el ostium de drenaje de los senos paranasales y favorece la proliferación bacteriana en tejidos retenidos, lo que hace mandatorio el inicio de profilaxis antibiótica sistémica (habitualmente amoxicilina con ácido clavulánico o cefazolina) para prevenir el temible Síndrome de Shock Tóxico estafilocócico y la rinosinusitis aguda supurada.

Trampa. El balón se insufla con agua (nunca aire, que se desinfla por difusión) y solo con 8-10 mL para evitar necrosis tisular.

TEMA 14.11 · PREGUNTA 31 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.012

¿Cuál es la anastomosis arterial responsable de la gran mayoría de las epistaxis anteriores en niños y adultos jóvenes...

CLAVE B **Plexo de Kiesselbach (Área de Little).**

La opción correcta es la B. El Plexo de Kiesselbach (o Área de Little) es una red vascular ricamente anastomosada en la submucosa de la porción anteroinferior del tabique nasal, donde confluyen ramas de la arteria esfenopalatina, palatina mayor, labial superior y etmoidal anterior.

Perla. Es el sitio anatómico de origen de más del 90% de las epistaxis anteriores.

TEMA 14.11 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.012

¿Por qué motivo está formalmente contraindicado realizar cauterización con nitrato de plata en ambas caras del tabique...

CLAVE B **Por el riesgo de provocar isquemia, necrosis avascular y perforación septal permanente.**

La opción correcta es la B. El cartílago del tabique nasal (cartílago cuadrangular) es avascular y se nutre exclusivamente por difusión a partir del pericondrio que lo recubre bilateralmente.

Perla. Si se cauteriza de forma química o eléctrica ambas caras del tabique al mismo nivel simultáneamente, se destruye el aporte sanguíneo de ambos lados, provocando necrosis isquémica del cartílago subyacente y una perforación septal permanente, complicación grave y de difícil reparación quirúrgica.

TEMA 14.12 · PREGUNTA 33 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.013

Un adolescente de 15 años sufre un pelotazo en la cara durante un partido de básquetbol, presentando deformidad nasal y...

CLAVE B **Hematoma septal; realizar incisión, drenaje quirúrgico inmediato y taponamiento nasal bilateral compresivo.**

La opción correcta es la B. La presencia de una tumefacción abombada violácea y fluctuante en el tabique nasal tras un traumatismo agudo es la manifestación clínica típica del Hematoma Septal. Es una emergencia otorrinolaringológica: el cartílago septal sufre necrosis isquémica por desprendimiento del pericondrio en menos de 24 a 48 horas si no se descomprime, lo que provocaría la pérdida de soporte de la pirámide nasal (deformidad en silla de montar). La conducta inmediata ineludible es el drenaje quirúrgico de los coágulos mediante incisión del mucopericondrio, colocación de taponamiento anterior bilateral compresivo y cobertura antibiótica.

Perla. Diferir la conducta (opción C) o usar descongestionantes (opción A) conduce a secuelas estéticas y funcionales irreparables.

TEMA 14.12 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.024

Una paciente de 46 años con antecedentes de asma bronquial de difícil control consulta por obstrucción nasal bilateral...

CLAVE C **Tríada de Samter (Enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina); debe evitar estrictamente la aspirina y todos los AINEs.**

La opción correcta es la C. La coexistencia de Poliposis Nasal bilateral (masas translúcidas insensibles como uva pelada) + Asma Bronquial + Intolerancia severa con broncoespasmo a la Aspirina y otros AINEs constituye la clásica Tríada de Samter (o Tríada de Widal / EREA). El mecanismo subyacente es una disregulación de la vía del ácido araquidónico: al bloquear la enzima COX-1 con AINEs, la cascada metabólica se desvía masivamente hacia la vía de la lipooxigenasa, produciendo una sobreproducción extrema de cisteinil-leucotrienos (LTC4, LTD4, LTE4) que provocan broncoconstricción fatal, vasodilatación y edema mucoso.

Trampa. Estos pacientes deben tener contraindicados de por vida la aspirina y todos los AINEs inhibidores de COX-1.

TEMA 14.13 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.002

Un escolar de 7 años es traído a la consulta por fiebre de 38.6°C y odinofagia de 2 días de evolución. No tiene tos ni...

CLAVE C **5 puntos; iniciar tratamiento antibiótico con penicilina benzatina IM o amoxicilina oral por 10 días.**

La opción correcta es la C. El paciente suma exactamente 5 puntos en la escala de McIsaac: fiebre > 38°C (+1), exudado amigdalino (+1), adenopatías anteriores sensibles (+1), ausencia de tos (+1) y edad de 3 a 14 años (+1). Con 5 puntos, la probabilidad de infección por Streptococcus pyogenes supera el 50-60%, estando formalmente indicado el inicio inmediato de tratamiento antibiótico de primera línea:

> **Perla.** Penicilina Benzatina intramuscular en dosis única o Amoxicilina oral (50 mg/kg/día) durante 10 días completos con el objetivo primordial de prevenir la fiebre reumática aguda.

TEMA 14.13 · PREGUNTA 36 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.002

Respecto a las complicaciones de la faringoamigdalitis aguda por Streptococcus pyogenes (estreptococo betahemolítico...

CLAVE B **El tratamiento antibiótico con penicilina benzatina o amoxicilina por 10 días previene la fiebre reumática aguda.**

La opción correcta es la B. Es una regla de oro de la infectología y pediatría: el tratamiento antibiótico adecuado de la faringitis estreptocócica previene de manera categórica la aparición de la Fiebre Reumática Aguda y sus secuelas valvulares cardíacas, siempre que se administre penicilina benzatina o se completen 10 días de antibióticos orales. Por el contrario (opción A), los antibióticos NO previenen la Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE), la cual depende de una respuesta inmune mediada por inmunocomplejos y antígenos nefritogénicos que se activa independientemente de la erradicación bacteriana.

> **Perla.** La opción E es falsa: el SBHGA mantiene un 100% de sensibilidad a la penicilina.

TEMA 14.13 · PREGUNTA 37 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.04.1.025

Un adolescente de 16 años consulta por odinofagia severa de 5 días de evolución, astenia marcada y fiebre. El médico...

CLAVE B **Mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr (EBV).**

La opción correcta es la B. La aparición de un exantema máculo-papular eritematoso difuso (rash por aminopenicilinas) en más del 90-95% de los pacientes con Mononucleosis Infecciosa por Virus de Epstein-Barr (EBV) tras recibir amoxicilina o ampicilina es un efecto inmunomediado clásico no alérgico.

> **Perla.** La presencia de odinofagia prolongada, exudado amigdalino, adenopatías en cadena cervical posterior y epitrocleares, sumado a esplenomegalia, confirma el síndrome mononucleósico.

TEMA 14.13 · PREGUNTA 38 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.002

En un paciente de 25 años con faringoamigdalitis estreptocócica confirmada por test rápido, con antecedente de reacción...

CLAVE C **Azitromicina oral por 5 días.**

La opción correcta es la C. Ante un antecedente fidedigno de reacción alérgica grave anafiláctica mediada por IgE (edema laríngeo, broncoespasmo o shock anafiláctico) a las penicilinas, están terminantemente contraindicados todos los antibióticos betalactámicos, incluyendo aminopenicilinas (opciones A y E) y cefalosporinas (opciones B y D) por riesgo de reacción anafiláctica cruzada potencialmente mortal.

> **Perla.** En esta situación clínica, los macrólidos (Azitromicina 500 mg/día por 5 días o Claritromicina 250-500 mg cada 12 horas por 10 días) constituyen la alternativa terapéutica formal de elección.

TEMA 14.14 · PREGUNTA 39 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.5.002

Un joven de 19 años con diagnóstico de amigdalitis aguda en tratamiento oral con amoxicilina desde hace 3 días consulta...

CLAVE B **Punción con aguja o incisión y drenaje del espacio periamigdalino derecho e inicio de antibióticos endovenosos.**

La opción correcta es la B. El cuadro clínico corresponde a un Absceso Periamigdalino derecho (quinsy), caracterizado por la tríada clásica de trismus, voz en papa caliente y desviación contralateral de la úvula provocada por la colección purulenta en el espacio periamigdalino. La conducta de elección que proporciona confirmación diagnóstica y alivio sintomático inmediato es la punción aspirativa con aguja o la incisión y drenaje en el punto de máxima fluctuación del pilar anterior, asociada al inicio inmediato de antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro con cobertura para anaerobios (Amoxicilina-Clavulánico o Penicilina + Metronidazol).

> **Perla.** Mantener tratamiento oral (opción A) es una conducta errónea ante una colección purulenta fascial.

TEMA 14.14 · PREGUNTA 40 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.004

Un lactante de 2 años presenta fiebre alta de 39.2°C, irritabilidad, rechazo alimentario, sialorrea y una postura fija...

CLAVE A **Absceso retrofaríngeo; mediastinitis necrotizante descendente.**

La opción correcta es la A. En niños menores de 5 años, la inflamación y supuración de los ganglios linfáticos retrofaríngeos de Gilette origina el Absceso Retrofaríngeo. Sus manifestaciones cardinales son fiebre, sialorrea, rigidez de nuca con tortícolis, estridor inspiratorio y ensanchamiento del espacio prevertebral visible en la radiografía lateral de cuello en inspiración. La complicación más grave y potencialmente letal es la propagación de la infección purulenta a través del 'espacio peligroso' (danger space) hacia el tórax, originando una Mediastinitis Necrotizante Descendente con shock séptico y alta mortalidad.

> **Perla.** Requiere hospitalización inmediata en UCI, TAC de cuello con contraste y drenaje quirúrgico en quirófano.

TEMA 14.14 · PREGUNTA 41 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.002

¿Cuál es la causa del trismus (dificultad para la apertura bucal) característico que acompaña al absceso periamigdalino...

CLAVE B **Compromiso inflamatorio y espasmo reflejo del músculo pterigoideo interno (medial).**

La opción correcta es la B.

> **Perla.** El trismus en las infecciones faríngeas profundas se debe a la inflamación por contigüidad, espasmo e hipertonía refleja de los músculos masticadores, específicamente del músculo pterigoideo interno (o medial), el cual se sitúa inmediatamente lateral al músculo constrictor superior de la faringe y al espacio periamigdalino.

TEMA 14.14 · PREGUNTA 42 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.003

Un paciente de 55 años con antecedentes de mala higiene dental consulta por aumento de volumen cervical anterior y...

CLAVE B **Asegurar y proteger la vía aérea de forma precoz (intubación guiada o traqueostomía).**

La opción correcta es la B. El paciente presenta una Angina de Ludwig, una celulitis gangrenosa rápidamente progresiva de los espacios submandibular, sublingual y submentoniano originada típicamente a partir de focos odontogénicos inferiores. El signo de máxima alarma es la induración leñosa del piso de boca que eleva y propulsa la lengua hacia la orofaringe posterior, causando una obstrucción mecánica inminente y letal de la vía aérea superior.

> **Perla.** La prioridad clínica número uno indiscutida es el aseguramiento expedito de la vía aérea (mediante intubación con fibrobroncoscopio o traqueostomía de urgencia), antes de intentar cualquier procedimiento quirúrgico de drenaje o exámenes complementarios.

TEMA 14.15 · PREGUNTA 43 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.027

Un niño de 5 años presenta ronquidos nocturnos de 6 meses de evolución y pausas respiratorias nocturnas documentadas...

CLAVE B **Indicación quirúrgica de adenoamigdalectomía bilateral.**

La opción correcta es la B. El paciente presenta un Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) infantil severo con repercusión en el desarrollo físico y amígdalas grado 4 que colapsan la orofaringe. El SAHOS pediátrico documentado secundario a hipertrofia de amígdalas y adenoides es la indicación quirúrgica absoluta indiscutida de adenoamigdalectomía.

> **Perla.** Postergar la intervención quirúrgica (opción D) expone al niño a fallo de medro, alteraciones ortodóncicas craneofaciales irreversibles y riesgo de hipertensión pulmonar / cor pulmonale crónico.

TEMA 14.15 · PREGUNTA 44 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.100

¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas constituye una indicación formal para considerar una amigdalectomía...

CLAVE B **Presentar 7 episodios documentados de faringoamigdalitis bacteriana en el último año tratados con antibióticos.**

La opción correcta es la B. Los Criterios de Paradise definen la indicación quirúrgica relativa de amigdalectomía por infecciones recurrentes basándose en una frecuencia mínima rigurosa de episodios bacterianos febriles documentados: ≥ 7 episodios en el último año; o ≥ 5 episodios por año durante 2 años consecutivos; o ≥ 3 episodios por año durante 3 años consecutivos.

> **Perla.** La caseosis amigdalina (opción D) es un cuadro benigno que no justifica cirugía resectiva de rutina.

TEMA 14.16 · PREGUNTA 45 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.010

Una educadora de párvulos de 28 años consulta por disfonía crónica de 4 meses de evolución que se acentúa en las...

CLAVE B **Terapia de rehabilitación fonoaudiológica y pautas de higiene vocal.**

La opción correcta es la B. La paciente presenta nódulos vocales bilaterales típicos, producidos por el impacto repetitivo y sobreesfuerzo vocal continuado propio de su profesión docente. El tratamiento de primera línea de consenso indiscutido es la Rehabilitación Fonoaudiológica integral, orientada a corregir la hiperfunción laríngea y mejorar la técnica respiratoria y de impostación de la voz, logrando la remisión de los nódulos en la mayoría de los casos.

> **Perla.** La cirugía resectiva (opción A) está desaconsejada como manejo inicial por riesgo de fibrosis y cicatrización de la cuerda vocal y porque presenta una altísima tasa de recidiva si no se corrigen los malos hábitos fonatorios de base.

TEMA 14.16 · PREGUNTA 46 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.5.009

Un hombre de 62 años, fumador activo de 40 paquetes/año y consumidor habitual de alcohol, consulta en el centro de...

CLAVE B **Solicitar interconsulta prioritaria a otorrinolaringología para visualización de cuerdas vocales mediante laringoscopía o nasofibroscopía.**

La opción correcta es la B. Constituye una 'Regla de Oro' oncológica en otorrinolaringología: toda disfonía que persista por más de 2 a 3 semanas de evolución, y de manera crucial en un paciente mayor de 40 a 50 años con factores de riesgo mayores como tabaquismo crónico y consumo de alcohol, debe considerarse sospechosa de Cáncer de Cuerda Vocal (carcinoma epidermoide de laringe) hasta demostrar lo contrario. Es mandatoria la derivación prioritaria a ORL para examen laringoscópico directo / nasofibroscópico que permita visualizar las cuerdas vocales y tomar biopsia de cualquier lesión proliferativa, leucoplaquia o ulceración.

> **Perla.** Asumir reflujo o laringitis y dar tratamientos de prueba sin mirar la laringe (opciones A y C) retrasa de forma negligente el diagnóstico de una neoplasia curable en estadios precoces.

TEMA 14.17 · PREGUNTA 47 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.025

Un niño de 2 años presenta cuadro de 24 horas de tos perruna y disfonía. Al examen físico en urgencia se encuentra en...

CLAVE B **Nebulización con adrenalina corriente con oxígeno y administración de dexametasona oral en dosis única, dejando en observación por 2 a 4 horas.**

La opción correcta es la B. La presencia de estridor inspiratorio presente en reposo clasifica a este Croup en Grado II o Moderado según la escala de Taussig. La indicación protocolizada indiscutida es la administración de Dexametasona oral (0.15 a 0.6 mg/kg) en dosis única más una nebulización con Adrenalina (corriente 1:1.000 4 mL o racémica), con permanencia obligatoria en observación en el servicio de urgencia durante 2 a 4 horas para vigilar la respuesta y descartar el fenómeno de rebote. El salbutamol (opción C) actúa en el músculo liso bronquial y carece de efecto sobre el edema mucoso subglótico laríngeo.

> **Perla.** Los antibióticos (opción A) no tienen indicación en el croup viral.

TEMA 14.17 · PREGUNTA 48 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.018

Un preescolar de 3 años es llevado a urgencia por cuadro fulminante de 4 horas de evolución caracterizado por fiebre...

CLAVE C **Deprimir la lengua con un abatelenguas para inspeccionar la faringe en el box de atención.**

La opción correcta es la C. El cuadro clínico corresponde a una Epiglotitis Aguda, una emergencia médica fulminante con riesgo inminente de asfixia mecánica. La tríada clásica es fiebre tóxica alta, babeo continuo (sialorrea) por disfagia severa y postura en trípode, con ausencia de tos. En estos pacientes está FORMALMENTE Y TERMINANTEMENTE PROHIBIDO deprimir la lengua con un abatelenguas o forzar la inspección de la orofaringe en el box de urgencia, ya que el estímulo físico del reflejo faríngeo puede desencadenar de forma instantánea un laringoespasmo reflejo total y paro cardiorrespiratorio irreversible.

> **Perla.** El paciente debe ser trasladado de inmediato a quirófano para intubación o traqueostomía por equipo especializado.

TEMA 14.17 · PREGUNTA 49 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.025

¿Cuál es la razón principal por la cual un niño con laringitis obstructiva que recibe nebulización con adrenalina debe...

CLAVE B **Para detectar el efecto rebote (reaparición del edema y del estridor) al decaer el efecto de la adrenalina.**

La opción correcta es la B. La adrenalina nebulizada tiene un inicio de acción ultrarrápido (10 a 30 minutos) por vasoconstricción alfa-1 local, pero su vida media es corta y su efecto desaparece a las 2 horas. Si el corticoide sistémico administrado conjuntamente aún no ha alcanzado niveles tisulares terapéuticos plenos (lo cual demora de 2 a 3 horas), puede producirse un 'efecto rebote' con reaparición súbita del estridor y de la insuficiencia respiratoria.

Perla. Por ello, el estándar de seguridad es mantener al paciente en observación médica por 2 a 4 horas antes de autorizar el alta.

TEMA 14.17 · PREGUNTA 50 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.025

¿Cuál de los siguientes agentes patógenos es el causante más frecuente de la laringotraqueítis aguda (croup viral) en...

CLAVE A **Virus Parainfluenza tipo 1**

La opción correcta es la A. El Virus Parainfluenza tipo 1 es responsable de más del 70 a 80% de los casos de laringotraqueítis aguda obstructiva (croup) en niños de 6 meses a 3 años.

Perla. Los tipos 2 y 3 de Parainfluenza, el virus respiratorio sincicial (VRS) y el virus influenza explican la mayor parte de los casos restantes.

TEMA 14.18 · PREGUNTA 51 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.010

Una madre acude al servicio de urgencia con su hijo de 3 años refiriendo que el niño se introdujo en la fosa nasal...

CLAVE B **Extracción inmediata del cuerpo extraño con gancho romo o derivación urgente a pabellón quirúrgico, sin realizar ninguna irrigación líquida.**

La opción correcta es la B. La pila de botón en una cavidad mucosa como la fosa nasal o el CAE es una emergencia quirúrgica de máxima prioridad debido a la rápida producción de quemaduras químicas alcalinas graves por electrólisis y fuga de hidróxido de potasio, las cuales pueden ocasionar perforación del cartílago septal en menos de 2 horas. La extracción debe realizarse de forma inmediata por personal entrenado con instrumental específico (gancho romo introducido por detrás del objeto).

Trampa. Está estrictamente contraindicada la irrigación con agua o suero (opción A) porque los líquidos actúan como electrolito conductor que acelera catastróficamente la corriente eléctrica y la destrucción tisular.

TEMA 14.18 · PREGUNTA 52 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.2.010

Un niño de 4 años es traído a la consulta médica ambulatoria porque desde hace 3 semanas presenta mucosidad purulenta...

CLAVE B **Cuerpo extraño nasal desapercibido en la fosa nasal derecha.**

La opción correcta es la B. En pediatría, la presencia de rinorrea purulenta, persistente, UNILATERAL y con OLOR FÉTIDO de varias semanas de evolución en un niño pequeño es el cuadro clínico clásico y patognomónico de un Cuerpo Extraño Nasal retenido y desapercibido (como fragmentos de esponja, papel o goma). La impactación del objeto bloquea el drenaje fisiológico de la mucosa y genera sobreinfección bacteriana local crónica anaerobia responsable de la fetidez extrema.

Perla. Requiere rinoscopía anterior o nasofibroscopía inmediata para visualización y extracción.

TEMA 14.19 · PREGUNTA 53 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.023

Un paciente de 50 años consulta por dolor y aumento de volumen agudo recurrente en la región submandibular derecha que...

CLAVE B **Sialolitiasis submandibular; conducto de Wharton.**

La opción correcta es la B. La presentación clínica de aumento de volumen y dolor paroxístico desencadenado por el estímulo alimentario ('cólico salival') es patognomónica de Sialolitiasis.

Perla. El 80 a 90% de los cálculos salivales se originan en la glándula submandibular y se impactan en su conducto excretor principal, el conducto de Wharton, el cual discurre por el piso de la boca hasta desembocar en las carúnculas sublinguales a ambos lados del frenillo lingual.

TEMA 14.19 · PREGUNTA 54 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.023

Una paciente de 42 años consulta por un nódulo indoloro en la región parotídea derecha que notó hace aproximadamente 1...

CLAVE B **Adenoma pleomorfo; parotidectomía superficial con disección y preservación del nervio facial.**

La opción correcta es la B. El tumor más frecuente de las glándulas salivales es el Adenoma Pleomorfo (tumor mixto benigno), el cual asienta en más del 80% de los casos en la glándula parótida. Su presentación clínica es clásica: nódulo parotídeo indoloro, móvil, de consistencia elástica y crecimiento lento de meses o años, con integridad rigurosa de la función del nervio facial (VII par). El tratamiento de elección estándar es la Parotidectomía Superficial con identificación, disección y preservación del nervio facial.

Trampa. La enucleación simple (opción D) está formalmente contraindicada debido a que presenta un riesgo de recidiva local superior al 40% y riesgo de transformación maligna a carcinoma.

TEMA 14.20 · PREGUNTA 55 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.015

Un hombre de 62 años, fumador crónico, consulta por una masa en la región lateral izquierda del cuello de 4 semanas de...

CLAVE B **Método de elección: Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía. Procedimiento contraindicado: Biopsia ganglionar abierta antes de descartar tumor primario en vía aérea superior.**

La opción correcta es la B. En un adulto fumador mayor de 40 años, una masa cervical pétrea fija es una metástasis ganglionar de carcinoma epidermoide de cabeza y cuello hasta demostrar lo contrario. El método diagnóstico citológico de primera línea indiscutido es la Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía, la cual permite tipificar la neoplasia con alta sensibilidad sin diseminar células tumorales.

Trampa. Al mismo tiempo, está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO realizar una biopsia incisional o abierta del ganglio sin haber evaluado la vía aérea superior y sin PAAF previa, debido a que la apertura quirúrgica rompe las fascias cervicales, produce siembra tumoral extracapsular masiva, deteriora el pronóstico y complica gravemente el posterior vaciamiento ganglionar cervical radical.

TEMA 14.20 · PREGUNTA 56 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.03.1.005

¿Cuál de los siguientes síntomas constituye una bandera roja de sospecha oncológica que obliga a descartar...

CLAVE B **Otalgia persistente unilateral con examen otoscópico rigurosamente normal.**

La opción correcta es la B. La otalgia referida o refleja unilateral en presencia de un oído completamente sano (otoscopía normal) es una de las banderas rojas oncológicas más características de los tumores malignos del tracto aerodigestivo superior. El dolor se transmite por vía refleja a través de ramos sensitivos de los nervios craneales que inervan tanto la orofaringe/hipofaringe como el oído (el nervio glosofaríngeo a través del nervio timpánico de Jacobson, y el nervio vago a través del nervio auricular de Arnold).

Perla. En todo adulto, especialmente si tiene antecedentes de tabaco o alcohol, este hallazgo exige nasofibroscopía inmediata para buscar un cáncer primario en amígdalas, base de lengua o laringe.